INSTRUÇÕES

Aqui temos o banco de questões do medgrupo. Cada pdf tem 500 questões, são 112 pdfs então 56.000 questões.

As questões são divididas da mesma forma que é no medgrupo, então, por exemplo, a pasta "CIR 1" irá conter as questões do modulo CIR 1 do medcurso. No pdf, primeiro há as questões e por final os comentários e gabaritos. Como é uma questão por pagina, sempre por volta da pagina 500 terá o começo do gabarito.

A numeração de cada questão é pelo seu ID, da mesma forma que é no app do medgrupo. Por exemplo, se no modulo CIR 1, uma questão ter o ID 33345 (o ID aparece em cima do enunciado em negrito), no gabarito irá aparecer o mesmo ID como a enumeração da questão.

Além disso, certas questões tem imagens e videos respostas. Dessa maneira se acaso a questão de ID 33345 ter uma imagem, ela estará na pasta Imagens (Cir 1/Imagens/33345.png) com o nome 33345.png e o vídeo estará em (Cir 1/videos/33345.mp4)

***Recomendo, para se localizar no gabarito, utilizar CTRL+F (pesquisar), procure o ID da questão que quer ver a resposta, como o ID 33345.**

***Se houver algum erro, envie mensagem no twitter @livremedicina**

345439)

Enunciado: Sobre o uso de vasopressores durante o atendimento de uma parada cardiorrespiratória (PCR) em paciente adulto, assinale a afirmativa CORRETA, de acordo com as recomendações da American Heart Association:

A) É razoável que se administre epinefrina para todos os pacientes com PCR, na dose de 01mg, com intervalo de 02 minutos entre cada dose.

B) Durante uma PCR em Atividade Elétrica sem Pulso (AESP), é recomendado que se administre epinefrina assim que possível.

C) Paciente com PCR em Fibrilação Ventricular (FV) deve receber adrenalina logo após a realização da primeira tentativa de desfibrilação.

D) O uso de vasopressina em substituição à primeira ou segunda dose de adrenalina deve ser feito sempre que disponível, já que apresenta melhores desfechos em comparação ao uso apenas de adrenalina.

345451)

Enunciado: Por velocidade de redução da pressão ventricular, a segunda bulha cardíaca pode apresentar hipofonese por:

A) Estado de baixo débito cardíaco (choque e miocardiopatia).

B) Enfisema pulmonar.

C) Edema Agudo de Pulmão.

D) Hipertensão arterial sistêmica.

343854)

Enunciado: Qual diagnóstico eletrocardiográfico (D2) da arritmia na figura abaixo?

A) Fibrilação atrial

B) Taquicardia paroxística supraventricular

C) Flutter atrial com bloqueio AV variável

D) Taquicardia ventricular

283271)

Enunciado: Paciente de 25 anos chega à emergência referindo dor torácica de forte intensidade, associada à taquicardia e palpitações. O eletrocardiograma evidenciou taquicardia sinusal com complexo QRS estreito, encurtamento do intervalo PR e supra desnivelamento de seguimento ST, sendo que a investigação enzimática não mostrou elevação de marcadores de necrose miocárdica. Em relação aos diagnósticos possíveis, assinale a alternativa CORRETA.

A) Síndrome de Brugada.

B) Síndrome de Wolff-Parkinson-White.

C) Fibrilação atrial aguda.

D) Flutter atrial.

281110)

Enunciado: Paciente de 59 anos, sexo masculino, chega ao ambulatório para consulta médica de rotina quando apresenta quadro súbito de inconsciência, associado a ausência de pulso e respiração. Nesse momento, recomenda-se ao profissional de saúde, chamar ajuda e realizar:

A) 15 compressões, intercaladas com 05 ventilações.

B) 15 compressões, intercaladas com 02 ventilações.

C) 90 compressões por minuto, apenas.

D) 30 compressões, intercaladas com 05 ventilações.

E) 30 compressões, intercaladas com 02 ventilações.

281119)

Enunciado: O achado ocasional ao eletrocardiograma de amplitude e forma na onda "p", em paciente jovem, chama atenção para eventuais problemas:

A) Ventrículares.

B) No ventrículo direito.

C) Na despolarização ventricular.

D) Atriais.

E) De bloqueio de ramos.

283367)

Enunciado: Paciente masculino, 65 anos, apresenta diagnóstico de hipertensão arterial há 8 anos, fazendo uso regular de enalapril e anlodipino. Há uma semana passou a apresentar queixa de palpitações e fadiga fácil, tendo sido solicitado um eletrocardiograma, que mostrou taquicardia supraventricular, FC= 135 bpm, sem sinais de isquêmica miocárdica. O exame físico do paciente é normal, exceto pela taquicardia, PA - 126X80 mmHg. Assinale dentre as alternativas abaixo, a melhor conduta neste caso:

A) Substituição da anlodipina pelo diltiazem.

B) Acréscimo da furosemida.

C) Aumento da dose do enalapril.

D) Acréscimo da espironolactona.

182678)

Enunciado: Um paciente inconsciente, não responsivo, com ausência de pulso carotídeo e com o seguinte traçado no monitor cardíaco: Qual a próxima medida terapêutica no atendimento de urgência?

A) Desfibrilação imediata com 200 joules.

B) Verificar cargas, ganhos e derivações da monitorização.

C) Pedir ajuda a outros membros da equipe de saúde e iniciar imediatamente o Suporte Básico de Vida.

D) Acesso venoso imediato e epinefrina endovenosa.

159034)

Enunciado: Paciente 67 anos, com 100 kg, hipertenso e diabético, adentra a emergência do pronto-socorro com dor torácica irradiando para mandíbula há 1 hora. Após o atendimento inicial, paciente apresentou parada cardiorrespiratória em fibrilação ventricular identificada pelo monitor cardíaco. A conduta mais adequada será utilizar:

A) O desfibrilador monofásico com carga de 200 J.

B) 100 mg de lidocaína endovenosa.

C) O desfibrilador bifásico com carga de 200 J.

D) Amiodarona 300 mg endovenosa.

50075)

Enunciado: F.A.S., masculino, 75 anos, procura o médico da Unidade Básica de Saúde referindo palpitações de início súbito na noite anterior. A ausculta cardíaca revela ritmo irregular e frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, compatível com fibrilação atrial. O paciente é hipertenso, mas fazia controle com resposta adequada da pressão arterial com o uso de hidroclorotiazida 25 mg uma vez ao dia e captopril 25 mg duas vezes ao dia. Entre as alternativas abaixo, qual o MELHOR plano de cuidado?

A) Substituir captopril por propranolol;

B) Encaminhar o paciente para a emergência a fim de que se avalie a possibilidade de cardioversão;

C) Prescrever digoxina;

D) Adotar conduta expectante, reavaliando o paciente após 7 dias.

37083)

Enunciado: A arritmia mais frequentemente encontrada em pacientes com estenose mitral é:

A) Flutter atrial.

B) Dissociação atrioventricular.

C) Fibrilação atrial.

D) Taquicardia atrial paroxística.

E) Fibrilação ventricular.

37111)

Enunciado: Assinale a alternativa correta: qual a arritmia mais comum na faixa etária pediátrica?

A) Taquicardia supraventricular.

B) Taquicardia juncional.

C) Taquicardia ventricular.

D) Bloqueio atrioventricular total.

E) Flutter atrial.

37108)

Enunciado: Na toxicidade sistêmica provocada por anestésicos locais:

A) Os bloqueadores de canal de cálcio são bem indicados.

B) A succinilcolina inibe a atividade do sistema nervoso central.

C) A lidocaina provoca inicialmente sintomas no sistema cardiovascular.

D) O sucesso da ressuscitação cardiovascular é maior com a lidocaína do que com a ropivacaina.

E) Aconselha-se evitar soluções lipídicas como o propofol.

343157)

Enunciado: A classificação de acordo com sua duração em segundos da taquicardia sustentada (TVS) ou não sustentada (TVNS), está de acordo com o seguinte item correto:

A) Se o período da arritmia for ou não superior a 90 s e/ou sem sintomas de instabilidade hemodinâmica.

B) Se o período da arritmia for ou não inferior a 30 s e/ou sem sintomas de instabilidade hemodinâmica.

C) Se o período da arritmia for ou não superior a 30 s e/ou sem sintomas de instabilidade hemodinâmica.

D) Se o período da arritmia for ou não superior a 30 s e/ou sem considerar sintomas de instabilidade hemodinâmica.

343164)

Enunciado: HMN, masculino de 57 anos, grande tabagista e obeso, analisando se ECG foi encontrado Sobrecarga Atrial Esquerda (SAE) com onda P com componente negativo aumentado (final lento e profundo) na derivação V1. Podemos indicar como correto que:

A) A área da fase negativa de pelo menos 0,09 mm/s, ou igual ou superior a 1 mm2, constitui o Índice de Morris, que apresenta melhor sensibilidade que o critério isolado de duração aumentada.

B) A área da fase negativa de pelo menos 0,04 mm/s, ou igual ou superior a 11 mm2, constitui o Índice de Morris, que apresenta melhor sensibilidade que o critério isolado de duração aumentada.

C) A área da fase negativa de pelo menos 0,04 mm/s, ou igual ou superior a 1 mm2, constitui o Índice de Morris, que apresenta pior sensibilidade que o critério isolado de duração aumentada.

D) A área da fase negativa de pelo menos 0,04 mm/s, ou igual ou superior a 1 mm2, constitui o Índice de Morris, que apresenta melhor sensibilidade que o critério isolado de duração aumentada.

343169)

Enunciado: Sobrecarga Atrial Direita (SAD), está de acordo com o seguinte item correto:

A) A onda P apresenta-se não apiculada com amplitude acima de 0,25 mV ou 2,5 mm.

B) A onda P apresenta-se apiculada com amplitude acima de 0,25 mV ou 2,5 mm.

C) A onda P apresenta-se apiculada com amplitude abaixo de 0,25 mV ou 2,5 mm.

D) A onda P apresenta-se apiculada com amplitude acima de 0,25 mV ou 3,5 mm.

313441)

Enunciado: Sobre as Arritmias em oncopediatria, assinale a alternativa incorreta.

A) Os pacientes que serão submetidos a quimioterapias potencialmente cardiotóxicas devem realizar um ECG prévio para diagnóstico, e fazer seguimento cardiológico pós-quimioterapia.

B) Os pacientes que apresentarem alterações no ECG devem realizar a monitoração eletrocardiográfica de 24 horas (Holter) e a monitoração hemodinâmica contínua durante a quimioterapia.

C) Na rotina do paciente que apresenta alterações eletrocardiográficas, deve-se incluir o ECG antes de cada novo ciclo de quimioterapia, especialmente nos casos de usuários de ATO (trióxido de arsênio).

D) Nas arritmias de QT prolongado e torsades de pointes, deve-se realizar sulfato de magnésio na dose de 50 a 85mg/Kg em 30 minutos.

279028)

Enunciado: Nas manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar de Pacientes com Diagnóstico ou Suspeita de COVID-19, está correto que.

A) Recomenda-se que tentativas de retorno do paciente para posição supina sejam executadas com o mínimo de segurança ao despronar, evitando a desconexão do ventilador e o risco de aerossolização. Se houver disponibilidade de pás adesivas do desfibrilador, deve?se colá-las em posição ântero posterior.

B) Recomenda-se que tentativas de retorno do paciente para posição supina sejam executadas com o máximo de segurança ao despronar, promovendo sempre a desconexão do ventilador e o risco de aerossolização. Se houver disponibilidade de pás adesivas do desfibrilador, deve-se colá-las em posição ântero posterior.

C) Recomenda-se que tentativas de retorno do paciente para posição supina sejam executadas com o máximo de segurança ao despronar, evitando a desconexão do ventilador e o risco de aerossolização. Se houver disponibilidade de pás adesivas do desfibrilador, deve-se colá-las em posição ântero posterior.

D) Recomenda-se que tentativas de retorno do paciente para posição supina sejam executadas com o máximo de segurança ao despronar, evitando a desconexão do ventilador e o risco de aerossolização. Se houver disponibilidade de pás adesivas do desfibrilador, nunca colá-las em posição ântero posterior.

279031)

Enunciado: A Parada Cardiorrespiratória (PCR) pode ser causada por quatro ritmos: FV, TVSP, AESP e Assistolia. A sobrevida depende da integração do SBV, do Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (SAVC) e dos cuidados pós-ressuscitação. Sendo correto que:

A) O atraso no início da administração de vasopressores para além dos primeiros 15 minutos de PCR, bem como a demora em instalar via aérea avançada, pode estar associado a pior prognóstico.

B) O atraso no início da administração de vasopressores para além dos primeiros 5 minutos de PCR, bem como a demora em instalar via aérea avançada, pode estar associado a pior prognóstico.

C) O atraso no início da administração de vasopressores para além dos primeiros 5 minutos de PCR, mas não a demora em instalar via aérea avançada, pode estar associado à pior prognóstico.

D) O atraso no início da administração de vasopressores para além dos primeiros 5 minutos de PCR, bem como a demora em instalar via aérea avançada, não pode estar associado à pior prognóstico.

278612)

Enunciado: Há uma diminuição de 6% na taxa de metabolismo cerebral de oxigênio na redução da temperatura corpórea a cada 1 °C. Indique o item com erro:

A) O uso de hipotermia atua como estimulador das vias facilitadoras da morte cerebral e da apoptose celular.

B) Existe evidência de uma diminuição dos radicais livres durante o controle da temperatura.

C) Há um bloqueio à ação intracelular da exposição às excitotoxina (acionadas pelo aumento do cálcio e do glutamato).

D) Redução da resposta inflamatória na síndrome pós-PCR.

279032)

Enunciado: Quando a monitorização com desfibrilador manual revela ritmo de FV/TVSP, assinale a alternativa correta.

A) A prioridade deve ser a desfibrilação precoce, uma vez que não aumenta o sucesso do prognóstico.

B) A prioridade deve ser a cardioversão precoce, uma vez que aumenta o sucesso do prognóstico.

C) A prioridade deve ser a desfibrilação precoce, uma vez que reduz o sucesso do prognóstico.

D) A prioridade deve ser a desfibrilação precoce, uma vez que aumenta o sucesso do prognóstico.

279033)

Enunciado: Quando da abordagem de Assistolia e Atividade Elétrica sem Pulso, podemos indicar como correto a alternativa:

A) São ritmos em que a desfibrilação está indicada. Deve-se, então, promover RCP de alta qualidade, além de aplicar as drogas indicadas e procurar identificar e tratar as causas reversíveis.

B) São ritmos em que a desfibrilação não está indicada. Deve-se, então, promover RCP de alta qualidade, além de aplicar as drogas indicadas e procurar identificar e tratar as causas reversíveis.

C) São ritmos em que a desfibrilação não está indicada. Deve-se, então, promover RCP de alta qualidade, sem aplicar as drogas indicadas e procurar identificar e tratar as causas reversíveis.

D) São ritmos em que a desfibrilação não está indicada. Deve-se, então, promover RCP de alta qualidade, além de aplicar as drogas indicadas e procurar identificar e não tratar as causas reversíveis.

278084)

Enunciado: O uso de escores de gravidade e sistemas de rastreamento e o disparo de códigos amarelos:

A) Permitem a detecção tardia de pacientes graves e podem otimizar o atendimento de eventuais PCRs.

B) Permitem a detecção precoce de pacientes graves e podem otimizar o atendimento de eventuais PCRs.

C) Permitem a detecção precoce de pacientes graves e não podem otimizar o atendimento de eventuais PCRs.

D) Não permitem a detecção precoce de pacientes graves e podem otimizar o atendimento de eventuais PCRs.

279034)

Enunciado: O racional para o uso de vasopressores durante a RCP. Assinale a alternativa que se fundamenta sendo o item correto.

A) Reduzir a pressão de perfusão coronariana, definida como a diferença entre a pressão aórtica e a pressão no átrio direito, durante a fase de relaxamento (descompressão) torácico.

B) Aumentar a pressão de perfusão coronariana, definida como a diferença entre a pressão aórtica e a pressão no átrio esquerdo, durante a fase de relaxamento (descompressão) torácico.

C) Aumentar a pressão de perfusão coronariana, definida como a diferença entre a pressão aórtica e a pressão no átrio direito, durante a fase de relaxamento (descompressão) torácico.

D) Aumentar a pressão de perfusão coronariana, definida como a diferença entre a pressão aórtica e a pressão no átrio direito, durante a fase de contração (descompressão) torácico.

249382)

Enunciado: Para que ocorra uma melhoria nas estruturas e nos sistemas de saúde, que é um dos pontos essenciais no sucesso do atendimento da Parada Cardiorrespiratória (PCR), sendo inadequado apenas:

A) Criação de um sistema integrado com treinamento de pessoas.

B) Auxílio de materiais de emergência.

C) Transportes para um atendimento unificado.

D) Disponibilidade de DEA em locais públicos com baixa movimentação de pessoas.

249385)

Enunciado: Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia ? 2019. Listamos abaixo itens referentes à cadeia de elos de sobrevivência diferenciadas no contexto de uma parada cardiorrespiratória (PCR) intra-hospitalar, determine o item que não pode ser considerado como parte da mesma:

A) RCP imediata de alta qualidade.

B) Rápida desfibrilação.

C) Suporte básico de Vida.

D) Cuidados pós-PCR.

249389)

Enunciado: A Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares inseridos nos Cuidados pós-PCR, apresenta como importante ponto o item:

A) Ênfase na avaliação neurológica, cumprimento das metas hemodinâmicas e controle térmico, com maior tolerância na variação de temperatura e prevenção de febre.

B) Ênfase na avaliação neurológica, cumprimento das metas hemodinâmicas e controle térmico, com menor variação de temperatura e prevenção de febre.

C) Ênfase na avaliação neurológica, cumprimento das metas hemodinâmicas e controle térmico, com menor variação de temperatura e sem prevenção de febre.

D) Ênfase na avaliação neurológica, sem o cumprimento das metas hemodinâmicas e controle térmico, com menor variação de temperatura e prevenção de febre.

249393)

Enunciado: A adequada abordagem de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares com ênfase nos cuidados após o retorno à circulação espontânea trouxe melhorias nos resultados, contribuído ao prognóstico dos pacientes. Podemos assim determinar como adequado que:

A) O reconhecimento precoce das causas desencadeantes, orientando a intervenção para cada cenário clínico.

B) O reconhecimento tardio das causas desencadeantes, orientando a intervenção para cada cenário clínico.

C) O reconhecimento precoce das causas desencadeantes, desorientando a intervenção para cada cenário clínico.

D) O reconhecimento precoce das causas desencadeantes, não orientando a intervenção para cada cenário clínico.

249216)

Enunciado: Assinale a alternativa incorreta:

A) Sintomas são as queixas apresentadas pelo paciente, relativas à doença. São dados subjetivos como dor de ouvido, dor de garganta, etc.

B) Consideramos os sinais as queixas subjetivas apresentadas pelo paciente, aquilo que o paciente refere e não são avaliados no exame físico.

C) Síndrome é definida como o conjunto de sinais e sintomas ligados a uma entidade mórbida que consta no quadro geral de uma doença.

D) É considerado sinal tudo que podemos avaliar no paciente através dos nossos sentidos.

249228)

Enunciado: Paciente feminina, 35 anos, sem comorbidades, admitida em leito de terapia intensiva após laparotomia exploradora por cisto de ovário roto. Após 12 horas de observação clínica, apresenta dor torácica de forte intensidade, palpitações, associada à dispneia súbita. Nega vômitos. Permanece estável hemodinamicamente, sem alterações neurológicas. Realizado eletrocardiograma abaixo. A conduta mais adequada neste caso é:

A) Amiodarona 300 mg em bolus.

B) Cardioversão elétrica.

C) Amiodarona 150 mg em bolus.

D) Metoprolol 25 mg via oral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

216246)

Enunciado: Paciente que desenvolve Insuficiência Cardíaca - IC devido à Fibrilação atrial - FA, com resposta ventricular rápida (usualmente > 150 bpm), está ADEQUADO apenas que:

A) Entidade denominada ?taquicardiomiopatia?, de prognóstico mais favorável com a correção da FA.

B) Entidade denominada ?taquicardiomiopatia?, de prognóstico menos favorável com a correção da FA.

C) Entidade não denominada ?taquicardiomiopatia?, de prognóstico mais favorável com a correção da FA.

D) Entidade denominada ?cardiomiopatia?, de prognóstico mais favorável com a correção da FA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

216263)

Enunciado: Vários estudos documentaram a efetividade do Cardiversor desfibrilador implantável - CDI em reduzir o risco de morte súbita em pacientes de alto risco (prevenção secundária) quando comparados às drogas antiarrítmicas. Sendo ADEQUADO que:

A) Os estudos de prevenção secundária contemplaram, em sua maioria, pacientes portadores de miocardiopatia de etiologia isquêmica, que foram recuperados de morte súbita ou que apresentassem TVS e pacientes com arritmias ventriculares complexas, induzidas por estimulação ventricular no estudo eletrofisiológico.

B) Os estudos de prevenção primária contemplaram, em sua maioria, pacientes portadores de miocardiopatia de etiologia isquêmica, que foram recuperados de morte súbita ou que apresentassem TVS e pacientes com arritmias ventriculares complexas, induzidas por estimulação ventricular no estudo eletrofisiológico.

C) Os estudos de prevenção secundária contemplaram, em sua maioria, pacientes portadores de miocardiopatia de etiologia isquêmica, que não foram recuperados de morte súbita ou que apresentassem TVS e pacientes com arritmias ventriculares complexas, induzidas por estimulação ventricular no estudo eletrofisiológico.

D) Os estudos de prevenção secundária contemplaram, em sua maioria, pacientes portadores de miocardiopatia de etiologia isquêmica, que foram recuperados de morte súbita ou que apresentassem TVS e pacientes com arritmias supraventriculares complexas, induzidas por estimulação ventricular no estudo eletrofisiológico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

216318)

Enunciado: Em pacientes com Insuficiência Cardíaca - IC e Fibrilação atrial - FA a opção por cardioversão elétrica de urgência só é indicada se houver deterioração hemodinâmica. Quanto à abordagem química das outras situações, podemos apenas considerar inteiramente CORRETO o item:

A) A amiodarona é eficaz para reverter quimicamente a FA para ritmo sinusal, reduzir os paroxismos de FA e ajudar na manutenção do ritmo sinusal, após a reversão espontânea ou elétrica.

B) A amiodarona não é eficaz para reverter quimicamente a FA para ritmo sinusal, reduzir os paroxismos de FA e ajudar na manutenção do ritmo sinusal, após a reversão espontânea ou elétrica.

C) A amiodarona é eficaz para reverter quimicamente a FA para ritmo sinusal, mas não para reduzir os paroxismos de FA e ajudar na manutenção do ritmo sinusal, após a reversão espontânea ou elétrica.

D) A amiodarona é eficaz para reverter quimicamente a FA para ritmo sinusal, reduzir os paroxismos de FA e ajudar na manutenção do ritmo sinusal, após a reversão espontânea, nunca para a elétrica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

216233)

Enunciado: Nos pacientes com taquicardia juncional, qual é a medida terapêutica a se adotar?

A) Resfriamento.

B) Cardioversão.

C) Atropina.

D) Amiodarona.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215530)

Enunciado: Escolha, entre as alternativas a seguir, aquela que apresenta uma droga que NÃO deve ser administrada pela cânula orotraqueal.

A) Lidocaína.

B) Atropina.

C) Bicarbonato de sódio.

D) Adrenalina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

201758)

Enunciado: Homem de 54 anos queixando-se de palpitações há 72 horas, após ingestão de bebida alcoólica, procura atendimento de urgência. Sem antecedentes de doença cardíaca. PA = 140 x 80 mmHg; FC = 168 bpm, e SatO2 = 98%. Orientado, sem outras queixas. ECG mostra fibrilação atrial. Qual a melhor conduta?

A) Amiodarona + enoxaparina + ecocardiograma transtorácico.

B) Metoprolol + enoxaparina + ecocardiograma transesofágico.

C) Propafenona + enoxaparina + ecocardiograma transesofágico.

D) Cardioversão elétrica + alta na reversão.

E) Cardioversão elétrica + enoxaparina + alta na reversão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

219902)

Enunciado: Homem de 48 anos queixa-se de fraqueza generalizada e dispneia. Ao exame físico, ausculta-se desdobramento da segunda bulha que é constante, mas aumenta quando o paciente inspira. O ritmo cardíaco é regular, a primeira bulha é normal e não há sopros. Qual das seguintes alterações eletrocardiográficas é MAIS COMPATÍVEL com os achados auscultatórios observados no paciente?

A) Bloqueio completo do ramo direito do feixe de His.

B) Elevação do segmento ST nas derivações anteriores.

C) Redução da duração do intervalo PR.

D) Repolarização precoce.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183596)

Enunciado: Os pacientes que se encontram na fase aguda de miocardite podem desenvolver tanto taquiarritmias como bradiarritmias. Estando INADEQUADO que:

A) Essas arritmias frequentemente desaparecem após a fase aguda da miocardite, sendo a terapia, habitualmente, de suporte.

B) As taquicardias supraventriculares (TSV), principalmente fibrilação e flutter atrial, podem induzir ou agravar a IC.

C) A abordagem inicial recomendada para a TSV sustentada sintomática é a restauração do ritmo sinusal através de cardioversão elétrica ou química.

D) Geralmente se recomenda terapia antiarrítmica para extrassístoles atriais e ventriculares assintomáticas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183611)

Enunciado: Os pacientes que se encontram na fase aguda de miocardite podem desenvolver anormalidades de condução que muitas vezes são transitórias, mas podem também desenvolver taquiarritmias. Quanto a isso, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Taquicardias ventriculares sustentadas assintomáticas não devem receber terapia específica.

B) As arritmias ventriculares sustentadas devem ser tratadas com drogas antiarrítmicas após a reversão elétrica aguda.

C) A opção é limitada a amiodarona.

D) Devido aos efeitos pró-arrítmicos, drogas de classe I e III (exceto a amiodarona) são geralmente evitadas nesses pacientes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182822)

Enunciado: ECG compatível com Fenômeno de Ashman (ou de Gouaux-Ashman) seria ADEQUADAMENTE descrito assim:

A) condução aberrante, que ocorre em batimento que segue imediatamente um ciclo curto após um ciclo longo, em razão da diminuição do período refratário no sistema de condução, principalmente no ramo direito do His, sendo mais frequente na FA.

B) condução aberrante, que ocorre em batimento que segue imediatamente um ciclo curto após um ciclo longo, em razão do aumento do período refratário no sistema de condução, principalmente no ramo esquerdo do His, sendo mais frequente na FA.

C) condução aberrante, que ocorre em batimento que segue imediatamente um ciclo curto após um ciclo longo, em razão do aumento do período refratário no sistema de condução, principalmente no ramo direito do His, sendo mais frequente na FA.

D) Condução aberrante, que ocorre em batimento que segue imediatamente um ciclo curto após um ciclo longo, em razão do aumento do período refratário no sistema de condução, principalmente no ramo direito do His, sendo muito raro na FA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182729)

Enunciado: Os tremores musculares podem afetar o ECG da seguinte forma:

A) Tremores musculares não podem interferir na linha de base, mimetizando alterações eletrocardiográficas como FLA e FV no paciente parkinsoniano.

B) Tremores musculares podem interferir na linha de base, mas não mimetizando alterações eletrocardiográficas como FLA e FV no paciente parkinsoniano.

C) Tremores musculares podem interferir na linha de base, mimetizando alterações eletrocardiográficas como FLA e FV no paciente com paralisia.

D) Tremores musculares podem interferir na linha de base, mimetizando alterações eletrocardiográficas como FLA e FV no paciente parkinsoniano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182732)

Enunciado: O comprometimento agudo do sistema nervoso central, pode levar aos seguintes achados no ECG:

A) ondas T negativas gigantes, simulando isquemia subepicárdica (onda T cerebral); aumento do intervalo QTc; irreversibilidade das alterações.

B) ondas T negativas gigantes, simulando isquemia subepicárdica (onda T cerebral); aumento do intervalo QTc; reversibilidade das alterações.

C) ondas T positivas gigantes, simulando isquemia subepicárdica (onda T cerebral); aumento do intervalo QTc; reversibilidade das alterações.

D) ondas T negativas gigantes, mas não simulando isquemia subepicárdica (onda T cerebral); aumento do intervalo QTc; reversibilidade das alterações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183588)

Enunciado: As alternativas abaixo apresentam causas cardíacas de síncope, EXCETO

A) lesão obstrutiva como estenose pulmonar.

B) arritmias cardíacas.

C) hipercianose.

D) DPOC.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183598)

Enunciado: Os sintomas prodrômicos de síncope neurogênica incluem, EXCETO

A) sonolência.

B) sudorese.

C) palidez.

D) náuseas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183115)

Enunciado: Assinale a alternativa CORRETA.

A) O tônus vagal excessivo é a forma mais comum de síncope autonômica.

B) A síncope reflexa resulta de aumento do tônus simpático associado a determinados eventos.

C) O tônus vagal excessivo ocorre, exclusivamente, na mudança brusca de decúbito supino para ortostático.

D) Na síncope autonômica a perda de consciência é repentina e não ultrapassa dois minutos de duração.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182746)

Enunciado: O sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA) desempenha um papel importante na fisiopatologia da IC, sendo INCORRETO apenas que:

A) A ativação do sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA) piora o remodelamento.

B) A inibição desse sistema leva à melhora da evolução dos pacientes com IC tanto em remodelamento, mas não em mortalidade.

C) DM causa ativação do SRAA, com aumento de renina, angiotensina II e aldosterona.

D) A importância do sistema adrenérgico na IC é conhecida e sua ativação piora o prognóstico dos pacientes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161170)

Enunciado: Paciente foi trazido por resgate com mal-estar geral, prostração e dispneia de inícios súbitos nesta manhã. Seu Eletrocardiograma demonstrava uma taquiarritmia que você inadequadamente indicou terapia elétrica, causando grave complicação instantânea. Felizmente após diversas manobras, foi conseguida a reversão do quadro. A complicação provocada pode ser explicada por uma das opções a seguir. Aponte-a.

A) A desfibrilação e cardioversão elétrica consistem na aplicação de corrente elétrica de alta energia para reversão de arritmias cardíacas geradas pelo mecanismo de reentrada.

B) Na desfibrilação, esta corrente elétrica é aplicada em qualquer momento do ciclo cardíaco.

C) Na cardioversão elétrica, esta corrente é sempre sincronizada com os complexos QRS do eletrocardiograma.

D) Na cardioversão elétrica, esta corrente é sempre sincronizada para que não seja administrada durante o período vulnerável da repolarização ventricular (onda T).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161176)

Enunciado: Paciente foi trazido ao Hospital por familiares com quadro de palpitação e mal-estar súbitos nesta tarde, previamente hipertenso e etilista. Seu Eletrocardiograma demonstrava uma arritmia cardíaca, que foi adequadamente tratada com choque elétrico com bons resultados. Frente a esse quadro, indique a alternativa CORRETA.

A) Nos desfibriladores externos, o choque elétrico é aplicado por intermédio das pás manuais, as quais o operador posiciona sobre o tórax, exercendo pressão de aproximadamente 3 kg.

B) No caso de flutter atrial, considera-se iniciar o procedimento com 150 J.

C) Caso o ritmo for fibrilação atrial, considera-se o uso de energia inicial de 300 J.

D) No caso de taquicardia supraventricular, considera-se iniciar o procedimento com 50 J.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161330)

Enunciado: Paciente previamente cardiopata evoluiu com súbito mal-estar seguido de perda de consciência. Foi levado ao hospital, sendo desde sua chegada iniciado processo de reanimação. Quanto ao uso e indicações de desfibrilador, podemos afirmar que existem cuidados a serem realizados durante sua utilização. Assinale a alternativa CORRETA em relação a esses cuidados.

A) Não existe necessidade de depilação quando do excesso de pelos torácicos.

B) Na presença de marcapasso definitivo, não existe maiores cuidados no uso do desfibrilados.

C) Tórax molhado: não necessita de secar por completo o tórax da vítima.

D) Vítima sobre uma poça d?água não há problema, porém se essa poça d?água também envolver o socorrista, remova a vítima para outro local, o mais rápido possível.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161185)

Enunciado: Senhora de 63 anos de idade apresentou súbito mal-estar nesta manhã, sendo imediatamente trazida por familiares ao Hospital. Apresentava intensa dispneia e palpitações, sua ausculta cardíaca demonstrava ritmo irregular. Seu ECG demonstrava taquiarritmia, sendo então decidido uso de cardioversão elétrica. Dentre as etapas a seguir referentes a esse procedimento, indique a opção INCORRETA.

A) Durante a cardioversão, deve-se acionar o botão de sincronização antes da administração de cada choque, nesta situação, geralmente, aparece um sinal gráfico no monitor confirmando a sincronização. Selecione o nível adequado de energia de acordo com a arritmia, conforme mencionado.

B) Aplique gel nas pás e posicioná-las sobre a superfície do tórax do paciente na posição adequada. Aplique uma pressão sobre as pás. Carregue o desfibrilador/cardioversor.

C) Verifique se o operador e os demais socorristas não estão mantendo contato com o paciente ou com a maca ou cama, pois existe o risco de condução da corrente elétrica para estes indivíduos, podendo causar graves complicações. Também, verifique a ausência de administração de oxigênio em alto fluxo próximo ao desfibrilador devido ao risco de formação de faíscas.

D) Aplique o choque elétrico, mantendo as pás sobre o tórax do paciente por alguns minutos, principalmente, durante a cardioversão, pois pode haver um pequeno atraso na administração do choque devido à necessidade de adequada sincronização.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161290)

Enunciado: Quando após criteriosa avaliação clínica de uma bradicardia sinusal é constatada a ausência de causas reversíveis, o implante de marca-passo definitivo é tratamento efetivo para a disfunção sinusal sintomática. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Apesar de não modificar a taxa de sobrevida, o marca-passo permite a melhora tanto dos sintomas como da qualidade de vida dessa população.

B) Portadores de doença do nó sinusal na ausência de estimulação cardíaca (ou seja, sem marca-passo) raramente evoluem com eventos sintomáticos que podem exigir tratamento imediato, tais como síncope, insuficiência cardíaca descompensada e fibrilação atrial permanente, além de taquiarritmias paroxísticas com resposta ventricular elevada.

C) O implante de marca-passo melhora significativamente a qualidade de vida dos portadores de doença do nó sinusal a partir do terceiro mês do procedimento, sem modificar a mortalidade por qualquer causa.

D) Em pelo menos metade dos pacientes com doença do nó sinusal, observam-se bradiarritmias alternando-se com taquiarritmias atriais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161337)

Enunciado: Idoso é trazido por neto ao hospital, após sentir fortes dores torácicas nesta manhã. Foi admitido na sala de emergência devido ao seu histórico de hipertenso e cardiopata. Foi monitorizado e, durante o período em que aguardava novos exames laboratoriais, perdeu os sentidos, sendo que não existia, neste momento, complexos QRS organizados no monitor. Iniciado protocolo de reanimação, que entre outros inclui terapêutica elétrica, podemos admitir que:

A) na desfibrilação deve-se utilizar a máxima energia do aparelho. Se esta orientação é desconhecida deve ser administrado choque de 200 J no caso do monofásico.

B) na desfibrilação deve-se utilizar a máxima energia do aparelho; sendo aplicada 360 J no desfibrilador monofásico e de 120 a 200 J no desfibrilador bifásico, conforme orientação do fabricante.

C) pode ser utilizado cardioversão com efetividade, caso esteja utilizando 360 J.

D) não deve ser tomada como prioritária em sua sequência de reanimação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161221)

Enunciado: A frequência cardíaca normalmente varia de 60 bpm a 100 bpm. Ritmos com Frequência Cardíaca < 60 bpm são definidos como bradicardia, podendo ser assintomática ou sintomática. As bradicardias sintomáticas têm características clínicas comuns, marcadas, sobretudo, pela síndrome do baixo fluxo, comumente ocasionadas por doença do nó sinusal. Na doença do nó sinusal, o implante de marca-passo é indicado nos casos a seguir, com EXCEÇÃO de

A) incompetência cronotrópica sintomática.

B) bradicardia sinusal sintomática, secundária ao uso de fármacos indispensáveis.

C) síncope de origem indeterminada, com evidências eletrocardiográficas de disfunção do nó sinusal documentada ou provocada no estudo eletrofisiológico.

D) disfunção do nó sinusal com frequência cardíaca < 60 bpm em vigília, sem correlação clara entre os sintomas e a bradicardia documentada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161231)

Enunciado: A doença do nó sinusal, condição em que existe disfunção do nó sinusal sintomática, é caracterizada por anormalidades da geração e da condução do estímulo sinusal, levando a ritmos com frequência cardíaca < 60 bpm, que são definidos como bradicardia. Assim, aponte a alternativa INCORRETA.

A) As bradicardias sintomáticas têm características clínicas comuns, marcadas, sobretudo, pela síndrome do baixo fluxo cerebral e/ou sistêmico, cujos sintomas mais comuns são tontura, pré-síncope, síncope, fadiga, dispneia de esforço e bradipsiquismo,
sendo comumente ocasionadas por doença do nó sinusal e bloqueio atrioventricular.

B) As sintomáticas, geralmente, são de causas fisiológicas, representadas por bradicardia sinusal e ritmos de escape da junção atrioventricular.

C) Fatores extrínsecos também podem causar bradicardia, como uso de fármacos que deprimem o sistema de condução ou distúrbios metabólicos ou endócrinos, como hipotireoidismo, hiperpotassemia e hipotermia.

D) Considerando que não há fármacos adequados para o tratamento das bradicardias sintomáticas irreversíveis, o implante de marca-passo definitivo é o tratamento mais indicado para essas afecções.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161201)

Enunciado: Em seu último plantão de emergência, você precisou utilizar um marca-passo em uma bradicardia, mas ele não estava funcionando adequadamente e você reclamou ao diretor. O diretor solicitou, então, a sua ajuda para fundamentar a necessidade de adquirir outro aparelho mais moderno para o Hospital. Assim, você o ajudou. Desse modo, aponte a alternativa CORRETA.

A) O Marca-passo Transcutâneo (MPTC) faz a estimulação cardíaca temporária, é um procedimento eletivo e tem a vantagem de ser uma técnica não invasiva e de instalação praticamente imediata.

B) O Marca-passo Transcutâneo (MPTC) é um dispositivo que pode estimular o ritmo cardíaco pelo fornecimento de corrente elétrica por eletrodos colados na pele. Há repolarização elétrica que levará à contração cardíaca.

C) A principal indicação de seu uso é em pacientes com bradicardia sintomática. Pode também ser utilizado na superestimulação para supressão de taquicardias refratárias com o intuito de eliminar Taquicardia Supraventricular (TSV) e Taquicardias Ventriculares (TV) malignas.

D) Recomendado para pacientes em PCR por assistolia, visto que trials randomizados indicaram melhora nos índices de sobrevida na admissão hospitalar, e na alta hospitalar, em pacientes submetidos à colocação do MPTC em PCR por assistolia tanto pré como intra-hospitalar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161355)

Enunciado: A terapia elétrica apresenta diversas utilidades no tratamento de patologia crônica e aguda, tanto ambulatorial como em emergências. Sobre isso, aponte a alternativa que NÃO se mostra adequada.

A) No caso de flutter atrial ou taquicardia supraventricular, considera-se iniciar o procedimento com 50 J; e se o ritmo for fibrilação atrial, considera-se o uso de energia inicial de 200 J.

B) Instabilidade de Fibrilação Atrial indica somente terapêutica elétrica.

C) Somente situações de parada cardíaca indicam terapêutica com choque.

D) Em arritmias ventriculares os aparelhos não são capazes de analisar o melhor momento dentro do ciclo cardíaco para descarregar a corrente elétrica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161205)

Enunciado: Durante procedimento eletivo com anestesia local na sala de pequenas cirurgias, ocorreu a emergência de um paciente eletivo da clínica cirúrgica. Você então foi chamado a ajudar no socorro do paciente apenas com a informação de que ele já era cardiopata em uso de digoxina e amiodarona. Na sua avaliação inicial, detectou bradicardia com grande repercussão clínica, assim indicou o uso de marca-passo transcutâneo. Referente aos passos desse procedimento, marque a opção INCORRETA:

A) Observe qual é o ponto de corte para que haja captura de algumas das espículas do MP. A partir desse ponto, deixe o valor da corrente elétrica com margem de segurança de 30% acima desse limiar.

B) Fixe as pás autoadesivas no tórax despido da vítima. Coloque o eletrodo anterior à esquerda do esterno, centralizado e o mais próximo possível do ponto de máximo do impulso cardíaco. Coloque o eletrodo posterior nas costas, diretamente atrás do
eletrodo anterior e à esquerda da coluna torácica. A alternativa a essa posição dos eletrodos é a colocação semelhante à do DEA: uma das pás deve ser posicionada na região sobre o ápice do coração e a outra sobre a região paraesternal direita.

C) Selecione inicialmente a frequência cardíaca desejada (geralmente em torno de 80 bpm, em casos de bradicardias). Em seguida, ajuste a corrente elétrica a ser administrada, aumentando gradualmente o valor de corrente elétrica a partir do valor mínimo, até que se obtenha captura elétrica. Geralmente, a captura se caracteriza pelo alargamento do complexo QRS com uma onda T larga e oposta à polaridade do QRS.

D) Avalie a resposta hemodinâmica do MP pelo pulso e pela pressão arterial. Forneça analgesia e sedação, conforme necessário.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161250)

Enunciado: A indicação mais comum para o implante de marca-passo definitivo é a doença do nó sinusal, condição em que existe disfunção do nó sinusal sintomática, caracterizada por anormalidades da geração e da condução do estímulo sinusal. A respeito das afirmações a seguir, indique aquela que é considerada INADEQUADA.

A) Existe a facilitação na passagem do estímulo do nó sinusal para o tecido atrial.

B) Ocorrem anormalidades da transmissão do impulso dentro dos átrios e para o sistema de condução cardíaco.

C) Disfunção na atividade de marca-passos subsidiários, e taquiarritmias crônicas e paroxísticas, principalmente a fibrilação atrial.

D) A etiologia da doença do nó sinusal pode ser intrínseca, que inclui processos inflamatórios, infecciosos e imunológicos, fibrose degenerativa, disfunção de canais iônicos e remodelamento do nó sinusal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161258)

Enunciado: Dados epidemiológicos a respeito da doença do nó sinusal demonstram que as seguintes afirmativas estão adequadas, com EXCEÇÃO de uma. Assinale-a.

A) A doença do nó sinusal afeta 1 a cada 600 pessoas com idade > 65 anos (média de 74 anos), somente ocorrendo em idosos.

B) Os distúrbios eletrolíticos mais comumente envolvidos são a hiperpotassemia, a hipopotassemia e a hipocalcemia.

C) Os sintomas mais comuns dos portadores de doença do nó sinusal são tonturas, vertigens, pré-síncope, síncope, palpitações, intolerância ao exercício e fadiga, geralmente intermitentes.

D) As principais manifestações eletrocardiográficas da doença do nó sinusal são bradicardia sinusal, pausas ou paradas sinusais, bloqueio sinoatrial, taquicardia atrial, fibrilação atrial e incompetência cronotrópica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161368)

Enunciado: Paciente feminina, 70 anos de idade, deu entrada desacordada no hospital trazida por corpo de bombeiros, tendo ocorrido perda de consciência após episódio de intensa dispneia, nesta tarde. Histórico de ser cardiopata com tratamento irregular. Exame físico demonstra estertores pulmonares, ritmo cardíaco irregular e taquicardíaco. Monitor cardíaco com frequência acima de 140 bpm, QRS fino, mas com distâncias variáveis. Podemos assim propor que o tratamento INDICADO deve considerar que:

A) na cardioversão elétrica, pode-se realizar o choque sequencial com um nível decrescente de energia se o primeiro choque não reverteu à arritmia, lembrando sempre de sincronizar o cardioversor antes de cada procedimento.

B) se o ritmo for fibrilação atrial, considera-se o uso de energia inicial de 200 J.

C) a corrente é sempre sincronizada com os complexos QRS do eletrocardiograma para que não seja administrada durante o período vulnerável da onda P.

D) está indicado desfibrilação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161175)

Enunciado: Bradiarritmias são graves emergências médicas potencialmente fatais. Ocorrendo a indicação do procedimento de marca-passo, assinale a alternativa ADEQUADA frente à desvantagem desta técnica.

A) O Marca-Passo Transcutâneo (MPTC) é um dispositivo que, em geral, causa desconforto e dor ao paciente, visto que correntes elétricas de 50 a 100 miliampères (mA) são necessárias. Considere analgesia e sedação do paciente.

B) A desvantagem do Marca-Passo Transcutâneo (MPTC) é a necessidade de alta energia em razão da necessidade de fazer a energia aplicada vencer a impedância transtorácica e chegar ao miocárdio. A impedância transtorácica consiste na resistência
da parede torácica ao fluxo da corrente elétrica e pode também ser influenciada pelo tamanho dos eletrodos.

C) Por ser eficaz, rápido, seguro e não invasivo é bastante útil em serviços de emergência. Porém, o Marca-Passo Transcutâneo (MPTC) é um procedimento temporário e deve ser utilizado como ponte até a colocação de um marca-passo transvenoso ou permanente, se indicados.

D) Verifique se há a opção de MPTC em seu monitor/desfibrilador/cardioversor. Lembrete: nem todos os aparelhos dispõem dessa função.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161374)

Enunciado: Idoso, 80 anos, referia intenso mal-estar de início nesta manhã com palpitação, sudorese de dispneia. Foi trazido ao pronto atendimento onde ocorreu diagnóstico eletrocardiográfico de fibrilação atrial aguda. Foi proposto tratamento elétrico com desfibrilação de vez que era emergência, porém logo após o choque inicial o paciente evoluiu em parada cardíaca. Teoricamente, podemos AFIRMAR que:

A) Isso pode ter ocorrido devido ao fato de que, na desfibrilação, a corrente elétrica é aplicada em qualquer momento do ciclo cardíaco.

B) Nessa situação a corrente foi sincronizada com os complexos QRS do eletrocardiograma para que não seja administrada durante o período vulnerável da despolarização ventricular.

C) Cardioversão pode potencialmente desencadear uma fibrilação ventricular caso associada à onda P.

D) Nessa situação a corrente foi sincronizada com os complexos QRS do eletrocardiograma para que não seja administrada durante o período refratário da despolarização ventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161326)

Enunciado: Adulto de 34 anos apresentou súbita dor torácica seguida de síncope nesta manhã. Foi socorrido e iniciado manobras de reanimação com sucesso, no sentido de retorno à circulação espontânea. Frente a essa situação, podemos AFIRMAR que:

A) somente após 24 horas podemos concluir clinicamente desfecho ruim neurológico.

B) a Pressão Arterial Sistólica inferior a 90 mmHg no pós PCR está associada a pior desfecho.

C) o período para avaliação neurológica não deve ser maior nos casos de suspeita de efeito residual de sedação.

D) existe uma meta geral para perfusão orgânica de todos os vitimados de parada cardíaca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161190)

Enunciado: Podemos considerar dentro da abordagem do paciente infartado uma grande importância da FV como mecanismo de óbito precoce. Estima-se que a desfibrilação salve cerca de seis vezes mais vidas que o tratamento trombolítico, mas depende de sua rápida aplicação ao paciente. Referente ao impacto potencial, em termos de benefício, ao se intervir na fase pré-hospitalar no IAM, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Identificar o perfil dos casos de IAM que não chegam aos hospitais, qualificando o estado atual de atendimento e quantificando o impacto de uma nova estratégia de grande difusão na população.

B) Fornecer maior informação somente a profissionais de saúde quanto aos sintomas de IAM e à importância de uma busca rápida por auxílio médico, evitando erros de conduta.

C) Realizar treinamento difuso da população para atendimento de urgência nos moldes do BLS.

D) Disponibilizar desfibriladores externos automáticos em locais públicos de grande circulação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161341)

Enunciado: De acordo com a maioria das diretrizes nacionais e internacionais atuais, ocorre a necessidade de grande conhecimento médico a respeito das terapias elétricas utilizadas em situações de emergência. Sobre isso, podemos considerar ADEQUADA a seguinte afirmativa ou negativa. Aponte-a.

A) Na cardioversão elétrica, pode-se realizar o choque sequencial com um nível crescente de energia se o primeiro choque não reverteu a arritmia.

B) Desfibrilação sempre utilizará uma corrente monofásica.

C) A posição de qual pá está em seu local; será determinante do sucesso, mesmo estando ambas nos locais adequados no tórax.

D) Desfibrilação é adequada em todos os ritmos sem pulso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161149)

Enunciado: Durante o período noturno, ocorreu algo inusitado no seu plantão, isto é, você foi chamado a avaliar um paciente que estava na observação e, ao ir até o seu leito, descobriu que ele estava em Parada Cardíaca. Você realizou os procedimentos que não foram bem sucedidos. Sobre esse caso, indique a opção INCORRETA.

A) A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é uma das situações clínicas de maior emergência na medicina. A rapidez e a eficácia das intervenções adotadas são fundamentais e interferem diretamente no prognóstico da vítima.

B) Dos adultos vítimas de parada cardíaca em ambiente intra-hospitalar, grande parte apresenta ritmo de atividade elétrica sem pulso e Assistolia como ritmo inicial de PCR.

C) Os ritmos de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso (FV/TVSP) são responsáveis por parte dos eventos de PCR em ambiente intra-hospitalar, apresentando as menores taxas de sobrevida.

D) Diversos fatores têm sido relacionados com maior sobrevida hospitalar, como o local onde acontece o evento, dias da semana quando comparados com finais de semana, eventos que acontecem no período diurno quando comparados com o período noturno, eventos presenciados, idade menor de 65 anos, presença de função normal do ventrículo esquerdo antes do evento, duração do evento, entre outros.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161159)

Enunciado: Durante esta manhã você recebeu, transferido de outro serviço de atendimento primário, um paciente grave em insuficiência respiratória por DPOC, no qual o colega adequadamente utilizou manejo de via aérea com máscara laríngea, o que levou você a elogiá-lo muito, AFIRMANDO que:

A) Embora a máscara laríngea ofereça proteção absoluta das vias aéreas contra aspiração, a frequência desta complicação é maior do que quando a ventilação é realizada com dispositivo bolsa-válvula-máscara.

B) Quando comparada com a intubação orotraqueal, a máscara laríngea oferece ventilação superior.

C) Ventilação com sucesso, entre a minoria dos casos, tem sido reportada durante a realização das manobras de RCP.

D) Para profissionais da área da saúde treinados no seu uso, a máscara laríngea é uma alternativa ao dispositivo bolsa-válvula-máscara ou à intubação orotraqueal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161167)

Enunciado: Dentro dos conceitos atuais de abordagem da parada cardiorrespiratória, a monitorização se apresenta como ferramenta clínica, sendo que o dióxido de carbono, exalado no final da expiração expressado em mmHg ? PETCO ?, detectado pela capnografia quantitativa em pacientes intubados, relaciona-se CORRETAMENTE com uma das opções seguintes. Aponte-a.

A) PETCO não tem sido correlacionado com a qualidade da RCP.

B) Durante a PCR não tratada, a produção de CO é mantida, porém não existe liberação pelos pulmões, sendo a presença de débito cardíaco a maior determinante da liberação do PETCO.

C) Os valores do PETCO têm sido correlacionados com o Retorno Circulação Espontânea, mas não com a pressão de perfusão coronária.

D) Valores < 100 mmHg revelam pouca probabilidade de Retorno Circulação Espontânea, indicando a necessidade de melhora na qualidade da RCP.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161401)

Enunciado: Idosa de 68 anos de idade procurou serviço hospitalar com queixa de mal-estar e fadigas progressivas nas últimas semanas. Dentre os exames solicitados inicialmente, foi realizado um Eletrocardiograma demonstrando padrão de baixa voltagem, o que NÃO pode ser decorrente de:

A) embolia pulmonar.

B) pericardite.

C) obesidade.

D) mamas volumosas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161172)

Enunciado: Quanto à análise do dióxido de carbono exalado no final da expiração expressado em mmHg ? PETCO ?, detectado pela capnografia quantitativa em pacientes intubados, indique a alternativa considerada INADEQUADA.

A) Evidências sugerem que, se o paciente mantiver valores baixos de PETCO por longos períodos, a despeito de condições ideais de RCP, facilmente o Retorno Circulação Espontânea (RCE) será atingido.

B) O valor baixo pode ser levado em consideração por ocasião da definição de cessação de esforços.

C) No entanto, se durante as manobras de RCP existe aumento abrupto do PETCO, é razoável considerar que houve RCE.

D) Para os pacientes que não estão intubados, ainda não existem evidências da utilidade da capnografia quantitativa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161406)

Enunciado: Diversas situações podem levar a graves arritmias cardíacas, podendo essas inclusive ser geradores de Fibrilação Ventricular como consequência. A doença descrita na síndrome de WolfParkinson White, contudo NÃO se relaciona com o seguinte dado. Assinale-o.

A) Falha no Isolamento Elétrico Ventricular.

B) Canais de Sódio defeituosos.

C) Aumento do potencial arritmogênico.

D) Feixe anômalo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161415)

Enunciado: Dentro da epidemiologia e algoritmos de avaliação do risco de fenômenos tromboembólicos da fibrilação atrial, podemos considerar INADEQUADA uma das alternativas. Aponte-a.

A) É a principal fonte emboligênica de origem cardíaca de que se tem conhecimento, representando cerca de 45% dos casos quando comparada com outras cardiopatias, como infarto do miocárdio, aneurismas ventriculares e doenças valvares.

B) As causas da formação de trombos são multifatoriais e estão relacionadas com a tríade de Virchow que inclui: (1) estase sanguínea atrial; (2) lesão endotelial; (3) aumento da trombogenicidade sanguínea, própria dessa arritmia.

C) No primeiro caso, a lenhificação do fluxo na região do Apêndice Atrial Esquerdo (AAE) favorece a estase sanguínea e a formação de coágulos de fibrina, que se acumulam e geram o trombo.

D) O cérebro, muito mais que membros e vísceras, é a região mais afetada, em cerca de 10% dos casos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161416)

Enunciado: Dentro da afirmativa de que as três condições estabelecidas por Virchow estão presentes em paciente com Fibrilação Atrial, indique a opção considerada INCORRETA.

A) Lesões do endocárdio atrial apresentavam microtrombos e que estes eram os precursores de trombos maiores. Pacientes que não apresentavam tais lesões tinham muito menor propensão à trombose atrial.

B) O atrito do sangue com o endocárdio, lesões miocitárias causadas por agressões teciduais secundárias a citocinas inflamatórias (fator de necrose tumoral, interleucina 6, proteína C-reativa e outras) prejudicam ainda mais os miócitos atriais e expõem o tecido colágeno na superfície, o que diminui a aderência de plaquetas e a deposição de fibrina, gerando o trombo. Dessa forma, a FA cria um estado pró-trombótico, hipercoagulável próprio.

C) O aumento da agregação plaquetária, mais intensa no Átrio Esquerdo (AE), e a elevação dos níveis plasmáticos do fator de Von Wilebrand.

D) Os fragmentos de protrombina e do fibrinogênio plasmático, dentre outros, confirmam essa maior trombogenicidade sanguínea, independentemente de qualquer outro fator.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161417)

Enunciado: Devido à maior propensão de pacientes com fibrilação atrial apresentarem risco, inerente à própria arritmia, de formar coágulos, independentemente de outros fatores, ocorre a necessidade de se identificar exatamente aquele de menor risco e excluí-lo da necessidade de anticoagular, por meio da inclusão de outros critérios de risco que possam caracterizá-los, ficando fora da necessidade de terapia com anticoagulante oral os pacientes com real risco baixo. Por essa razão, outras variáveis, que foram identificadas, passaram a ser valorizadas como fatores de risco, EXCETO:

A) Sexo masculino.

B) Doença vascular periférica.

C) Idade entre 64 e 75 anos.

D) Idade acima de 75 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161327)

Enunciado: Pacientes com Fibrilação Atrial apresentam um risco maior de hemorragia quando tratados com Anticoagulante Oral, tornando-se necessário não apenas avaliar o risco de tromboembolismo sistêmico, mas também de hemorragia quando o ACO for prescrito. Nas alternativas a seguir estão contidos os fatores associados a sangramento, com EXCEÇÃO de um. Indique-o.

A) Hipertensão arterial não controlada (níveis pressóricos acima de 160 mmHg).

B) Estabilidade da taxa de Razão Normalizada Internacional (RNI).

C) Uso de fármacos anti-inflamatórios.

D) Consumo de álcool.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161340)

Enunciado: Para adequadamente indicar o uso de drogas Antiarrítmicas, o que representa um papel relevante em ambas as estratégias no manejo clínico da Fibrilação Atrial, devemos entender que as drogas antiarrítmicas mais utilizadas variam de acordo com suas características clínicas, ecocardiográficas e evolução de tratamentos anteriores. Após a avaliação de um caso de FA, o paciente pode ser alocado na estratégia de controle do ritmo ou controle da frequência. A respeito disso, aponte a alternativa INCORRETA.

A) A avaliação inicial deve definir a presença de cardiopatia estrutural, assim como avaliar se a causa é reversível.

B) Episódios causados por ingestão excessiva de álcool ou crise tireotóxica, que reverteram ao ritmo sinusal espontaneamente ou após cardioversão, necessitam de tratamento com antiarrítmico por longo prazo.

C) Deve-se lembrar que as medidas não farmacológicas, como atividade física regular, dieta balanceada, controle de peso, otimização da qualidade do sono, devem ser instituídas.

D) Além disso, alguns medicamentos não antiarrítmicos apresentam importante papel na prevenção de FA como as estatinas, os

inibidores da enzima conversora da angiotensina e bloqueadores dos receptores da angiotensina I, especialmente nos pacientes que também apresentam hipertensão arterial ou IC.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161347)

Enunciado: Acerca da abordagem da arritmia, o controle da frequência na Fibrilação Atrial é uma estratégia importante para a prevenção de diversas complicações cardiovasculares, com EXCEÇÃO de

A) lesão endotelial.

B) cansaço e redução da capacidade de exercício.

C) redução da morbidade.

D) taquicardiomiopatia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161247)

Enunciado: Leia as seguintes afirmativas sobre o atendimento intra-hospitalar do paciente vítima de afogamento. I. O controle da glicemia no paciente que sofreu afogamento deve focar na prevenção da hipoglicemia ou hiperglicemia e nas rápidas flutuações no estado glicêmico. II. Crianças que sofreram afogamento e que estão comatosas e apresentam tomografia computadorizada alterada geralmente têm pior prognóstico. III. A pressão arterial deve ser continuamente monitorada. As afirmativas CORRETAS estão contidas em:

A) I, II e III.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I e III, apenas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134046)

Enunciado: Paciente deu entrada no hospital sem sinais vitais, familiares referem que ele vinha falando no carro, apesar de não conseguir deambular. Histórico de insuficiência renal em hemodiálise, mas rebelde ao tratamento. Durante as diversas manobras de reanimação cardíaca foi aventada a possibilidade do uso de bicarbonato de sódio EV no paciente. Para esse caso, indique a alternativa considerada INADEQUADA:

A) O melhor tratamento para acidose na PCR são as compressões torácicas.

B) Durante PCR a gasometria não se correlaciona com o estado tecidual.

C) Não é benéfica na hipercalemia.

D) Pode levar a aumento da geração de CO_2.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134793)

Enunciado: Quando iniciamos o tratamento de taquiarritmias de QRS estreito, devemos considerar que

A) A Adenosina deve ser feita em bolus, de vez que sua metabolização é endotelial.

B) A Lidocaína apresenta bom efeito atrial.

C) A Amiodarona em bolus apresenta-se como opção segura.

D) Sempre está indicada cardioversão química.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134053)

Enunciado: Quando da abordagem das taquiarritmias de QRS estreito, a medicação Adenosina assume importante papel, tanto diagnóstico quanto terapêutico. Porém, apresenta as seguintes contraindicações, com EXCEÇÃO do que consta em uma das alternativas. Aponte-a.

A) BAV de 2º.

B) Disfunção do nó sinusal.

C) Fibrilação atrial pré-excitada.

D) Início do quadro há mais de 12 horas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134076)

Enunciado: Qual dos antiarrítmicos listados abaixo, NÃO apresenta precisa indicação para reversão de taquiarritmias de QRS estreito?

A) Lidocaína.

B) Amiodarona.

C) Propafenona.

D) Metoprolol.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134079)

Enunciado: Podemos considerar como capazes de produzir uma morfologia de taquiarritmia de QRS largo, as seguintes condições clínicas, com EXCEÇÃO de uma alternativa. Assinale-a.

A) TSV com BRE.

B) TV.

C) Taquicardia atrial multifocal.

D) TSV com hipercalêmia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134083)

Enunciado: Paciente masculino, 54 anos de idade, deu entrada em hospital queixando-se de palpitação e algumas tonturas. Durante realização de ECG foi visto o seguinte: sequência de 3 ou mais batimentos acima de 100 bpm, que se origina abaixo do feixe de His, aspecto de TV mono mórfica. Clinicamente está estável. Diante de tal caso, indique a alternativa que NÃO pode ser considerada como adequada.

A) Amiodarona em 10 min EV.

B) Coração pode estruturalmente ser normal.

C) A estabilidade hemodinâmica não permite um tempo adicional para o diagnóstico.

D) Lidocaína atualmente tem seu uso limitado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134116)

Enunciado: Adulto de 45 anos de idade deu entrada no hospital com queixa de dor torácica intensa de início há 30 minutos. Logo a seguir, iniciou respiração em "Gasping", desaparecendo seus sinais vitais. Nas atuais condutas frente a essa emergência, qual das alternativas abaixo, mostra-se ADEQUADA?

A) Vasopressina.

B) Massagem cardíaca com no máximo 6 cm de compressão.

C) Massagem cardíaca com no mínimo 100 por minuto, sendo realizadas o máximo possível.

D) Iniciar com duas ventilações de resgate.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134860)

Enunciado: Paciente feminina de 58 anos deu entrada no Hospital se queixando de mal-estar e discreto desconforto torácico de início nessa tarde, após discussão familiar. Logo após realização de ECG apresentou síncope e dispneia, logo a seguir, seu pulso central desapareceu. Qual das afirmativas abaixo pode ser considerada INADEQUADA?

A) Primeira atitude é entubar a paciente devido à dispneia.

B) Dentro da cadeia de sobrevivência, devemos solicitar por socorro.

C) Iniciadas manobras de reanimação a sequência se dá utilizando ciclo de C-A-B.

D) Iniciadas manobras de reanimação a sequência se dá utilizando ciclos de 30 massagens e duas ventilações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134122)

Enunciado: Durante as emergências de parada cardíaca, frequentemente lidamos com a problemática da dificuldade de via de acesso para infusão de medicação. Diante desse caso, aponte a alternativa em que a afirmação a seguir seja considerada INADEQUADA.

A) As doses recomendadas para via traqueal são de 2 a 2,5 vezes maiores que as doses administradas por via IV.

B) A via traqueal pode ser utilizada para infusão de adrenalina e lidocaína.

C) Baixas concentrações plasmáticas de adrenalina, após administração endotraqueal, podem produzir efeitos beta-adrenérgicos,
resultando em vasodilatação.

D) Via traqueal é opção de escolha.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134128)

Enunciado: Desequilíbrios hidroeletrolíticos e emergências, tanto renais quanto cardíacas, apresentam grande correlação, o que muitas das vezes torna difícil a condução do tratamento. Apesar de sua frequente utilização, o Glucanato de Cálcio possui indicações específicas, das quais NÃO pode ser incluído

A) intoxicação por agentes bloqueadores dos canais de cálcio.

B) hiperpotassemia.

C) hipocalcemia.

D) rotineiramente, nas Paradas Cardíacas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134032)

Enunciado: Quando da ocorrência de graves arritmias de origem ventricular, apresenta grande importância a escolha adequada da medicação a ser utilizada para o tratamento. No caso do uso do Magnésio, podemos considerar que

A) apresenta efetiva para taquicardia ventricular polimórfica em pacientes com intervalo QT normal.

B) pode finalizar taquicardia ventricular polimórfica do tipo torção das pontas.

C) pode ser recomendado rotineiramente na RCP.

D) não apresenta atualmente uso recomendado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134340)

Enunciado: Durante manobras de reanimação cardiorrespiratória, existe a necessidade de ventilação do paciente com AMBU. Caso ocorra uma frequência respiratória elevada, ocasiona

A) Piora do retorno venoso.

B) Melhora da oxigenação.

C) Maior risco de lesão cardíaca.

D) Piora da troca gasosa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110058)

Enunciado: Com relação ao Tromboembolismo secundário à reversão da fibrilação atrial aguda, assinale a alternativa CORRETA.

A) Ocorre independente do tempo de início, porém o risco é maior após 48 horas de duração.

B) Ocorre somente após 48 horas do início do episódio.

C) Ocorre somente quando a fibrilação atrial se torna permanente, com duração maior que dois meses.

D) Ocorre em proporção semelhante, independente do tempo de duração.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109980)

Enunciado: A condição em que há MAIOR taxa de sobrevivência na parada cardiorrespiratória, fora de ambiente hospitalar, é em paciente com ritmo inicial de:

A) Assistolia com menos de dez minutos de duração.

B) Fibrilação ventricular presenciada por outras pessoas.

C) Taquicardia ventricular que evoluiu para assistolia.

D) Atividade elétrica sem pulso que evoluiu com assistolia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286702)

Enunciado: Assinale a alternativa que NÃO faz parte da doença do nó sinusal:

A) Síndrome bradicardia-taquicardia.

B) Pausa sinusal.

C) Taquicardia por reentrada nodal.

D) Bradicardia sinusal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286704)

Enunciado: Em relação a Hipertensão arterial em situações especiais, é CORRETO afirmar:

A) A pressão arterial na criança deve ser aferida em todas as consultas nas crianças acima de 3 anos.

B) A pressão arterial na criança deve ser aferida em todas as consultas nas crianças acima de 5 anos.

C) No obeso e com mais de 50cm de circunferência do braço deve-se aferir a pressão arterial com aparelho automático de punho.

D) No idoso sempre nas aferições não devo me preocupar com o hiato auscultatório.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286705)

Enunciado: A indicação de marcapasso definitivo nos bloqueios atrioventriculares são todos abaixo, EXCETO:

A) BAV do 2° grau do tipo 2 ou mobitz 2

B) BAV do 2° grau do tipo 2:1

C) BAV do 3° grau

D) BAV do 2° grau do Tipo 1 ou mobitz 1

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107648)

Enunciado: De acordo com as últimas diretrizes da American Heart Association (AHA - 2010), endossadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia na I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência, marque a alternativa CORRETA:

A) O soco precordial é recurso possivelmente útil em PCR não presenciada, na ausência de um desfibrilador.

B) A utilização do pistão mecânico durante o atendimento mostrou ser superior em termos de sobrevida quando comparado com a RCP padrão.

C) A escolha de melhor método de ventilação deve basear-se na experiência do socorrista, sendo aceitável a utilização do dispositivo de bolsa-válvula-máscara isoladamente ou em combinação com a cânula orotraqueal.

D) O dióxido de carbono exalado ao final da expiração (PETCO2) em níveis inferiores a 10 mmHg tem boa correlação com a qualidade de reanimação e com o retorno da circulação espontânea.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103807)

Enunciado: Cada uma das opções a seguir é um componente aterogênico da "síndrome metabólica", EXCETO:

A) Hiperglicemia

B) Triglicerídeos sérico elevados

C) Obesidade Abdominal

D) Lipoproteína de baixa densidade sérica >140 mg/dL

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81006)

Enunciado: Correlacione os quadros clínicos dos pacientes abaixo com as doenças do quadro seguinte, assinalando a resposta certa da correspondência: 1. M.S.F., homem, 57 anos, etilista pesado, hipertenso e diabético, com queixa de dispneia aos esforços, dispneia paroxística noturna, ortopneia e edema de membros inferiores. Ao exame encontra-se ictérico (+/4), com ritmo cardíaco regular, em 3T (B3) e fígado palpável há 3 cm do RCD, edema MMI 2+/4 IECG com sobrecarga ventricular esquerda. Radiografia de tórax com cardiomegalia.; II. A.M.S., Homem, 71 anos, tabagista pesado, etilista e hipertenso, com queixa de dispneia aos esforços e edema de membros inferiores. Ao exame encontra-se com pletora facial, com ritmo cardíaco regular, em 2T. B2 hiperfonética. MV diminuído difusamente, edema MMII 2+/4 ECG com sobrecarga atrial direta; III. F.C.A., mulher, 54 anos, tabagista, e não etilista, com queixas de dispneia aos esforços, ortopneia e edema de membros inferiores. Ao exame encontra-se ictérica (++/4), com turgência jugular a 45º, com ritmo cardíaco regular em 3T (B3) e fígado palpável há 4 cm do RCD, edema MMII 3+/4 ECG com bloqueio de ramo direito. Radiografia de tórax com cardiomegalia; IV. R.G.L., mulher, 70 anos, diabética, hipertensa, obesa, tabagista e etilista social, com queixas de dispneia aos esforços, ortopneia e edema de membros inferiores. Ao exame encontra-se com ritmo cardíaco regular em 2T, crepitantes em bases pulmonares bilateralmente, edema MMII e+/4 ECG com onda Q em parede anterior. 1. Miocardiopatia dilatada provavelmente de etiologia chagásica. 2. Miocardiopatia isquêmica. 3. Miocardiopatia dilatada provavelmente de etiologia alcoólica. 4. Cor pulmonale.

A) I-1, II-3, III-2, IV-4.

B) I-3, II-2, III-4, IV-1.

C) I-3, II-2, III-1, IV-4.

D) I-3, II-4, III-1, IV-2.

E) I-1, II-4, III-3, IV-2.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61525)

Enunciado: Residente da clínica médica, de plantão na enfermaria do hospital, é avisado pela enfermagem que um paciente está passando mal no leito. Ao chegar no quarto, o paciente não respira e está sem pulso. É solicitado o carro de parada com desfibrilador e imediatamente dá início , às compressões torácicas. Três minutos depois da chegada do médico, chega o desfibrilador (bifásico), e é conectado ao paciente. No monitor mostra fibrilação ventricular. As condutas seguintes a serem executadas são:

A) Interromper as compressões torácicas, carregar o desfibrilador até 350 J e intubar o paciente.

B) Manter as compressões torácicas, administrar epinefrina e desfibrilar usando 200 Joules.

C) Interromper as compressões torácicas, carregar o desfibrilador e desfibrilar usando 200 Joules.

D) Interromper as compressões torácicas, intubar, administrar epinefrina e desfibrilar com 360 Joules.

E) Interromper as compressões torácicas, administrar amiodarona, carregar o desfibrilador e desfibrilar três vezes usando 200 J, 200 J e 200 Joules.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49803)

Enunciado: Em paciente com Estenose Mitral, o aparecimento de fibrilação atrial aguda com alta resposta ventricular pode precipitar o aparecimento de:

A) Embolia Pulmonar;

B) BAV de 1º grau;

C) Infarto Agudo do Miocárdio;

D) Edema pulmonar;

E) Angina pectoris.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

26689)

Enunciado: Qual a causa mais rara de embolia arterial de origem cardíaca?

A) doença valvar reumática

B) Mixoma atrial

C) Cardiomiopatia dilatada

D) Aneurisma de ventrículo esquerdo

E) Fibrilação atrial

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324810)

Enunciado: Homem, 49 anos de idade, é atendido pelo SAMU em via pública após perda de consciência presenciada por transeuntes. Ao chegar ao local, os socorristas observaram ausência de movimentos respiratórios e de pulso. Foram iniciadas manobras de ressuscitação e instalado o desfibrilador externo automático, sendo indicada a necessidade de choque. Ao final do atendimento, o paciente recebeu 4 choques e evoluiu para atividade elétrica com pulso, sendo regulado para o Pronto-Socorro. Considerando o caso clinico descrito, conforme os protocolos da American Heart Association (AHA). Indique, entre os ritmos de parada cardíaca, aqueles que, necessariamente, o paciente apresentou.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324811)

Enunciado: Homem, 49 anos de idade, é atendido pelo SAMU em via pública após perda de consciência presenciada por transeuntes. Ao chegar ao local, os socorristas observaram ausência de movimentos respiratórios e de pulso. Foram iniciadas manobras de ressuscitação e instalado o desfibrilador externo automático, sendo indicada a necessidade de choque. Ao final do atendimento, o paciente recebeu 4 choques e evoluiu para atividade elétrica com pulso, sendo regulado para o Pronto-Socorro. Considerando o caso clinico descrito, conforme os protocolos da American Heart Association (AHA). Determine a etiologia mais provável para a parada cardiorrespiratória deste paciente.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

324812)

Enunciado: Homem, 49 anos de idade, é atendido pelo SAMU em via pública após perda de consciência presenciada por transeuntes. Ao chegar ao local, os socorristas observaram ausência de movimentos respiratórios e de pulso. Foram iniciadas manobras de ressuscitação e instalado o desfibrilador externo automático, sendo indicada a necessidade de choque. Ao final do atendimento, o paciente recebeu 4 choques e evoluiu para atividade elétrica com pulso, sendo regulado para o Pronto-Socorro. Considerando o caso clinico descrito, conforme os protocolos da American Heart Association (AHA). Determine os fármacos indicados, para esse paciente, durante a parada cardiorrespiratória.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

294394)

Enunciado: Mulher, 52 anos de idade, é atendida pelo SAMU após episódio de síncope, há cerca de uma hora e meia. O episódio foi precedido por mal-estar e sensação de escurecimento da visão, seguido por abalos musculares presenciados pelos familiares. De antecedentes refere diabetes mellitus em tratamento irregular. Ao exame físico, apresenta-se afebril, com FC: 34 bpm, PA: 86 x 52 mmHg, SatO?: 94%, glicemia capilar de 210 mg/dl. Ausculta cardíaca com bulhas rítmicas, bradicárdicas, em 2 tempos, sem sopros. Ausculta respiratória sem alterações. Realizado eletrocardiograma, com frequência cardíaca de 30 bpm e ondas P dissociadas dos complexos QRS. Diante do quadro clínico, indique o diagnóstico etiológico mais provável da síncope.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

294395)

Enunciado: Mulher, 52 anos de idade, é atendida pelo SAMU após episódio de síncope, há cerca de uma hora e meia. O episódio foi precedido por mal estar e sensação de escurecimento da visão, seguido por abalos musculares presenciados pelos familiares. De antecedentes refere diabetes mellitus em tratamento irregular. Ao exame físico, apresenta-se afebril, com FC: 34bpm, PA: 86x52mmHg, SatO?: 94%, glicemia capilar de 210mg/dL. Ausculta cardíaca com bulhas rítmicas, bradicárdicas, em 2 tempos, sem sopros. Ausculta respiratória sem alterações. Realizado eletrocardiograma, com frequência cardíaca de 30bpm e ondas P dissociadas dos complexos QRS. Diante do quadro clínico, Indique a droga de escolha para uso imediato nessa paciente.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

294396)

Enunciado: Mulher, 52 anos de idade, é atendida pelo SAMU após episódio de síncope, há cerca de uma hora e meia. O episódio foi precedido por mal-estar e sensação de escurecimento da visão, seguido por abalos musculares presenciados pelos familiares. De antecedentes refere diabetes mellitus em tratamento irregular. Ao exame físico, apresenta-se afebril, com FC: 34 bpm, PA: 86 x 52 mmHg, SatO?: 94%, glicemia capilar de 210 mg/dl. Ausculta cardíaca com bulhas rítmicas, bradicárdicas, em 2 tempos, sem sopros. Ausculta respiratória sem alterações. Realizado eletrocardiograma, com frequência cardíaca de 30 bpm e ondas P dissociadas dos complexos QRS. Diante do quadro clínico, indique o procedimento terapêutico específico de escolha que pode ser realizado pelo SAMU, nesse caso.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106584)

Enunciado: Paciente, portador de DPOC, evoluindo há cerca de uma semana com tosse produtiva e dispneia, deu entrada no Pronto Atendimento do hospital com quadro de insuficiência respiratória. Durante o atendimento o paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória. O ritmo no monitor cardíaco mostra um QRS alargado com frequência de 54 bpm. O paciente não tem pulso central. Diante do caso apresentado, indentifique os principais ritmos definidores de PCR.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106585)

Enunciado: Paciente, portador de DPOC, evoluindo há cerca de uma semana com tosse produtiva e dispneia, deu entrada no pronto atendimento do hospital com quadro de insuficiência respiratória. Durante o atendimento, o paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória. O ritmo no monitor cardíaco mostra um QRS alargado com frequência de 54 bpm. O paciente não tem pulso central. Diante do caso apresentado, identifique o ritmo da PCR desse paciente:

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106541)

Enunciado: Paciente, portador de DPOC, evoluindo há cerca de uma semana com tosse produtiva e dispneia, deu entrada no Pronto Atendimento do hospital com quadro de insuficiência respiratória. Durante o atendimento o paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória. O ritmo no monitor cardíaco mostra um QRS alargado com frequência de 54 bpm. O paciente não tem pulso central. Diante do caso apresentado indentifique o tratamento para essa situação a partir do ritmo da PCR desse paciente.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49365)

Enunciado: Homem, 52 anos de idade, internado para tratamento de infarto agudo do miocárdio, apresentou fibrilação ventricular na UTI, sendo prontamente assistido. Após três minutos de massagens torácicas externas, foi submetido à desfibrilação elétrica, com retorno à circulação espontânea, após o primeiro choque. A próxima medida é fazer:

A) atropina 1 mg, EV.

B) amiodarona 150 mg, EV.

C) bicarbonato de sódio a 8,4%, EV ? 1 ml/kg de peso.

D) sulfato de magnésio 2 g, EV.

E) vasopressina 40 U, EV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35000)

Enunciado: O eletrocardiograma (VER IMAGEM) é de um paciente, 70 anos de idade, sexo masculino, que apresenta dor torácica típica há cinco horas. O médico que o atendia obteve outras informações adicionais, como paciente diabético há 10 anos, hipertenso há 5 anos, tabagista de 20 cigarros/dia por 30 anos. Tem peso estimado em torno de 60 kg. Dados vitais na admissão mostravam PA: 90 x 50 mmHg, pulso: 110 bpm, FR: 24 inc/min; mucosas coradas. Cabeça e pescoço: percebe-se estase jugular a 45°. Tórax: pulmões com MV rude bem distribuído, estertores crepitantes em terço inferior de ambos os hemitóraces. ACV: B1 e B2 normais. B3+ em FM, SS grau II/VI em FM, irradia para axila. Abdome: sem alterações. O ECG (VER IMAGEM) mostra a evolução do paciente após seis horas da admissão, durante episódio de instabilidade hemodinâmica. Nessa situação, é CORRETO afirmar:

A) Trata-se de arritmia de reperfusão (taquicardia ventricular sustentada) após trombólise, não exigindo drogas antiarrítmicas ou
desfibrilação, será muito frequente a reversão espontânea.

B) Trata-se de taquicardia ventricular não sustentada (D2 longo), devendo ser tratada com amiodarona ataque de 5 mg/kg a 10 mg/kg e
solução venosa de manutenção 900 mg/dia.

C) O paciente evoluiu com taquicardia ventricular e deve ser tratado com desfibrilação elétrica imediata, seguido de amiodarona venosa
contínua (ataque e manutenção).

D) Trata-se de ritmo idioventricular acelerado, frequentemente atribuído à reperfusão química ou mecânica da artéria coronária, e o
tratamento deve ser conservador inicialmente.

E) Trata-se de ritmo de flutter ventricular e deve ser tratado da mesma forma que a taquicardia ventricular, sem categorizar maior risco de morte.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

11133)

Enunciado: O uso de desfibrilador externo automático, DEA, tem sido preconizado como elemento fundamental dos cuidados referentes ao suporte básico de vida, na parada cardiorrespiratória, PCR. Esse uso encontra respaldo na seguinte assertiva:

A) o DEA aplica choques que revertem precocemente a assistolia.

B) o uso de DEA pode ser feito mesmo por pessoal não treinado.

C) o acesso ao DEA, até o quinto minuto, modifica o prognóstico da PCR.

D) após uso eficaz do DEA, as manobras de compressão torácica/ventilação são dispensáveis.

E) o DEA é mais barato que as outras medidas de reanimação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13296)

Enunciado: Mulher, 73 anos de idade, com hipercolesterolemia, apresentou síncope de duração de 5 minutos em domicílio. Filha nega o uso de medicações, exceto sinvastatina e colírio para glaucoma. Esteve no cardiologista há 3 meses, que não recomendou novas medidas. Foi trazida ao PA onde se apresenta confusa, com pulso radial de 36 bpm, com pausas à inspiração. TA: 120 x 60 mmHg, FR: 20 ipm. Mucosas coradas, sem sinais neurológicos de localização ou de irritação meníngea. Pulmões limpos. Ausculta cardíaca mostra bulhas arrítmicas à custa de pausas, que duram até 30 segundos, além de sopro sistólico suave em foco aórtico. A melhor conduta imediata é:

A) fazer atropina EV

B) fazer manitol EV

C) instalar marca-passo transitório

D) instalar noradrenalina EV

E) fazer adrenalina EV

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13297)

Enunciado: Mulher, 73 anos de idade, com hipercolesterolemia, apresentou síncope de duração de 5 minutos em domicílio. Filha nega o uso de medicações, exceto sinvastatina e colírio para glaucoma. Esteve no cardiologista há 3 meses, que não recomendou novas medidas. Foi trazida ao PA onde se apresenta confusa, com pulso radial de 36 bpm, com pausas à inspiração. TA: 120 x 60 mmHg, FR: 20 ipm. Mucosas coradas, sem sinais neurológicos de localização ou de irritação meníngea. Pulmões limpos. Ausculta cardíaca mostra bulhas arrítmicas à custa de pausas, que duram até 30 segundos, além de sopro sistólico suave em foco aórtico. O ECG dessa paciente revela presença de onda P em D2, com intervalo PR de 0,13 segundos, períodos de pausa não precedidos de onda P, não múltiplos do intervalo RR, com duração de até 50 segundos e QRS com morfologia normal e eixo de 30 graus. Esses achados são compatíveis com:

A) bloqueio AV de segundo grau, mobitz tipo II

B) bloqueio AV de primeiro grau

C) bloqueio AV total

D) marca-passo migratório

E) bradicardia sinusal com parada sinusal

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13298)

Enunciado: Mulher, 73 anos de idade, com hipercolesterolemia, apresentou síncope de duração de 5 minutos em domicílio. Filha nega uso de medicações, exceto sinvastatina e colírio para glaucoma. Esteve no cardiologista há 3 meses, que não recomendou novas medidas. Foi trazida ao PA onde se apresenta confusa, com pulso radial de 36 bpm, com pausas à inspiração. TA: 120x60mmHg, FR: 20ipm. Mucosas coradas, sem sinais neurológicos de localização ou de irritação meníngea. Pulmões limpos. Ausculta cardíaca mostra bulhas arrítmicas à custa de pausas, que duram até 30 segundos, além de sopro sistólico suave em foco aórtico.

A causa mais provável desse quadro é:

A) intoxicação medicamentosa

B) infarto agudo do miocárdio

C) hipertensão intracraniana

D) AVC hemorrágico

E) estenose aórtica

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

11136)

Enunciado: A alteração eletrocardiográfica mais precoce no paciente renal crônico com hipercalemia é:

A) bloqueio AV de primeiro grau

B) onda P aplainada

C) onda T apiculada

D) alteração de segmento ST

E) alargamento do complexo QRS

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

18042)

Enunciado: Algumas medicações têm sido retiradas do mercado pelas agências reguladoras, em virtude de efeitos cardíacos adversos. Muitos desses efeitos decorrem de alterações eletrofisiológicas que se traduzem no eletrocardiograma, através dos QT e QTc, e que conduzem a arritmia e morte. Essas alterações são observadas por:

A) redução no tempo de duração da onda Q e na sua amplitude, levando à fribilação ventricular.

B) aumento no intervalo entre a onda Q e a onda T e na correlação entre a amplitude de Q e de T, levando à taquicardia supraventricular.

C) aumento no segmento entre o início da onda Q e o fim da onda T, e na correção desse intervalo pela frequência cardíaca, levando à torsade de pointes.

D) aumento no intervalo entre a onda Q e o início da onda T e na correlação entre a amplitude de Q e de T, levando à torsade de pointes.

E) aumento no segmento entre o início da onda Q e o fim da onda T e na correlação entre a amplitude de Q e de T, levando à fibrilação ventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

18050)

Enunciado: Paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda, em observação monitorizada no pronto atendimento, apresenta síncope, sem responsividade, presenciada pela enfermeira , há cerca de 2 minutos. O monitor de ECG mostra linha isoelétrica. Após as vias aéreas serem abertas com reposicionamento da cabeça, o médico verifica que o paciente não respira. Há um dispositivo bolsa-máscara disponível e um desfibrilador não automático. A sequência de condutas a ser adotada, de acordo com os protocolos padrões de reanimação, é:

A) insuflar vias aéreas 2 vezes com dispositivo bolsa-máscara, checar pulso. Se ausente, iniciar compressões torácicas e ventilação no ritmo 30/2, checando pulso e ritmo cardíaco após 2 minutos.

B) insuflar vias aéreas 2 vezes com dispositivo bolsa-máscara, checar pulso. Se ausente, pedir desfibrilador, aplicar um choque com 360 joules e checar pulso e ritmo.

C) pedir desfibrilador, imediatamente aplicar um choque com 360 joules e checar pulso e ritmo.

D) insuflar vias aéreas 2 vezes com dispositivo bolsa-máscara, checar pulso. Se ausente, iniciar compressões torácicas e ventilação no ritmo 30/2, até que o desfibrilador esteja pronto. Aplicar, assim que disponível, um choque com 360 joules e checar pulso e ritmo.

E) insuflar vias aéreas 2 vezes com dispositivo bolsa-máscara, checar pulso. Se ausente, iniciar compressões torácicas e ventilação no ritmo 15/1, com a enfermeira, até que o desfibrilador esteja pronto. Aplicar, assim que disponível, um choque com 360 joules e checar pulso e ritmo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343338)

Enunciado: HMN, masculino de 57 anos, grande tabagista e obeso, analisando se ECG foi encontrado Sobrecarga Atrial Esquerda (SAE) com onda P com componente negativo aumentado (final lento e profundo) na derivação V1. Podemos indicar como correto que:

A) A área da fase negativa de pelo menos 0,09 mm/s, ou igual ou superior a 1 mm2, constitui o Índice de Morris, que apresenta melhor sensibilidade que o critério isolado de duração aumentada.

B) A área da fase negativa de pelo menos 0,04 mm/s, ou igual ou superior a 11 mm2, constitui o Índice de Morris, que apresenta melhor sensibilidade que o critério isolado de duração aumentada.

C) A área da fase negativa de pelo menos 0,04 mm/s, ou igual ou superior a 1 mm2, constitui o Índice de Morris, que apresenta pior sensibilidade que o critério isolado de duração aumentada.

D) A área da fase negativa de pelo menos 0,04 mm/s, ou igual ou superior a 1 mm2, constitui o Índice de Morris, que apresenta melhor sensibilidade que o critério isolado de duração aumentada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343343)

Enunciado: Sobrecarga Atrial Direita (SAD), está de acordo com o seguinte item correto:

A) A onda P apresenta-se não apiculada com amplitude acima de 0,25 mV ou 2,5 mm.

B) A onda P apresenta-se apiculada com amplitude acima de 0,25 mV ou 2,5 mm.

C) A onda P apresenta-se apiculada com amplitude abaixo de 0,25 mV ou 2,5 mm.

D) A onda P apresenta-se apiculada com amplitude acima de 0,25 mV ou 3,5 mm.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249970)

Enunciado: Infelizmente os dados na literatura quanto à incidência de PCR no Brasil são escassos. Podemos entretendo indicar que ocorre erro no item:

A) O principal ritmo de PCR em ambiente extra-hospitalar não é a Fibrilação Ventricular (FV) e sim a Taquicardia Ventricular (TV).

B) A Fibrilação Ventricular (FV) e a Taquicardia Ventricular (TV), juntas chegando a quase 80% dos eventos.

C) A Fibrilação Ventricular (FV) e a Taquicardia Ventricular (TV) apresentam um bom índice de sucesso na reversão, se prontamente tratados.

D) Quando a desfibrilação é realizada precocemente, em até 3 a 5 minutos do início da PCR, a taxa de sobrevida é em torno de 50% a 70%.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215593)

Enunciado: As crianças que recebem assistência ventilatória domiciliar devem ter sempre disponíveis os seguintes materiais, EXCETO:

A) Oxigênio suplementar.

B) Monitor de eletrocardiograma.

C) Bolsa autoinflável e máscara.

D) Oxímetro de pulso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215568)

Enunciado: Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao suporte ventilatório em portadores de insuficiência respiratória crônica.

A) As necessidades do indivíduo, além da estrutura domiciliar e do seguimento pela equipe de saúde, devem ser levadas em conta no momento da decisão sobre a modalidade ventilatória a ser utilizada.

B) As falhas repetidas de extubação traqueal ou da retirada de suporte não invasivo precedem à decisão pela desospitalização ainda em uso desse suporte.

C) O processo de suporte ventilatório domiciliar tem início no momento da alta do paciente.

D) Antes da hospitalização é realizada a transição para o ventilador de uso domiciliar, com determinação das demandas específicas de cada indivíduo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181186)

Enunciado: Dos exames relacionados abaixo, qual não deve ser realizado de rotina no paciente afogado?

A) Medida da pressão arterial.

B) Eletroencefalograma.

C) Controle do sensório.

D) Gasometria.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181192)

Enunciado: Assinale a alternativa INCORRETA:

A) A lesão cerebral primária no paciente vítima de afogamento ocorre durante a submersão, enquanto a secundária resulta de fatores como hipotensão, febre ou crises convulsivas.

B) O diagnóstico de pneumonia é feito, muitas vezes, de forma equivocada por exames de radiografia, solicitados no início do quadro, em decorrência da presença de opacificações que correspondem à água nos pulmões.

C) Afogamentos em piscina têm alto potencial de desenvolver infecção pulmonar precoce.

D) Antes de tomar a decisão de iniciar antibióticoterapia no paciente afogado, recomenda-se observar o paciente clinicamente por meio da presença de febre, leucocitose, novos infiltrados pulmonares na radiografia e exames de culturas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181195)

Enunciado: São medidas de prevenção de afogamento todas as abaixo, EXCETO:

A) Sempre valorizar a sua capacidade de nadar, evitando o uso de coletes que possam dificultar o seu deslocamento durante a prática de esportes náuticos.

B) Sempre supervisionar crianças pequenas.

C) Investir em equipamentos de proteção ? redes, grades, alarmes.

D) Ensinar lições de natação a partir de um ano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181147)

Enunciado: Em relação ao afogamento, assinale a alternativa correta:

A) Em áreas com salva-vidas os afogamentos são mais graves pela confiança que as pessoas tem de avançar em áreas mais profundas.

B) Pessoas sem treinamento devem tentar atendimento ao afogado dentro da água.

C) Compressões torácicas devem ser realizadas apenas em terra.

D) Imobilizações cervicais devem ser feitas de rotina em pacientes afogados.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157591)

Enunciado: Foi atendido, nesta tarde, um paciente com arritmia cardíaca. Sendo diagnosticado Fibrilação Atrial, foi indicado anticoagulação oral para profilaxia. Dentre as condutas a seguir, aponte aquela que é considerada INADEQUADA frente a esse caso.

A) Devido à maior propensão de pacientes com FA de apresentarem risco inerente à própria arritmia de formar coágulos, independentemente de outros fatores.

B) O sucesso do tratamento anticoagulante está muito mais influenciado pela educação do paciente e familiares e cuidadores, do que pela escolha do ACO em si.

C) Os pacientes que estão em uso de antagonistas da vitamina K necessitam de controles laboratoriais periódicos, devendo ser feito o reajuste da dose de acordo com o valor estabelecido do RNI padrão, que é oscilar entre 2,0 e 3,0 a cada aferição, pelo menos diário ambulatoriamente.

D) Em pacientes em uso dos novos anticoagulantes orais, antes de prescrever um NACO ao paciente com FA, a função renal deve ser avaliada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157745)

Enunciado: Entre as complicações da hipotermia terapêutica, pode ser citada a

A) hiperglicemia.

B) hipercalcemia.

C) taquicardia.

D) plaquetose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157704)

Enunciado: A epidemiologia possui dificuldade em avaliar a verdadeira incidência de arritmias em crianças. É possível que muitas alterações permaneçam sem identificação, pois vários sintomas são vagos e inespecíficos. Por esse motivo, é importante conhecer a epidemiologia, o que pode facilitar seu reconhecimento em cada faixa etária. Sobre esse caso, assinale a alternativa considerada INCORRETA.

A) Em crianças com corações normais, a incidência e o mecanismo das arritmias variam de acordo com idade, sexo e etnia.

B) As vias acessórias e os focos atriais ectópicos são mecanismos mais frequentes em crianças pequenas.

C) A reentrada Atrioventricular (AV) ganha importância nos adolescentes, especialmente do sexo Masculino.

D) As vias acessórias, os focos atriais ectópicos e a reentrada Atrioventricular (AV) representam os mecanismos da maioria das taquiarritmias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157732)

Enunciado: É difícil avaliar arritmias em crianças, sendo necessários muitos conhecimentos de epidemiologia para avaliar corretamente uma situação. Acerca desse assunto, aponte a alternativa INCORRETA.

A) As arritmias ventriculares são raras em crianças.

B) As bradiarritmias são comuns em crianças.

C) As bradiarritmias têm como mecanismos mais comuns a depressão da função de marca-passo do nó sinusal e os bloqueios do sistema de condução.

D) Causas de bradicardia em crianças incluem estimulação vagal, hipoxemia, acidose e elevação da pressão intracraniana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157743)

Enunciado: Qual dos fármacos listados abaixo apresenta atividade de reversão para arritmias supraventriculares e ventriculares complexas?

A) Adenosina.

B) Digital.

C) Amiodarona.

D) Lidocaína.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157714)

Enunciado: Paciente deu entrada com palpitações no Hospital e, logo a seguir, evoluiu com perda da consciência. Foi levado à sala de emergência e realizado monitorização cardíaca, que demonstrou uma arritmia. Sobre o caso, aponte a alternativa CORRETA.

A) Na situação de desfibrilação, utilizada em situações de parada cardiorrespiratória, os choques sucessivos devem ser intercalados por 2 minutos de ressuscitação cardiopulmonar.

B) Na cardioversão elétrica, pode-se realizar o choque sequencial com um nível crescente de energia se o primeiro choque não reverteu a arritmia, não tendo preocupação quanto à sincronização dos choques.

C) Na desfibrilação, deve-se utilizar a máxima energia do aparelho; sendo aplicado 360 J, independe da formatação onda do aparelho.

D) Caso o ritmo for fibrilação atrial, considera-se o uso de energia inicial de 200 J.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157729)

Enunciado: A desfibrilação e a cardioversão elétrica consistem na aplicação de corrente elétrica de alta energia para reversão de arritmias cardíacas geradas pelo mecanismo de reentrada, apresentando diversas indicações nas mais diversas arritmias cardíacas. Frente ao caso, assinale a alternativa considerada INADEQUADA.

A) Na cardioversão elétrica, esta corrente é sempre sincronizada com os complexos QRS do eletrocardiograma para que não seja
administrada durante o período vulnerável da repolarização ventricular.

B) Nos monofásicos, toda a energia elétrica selecionada é aplicada em um único sentido vetorial.

C) No formato de onda bifásica, parte da corrente é administrada em um sentido, e a outra parte no sentido inverso por inversão de polaridade.

D) O operador posiciona sobre o tórax, exercendo pressão de aproximadamente 23 kg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157659)

Enunciado: Paciente procura hospital com queixa de intensa palpitação e mal-estar. Seu ECG demonstra arritmia. Qual das alternativas abaixo se refere a antiarrítmico de ação apenas supraventricular?

A) Amiodarona.

B) Lidocaína.

C) Deslanodio.

D) Adenosina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157688)

Enunciado: Paciente referindo, inicialmente, mal-estar. Ao dar entrada no Pronto-socorro, perde a consciência, sendo então trazido à sala de emergência. No monitor cardíaco é demonstrado um padrão de arritmia cardíaca que permite escalonamento progressivo do tratamento elétrico. Qual das situações abaixo listadas corresponde a essa possibilidade?

A) Fibrilação Atrial.

B) Taquicardia Ventricular sustentada sem pulso.

C) Fibrilação Ventricular.

D) Torsade de Pointes sem pulso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157723)

Enunciado: Paciente procurou serviço médico com quadro de tonturas que foram piorando nos últimos dias. Como em sua ausculta cardíaca foi constatado ritmo cardíaco irregular, foi feito o ECG que demonstrou bradiarritmia. Acerca desse caso, marque a opção CORRETA:

A) Bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo I eletrocardiograficamente caracteriza-se pelo aumento progressivo do intervalo PR, acarretando em uma onda P ?bloqueada?, ou isolada, gerando uma pausa no traçado do ECG e se relaciona com situações em que há aumento importante do tônus vagal.

B) Bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo II é considerado de menor gravidade que o do tipo I. Pode localizar-se dentro do feixe de His, sendo o QRS estreito nestes casos. Quando está localizado abaixo do feixe de His, o QRS é largo.

C) A presença do BAV de segundo grau tipo II indica doença do sistema His-Purkinje, sendo o paciente assintomático. Não indica intervenção.

D) Quando o BAV é acompanhado por bloqueio de ramo, como bloqueio de ramo direito ou esquerdo, a possibilidade de ser uma lesão no sistema His-Purkinje é menor.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157734)

Enunciado: A atropina apresentou diminuição de suas indicações nos últimos protocolos de reanimação, porém ainda apresenta diversas indicações em outras situações de emergências cardiovasculares. Sobre o caso, indique a alternativa considerada ADEQUADA.

A) Atropina é a droga de escolha para bradicardia sintomática aguda na ausência de causas reversíveis.

B) Podemos utilizar atropina na presença de síndrome coronariana aguda sem maiores riscos.

C) A atropina será eficaz em pacientes que se submeteram a transplante cardíaco.

D) A administração de atropina pode ser utilizada para retardar a aplicação de um marca-passo transcutâneo nos pacientes com baixa perfusão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157739)

Enunciado: Paciente deu entrada no hospital com mal-estar, palpitação e alguma tontura, sua pressão era de 110 x 60 mmHg e seu ritmo cardíaco acelerado e irregular. Seu ECG demonstrou arritmia sem critério para cardioversão elétrica, sendo indicado tratamento químico. Para essa situação, indique a alternativa considerada INADEQUADA.

A) Verapamil e diltiazem mostraram-se efetivos em reversão para ritmo sinusal em taquicardias supraventriculares.

B) Adenosina é uma droga que diminui a condução pelo NAV e que promove vasodilatação coronária. Possui meia-vida longa de de 5 a 10 minutos.

C) Adenosina poderá causar, no paciente, pressão torácica importante com sensação de ?morte iminente?, porém tais efeitos são transitórios.

D) Para pacientes com disfunção ventricular sistólica, a amiodarona e a digoxina são as drogas mais utilizadas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134686)

Enunciado: A recomendação atual, referente ao protocolo de reanimação cardiorrespiratória, dá ênfase à qualidade das massagens cardíacas. Dentre as recomendações atuais, não se deve apoiar por sobre o tórax no retorno do tórax após a compressão torácica. Não sendo essa recomendação decorrente:

A) da piora do desfecho da massagem cardíaca.

B) da piora do retorno venoso.

C) de dificultar a ventilação.

D) da piora da pressão de perfusão coronariana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134684)

Enunciado: Dentro do uso de medicações antiarrítmicas, qual das listadas abaixo possui a capacidade de atuação tanto em arritmias supraventriculares, quanto ventriculares, sendo clinicamente indicadas para tal?

A) Propafenona.

B) Lidocaína.

C) Amiodarona.

D) Adenosina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134700)

Enunciado: A Amiodarona apresenta potencialmente diversos efeitos colaterais, isso tanto em nível cardíaco, quanto fora do sistema cardiovascular. Podemos apontar como potenciais efeitos colaterais da Amiodarona, a:

A) Fibrose pulmonar.

B) Taquicardia.

C) Descompensação da glicemia.

D) Perversão visual tipo xantocromia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

139777)

Enunciado: Jovem, 24 anos de idade, apresentou dificuldade respiratória súbita, que se iniciou em seu domicílio, sendo, posteriormente, trazido do trabalho por colegas ao hospital, já sem sinais vitais. Por isso, foi iniciado manobras de massagem cardíaca, ventilação e adrenalina. Massagem iniciou as manobras, com uma frequência mínima de 100 por minutos, aprofundando o tórax o máximo possível, mas permitindo seu retorno completo sem se apoiar sobre ele. Ao avaliar a qualidade das manobras, é sugerido que se modifique a conduta utilizada, segundo as recentes diretrizes de emergência, e, ao modificá-la,

A) mantenha, no mínimo, essa frequência de massagem.

B) mantenha, no máximo, essa frequência de massagem.

C) comprima, no máximo, o tórax por 6 cm.

D) comprima, no mínimo, o tórax por 2 polegadas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

139785)

Enunciado: Idosa, 87 anos de idade, apresentou dificuldade respiratória súbita, que se iniciou em seu domicílio, sendo, então, trazida de casa por familiares ao hospital, já sem sinais vitais. Por isso, foi iniciado manobras de massagem cardíaca, ventilação e adrenalina. Massagem iniciou as manobras, com uma frequência mínima de 120 por minutos, aprofundando o tórax o máximo possível, mas permitindo seu retorno completo sem se apoiar sobre ele. Ao avaliar a qualidade das manobras, é sugerido que se modifique a conduta utilizada, segundo as recentes diretrizes de emergência, e, aomodificá-la, alega-se que:

A) foi perdido o adequado tempo de massagem.

B) foi perdida a eficácia da massagem cardíaca.

C) foi muito lenta a massagem cardíaca.

D) podemos nos apoiar no tórax.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111837)

Enunciado: Idoso de 60 anos de idade apresenta dor torácica e por isso procura atendimento médico. Enquanto realizava Eletrocardiograma, perdeu os sentidos e você iniciou as manobras de reanimação. Porém, um membro de sua equipe se mostrava muito ansioso e não conseguia manter a ventilação de maneira adequada, mantendo uma frequência de 20 por minuto (após manejo de via aérea definitivo). Você, então, explica que:

A) já ocorreu hiperoxia e não precisa mais ventilar.

B) isso está adequado.

C) piora a pressão torácica.

D) não faz diferença porque está entubado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

350882)

Enunciado: Especialistas recomendam que várias ?camadas de proteção? sejam usadas para prevenção de afogamentos, pois raramente são causados por um único fator. Das ações de prevenção elencadas abaixo qual tem o potencial isoladamente de prevenir mais de 50% dos afogamentos em crianças?

A) Dispositivos de flutuação pessoal tipo boias de braços.

B) Cercas de proteção com pelo menos de 1,5 m de altura.

C) Aulas de natação para crianças menores de 4 anos.

D) Supervisão, principalmente, aos maiores de 5 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321298)

Enunciado: Homem, 67 anos, tabagista, hipertenso e dislipidêmico, procurou pronto-atendimento por mal-estar, palpitações e dispneia. Refere episódios prévios autolimitados, com duração de 5 minutos. Paciente acordado, porém letárgico. PA 90x50 mmhg, SpO? 95%. Realizou o seguinte ECG, na triagem: Assinale a conduta adequada no momento.

A) Manobra vagal e diltiazem endovenoso; evitar betabloqueadores pelo risco de DPOC.

B) Desfibrilação elétrica sem necessidade de anticoagulação devido risco iminente de morte.

C) Cardioversão elétrica imediata e anticoagulação para prevenção de fenômenos tromboembólicos.

D) Solução cristaloide endovenosa para estabilização hemodinâmica e investigação de hipertireoidismo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321313)

Enunciado: Paciente de 26 anos, sexo masculino, acompanhado por esquizofrenia é atendido na emergência por importante agitação. Foi realizada contenção física e administrado 10mg de haloperidol. Após 30 minutos, paciente está torporoso, pouco responsivo, com pressão arterial de 60x30mmHg, taquicárdico com pulso filiforme, saturação periférica de O2 de 95%. Ainda não há exames laboratoriais disponíveis. Eletrocardiograma realizado foi o seguinte: Qual a melhor conduta a ser adotada?

A) Infusão de sulfato de magnésio.

B) Infusão de cloreto de potássio.

C) Imediata cardioversão elétrica.

D) Imediata desfibrilação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292822)

Enunciado: Homem, 70 anos, procura atendimento médico em Unidade Básica de Saúde devido a episódio de fraqueza em hemicorpo à direita e dificuldade na fala, durante 1 hora, que aconteceram há duas semanas. Paciente procurou, naquela ocasião, emergência médica onde fez tomografia de crânio e doppler de carótidas e vertebrais com laudos normais, exames de sangue que não mostraram alterações, e eletrocardiograma que mostrou fibrilação atrial. Paciente optou por não permanecer internado, saiu do hospital sem nenhuma prescrição médica e veio à consulta hoje, devido ao "medo de sentir novamente os sintomas" e querendo saber qual o melhor tratamento que deve fazer para evitar essa recorrência. Tem antecedente de febre reumática com necessidade de troca valvar (válvula metálica) há 5 anos, mas vinha em uso irregular de suas medicações. No momento está sem utilizar nenhuma. Pulso: 80bpm, PA:120x80mmHg. Exame neurológico sem alterações. Qual medicação está indicada para a profilaxia secundária, nesse paciente?

A) Ácido acetil salicílico.

B) Clopidogrel.

C) Apixabana.

D) Varfarina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292823)

Enunciado: Mulher, 56 anos, hipertensa e diabética chegou na emergência referindo palpitação e taquicardia há 3 dias. Refere episódios semelhantes, esporadicamente, que costumam melhorar espontaneamente, porém o episódio atual não melhorou, procurando então a emergência. Chegou com pressão arterial = 120 x 80 mmHg, frequência cardíaca = 140 batimentos por minuto e o eletrocardiograma está apresentado abaixo. Qual é a melhor conduta para essa paciente?

A) Cloridrato de amiodarona endovenoso e ablação posterior.

B) Cloridrato de amiodarona endovenoso e anticoagulação.

C) Tartarato de metoprolol endovenoso e anticoagulação.

D) Cardioversão elétrica com 100 J e anticoagulação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234032)

Enunciado: Paciente, 52 anos, sexo masculino, previamente hígido, assintomático, comparece à consulta de rotina no ambulatório. Ao exame físico, chamam atenção sopro em ruflar diastólico 3+/6+ no foco mitral e ritmo cardíaco irregular com frequência cardíaca em torno de 84 batimentos por minuto. Realizado eletrocardiograma (figura abaixo) e ecocardiograma transtorácico que evidenciou estenose mitral moderada. Qual conduta deve ser tomada nesse momento?

A) Iniciar uso de rivaroxaban sem necessidade de monitoração do INR.

B) Iniciar warfarin e realizar a monitorização do INR ambulatorialmente.

C) Internar o paciente para administrar enoxaparina e iniciar uso de warfarin.

D) Manter conduta expectante, pois o paciente apresenta baixo risco de complicações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199664)

Enunciado: Criança de 5 anos foi encontrada inconsciente na piscina por vigilante de um condomínio e foi removida rapidamente para a unidade de pronto atendimento. Não se sabe o tempo de duração do afogamento. Qual é a causa mais comum de morbimortalidade em hospitalizados afogados?

A) Distúrbio hidroeletrolítico por aspiração de água.

B) Insuficiência cardíaca com edema agudo de pulmão.

C) Laringoespasmo seguido de relaxamento da laringe com aspiração de água.

D) Desenvolvimento de encefalopatia por hipóxia, com ou sem edema cerebral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150870)

Enunciado: Paciente masculino, 63 anos, é trazido à Unidade Básica de Saúde pela filha que informa que o pai é "um paciente complicado" e que raramente procura o serviço de saúde. Morador de zona rural, de difícil acesso e transporte, é hipertenso, dislipidêmico, obeso, sedentário, tabagista de 2 maços/dia, e apresenta-se com queixa de palpitações associadas à "falta de ar" há 4 meses. Refere que esses eventos ocorrem 2 a 3 vezes por semana, sendo mais frequentes nas segundas-feiras. Durante um desses episódios, foi levado ao serviço de emergência do município e realizou um ECG (VER IMAGEM). No momento, não tem queixas de palpitações. Faz uso de enalapril, hidroclorotiazida e atorvastatina. Ingere cerca 8 a 10 unidades de álcool nos finais de semana. Ao exame físico, encontra-se com PA sentado 126 x 94 mmHg. Peso 80 kg. Altura 165 cm. Apresenta ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular e frequência de 82 bpm. Sopro sistólico 3+/6+ em foco aórtico com irradiação para pescoço. Os pulsos são palpáveis, têm ascensão lenta e são regulares, congruentes com ausculta. Índice Tornozelo Braquial foi 0,8 e 0,94 para membro inferior direito e esquerdo, respectivamente. Os exames laboratoriais trazidos não evidenciam alterações nas provas de coagulação ou função hepática. Creatinina 1,6 mg/dL. Qual deve ser a prescrição farmacológica com ênfase na prevenção de eventos vasculares/tromboembólicos?

A) Aspirina 325 mg/dia.

B) Cilostazol 200 mg/dia.

C) Aspirina 100 mg/dia e Clopidogrel 75 mg/dia.

D) Varfarina 5 mg/dia (manter INR entre 2,0 e 3,0).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102088)

Enunciado: Paciente feminina, 72 anos, hipertensa, há cerca de 6h com palpitações intensas, dá entrada na emergência, sonolenta e pouco responsiva, após síncope. No exame físico, chamava atenção uma PA de 80 x 40 mmHg e um pulso rápido, irregular, sem pausas ou falhas, com frequência de 150 bpm, confirmado pela ausculta cardíaca com as mesmas características e sem outras alterações. Considerando o diagnóstico mais provável, a conduta mais adequada, após o ECG de 12 derivações, seria:

A) Heparina subcutânea.

B) Digitálico endovenoso.

C) Antiarrítmico endovenoso.

D) Cardioversão transtorácica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81319)

Enunciado: Paciente de 82 anos, restrito ao leito, recebe visita domiciliar de seu médico da atenção primária. Paciente é hipertenso, portador de insuficiência cardíaca congestiva, fibrilação atrial crônica e apresenta sequela motora de acidente vascular cerebral. Estava em uso de enalapril: 20 mg/dia; carvedilol: 50 mg/dia; ácido acetilsalicílico: 100 mg/dia; hidroclorotiazida: 25 mg/dia; metildopa: 500 mg/dia e digoxina: 0,25 mg/dia. Como o médico deverá fazer o ajuste na medicação, considerando o melhor benefício para esse paciente e diminuição do risco de iatrogenias?

A) Reduzir os intervalos entre as doses dos medicamentos para diminuir a probabilidade de efeitos adversos.

B) Solicitar avaliação da função hepática desse paciente semestralmente, devido ao risco de intoxicação digitálica.

C) Reduzir a dose da digoxina para 0,125 mg e substituir diurético tiazídico, ante risco elevado de intoxicação digitálica.

D) Suspender a metildopa, visto que aumenta o número de receptores locais para medicações adrenérgicas, podendo causar hipotensão importante na associação dessas drogas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65699)

Enunciado: Médico de família e comunidade realiza visita domiciliar a um homem de 70 anos, que vive com a esposa de 72 anos e uma filha. A filha referiu preocupação, pois o pai caiu quatro vezes no último mês e na última queda cortou a região dos supercílios. Neste episódio, o paciente caiu da própria altura à noite quando ia ao banheiro. O mesmo é independente para as atividades de vida diária e dependente para as atividades de vida instrumentais. É hipertenso e possui insuficiência renal crônica. Faz uso de furosemida 40 mg às 16h e enalapril 20 mg às 7h. Pratica atividade física duas vezes por semana. Em relação às orientações para prevenção de quedas deste senhor, assinale a alternativa CORRETA:

A) A furosemida deve ser suspensa, pois aumenta o risco de quedas.

B) O uso de protetores pélvicos não tem indicação, pois não diminuem o risco de fraturas de colo femoral.

C) A atividade física aumenta o risco de quedas em idosos dependentes para as atividades de vida instrumentais.

D) O fato do indivíduo não ter sido indagado sobre a perda de consciência mantém a hipótese diagnóstica de síncope.

E) Deve-se recomendar restrição das atividades para reduzir o risco de quedas, pois o risco de fraturas é superior à necessidade e ao desejo de independência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

51234)

Enunciado: Mulher de 60 anos, em primeiro dia pós-operatório de tiroidectomia total, apresenta agitação na enfermaria. Ao ser abordada, a paciente encontra-se alerta, porém com desorientação espacial e alucinações visuais (descrevia animais e monstros circulando seu leito). A cicatriz cirúrgica estava limpa. Ao aferir a pressão arterial da paciente, observa-se intenso espasmo carpal. Não havia outros achados no exame físico. Qual alteração deve estar presente no eletrocardiograma desta paciente?

A) Alargamento do QRS.

B) Aumento do intervalo PR.

C) Elevação do segmento ST.

D) Prolongamento do intervalo QT.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

51259)

Enunciado: Homem de 68 anos é admitido em uma emergência trazido por familiares. Apresentava dispneia intensa e tontura há 30 minutos, de início súbito. O paciente é hipertenso, em uso de losartana. Exame físico: orientado, dispneico 3+/4+, PA 130 x 90 mmHg, crepitações na metade inferior de ambos os pulmões, sem edema de extremidades. Administrado O2 e diurético, sem melhora, evoluindo com dor torácica anginosa. ECG da admissão a seguir (VER IMAGEM). Qual a conduta recomendada nesse contexto?

A) Cardioversão elétrica.

B) Amiodarona endovenosa.

C) Parecer de um especialista.

D) Massagem dos seios carotídeos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

30842)

Enunciado: Qual condição tem sido associada individualmente a vários componentes da síndrome metabólica, como o aumento da pressão sanguínea, hipertrigliceridemia, baixo HDL-C e tolerância à glicose diminuída?

A) Disfunção endotelial.

B) Plaquetopenia.

C) Tabagismo.

D) Alcoolismo.

E) Esteatose hepática.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

32514)

Enunciado: Paciente, 56 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, internado para quimioterapia por câncer de pulmão, apresenta palpitações e coração acelerado. Sua pressão arterial está 100 x 60 mmHg e o pulso é de 160 bpm. Ele está alerta e cooperativo. Seu eletrocardiograma prévio mostra síndrome de Wolff-Parkinson-White e agora há fibrilação atrial. Qual das drogas abaixo é a melhor para tentar reversão do ritmo no paciente em questão?

A) Ibutilida.

B) Amiodarona.

C) Metoprolol.

D) Verapamil.

E) Digoxina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

32528)

Enunciado: Num paciente com intoxicação aguda e grave por propranolol, qual das medicações abaixo é a mais adequada ao tratamento?

A) Atropina.

B) Glucagon.

C) Clonazepam.

D) Cloreto de cálcio.

E) Sulfato de Magnésio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

36981)

Enunciado: Na emergência, comparece uma mulher de 25 anos, ciclista, com queixa de desconforto torácico e coração acelerado. Ela é portadora de vitiligo e não usa drogas lícitas ou ilícitas. No ECG há ritmo irregular e não é visualizada onda P. Qual o diagnóstico mais provável como causa de base da arritmia?

A) Apneia do Sono Obstrutiva.

B) Hipertireoidismo.

C) Hipertrigliceridemia familiar.

D) Infarto Agudo do Miocárdio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37640)

Enunciado: Sr. Francisco das Chagas procurou seu médico de família apresentando ECG compatível com fibrilação atrial crônica. Dr. Francélio decidiu, baseado em evidências científicas, iniciar o uso de varfarina. Assinale a alternativa incorreta.

A) A varfarina é um anticoagulante oral que produz seu efeito inibindo o ciclo de conversão da vitamina K;

B) O objetivo deve ser manter o RNI entre 2, 0 - 3, 0;

C) Deve-se iniciar o tratamento com doses de 5 ou 10 mg de varfarina, sem que haja diferenças em risco de sangramento ou efeitos tromboembólicos;

D) A administração de heparina concomitantemente a varfarina é contraindicada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

30871)

Enunciado: Paciente se apresenta no consultório com queixa de palpitações. No exame físico, você percebe um sopro diastólico mais intenso no ápice e uma primeira bulha hiperfonética. Ele traz um ECG que revela onda P entalhada com duração de 120ms em D2 e com inflexão negativa de 02 mm em V1. O eixo do QRS está em 120°. Qual das patologias abaixo é o diagnóstico mais provável?

A) Hipertireoidismo com taquicardiomiopatia.

B) Forame oval patente.

C) Insuficiência aórtica.

D) Defeito do septo ventricular.

E) Estenose mitral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

24299)

Enunciado: Hipercalemia de início rápido causa arritmias cardíacas que podem ser fatais. A principal causa desse distúrbio é:

A) Pós-operatório de grandes procedimentos com rabdomiólise

B) Cetoacidose diabética

C) Disfunção ou falência renal

D) Grandes queimados

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

24358)

Enunciado: Qual dos seguintes é a causa mais frequente de morte cardíaca súbita em adolescentes e adultos jovens?

A) Aterosclerose coronariana

B) Miocardiopatia dilatada

C) Miocardite viral

D) Síndromes arrítmicas hereditárias

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

24323)

Enunciado: Karla, 12 anos, com quadro de insuficiência renal aguda, realizou um eletrocardiograma que evidenciou uma diminuição do intervalo QT, associada a uma onda T alta e apiculada, sinal de repolarização ventricular precoce. Posteriormente, ocorreu achatamento da onda P, alargamento de QRS, até o desaparecimento da onda P. Com essa patologia, o provável distúrbio que gerou as alterações eletrocardiográficas foi:

A) Hipercalemia

B) Hipocalemia

C) Hipomagnesemia

D) Hiperglicemia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

25326)

Enunciado: Essas manobras são úteis em que situação? (VER IMAGEM)

A) Afogamento

B) Engasgo

C) Insuficiência Respiratória

D) Apneia

E) Intoxicação Exógena

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13406)

Enunciado: José Maria, 65 anos, desmaiou jogando uma partida de futebol. O SAMU 192 foi acionado e chegou em 10 minutos. Ao exame, ausência de respiração e pressão arterial no ECG asistolia. Foram realizadas manobras de reanimação cardior-repiratória durante 10 minutos, sem que fosse obtido sucesso. Os familiares chegaram assustados e informaram angina há 05 anos e diabetes do tipo 2. Dos quadros relatados abaixo, qual a mais provável causa mortis?

A) Parada cardíaca.

B) Tamponamento cardíaco.

C) Rotura de cordoalha tendínea.

D) Fibrilação Ventricular.

E) Necrose do miocárdio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9060)

Enunciado: Homem de 64 anos com história de síncopes de repetição. Usa amiodarona há 5 anos para "problema no coração". O exame físico é normal, não há déficits motores e um ECG realizado, na ocasião, não demonstra alterações. Qual a avaliação complementar inicial recomendada?

A) Angiorressonância cerebral

B) Tilt teste (Teste da mesa inclinada)

C) Eletroencefalograma

D) Holter 24 horas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

8844)

Enunciado: Em pacientes com fibrilação atrial, qual dos achados de exame físico abaixo é incompatível com o diagnóstico?

A) Alternância de intensidade de bulhas

B) B3

C) B4

D) Desdobramento de B2

E) Desdobramento de B1

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13407)

Enunciado: Paciente com eletrocardiograma mostrando ritmo sinusal com intervalo RR de 15 mm e com QRS positivo em D1 e negativo em aVF. Em aVR o QRS está isodifásico. Marque a resposta correta:

A) Apresenta hemibloqueio anterior esquerdo com eixo elétrico do QRS de +30 graus.

B) Apresenta eixo elétrico do QRS indeterminado.

C) Apresenta frequência cardíaca de 100/min com sinais de sobrecarga ventricular direita.

D) Apresenta eixo elétrico do QRS em --60 graus.

E) Apresenta ECG compatível com doença do nó sinusal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

17794)

Enunciado: Com referência às formas de intervenção do modelo ?sanitarista?, pode-se afirmar que:

A) usualmente contemplam a totalidade da situação de saúde

B) concentram sua atenção no controle de certos agravos

C) preocupam-se com os determinantes mais gerais da situação sanitária

D) enfatizam a integralidade da atenção

E) estimulam a descentralização na organização dos serviços

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

17804)

Enunciado: Durante o exame físico de um paciente cardiológico, qual dos seguintes achados definitivamente descarta o diagnóstico de Fibrilação Atrial?

A) Ritmo cardíaco aparentemente regular

B) Ausência das ondas a no pulso jugular

C) Presença de B3

D) Frequência cardíaca > 200 batimentos por minuto

E) Presença de B4

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

17868)

Enunciado: No estudo da hipertensão arterial na gravidez, Page (1972) considera a seguinte equação para aferir a pressão arterial média:

A) PAM = PAS ? PAD / 2

B) PAM = PAS + PAD / 3

C) PAM = PAS + 2xPAD / 3

D) PAM = 2xPAS + PAD / 3

E) PAM = PAS ? PAD / 3

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

349742)

Enunciado: Uma mulher de 58 anos apresentou-se à sala de emergência com palpitações intensas, dor torácica e dispneia. Ela relatou que as palpitações começaram repentinamente enquanto estava em repouso em casa. Não havia histórico prévio de arritmias. A seguir está o eletrocardiograma realizado: Sinais vitais: frequência cardíaca estimada em cerca de 150 bpm; pressão arterial: 80/50 mmHg. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e a conduta adequada para esse caso.

A) Taquicardia supraventricular / Sedação leve e cardioversão química.

B) Fibrilação atrial / Sedação leve e cardioversão elétrica.

C) Flutter atrial / Desfibrilação.

D) Taquicardia sinusal / Conduta expectante.

E) Fibrilação atrial / Sedação leve e cardioversão química.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

349739)

Enunciado: Diante de um atendimento a um paciente em parada cardiorrespiratória, o líder precisa conduzir a equipe que está realizando a Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Qual é a maneira de comunicação mais apropriada entre o líder e a equipe nessa situação?

A) Apenas o líder da equipe possui a competência necessária para verbalizar informações, devendo o restante da equipe permanecer em silêncio durante todo o atendimento.

B) O líder deve transmitir mensagens simultâneas a cada membro da equipe para que sejam evitados atos de procrastinação e a situação possa ser revertida o mais rápido possível.

C) O líder deve transmitir uma mensagem, ordem ou atribuição a um membro da equipe; solicitar uma resposta clara e contato visual do membro da equipe para garantir que tenha entendido a mensagem; confirmar que o membro da equipe concluiu a tarefa, antes de lhe atribuir outra tarefa.

D) O líder deve elevar o tom de voz ao perceber que um dos membros da equipe não compreendeu a ordem dada, a fim de que tal atitude não se repita.

E) É necessário que o líder reconheça sua equipe com elogios, como forma de incentivá-la quando o atendimento é bem sucedido, bem como repreender em alto tom de voz ao perceber quaisquer falhas durante o atendimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

365613)

Enunciado: Durante a assistência a um paciente em parada cardiorrespiratória no ambiente hospitalar, foi realizada a checagem de ritmo, com o traçado apresentado. O ritmo representado no traçado é.

A) chocável e passível de pulso.

B) não chocável e passível de pulso.

C) não chocável e não passível de pulso.

D) chocável e não passível de pulso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

365612)

Enunciado: Durante a assistência a um paciente em parada cardiorrespiratória no ambiente hospitalar, foi realizada a checagem de ritmo, com o traçado apresentado. No decorrer do manejo da parada cardiorrespiratória nesse ritmo, são indicados o uso de

A) adrenalina e noradrenalina.

B) adrenalina e amiodarona.

C) atropina.

D) adrenalina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

365635)

Enunciado: Uma paciente de 43 anos de idade, com história de cardiopatia estrutural, procurou o pronto-socorro queixando-se de desconforto torácico inespecífico e três pré-síncopes nas últimas 12 horas. Na admissão, foi realizado eletrocardiograma (ECG) com o traçado apresentado.

Considerando esse caso e com base nesse traçado, é correto afirmar que se trata de

A) ritmo sinusal normal.

B) bloqueio atrioventricular de primeiro grau.

C) bloqueio atrioventricular de segundo grau.

D) bloqueio atrioventricular total.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

322152)

Enunciado: Um homem de 63 anos, recebendo medicação para dor epigástrica na sala de observação do pronto atendimento, apresenta um colapso ao levantar-se da poltrona. Qual é a conduta imediata mais adequada nesse caso?

A) Realizar um eletrocardiograma de 12 derivações.

B) Checar a responsividade.

C) Aplicar 1 mg de epinefrina EV.

D) Iniciar compressões torácicas.

E) Solicitar avaliação da cardiologia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337519)

Enunciado: Paciente de 80 anos foi encontrado em rua pública, e testemunhas disseram que ele estava caminhando quando subitamente caiu no chão, perdendo a consciência. No hospital, foi realizado eletrocardiograma mostrado a seguir. Ao exame físico, sua pressão arterial era de 80x40mmHg, havia estertores pulmonares em todos os segmentos pulmonares com turgência jugular; sua glicemia estava normal. Durante seu atendimento, o paciente demonstrou ritmo cardíaco no monitor. Com base nos conhecimentos clínicos e nos eletrocardiogramas apresentados, julgue o item a seguir: No eletrocardiograma número 2, o paciente apresenta taquicardia ventricular.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337520)

Enunciado: Paciente de 80 anos foi encontrado em rua pública, e testemunhas disseram que ele estava caminhando quando subitamente caiu no chão, perdendo a consciência. No hospital, foi realizado eletrocardiograma mostrado a seguir. Ao exame físico, sua pressão arterial era de 80x40mmHg, havia estertores pulmonares em todos os segmentos pulmonares com turgência jugular; sua glicemia estava normal. Durante seu atendimento, o paciente demonstrou ritmo cardíaco no monitor. Com base nos conhecimentos clínicos e nos eletrocardiogramas apresentados, julgue o item a seguir: Na ausência de pulso no eletrocardiograma número 2, deve-se realizar cardioversão elétrica sincronizada.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

322164)

Enunciado: Um homem de 46 anos procura atendimento médico de urgência com queixa de palpitações e dor torácica do tipo aperto, de início há aproximadamente 1 hora. Seus sinais vitais são aferidos: ? PA: 70x40mmHg (pressão arterial); ? FC: 190bpm (Frequência cardíaca); ? SatO2: 86% (saturação de oxigênio). E o seu eletrocardiograma (ECG) é o seguinte: Nesse caso, conforme as informações apresentadas, é correto afirmar que

A) se trata de uma taquicardia supraventricular, e o uso da manobra vagal modificada está indicado.

B) a avaliação de um especialista deve ser prioritária.

C) o uso de atropina 1mg endovenosa (EV) está indicado.

D) a cardioversão elétrica sincronizada está indicada.

E) um estudo eletrofisiológico deve ser realizado antes de qualquer intervenção terapêutica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

322174)

Enunciado: Você está de férias, na praia, quando se depara com um afogamento. A vítima está desacordada, parece ter 16 anos, aproximadamente, e está sendo retirada da água. Ela é colocada na areia, em decúbito dorsal, e você vai prestar o atendimento inicial. Uma ambulância já foi chamada e chegará em poucos minutos. Das alternativas a seguir, qual deve ser a sua próxima atitude?

A) Estabilização de cervical.

B) Ventilação de resgate.

C) Posicionar o paciente em decúbito lateral.

D) Manobra de Helmlich.

E) Compressões abdominais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305287)

Enunciado: Qual das seguintes taquiarritmias apresenta complexo QRS estreito e regular?

A) Fibrilação atrial.

B) Torsades de pointes.

C) Taquicardia atrial.

D) Taquicardia de movimento circular antidrômica.

E) Flutter atrial com bloqueio AV variado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298858)

Enunciado: Um paciente de 45 anos de idade vem apresentando sintomas de palpitação, mal-estar e sudorese profusa no decorrer da hemodiálise. Em cada sessão, são ultrafiltrados 4 litros em duas horas e meia. Na última diálise, o paciente ficou com hipotensão = 85 mmHg x 40 mmHg, SatO2 = 94% em ar ambiente e frequência cardíaca conforme o eletrocardiograma a seguir. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Provavelmente, no período do eletro de repouso, o intervalo PR seja normal.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298859)

Enunciado: Um paciente de 45 anos de idade vem apresentando sintomas de palpitação, mal-estar e sudorese profusa no decorrer da hemodiálise. Em cada sessão, são ultrafiltrados 4 litros em duas horas e meia. Na última diálise, o paciente ficou com hipotensão = 85 mmHg x 40 mmHg, SatO2 = 94% em ar ambiente e frequência cardíaca conforme o eletrocardiograma a seguir. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Tratamento com sotalol é o padrão-ouro, no caso desse paciente, para tratamento em longo prazo.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305291)

Enunciado: Um homem de 57 anos procura atendimento médico com queixa de palpitações e dor torácica tipo aperto, de início há 30 minutos. Apresenta hipotensão (PA = 60 x 40 mmHg). Após avaliar o ritmo mostrado a seguir, qual é a conduta mais adequada?

A) Manobra vagal.

B) Adenosina 6 mg EV em bólus.

C) Amiodarona 150 mg EV em 30 minutos.

D) Deslanosídeo 0,8 mg EV em blus.

E) Cardioversão elétrica sincronizada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298860)

Enunciado: Um paciente de 45 anos de idade vem apresentando sintomas de palpitação, mal-estar e sudorese profusa no decorrer da hemodiálise. Em cada sessão, são ultrafiltrados 4 litros em duas horas e meia. Na última diálise, o paciente ficou com hipotensão = 85 mmHg x 40 mmHg, SatO2 = 94% em ar ambiente e frequência cardíaca conforme o eletrocardiograma a seguir. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O risco de morte súbita para esse paciente é elevado em relação à população normal.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298861)

Enunciado: Um paciente de 45 anos de idade vem apresentando sintomas de palpitação, mal-estar e sudorese profusa no decorrer da hemodiálise. Em cada sessão, são ultrafiltrados 4 litros em duas horas e meia. Na última diálise, o paciente ficou com hipotensão = 85 mmHg x 40 mmHg, SatO2 = 94% em ar ambiente e frequência cardíaca conforme o eletrocardiograma a seguir. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Cardioversão é o melhor tratamento para manejo agudo.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305305)

Enunciado: Um homem de aproximadamente 50 anos apresenta um colapso na recepção do pronto-socorro e é levado diretamente para a sala de emergência. Após verificar a responsividade, qual é a conduta mais adequada?

A) Iniciar compressões torácicas.

B) Aplicar duas ventilações de resgate.

C) Acesso venoso calibroso e expansão volêmica.

D) Eletrocardiograma de 12 derivações.

E) Checar o pulso carotídeo e a respiração.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274359)

Enunciado: Paciente masculino, 60 anos, foi admitido na urgência com quadro de taquiarritmia de início recente, sintomática. Foi realizado o eletrocardiograma na admissão, que é apresentado em seguida. Analisando o eletrocardiograma e as alternativas a seguir, qual é o ritmo predominante mais provável que se apresenta?

A) Taquicardia supraventricular de reentrada.

B) Taquicardia ventricular.

C) Flutter atrial.

D) Fibrilação atrial.

E) Ritmo juncional.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255692)

Enunciado: Paciente de 35 anos de idade chega ao pronto-socorro com dor torácica em aperto, irradiada para membro superior esquerdo há duas horas. Foi realizado um eletrocardiograma de repouso. Acerca desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos médicos correlatos, considerando o traçado eletrocardiográfico apresentado, julgue o item a seguir. No traçado eletrocardiográfico, o paciente apresenta bloqueio atrioventricular de segundo grau.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255740)

Enunciado: Uma gestante de 25 semanas vem apresentando taquicardia supraventricular paroxística durante a gestação. O cardiologista dela avaliou, junto ao obstetra, situações terapêuticas para minimizar a taxa de recorrência. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Segundo as diretrizes de taquicardia supraventricular da ESC 2019, não se deve utilizar sotalol na recorrência das crises de taquicardia supraventricular.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255741)

Enunciado: Uma gestante de 25 semanas vem apresentando taquicardia supraventricular paroxística durante a gestação. O cardiologista dela avaliou, junto ao obstetra, situações terapêuticas para minimizar a taxa de recorrência. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. De acordo com as diretrizes da ESC 2019, ablação com cateter, com mapeamento e sem uso de radiação pode ser uma opção terapêutica para pacientes gestantes.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255742)

Enunciado: Uma gestante de 25 semanas vem apresentando taquicardia supraventricular paroxística durante a gestação. O cardiologista dela avaliou, junto ao obstetra, situações terapêuticas para minimizar a taxa de recorrência. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. É incapaz de causar síncope e queda ao solo, não causando risco de quedas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

211982)

Enunciado: Um paciente comparece ao consultório do cardiologista para exames de rotina. Segundo o médico, nos exames não se observou qualquer alteração, mas o paciente foi ao ambulatório de clínica médica, pois desejava saber o significado do número 1 no exame de imagem ecocardiográfica que foi realizado. Considerando que a imagem apresentada é obtida na incidência longitudinal paraesternal durante a sístole, nesse caso clínico, o médico informou corretamente ao paciente que, na imagem, o número 1 corresponde ao (à):

A) Ventrículo direito.

B) Ventrículo esquerdo.

C) Aorta.

D) Átrio esquerdo.

E) Átrio direito.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

211957)

Enunciado: Determinado paciente, atleta de alto rendimento não profissional, compareceu ao consultório médico para fazer avaliação clínica, pois está sentindo tonteira e mal-estar e relata fadiga durante exercícios ergométricos. Realizou teste ergométrico com o seguinte resultado: taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, conforme a figura apresentada. Nesse caso clínico, ao ser questionado acerca de quando o paciente poderá voltar a fazer atividade física em competição, o médico deve responder que o paciente:

A) Poderá praticar todos os exercícios físicos competitivos.

B) Poderá realizar esportes competitivos de baixa intensidade.

C) Poderá fazer todos os esportes, com restrição somente aos praticados em ambientes perigosos.

D) Não poderá praticar qualquer esporte competitivo.

E) Deve fazer apenas esportes competitivos de baixa intensidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212003)

Enunciado: Durante reanimação de um paciente previamente hígido, internado para avaliação pressórica, o quadro evoluiu com parada cardiorrespiratória e ressuscitação por 17 minutos, bem-sucedida. O paciente evolui com estabilidade pressórica, pressão arterial invasiva (PAI) = 84 mmHg, FC = 102 bpm e SatO? = 96% sob ventilação mecânica em via aérea definitiva. Intensivista decidiu então fazer hipotermia, com temperatura entre 32°C e 34°C, pois o ritmo inicial era fibrilação ventricular. No que tange a esse caso clínico, assinale a alternativa que equivale a possíveis complicações dessa terapêutica.

A) Nova parada cardíaca pelo resfriamento do sistema nervoso central.

B) Crises hipertensivas e convulsivas.

C) Coagulopatia e risco do aumento de infecção.

D) Quadros álgicos intensos com fratura de ossos instáveis.

E) Melhora clínica rápida com menos de oito horas de evolução e extubação acidental.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196706)

Enunciado: Certa paciente de 62 anos de idade, com histórico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, assintomática no momento, traz Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações, solicitado por médico em consulta anterior. Com base nesse caso clínico, e considerando-se a reprodução do ECG apresentado, mediante a utilização da diretriz de interpretação de eletrocardiograma de repouso, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, julgue o item a seguir. Considere: FC = 51 spm; intervalo PR = 195ms; intervalo QRS = 130ms; intervalo QT = 440ms. Observa-se um bloqueio divisional posteroinferior esquerdo.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196614)

Enunciado: Certa paciente de 62 anos de idade, com histórico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, assintomática no momento, traz Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações, solicitado por médico em consulta anterior. Com base nesse caso clínico, e considerando-se a reprodução do ECG apresentado, mediante a utilização da Diretriz de Interpretação de Eletrocardiograma de Repouso, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, julgue o item a seguir. Considere: FC = 51 bpm; intervalo PR = 195ms; intervalo QRS = 130ms; intervalo QT = 440ms. Verifica-se um bloqueio atrioventricular de primeiro grau.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196623)

Enunciado: Certa paciente de 62 anos de idade, com histórico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, assintomática no momento, traz Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações, solicitado por médico em consulta anterior. Com base nesse caso clínico, e considerando-se a reprodução do ECG apresentado, mediante a utilização da diretriz de interpretação de eletrocardiograma de repouso, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, julgue o item a seguir. Considere: FC = 51 spm; intervalo PR = 195ms; intervalo QRS = 130ms; intervalo QT = 440ms. As alterações de onda T em V5?V6 podem ser justificadas pela presença de bloqueio de ramo esquerdo.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196629)

Enunciado: Certa paciente de 62 anos de idade, com histórico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, assintomática no momento, traz eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações, solicitado por médico em consulta anterior. Com base nesse caso clínico, e considerando-se a reprodução do ECG apresentado, mediante a utilização da Diretriz de Interpretação de Eletrocardiograma de Repouso, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, julgue o item a seguir. Considere: FC = 51 spm; intervalo PR = 195 ms; intervalo QRS = 130 ms; intervalo QT = 440 ms. Observa-se uma bradicardia sinusal.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214450)

Enunciado: Uma paciente de 8anos de idade, sem histórico de sintomas cardiovasculares e com exame físico normal, leva a consulta o eletrocardiograma (ECG) de repouso apresentado (1 cm = 1 mv), como parte da avaliação anual de respectivo clube de natação, onde treina competitivamente. Realiza treinos cinco vezes por semana, com uma hora de duração. Ao exame físico, verificam-se FC de 70 bpm, FR d 16 irpm e saturação de oxigênio de 99%. Após uma análise do ECG da paciente desse caso clínico, considerando as Diretrizes Brasileiras de Interpretação de ECG e as Diretizes de Cardiologia do Esporte da SBC/SBME, julgue o item a seguir: Essa paciente deve ser afastada do esporte até o fim das investigações cardiológicas adicionais necessárias.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214458)

Enunciado: Uma paciente de 8anos de idade, sem histórico de sintomas cardiovasculares e com exame físico normal, leva a consulta o eletrocardiograma (ECG) de repouso apresentado (1 cm = 1 mv), como parte da avaliação anual de respectivo clube de natação, onde treina competitivamente. Realiza treinos cinco vezes por semana, com uma hora de duração. Ao exame físico, verificam-se FC de 70 bpm, FR d 16 irpm e saturação de oxigênio de 99%. Após uma análise do ECG da paciente desse caso clínico, considerando as Diretrizes Brasileiras de Interpretação de ECG e as Diretizes de Cardiologia do Esporte da SBC/SBME, julgue o item a seguir: As alterações encontradas em V1/V2 devem-se ao alto volume de treinamento aeróbico.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196650)

Enunciado: Certo paciente de 33 anos de idade, que pratica corrida de rua há 15 anos, apresenta-se para avaliação anual periódica em um posto de saúde. Leva eletrocardiograma com presença de bradicardia (45 bpm) e bloqueio atrioventricular de primeiro grau (intervalo PR de 240 ms). Não apresenta qualquer queixa espontânea. Tem histórico familiar de hipertensão arterial sistêmica, assim como de diabetes mellitus. Com base nesse caso clínico e considerando a liberação para a prática de exercício físico, utilizando como referência o International criteria for electrocardiographic interpretation in athletes (2017), julgue o item a seguir. A atividade física deve ser suspensa até maiores investigações das alterações eletrocardiográficas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196656)

Enunciado: Certo paciente de 33 anos de idade, que pratica corrida de rua há 15 anos, apresenta-se para avaliação anual periódica em um posto de saúde. Leva eletrocardiograma com presença de bradicardia (45 bpm) e bloqueio atrioventricular de primeiro grau (intervalo PR de 240 ms). Não apresenta qualquer queixa espontânea. Tem histórico familiar de hipertensão arterial sistêmica, assim como de diabetes mellitus. Com base nesse caso clínico e considerando a liberação para a prática de exercício físico, utilizando como referência o International criteria for electrocardiographic interpretation in athletes (2017), julgue o item a seguir. Para esse paciente, deve-se solicitar ecocardiograma.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196661)

Enunciado: Certo paciente de 33 anos de idade, que pratica corrida de rua há 15 anos, apresenta-se para avaliação anual periódica em um posto de saúde. Leva eletrocardiograma com presença de bradicardia (45 bpm) e bloqueio atrioventricular de primeiro grau (intervalo PR de 240 ms). Não apresenta qualquer queixa espontânea. Tem histórico familiar de hipertensão arterial sistêmica, assim como de diabetes mellitus. Com base nesse caso clínico e considerando a liberação para a prática de exercício físico, utilizando como referência o International criteria for electrocardiographic interpretation in athletes (2017), julgue o item a seguir. Caso o paciente apresente hipertensão arterial ao longo do seguimento, a prática do exercício físico aeróbico deve ser estimulada, mas o exercício resistido (com pesos) deve ser contraindicado.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196672)

Enunciado: Certo paciente de 33 anos de idade, que pratica corrida de rua há 15 anos, apresenta-se para avaliação anual periódica em um posto de saúde. Leva eletrocardiograma com presença de bradicardia (45 bpm) e bloqueio atrioventricular de primeiro grau (intervalo PR de 240 ms). Não apresenta qualquer queixa espontânea. Tem histórico familiar de hipertensão arterial sistêmica, assim como de diabetes mellitus. Com base nesse caso clínico e considerando a liberação para a prática de exercício físico, utilizando como referência o International criteria for electrocardiographic interpretation in athletes (2017), julgue o item a seguir. A Diretriz Brasileira em Cardiologia do Esporte e do Exercício indica a realização de eletrocardiograma de 12 derivações antes da liberação para a prática de atividade física em todos os indivíduos.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177607)

Enunciado: M.C.L., sexo feminino, de 76 anos de idade, é paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (40%), atualmente com classe funcional NYHA II. Como comorbidades, apresenta HAS, DM e fibrilação atrial fixa. Considerando o quadro dessa paciente e sua patologia, julgue o item a seguir. Há indicação de terapia anticoagulante para essa paciente?

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134985)

Enunciado: A respeito da parada cardiorrespiratória (PCR) em crianças, julgue o item a seguir.

Quando administrada na PCR, a ação farmacológica da adrenalina promove a vasoconstrição (efeito alfa), o que eleva a pressão de perfusão durante a compressão torácica e aumenta a liberação de oxigênio para o coração.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

105533)

Enunciado: O achado ocasional ao eletrocardiograma de amplitude e forma na onda "p", em paciente jovem, chama atenção para eventuais problemas:

A) Ventriculares.

B) No ventrículo direito.

C) Na despolarização ventricular.

D) Atriais.

E) De bloqueio de ramos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108161)

Enunciado: Em atendimento a paciente vítima de insuficiência renal crônica, o médico deparou-se com perda súbita de consciência da paciente. Durante o atendimento, a paciente não respondia a estímulos, estava sem respiração e sem pulso carotídeo perceptível. O monitor do cardioversor/desfibrilador, que estava corretamente conectado à paciente, mostrou o seguinte ritmo cardíaco. (VER IMAGEM) Considerando esse caso clínico e tendo a leitura do cardioversor/desfibrilador acima como referência, julgue o item a seguir. Nesse caso clínico, ao realizar a estimulação cardíaca temporária, o médico não deverá utilizar marca-passo transcutâneo.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82034)

Enunciado: Acerca dos sistemas cardiovascular, gastrointestinal e endócrino, julgue o item que se segue. A medida da circunferência da cintura abdominal maior que 85 cm em homens e que 70 cm em mulheres configura obesidade e leva ao diagnóstico de síndrome metabólica.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82042)

Enunciado: Acerca dos sistemas cardiovascular, gastrointestinal e endócrino, julgue o item que se segue. A apneia do sono atinge a maioria dos portadores da síndrome metabólica.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

79655)

Enunciado: Homem, 76 anos, apresenta, após exames conclusivos, disfunção do nó sinusal com manifestação eletrocardiográfica de uma bradicardia sinusal inapropriada e persistente. Episódios de bloqueio sinoatrial, parada sinusal, fibrilação atrial de frequência baixa. Entre as patologias abaixo, assinale a alternativa que apresenta a que mais condiz com o caso descrito.

A) Doença de Chagas.

B) Cardiomiopatia difusa.

C) Cardiomiopatia hipotrófica.

D) Angina pectoris.

E) Angina instável.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82099)

Enunciado: Acerca de traumas, urgências ortopédicas e doenças infecciosas, julgue o próximo item: A fibrilação ventricular é a causa mais frequente de morte súbita. Nos casos em que quase se iniciam a desfibrilação por choque elétrico e o suporte básico local de oxigenação tecidual nos três primeiros minutos após a parada cardíaca, a taxa de vida é aumentada.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88690)

Enunciado: Com relação à parada cardiorrespiratória e ao trauma, julgue o item que segue.

Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, assistolia e atividade elétrica sem pulso constituem modalidades de parada cardíaca.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64687)

Enunciado: Paciente portador de insuficiência cardíaca classe funcional IV da NYHA realizará um tratamento farmacológico que deverá incluir:

A) IECA + diurético de alça + espironolactona, apenas.

B) digital + bloqueador de canais de cálcio + espironolactona.

C) IECA + betabloqueador + espironolactona.

D) IECA + digital + diurético de alça.

E) IECA + betabloqueador + diurético de alça + espironolactona.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64255)

Enunciado: No Brasil, estima-se que ocorreram cerca de 300.000 mortes por ano devido à causas cardiovasculares. O êxito no atendimento de situações de parada cardiorrespiratória depende do conhecimento sólido dos procedimentos recomendados, internacionalmente, pelas diretrizes da Associação Americana do Coração (AHA). Com base nas recomendações da AHA para o suporte básico de vida, julgue o item que se segue. Nesse sentido, considere que a sigla RCP, sempre que utilizada, refere-se à Reanimação Cardiopulmonar. Como a checagem do pulso carotídeo é fundamental para o início das manobras de RCP, o socorrista (leigo e único) deve, obrigatoriamente, palpar o pulso carotídeo do paciente, deslocando, lateralmente, os quirodáctilos na altura da cartilagem tireóidea até encontrar a borda posterior do músculo esternocleidomastoideo, de preferência por mais de trinta segundos. Somente após confirmar a ausência dessa pulsação, deve-se iniciar os procedimentos da RCP, realizando-se seis ventilações pulmonares (por técnica boca a boca) seguidas de compressões torácicas.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64272)

Enunciado: No Brasil, estima-se que ocorreram cerca de 300.000 mortes por ano devido à causas cardiovasculares. O êxito no atendimento de situações de parada cardiorrespiratória depende do conhecimento sólido dos procedimentos recomendados, internacionalmente, pelas diretrizes da Associação Americana do Coração (AHA). Com base nas recomendações da AHA para o suporte básico de vida, julgue o item que se segue. Nesse sentido, considere que a sigla RCP, sempre que utilizada, refere-se à Reanimação Cardiopulmonar. Deve-se manter as compressões torácicas realizadas durante as manobras de RCP em uma frequência de, pelo menos, cem compressões por minuto, produzindo, a cada compressão, uma depressão torácica de, pelo menos, cinco centímetros. Esse procedimento tem por fim a geração de fluxo sanguíneo pelo aumento tanto na pressão intratorácica quanto pela compressão direta do coração, o que promove fluxo sanguíneo e oferta de oxigênio para o miocárdio e o cérebro.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

29749)

Enunciado: Considerando os distúrbios que ocorrem no balanço hidreletrolítico, julgue o próximo item. Em um paciente que apresente tetania, laringoespasmo, sinais de Chevostek e Trousseau e eletrocardiograma com intervalo QT prolongado, deve-se suspeitar de hipercalcemia grave.

A) Certo

B) Errado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

19249)

Enunciado: Homem de 65 anos de idade, tabagista, diabético, dislipidêmico, chega ao pronto-socorro com história de dor torácica progressiva em hemitórax esquerdo há duas horas, acompanhada de surdorese fria e náuseas. Durante o exame clínico, na sala de emergência, o paciente perde a consciência e não responde ao chamado. Identifica-se a ausência de pulso carotídeo e o ritmo visualizado no monitor cardíaco, através das pás do desfibrilador, revela assistolia. A sequência correta de condutas a serem adotadas é:

A) confirmar o ritmo de assistolia em outra derivação; realizar a intubação orotraqueal, solicitar a monitoração cardíaca com eletrodos e um acesso venoso periférico. A adrenalina não poderá ser administrada enquanto o acesso venoso não for estabelecido.

B) confirmar o ritmo de assistolia em outra derivação, realizar a intubação orotraqueal, solicitar a monitoração cardíaca com eletrodos e um acesso venoso periférico. Assim que possível, realizar a desfibrilação com 200J, pois a assistolia pode mascarar uma fibrilação ventricular em até 10% dos casos.

C) confirmar a assistolia em outra derivação; após a confirmação, realizar massagem cardíaca externa e ventilações sincronizadas com a massagem cardíaca, enquanto se prepara o material para intubação, a monitoração cardíaca com eletrodos e o acesso venoso.

D) caso seja encontrado o ritmo de fibrilação ventricular fina na confirmação do ritmo em outra derivação, não se deve realizar a desfibrilação até que a mesma seja administrada a adrenalina para que haja aumento da amplitude de fibrilação, pois a fibrilação ventricular fina pode evoluir para a assistolia após o choque.

E) o marcapasso transcutâneo deve ser colocado imediatamente, pois essa atitude muda o prognóstico da parada cardíaca em assistolia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

19337)

Enunciado: Lactente de 16 meses de idade é levado ao pronto-socorro pálido e sudoreico. A mãe refere que sente o coração do filho muito acelerado. Ao exame a criança está hipoativa com frequência cardíaca (FC) = 220 bpm e pressão arterial = 78 x 65 mmHg. Realizado eletrocardiograma de repouso que confirma a FC e mostra um traçado com complexos estreitos e regulares (reproduzido a seguir). A conduta mostra neste momento é a administração de:(VER IMAGEM)

A) Expansão com soro fiosiológico 20mL/Kg

B) Beta-bloqueador via retal

C) Digoxina por via intravenosa

D) Furosemide intravenosa

E) Adenosina intravenosa

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343407)

Enunciado: O nome da arritmia que é um ritmo que o impulso elétrico se origina logo acima do ventrículo, com reentrada por uma via de condução acessória, e o ECG não mostra a onda P, mas ela pode estar presente e com morfologia anormal, nem sempre sendo possível determinar o intervalo PR e o intervalo RR é constante e o QRS estreito, com frequência cardíaca superior a 220 bpm em lactentes e a 180 bpm em crianças maiores é:

A) Bloqueio Atrioventricular.

B) Bradicardia sinusal.

C) Flutter Ventricular.

D) Taquicardia Supraventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273313)

Enunciado: Criança de 2 anos de idade, inicia quadro súbito de taquipnéia, palidez e sudorese. Apresenta-se afebril, com FR = 40 mrpm, FC = 230 bpm, pulsos periféricos finos e rápidos, perfusão periférica preservada. A criança está consciente, contactando normalmente com os pais. Feito ECG: O diagnóstico e conduta mais adequados são:

A) Taquicardia sinusal; expansão com solução cristalóide.

B) Taquicardia ventricular; cardioversão sincronizada.

C) Taquicardia supraventricular; adenosina IV.

D) Taquicardia juncional; amiodarona IV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230558)

Enunciado: A varfarina é altamente eficaz na prevenção de fenômenos tromboembólicos na FA, com redução de 64% do risco nos pacientes adequadamente tratados. NÃO podemos aceitar que:

A) Menos metade dos pacientes não são adequadamente tratados, por motivos que variam desde a dificuldade de controle frequente de RNI até alto risco de sangramento.

B) Pacientes em uso de varfarina nem sempre se encontram na faixa terapêutica adequada (em geral RNI entre 5 e 6).

C) Ocorre interação medicamentosa, principalmente antibióticos e anti-inflamatórios.

D) Ocorre interação com alimentos, uso irregular da medicação, intercorrências clínicas agudas, entre outros.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230579)

Enunciado: Quais os parâmetros do ECG devem se conhecidos ao se avaliar uma criança com alteração do ritmo?

A) Conhecimento da FC normal de acordo coma idade, o débito cardíaco e o ritmo de base.

B) Conhecimento da FC normal de acordo com a idade, o débito cardíaco e a duração do complexo QRS.

C) Conhecimento do débito cardíaco, ritmo de base e duração do complexo QRS.

D) Conhecimento da FC normal de acordo com a idade, o ritmo de base e a duração do complexo QRS.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

203130)

Enunciado: Uma paciente de 45 anos de idade sente tontura, pressão no peito e fadiga há três horas. Durante o exame, verifica-se que ela apresenta níveis pressóricos de 80 mmHg x 50 mmHg e FC = 140 bpm, associada a má perfusão periférica. Ao ECG, nota-se que ela tem fibrilação atrial, sendo que um ECG basal prévio mostrou ondas delta. A respeito desse caso clínico, assinale alternativa correta.

A) Essa paciente não possui risco de taquicardia ventricular, pois a respectiva fibrilação atrial possui complexo QRS estreito, assim o risco maior seria evolução para taquicardia supraventricular.

B) A onda delta indica a presença de extrassístoles ventriculares (provável disfunção do nó sinusal); assim, o diagnóstico para esse caso é fibrilação atrial com complexo de QRS alargado.

C) A terapia de escolha para essa paciente seria administração de betabloqueadores, com objetivo de redução da frequência cardíaca.

D) A terapia com verapamil é uma opção aceitável para ser realizada nessa paciente em caráter de emergência, em razão da rápida absorção e objetivando a redução da frequência cardíaca e do inotropismo cardíaco.

E) O diagnóstico clínico dessa paciente é fibrilação atrial em uma paciente portadora de síndrome de Wolff-Parkinson-White, indicado pelas ondas delta no ECG anterior, que mostram uma via acessória ao nó atrioventricular para a comunicação elétrica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206170)

Enunciado: Responda qual a alternativa CORRETA sobre o ritmo apresentado:

A) Trata-se de taquicardia supraventricular.

B) Deve-se iniciar massagem cardíaca e oferecer adenosina rapidamente.

C) Trata-se do tipo mais comum de PCR em crianças, é a assistolia.

D) Devemos realizar desfibrilação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212110)

Enunciado: Caso clínico - paciente sem doenças prévias; Idade: 19 anos: sexo: feminino; Sinais e sintomas: tremores nas extremidades, nervosismo e palpitações taquicárdicas (FC = 15 bpm, PA 135 mmHg x 65 mmHg, pulsos radiais palpáveis e arrítmicos); Avaliação cardiovascular evidenciou ictus cordis in situ, ritmo cardíaco irregular em 2 tempos, taquicárdico, bulhas normofonéticas, sem sopros ou ruídos adventícios. Na palpação, percebeu-se glândula tireoide indolor, levemente aumentada e não nodular. Resultado de dosagem séricas: TSH (tirotrofina) = 0,05 mU/L (valores de referência = 0,4 - 4,2 mU/L); T4 livre (tiroxina livre) = 4,0 nanogramas/dL (valores de referência = 0,8 - 2,7 nanograma/dL); anticorpos antirreceptor de TSH (ou Trab) = 2 U/L (valor de referência < 10 U/L); anticorpos antitireoglobulinas = positivo 1/6.400 (valores de referência não reagente < 1/100); determinação de anticorpos antiperoxidase tireoidiana (anti-TPO) = 70 U/mL (valores de referência < 35 U/mL). Ecodopplercardiograma = normal. Tira de ritmo eletrocardiográfico (ECG) mostrada na figura a seguir (derivação D2, velocidade do papel: 25 mm/s, calibração: 1 cm = 1 mV). A respeito das informações do caso clínico descrito anteriormente, julgue o item subsequente. A arritmia cardíaca mostrada na tira de ECG é a fibrilação atrial.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175085)

Enunciado: Dentro do estudo da genética, relacionada com o eletrocardiograma ocorre descrição de entidades clínicas potencialmente fatais, que apresentam padrão eletrocardiográfico característico. Dentro desse grupo de doenças, destacam-se aquelas com coração estruturalmente normal, como as canalopatias. Não sendo ADEQUADA a seguinte alternativa a seu respeito:

A) As canalopatias cardíacas são o resultado de mutações genéticas ou de um mau funcionamento adquirido dos canais iônicos.

B) Os canais iônicos são responsáveis por desencadear alterações na despolarização.

C) Os canais iônicos são responsáveis por desencadear alterações na repolarização das fases do potencial de ação celular.

D) Achados eletrocardiográficos específicos, com associação de síncopes espontâneas, mas não as desencadeadas pelo exercício.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175106)

Enunciado: A Síndrome do QT longo pode causar inúmeros sintomas. Sobre ela, podemos afirmar que:

A) A claritromicina pode aumentar o intervalo QT.

B) Calcula-se o QT corrigido apenas se a frequência cardíaca for maior que 80 bpm.

C) Calcula-se o QT corrigido apenas se a frequência cardíaca for menor que 90 bpm.

D) Apenas calcula-se QT corrigido para crianças maiores de 10 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175110)

Enunciado: Sobre a morfologia da Onda P, é correto afirmar:

A) A onda P sinusal é positiva em AVR, D1 e D2.

B) No ritmo atrial ectópico a onda P é negativa em D2, sendo comum em adolescentes.

C) Quando há situs atrial inversus, a onda P é negativa em D1 e em AVR.

D) A amplitude normal da onda P é de 4mm.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175111)

Enunciado: Nas arritmias é CORRETO afirmar que:

A) Quando há QT longo, há proteção contra a morte súbita.

B) No torsades de pointes devemos oferecer cálcio ao paciente para tratá-lo e seu ECG apresenta QT curto.

C) No torsades de pointes há espaço QT curto e tratamos com magnésio.

D) No Wolff-Parkinson-White há espaço PR curto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183963)

Enunciado: Considerando o ritmo eletrocardiográfico apresentado na figura precedente - derivação: D2; velocidade do papel 25 mm/seg; calibração: 1cm = 1 mV - , julgue o seguinte item. A arritmia apresentada decorre diretamente de um distúrbio na propriedade cronotrópica do nó sinusal.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183965)

Enunciado: Considerando o ritmo eletrocardiográfico apresentado na figura precedente - derivação: D2; velocidade do papel 25 mm/seg; calibração: 1cm = 1 mV - , julgue o seguinte item. A arritmia observada nessa tira de ritmo é a extrassístole supraventricular com pausa compensatória.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175163)

Enunciado: A classificação mais utilizada na prática clínica refere-se à forma de apresentação da FA. Definem-se assim diversas classificações, sendo que somente uma das abaixo se mostra completamente correta, assinale-a:

A) ?Fibrilação atrial paroxística? aquela que é revertida espontaneamente ou com intervenção médica em até 24 horas de seu início.

B) Episódios com duração superior a 7 dias têm o nome de ?Fibrilação atrial persistente?.

C) Alguns estudos utilizam a terminologia de ?Fibrilação atrial persistente de longa duração? para designar os casos com duração superior a mês.

D) Finalmente, o termo ?Fibrilação atrial permanente? é utilizado nos casos em que as tentativas de reversão ao ritmo sinusal não foram feitas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175174)

Enunciado: Dentro do estudo das complicações relacionadas à trombogênese e embolia na Fibrilação Atrial, podemos considerar que as três condições estabelecidas por Virshow estão presentes em paciente com FA. Não sendo, contudo, completamente adequada a afirmativa:

A) Lesões do endocárdio atrial apresentavam microtrombos, e estes eram os precursores de trombos maiores.

B) O atrito do sangue com o endocárdio, lesões miocitárias causadas por agressões teciduais secundárias a citocinas inflamatórias (fator de necrose tumoral, interleucina 6, proteína C-reativa e outras) prejudicam ainda mais os miócitos atriais e expõem tecido colágeno na superfície, o que aumenta a aderência de plaquetas e a deposição de fibrina, gerando o trombo.

C) Dessa forma, a FA cria um estado pró-trombótico e hipercoagulável próprio.

D) O aumento da agregação plaquetária, menos intensa no Átrio Esquerdo (AE), e a redução dos níveis plasmáticos do fator de Von Wilebrand, os fragmentos de protrombina e do fibrinogênio plasmático, dentre outros, confirmam essa maior trombogenicidade sanguínea, independentemente de qualquer outro fator.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

168486)

Enunciado: Uma lactante com 15 meses de idade é levada pela mãe ao Pronto-Socorro. A mãe relata que o coração do bebê está muito acelerado. A mãe nega outras queixas e informa que realiza acompanhamento na Unidade Básica de Saúde, não tendo ocorrido até então, intercorrências. Ao exame físico, a lactante apresenta-se em bom estado geral, corada, hidratada, afebril, consciente, com boa perfusão periférica, saturação de oxigênio de 98% em ar ambiente, BNF 2T sem sopro audivél, frequência cardíaca = 230 bpm, ausência de edema e pulsos de boa amplitude. O eletrocardiograma apresenta onda P não visível; intervalo RR fixo QRS estreito (menor que 0,09 segundos). Diante desse quadro, além da manobra vagal, a conduta inicial adequada é

A) administrar lidocaina

B) administrar adenosina

C) administrar amiodaroma

D) realizar cardioversão elétrica sincronizada

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159580)

Enunciado: O item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a propósito da fisiopatologia, do diagnóstico precoce e do tratamento de doenças em crianças e adolescentes. Uma gestante com trinta e quatro semanas gestacionais foi a uma consulta de rotina, e o médico obstetra observou que a frequência cardíaca fetal era de 70 bpm. Neste caso, um diagnóstico que pode ser excluído na gestante é lúpus eritematoso sistêmico.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

168519)

Enunciado: Um homem com 60 anos de idade foi internado em um hospital municipal com quadro de confusão mental. O paciente reside em outro município, há 300 km do hospital. Na admissão, o paciente se disse assintomático, relatou que não costuma procurar atendimento médico e que preferia morar sozinho no sítio onde nasceu e cuida de uma pequena lavoura. Os familiares que o acompanhavam confirmaram que ele não apresenta comorbidades diagnosticadas, mas relataram que, há 5 dias, o paciente apresentou um episódio de confusão mental, tendo sido levado para internação hospitalar. Acrescentaram que, na ocasião, foi diagnosticada e tratada uma infecção do trato urinário e que, durante o exame físico, detectou-se uma arritmia cardíaca, confirmada por eletrocardiograma, cujo resultado é reproduzido a seguir. (Conforme imagem no caderno de questões) O resultado do eletrocardiograma realizado na internação atual apresenta o mesmo padrão. Agora, consciente e orientado, sem queixas, o paciente manifesta desejo de ter alta e de retornar ao seu sítio, afirmando que não pretende realizar outras consultas médicas. Nesse contexto, qual é a conduta médica indicada?

A) Dar alta hospitalar ao paciente após introdução de digoxina.

B) Dar alta hospitalar ao paciente após a introdução e o ajuste da dose da varfarina.

C) Dar alta hospitalar ao paciente após introdução e ajuste de dose do betabloqueador.

D) Orientar os familiares para que busquem, por meios jurídicos, a guarda do idoso e o mantenham na sede do município para iniciar tratamento com varfarina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111304)

Enunciado: O bloqueio cardíaco é uma condição na qual a propagação da despolarização pelo nodo AV ou pelo feixe de Hiss é anormalmente lenta. Os pacientes têm consciência disso relatando que ?meu coração perdeu um batimento?. A principal alteração observada no registro eletrocardiográfico, independentemente da derivação escolhida, é o:

A) Desaparecimento da onda T.

B) Desaparecimento da onda P.

C) Aparecimento de duas ondas P sucessivas.

D) Desaparecimento do complexo QRS, sem afetar a onda T.

E) Aparecimento de duas ondas T sucessivas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111316)

Enunciado: Um homem de 68 anos, previamente hígido, procura o pronto-socorro com queixa de 2 desmaios de curta duração há 1 hora. Os familiares relatam que não consegue ficar de pé. Está sonolento, sudoreico e bradicárdico. A PA é inaudível e os pulsos carotídeos e femorais são palpáveis. O monitor mostra: (VER IMAGEM) O diagnóstico eletrocardiográfico é de:

A) Bloqueio atrioventricular completo.

B) Infarto agudo do miocárdio.

C) Ritmo idioventricular.

D) Flutter atrial 2:1.

E) Bradicardia sinusal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97864)

Enunciado: Um homem com 72 anos de idade, com antecedentes de hipertensão arterial desde os 40 anos de idade e ?arritmia cardíaca? há dois anos, em uso de captopril-25 mg de 12/12h, hidroclorotiazida-25 mg/dia e warfarina-5 mg/dia, deu entrada no Pronto-Socorro com quadro de hemiplegia direita, completa e proporcionada, de início súbito há cerca de 9 horas. O paciente nega outras comorbidades, cirurgias ou traumas prévios, episódios semelhantes ou sangramentos anteriores. No exame físico da chegada ao hospital se observou um paciente em regular estado geral, eupneico (frequência respiratória = 16 irpm), acianótico, descorado (+/4+). Na ausculta cardíaca se observou um ritmo taquicárdico, em 2 tempos, sem sopros, frequência cardíaca = 148 bpm, pressão arterial = 190 x 100 mmHg. A ausculta pulmonar e o exame do abdome estavam normais e não havia edema de membros inferiores. Ao exame neurológico, paciente consciente, com leve desorientação temporoespacial, Glasgow = 15, pupilas simétricas e fotorreagentes, sem sinais de irritação meníngea. Observava-se hemiplegia completa à direita, sem alterações da sensibilidade. Escala de Acidente Vascular Cerebral do National Institute of Health = 18. Foi realizada tomografia computadorizada de crânio sem contraste que não revelou sangramentos ou áreas de hipodensidade. Os resultados dos exames laboratoriais foram os seguintes: leucócitos = 12.000/mm³ (Valor de referência: 4.500 - 11.000/mm³) com 74% de segmentados, 1% de eosinófilos, 15% de linfócitos; hemoglobina = 13 g/dl (Valor de referência: 13,5 - 17,5 g/dl); hematócrito = 33,3% (Valor de referência: 41-53%); plaquetas = 231.000/mm³ (Valor de referência: 150.000-350.000/mm³); glicemia = 84 mg/dl (Valor de referência: 80-100 mg/dl); ureia = 30 mg/dl (Valor de referência 20-35 mg/dl); creatinina = 1,2 mg/dl (Valor de referência : 0,8-1,4 mg/dl); tempo de protrombina = 19,5 seg (Valor de referência: 12,5-15,5 seg.); atividade de protrombina = 30% (Valor de referência: 70-120%); INR = 2,1; tempo de tromboplastina parcial ativada = 35 seg. (Valor de referência: 24-45 seg.); Relação = 1,0; Na sérico = 135 mEq/L (Valor de referência: 135-145 mEq/L); K+ sérico = 4,1 mEq/L (Valor de referência: 3,5-5,5 mEq/L). O ECG da admissão é mostrado abaixo. (VER IMAGEM). Quais os achados que podem ser observados no eletrocardiograma (ECG) do paciente? Qual a possível relação dos achados encontrados no ECG e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

o quadro neurológico apresentado pelo paciente?

A) Resposta:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97862)

Enunciado: Um homem com 72 anos de idade, com antecedentes de hipertensão arterial desde os 40 anos de idade e ?arritmia cardíaca? há dois anos, em uso de captopril: 25 mg de 12/12h, hidroclorotiazida: 25 mg/dia e warfarina: 5 mg/dia, deu entrada no pronto-socorro com quadro de hemiplegia direita, completa e proporcionada, de início súbito há cerca de 9 horas. O paciente nega outras comorbidades, cirurgias ou traumas prévios, episódios semelhantes ou sangramentos anteriores. No exame físico da chegada ao hospital se observou um paciente em regular estado geral, eupneico (frequência respiratória = 16 irpm), acianótico, descorado (+/4+). Na ausculta cardíaca se observou um ritmo taquicárdico, em 2 tempos, sem sopros, frequência cardíaca = 148 bpm, pressão arterial = 190 x 100 mmHg. A ausculta pulmonar e o exame do abdome estavam normais e não havia edema de membros inferiores. Ao exame neurológico, paciente consciente, com leve desorientação temporoespacial, Glasgow = 15, pupilas simétricas e fotorreagentes, sem sinais de irritação meníngea. Observava-se hemiplegia completa à direita, sem alterações da sensibilidade. Escala de Acidente Vascular Cerebral do National Institute of Health = 18. Foi realizada tomografia computadorizada de crânio sem contraste que não revelou sangramentos ou áreas de hipodensidade. Os resultados dos exames laboratoriais foram os seguintes: leucócitos = 12.000/mm³ (Valor de referência: 4.500 - 11.000/mm³) com 74% de segmentados, 1% de eosinófilos, 15% de linfócitos; hemoglobina = 13 g/dl (Valor de referência: 13,5 - 17,5 g/dl); hematócrito = 33,3% (Valor de referência: 41-53%); plaquetas = 231.000/mm³ (Valor de referência: 150.000-350.000/mm³); glicemia = 84 mg/dl (Valor de referência: 80-100 mg/dl); ureia = 30 mg/dl (Valor de referência 20-35 mg/dl); creatinina = 1,2 mg/dl (Valor de referência : 0,8-1,4 mg/dl); tempo de protrombina = 19,5s (Valor de referência: 12,5-15,5s); atividade de protrombina = 30% (Valor de referência: 70-120%); INR = 2,1; tempo de tromboplastina parcial ativada = 35s (Valor de referência: 24-45s); Relação = 1,0; Na sérico = 135 mEq/L (Valor de referência: 135-145 mEq/L); K+ sérico = 4,1 mEq/L (Valor de referência: 3,5-5,5 mEq/L). O ECG da admissão é mostrado abaixo (VER IMAGEM). Cite 3 condutas adequadas à taquiarritmia apresentada pelo paciente, no contexto do quadro clínico geral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

A) Resposta:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97794)

Enunciado: Um homem com 53 anos de idade, tabagista e com história prévia de cardiopatia, tem parada cardiorrespiratória na unidade básica de saúde, enquanto aguardava atendimento. A sequência CORRETA de medidas a serem adotadas nessa situação é:

A) Verificar o nível de consciência; acionar o serviço de emergência; verificar o pulso; iniciar compressões torácicas.

B) Iniciar compressões torácicas; verificar o pulso; acionar o serviço de emergência; verificar o nível de consciência.

C) Acionar o serviço de emergência; verificar o pulso; verificar o nível de consciência; iniciar compressões torácicas.

D) Acionar o serviço de emergência; avaliar o nível de consciência; iniciar compressões torácicas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64449)

Enunciado: Paciente feminino, 75 anos, dá entrada no setor de emergência com quadro de tontura, falta de ar, sonolenta e hipotensa. O ECG evidencia fibrilação atrial com frequência cardíaca de 130 BPM. Sua conduta é:

A) desfibrilação cardíaca imediata

B) cardioversão elétrica imediata

C) amiodarona 300 mg EV em bolus

D) adenosina 1 amp EV

E) N.D.A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

75557)

Enunciado: Mulher com 60 anos de idade, hipertensa, vai à consulta em Unidade Básica de Saúde porque apresentou quadro de parestesias e hemiparesia no membro superior esquerdo há uma semana, com reversão espontânea completa em 12 horas. Pressão arterial = 180 x 110 mmHg, ausculta cardíaca com ritmo irregular, em 2 tempos, exame neurológico sem alterações significativas. Traz tomografia computadorizada de crânio sem contraste, realizada no dia dos sintomas, que é normal. Realizou eletrocardiograma conforme mostrado abaixo - DII (traz exame semelhante feito há 60 dias). (VER IMAGEM). Qual outro fármaco, além do tratamento anti-hipertensivo, é o mais indicado para essa paciente como medida de maior impacto na prevenção de novos episódios do quadro neurológico?

A) Warfarina.

B) Clopidogrel.

C) Ticlopidina.

D) Atorvastatina.

E) Ácido acetilsalicílico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137579)

Enunciado: Um homem de 55 anos de idade, portador de infecção pelo HIV, diabético do tipo II, hipertenso, em terapia antiretroviral, estável há 6 anos, com contagem de linfócitos CD4 de 980 células/mm (valor de referência < 1 000 células/mm) e carga viral indetectável (< 25 cópias/mL), apresentou quadro de perda súbita e transitória da consciência, com queda da própria altura e recuperação espontânea. Na semana seguinte ao episódio, procurou o médico clínico que o acompanha; a

hipertensão arterial e o diabetes mellitus mantinham-se controlados. O paciente relatou que, desde o episódio mencionado, sente ?palpitações? e ?pulso acelerado?. O médico observou no exame cardiovascular: frequência cardíaca = 105 bpm; pressão arterial = 140 x 90 mmHg, ritmo cardíaco irregular, achados que não haviam sido até então documentados em 10 anos de seguimento ambulatorial do paciente. O eletrocardiograma realizado naquela ocasião mostra ausência de ondas P e intervalos RR muito irregulares. A conduta imediata mais adequada é

A) monitorizar o paciente por 48 horas, para observar a

possibilidade de reversão espontânea da arritmia.

B) encaminhar o paciente para a emergência cardiológica, para ser submetido à cardioversão elétrica.

C) solicitar ecocardiograma transesofágico, para avaliar a presença de trombos em átrio esquerdo.

D) iniciar heparinização plena e warfarina, para minimizar o

risco existente de doença tromboembólica.

E) administrar antiarrítmicos intravenosos, para induzir reversão farmacológica da arritmia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138414)

Enunciado: Adolescente, após tentativa de suicídio com ingestão de antidepressivo tricíclico, manifestou parada cardiorrespiratória. Durante a reanimação cardiopulmonar, observou-se o seguinte ritmo no monitor cardíaco (VER IMAGEM). A análise do monitor cardíaco permite afirmar que o traçado eletrocardiográfico demonstra ritmo de

A) taquicardia ventricular, que pode ser responsiva a choque e a uso de atropina.

B) fibrilação ventricular, que pode ser responsiva a cardioversão (choque no modo sincronizado).

C) fibrilação ventricular, que pode ser responsiva a desfibrilação (choque no modo sincronizado).

D) taquicardia ventricular, que pode ser responsiva a cardioversão (choque no modo sincronizado).

E) taquicardia ventricular, que pode ser responsiva a desfibrilação (choque no modo não sincronizado).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

31041)

Enunciado: Um paciente de 28 anos de idade com diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, que estava recebendo Quimioterapia (QT) curativa, hidratação adequada e agente hipouricêmico, passou a apresentar, no 7° dia após o início da QT, os seguintes achados laboratoriais: ácido úrico sérico de 12 mg/dl (valores de referência de 3,5 mg/dl a 7,2 mg/dl) e fosfato sérico de 8,0 mg/dl (valores de referência de 2.5 mg/dl a 4,5 mg/dl). O paciente também realizou Eletrocardiograma (ECG) convencional de 12 derivações conforme figura abaixo (traçado realizado com velocidade do papel de 25 mm/s e calibração de 10 mm = 1 mV). (VER IMAGEM). Com base nessas informações e no ECG acima, julgue o item seguinte: Flutter atrial típico com condução atrioventricular 2:1 representa o ritmo de base observado nesse ECG.

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138584)

Enunciado: Paciente, com 57 anos de idade, sexo masculino, chega ao pronto atendimento queixando-se de palpitações que se iniciaram há três dias, associadas à tontura e à dispneia. Relata fazer uso de metimazol 10 mg/dia há um mês por diagnóstico de hipertireoidismo. Faz uso ainda de enalapril 20 mg para hipertensão arterial desde os 45 anos de idade. Ao exame: Pressão arterial = 110 x 70 mmHg; Frequência cardíaca = 160 BPM; Frequência respiratória = 26 irmp; rítmo cardíaco taquicárdico, irregular, em dois tempos, sem sopros; murmúrio vesicular fisiológico com crepitações bibasais; abdome livre, indolor, ruídos hidroaéreos positivos; aparelho locomotor sem alterações. Saturação periférica de oxigênio de 87%. Solicitado ECG: (VER IMAGEM). Instalada a suplementação de oxigênio e monitorização cardíaca. Assinale a alternativa que identifica a arritmia e a conduta a ser tomada ainda na sala de pronto atendimento.

A) Flutter atrial e amiodarona.

B) Taquicardia supra ventricular paroxistica e procainamida.

C) Sindrome de Wolff-Parkinson-White e beta bloqueador.

D) Taquicardia atrial multifocal e bloqueadores de canais de cálcio.

E) Fibrilação atrial e digitálico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

22169)

Enunciado: Um paciente de 58 anos de idade, sem quaisquer sintomas procurou atendimento médico ambulatorial com vistas à realização de checkup. Informou ser tabagista há 25 anos e que sua mãe e seu pai faleceram de ataque cardíaco, ambos aos 75 anos de idade. Relatou também sedentarismo. O exame clínico mostrou paciente consciente, orientado, eupneico, pressão arterial de 95 x 80 mmHg, frequência cardíaca de 75 bpm, índice de massa corporal igual a 28 Kg/m². Exame do aparelho respiratório e do abdome sem anormalidades. Extremidades com discretas varizes em membros inferiores. O exame cardiovascular evidenciou precórdio calmo, ictus cordis visível e palpável no 5º espaço intercostal esquerdo e na linha hemiclavicular esquerda, com 2,5 cm de extensão com impulsividade aumentada (cupuliforme), presença de frêmito sistólico +3/-4 em foco aórtico irradiado para fúrcula esternal e ao longo do trajeto das artérias carótidas. Auscultou-se ritmo cardíaco regular em três tempos à custa de quarta bulha, segunda bulha única em foco aórtico (apenas componente P2) presença de clique sistólico sucedido por sopro sistólico ejetivo, grau IV de Levine, mais bem audível em foco aórtico e irradiado para a base de pescoço e para as artérias carótidas, que reduz de intensidade após a realização da manobra de preensão manual (hand grip), pulso carotídeo tem amplitude reduzida e enchimento com duração lentificada, ausência de turgência jugular a 45°. O eletrocardiograma mostrou ritmo sinusal, com frequência ventricular média de 70 bpm, eixo do QRS a -35°, sobrecarga atrial esquerda, onda S em V1 com 35 mm de amplitude intradesnivelamento do segmento ST com onda T negativa (padrão strain) em derivações V5 e V6. Considerando os dados clinicoslaboratoriais apresentados acima, julgue o item subsequente. Considere ainda que o paciente em questão, em outro dia, tenha dado entrada no pronto-socorro com quadro de edema agudo de pulmão e durante a monitorização eletrocardiográfica, tenha sido realizado o registro em papel (velocidade do papel 25 mm/s, calibração 1 cm = 1 mV, derivação de monitor MCl) apresentado abaixo. Nessa situação, é correto afirmar que a arritmia observada é a taquicardia paroxística supraventricular com reentrada nodal. (VER IMAGEM)

A) certo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

B) errado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

19226)

Enunciado: Considere que uma paciente, com 60 anos de idade, tenha apresentado quadro de perda súbita da consciência precedida por acesso de tosse, tendo recobrado a consciência cerca de 1 minuto após a adoção de medidas de urgência. Considere ainda que, no exame físico, não tenha sido verificada nenhuma alteração, mas a revisão de seu histórico clínico revelou que era portadora de asma persistente grave. Nessa situação, a etiologia mais provável é distúrbio metabólico.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

19227)

Enunciado: Considere que uma paciente, com 60 anos de idade, tenha apresentado quadro de perda súbita da consciência precedida por acesso de tosse, tendo recobrado a consciência cerca de 1 minuto após a adoção de medidas de urgência. Considere ainda que, no exame físico, não tenha sido verificada nenhuma alteração, mas a revisão de seu histórico clínico revelou que era portadora de asma persistente grave. Nessa situação, a etiologia mais provável é síncope de tosse.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

352188)

Enunciado: Sobre a fibrilação atrial, selecione a alternativa incorreta:

A) Fibrilação atrial paroxística é aquela que é revertida espontaneamente ou com intervenção médica em até 7 dias de seu início.

B) Fibrilação atrial persistente é aquela com episódios com duração superior a 7 dias.

C) O termo fibrilação atrial permanente é utilizado nos casos em que as tentativas de reversão ao ritmo sinusal não serão mais instituídas.

D) Considera-se fibrilação atrial aguda quando iniciada há menos de 7 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

345697)

Enunciado: O eletrocardiograma nas mulheres difere:

A) Em relação à magnitude dos sinais elétricos, com maior amplitude do QRS, do ponto J e da onda T e maior intervalo QT corrigido.

B) Em relação à magnitude dos sinais elétricos, com menor amplitude do QRS, do ponto J e da onda T e menor intervalo QT corrigido.

C) Em relação à magnitude dos sinais elétricos, com menor amplitude do QRS, do ponto J e não da onda T e maior intervalo QT corrigido.

D) Em relação à magnitude dos sinais elétricos, com menor amplitude do QRS, do ponto J e da onda T e maior intervalo QT corrigido.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

346839)

Enunciado: Homem de 68 anos se queixa de tontura ao se levantar. É portador de DM-2 e HAS, e faz uso de metformina, clortalidona e enalapril. Ao exame físico, PA/FC: (deitado) 190x96mmHg/62bpm; PA/FC: (em pé) 90x46mmHg/61bpm; PA/FC: (após 3 minutos de ortostatismo) 82x40mmHg/64bpm. Hemoglobina glicada 8,9%. Assinale a alternativa que apresenta uma conduta INCORRETA para esse paciente:

A) Prescrever dapagliflozina.

B) Orientar o aumento da ingestão de água e sal.

C) Orientar dormir com a cabeceira elevada (30 a 45 graus).

D) Substituir clortalidona e enalapril por captopril uma vez ao dia antes de dormir.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

345701)

Enunciado: MJD, feminina de 40 anos, procurou seu atendimento por ter realizado ECG com achados no exame periódico. A inversão da onda T anterior, isso é, além de V1, ocorre em cerca de 2,3% da população e é mais comum em mulheres, independentemente do status de atividade física. Sendo correto que:

A) É um padrão maligno desde que ocorra em assintomáticas e de baixo risco, pois estudos sugerem que possa refletir um deslocamento lateral do ventrículo direito.

B) É um padrão benigno desde que não ocorra em assintomáticas e de baixo risco, pois estudos sugerem que possa refletir um deslocamento lateral do ventrículo direito.

C) É um padrão benigno desde que ocorra em assintomáticas e de baixo risco, pois estudos sugerem que possa refletir um deslocamento lateral do ventrículo direito.

D) É um padrão benigno desde que ocorra em assintomáticas e de alto risco, pois estudos sugerem que possa refletir um deslocamento lateral do ventrículo direito.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

345705)

Enunciado: VLD, feminina de 34 anos, apresentou dor torácica relacionada a cirurgia plástica, porém informou que seu ECG estava com achados, por isso solicitou sua avaliação. Sua posição foi de que alterações eletrocardiográficas são observadas em 45% das portadoras de implantes mamários sendo correto que:

A) Inversão de ondas T, depressão do segmento ST inferolateral, alta progressão de R de V1-V4, intervalo QT prolongado e hipertrofia ventricular esquerda, podendo assim levar a interpretações enganosas.

B) Inversão de ondas T, depressão do segmento ST inferolateral, baixa progressão de R de V1-V4, intervalo QT prolongado e hipotrofia ventricular esquerda, podendo assim levar a interpretações enganosas.

C) Inversão de ondas T, depressão do segmento ST inferolateral, baixa progressão de R de V1-V4, intervalo QT prolongado e hipertrofia ventricular esquerda, podendo assim levar a interpretações enganosas.

D) Inversão de ondas T, depressão do segmento ST inferolateral, baixa progressão de R de V1-V4, intervalo QT prolongado e hipertrofia ventricular esquerda, nunca podendo assim levar a interpretações enganosas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337624)

Enunciado: Paciente 70 anos, sexo feminino, procura atendimento com quadro de piora do estado geral há alguns meses, informa que tem observado perda de peso, mesmo com aumento do apetite. Relata que tem apresentado tremor de extremidades ocasionalmente. E o que tem mais lhe incomodado são as palpitações que tem se tornado mais frequentes, principalmente nas últimas 2 semanas atrapalhando suas atividades da vida diária. Informa ser apenas hipertensa em uso de hidroclorotiazida. Nega outras comorbidades. Você observa os exames solicitados em última consulta em UBS que ainda não haviam sido avaliados e opta por realizar um ECG de 12 derivações. Ao exame: PA: 145x90mmHg, Sat.99%, FR: 18irmp, FC:144bpm, Hb: 10,1g/dL, Ht: 29%, GL: 4500, Plaq: 129.000mm³, TSH: 0,001 e T4L: 5,4. Considerando o caso descrito, assinale a alternativa que apresenta a conduta MAIS adequada.

A) Realizar cardioversão sincronizada seguido de anticoagulação, encaminhar para realização de tireoidectomia.

B) Iniciar amiodarona ou propafenona para controle de ritmo seguido de anticoagulação com enoxaparina, solicitar TRAB e iniciar metimazol.

C) Iniciar metoprolol para controle de frequência e rivaroxabana como anticoagulante, encaminhar para ultrassom de tireoide.

D) Iniciar atenolol para controle de frequência, warfarina como anticoagulante e iniciar metimazol.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

345706)

Enunciado: As mulheres têm mais taquicardia:

A) Sinusal e taquicardia por reentrada nodal, sendo que a gravidez reduz o risco de taquicardias supraventriculares

B) Sinusal e taquicardia por reentrada nodal, sendo que a gravidez aumenta o risco de taquicardias supraventriculares.

C) Sinusal e não de taquicardia por reentrada nodal, sendo que a gravidez aumenta o risco de taquicardias supraventriculares.

D) Sinusal e taquicardia por reentrada nodal, sendo que a gravidez não aumenta o risco de taquicardias supraventriculares.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

346856)

Enunciado: Isadora, 10 anos, sem história prévia de doenças, apresentou subitamente episódio de taquicardia, dificuldade de respirar, acompanhada de palidez e sensação de desmaio. Relata a ?sensação do coração estar saindo pela boca?. Nega desmaios ou síncopes. Ao chegar no pronto-atendimento, a pediatra notou olhar ansioso, FC: 220bpm, PA: 120x70mmHg, enchimento capilar adequado. Aparelho Respiratório - FR: 48irpm, sem ruídos adventícios. Abdômen: fígado e baço não palpados. Foi inicialmente tratado com manobras vagais, sem resposta. Um ECG é obtido e mostrou taquicardia, QRS estreito e ausência de onda P. Considerando o caso apresentado, o diagnóstico MAIS provável é de:

A) Taquicardia sinusal.

B) Bloqueio Mobitz tipo I.

C) Taquicardia ventricular monomórfica.

D) Taquicardia supraventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

335100)

Enunciado: Homem de 58 anos de idade, hipertenso e diabético, sem histórico de eventos isquêmicos, tem FA persistente recém-diagnosticada. Faz uso de enalapril, anlodipina, metformina e AAS. Nega uso de álcool ou drogas. Hemograma, função hepática e coagulograma normais. Não faz uso de AINE e não tem histórico de úlcera nem de quedas. Seu ecocardiograma mostra miocardiopatia dilatada com leve regurgitação mitral funcional. É proposta adequada para o paciente:

A) Iniciar anticoagulação com varfarina, mantendo o AAS.

B) Iniciar anticoagulação com varfarina, suspendendo o AAS.

C) Manter apenas oAAS, sem iniciar anticoagulante.

D) Manter o AAS e associar clopidogrel.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

336303)

Enunciado: Homem, 74 anos, hipertenso e diabético internado na UTI em pós operatório de debridamento cirúrgico de ?pé-diabético? infectado em membro inferior direito. Inicia quadro de sudorese, precordialgia e taquicardia seguida de perda do nível de consciência. Monitor eletrocardiográfico apresenta o traçado abaixo. Qual a conduta imediata?

A) Cardioversão elétrica

B) Amiodarona

C) Desfibrilação

D) Adenosina

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

304993)

Enunciado: Assinale a alternativa que apresenta a causa que pode determinar a ocorrência de flutter atrial:

A) Cardiopatia hipertensiva.

B) Infarto agudo do miocárdio.

C) Miocardiopatia dilatada.

D) Cardiopatia chagásica aguda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

304854)

Enunciado: Durante o atendimento à parada cardiorrespiratória, o acesso venoso profundo está contraindicado. A explicação que fundamenta tal recomendação é:

A) Piora do prognóstico neurológico por interrupção das compressões torácicas.

B) Maior risco de ocorrência de pneumotórax.

C) Dificuldade técnica no acesso venoso central.

D) Maior incidência de punção de vasos arteriais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283892)

Enunciado: No tratamento das taquiarritmias supraventriculares regulares, com estabilidade hemodinâmica, qual das alternativas abaixo NÃO é capaz de reverter a taquiarritmia?

A) Manobra de Valsalva.

B) Massagem do seio carotídeo.

C) Contato facial com água gelada.

D) Uso de adenosina intravenosa.

E) Respirar dentro de um saco plástico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227077)

Enunciado: Homem de 77 anos se queixa de palpitação em repouso. Sem outras queixas. Nega doenças conhecidas ou uso de medicamentos. Ao exame físico, PA: 140 X 90mmHg, FC 116bpm, FR 15ipm, SpO? 98%. O ritmo cardíaco é irregular, a primeira bulha é hiperfonética e há sopro mesodiastólico em ruflar no apex do coração. Sem outras alterações ao exame físico. Ecocardiograma: ventrículo esquerdo de dimensões levemente aumentadas, sem déficits segmentares da contratilidade e fração de ejeção de 40%. Átrio esquerdo de volume muito aumentado. Estenose mitral moderada e insuficiência mitral moderada de morfologia reumática. Não se visualizam trombos. Eletrocardiograma; Considerando o caso descrito, assinale a alternativa que apresenta a prescrição CORRETA para esse paciente.

A) Bisoprolol e varfarina.

B) Digoxina e enoxaparina.

C) Diltiazem e rivaroxabana.

D) Metoprolol e apixabana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234408)

Enunciado: Uma mulher de 78 anos vai ao consultório de Clínica Médica para uma consulta de acompanhamento clínico. Está assintomática. É portadora de insuficiência cardíaca e faz uso de furosemida, enalapril, metoprolol, espironolactona e digoxina. Ao exame físico, apresenta-se alerta e orientada. Os dados vitais são PA: 120 X 70mmHg, FC: 30bpm, FR: 17ipm, SpO? em ar ambiente 97%. O exame cardiovascular revela bradicardia e variação da fonese da primeira bulha. Sem outras anormalidades ao exame físico. Solicitou-se um eletrocardiograma apresentado a seguir: Considerando o caso descrito, assinale a conduta imediata MAIS ADEQUADA para essa paciente.

A) Administrar atropina, dopamina ou dobutamina em infusão contínua pela via intravenosa.

B) Posicionar um marcapasso transvenoso até a colocação do marca-passo definitivo.

C) Suspender o metoprolol e realizar o estudo eletrofisiológico após 48h.

D) Suspender o metoprolol e a digoxina e manter a monitoração clínica e eletrocardiográfica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

232140)

Enunciado: Paciente de 23 anos, com palpitações, apresenta o eletrocardiograma a seguir. Qual o diagnóstico?

A) Fibrilação atrial.

B) Taquicardia sinusal.

C) Taquicardia atrial unifocal.

D) Taquicardia atrial multifocal.

E) Taquicardia atrial incessante.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

232141)

Enunciado: Paciente de 84 anos, evoluindo com quadros de síndromes convulsivas tônico-clônicas de repetição, que se iniciam ao repouso, não acompanhadas de liberação esfincteriana. Procurou consultório do cardiologista, onde chegou deambulando normalmente e, no meio da consulta, apresentou uma síncope, seguida de crise convulsiva. Nesse momento, foi realizado eletrocardiograma abaixo, que confirmou o diagnóstico:

A) Bloqueio átrio-ventricular avançado alternante.

B) Bloqueio átrio-ventricular do segundo grau.

C) Bloqueio átrio-ventricular do tipo 2:1.

D) Bloqueio átrio-ventricular do primeiro grau.

E) Bloqueio átrio-ventricular total.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

227322)

Enunciado: Paciente feminina, 6 anos, será submetida à cirurgia eletiva e ao ser examinada notou-se ritmo cardíaco irregular, sem outros sinais ou sintomas. Feito ECG que demonstrou:

Baseado na história e ECG, o diagnóstico provável é:

A) Arritmia sinusal.

B) Bloqueio AV de segundo grau.

C) Bloqueio AV de primeiro grau.

D) Escape juncional por provável distúrbio eletrolítico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199493)

Enunciado: Uma mulher de 76 anos apresentou perda súbita da consciência e caiu da cadeira onde estava sentada conversando com o filho. Recobrou totalmente o sensório após 2 minutos. Negou quaisquer sintomas ou sinais antes e após esse episódio. É portadora de diabetes Mellitus, doença renal crônica e angina do peito. Sofreu de infarto agudo do miocárdio há 10 anos. O exame clínico revelou PA 90 x 50mmHg, FC 104bpm, FR 25ipm, SpO2 91%. Os exames respiratório, cardiovascular, abdominal e neurológico resultaram normais. Sobre o caso descrito, assinale a alternativa CORRETA:

A) A ausência de pródromo afasta a possibilidade de causa cardíaca.

B) A síncope dessa paciente é postural e pode ser devida à disautonomia da neuropatia periférica do diabetes.

C) A principal hipótese diagnóstica é hipoglicemia.

D) O tromboembolismo pulmonar deve ser considerado no diagnóstico diferencial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

220298)

Enunciado: Mulher de 45 anos apresentou perda da consciência após se levantar e sair do ônibus em frente a um Pronto-Socorro. Recuperou completamente a consciência em 2 minutos e estava assintomática. Relatou uma sensação de escurecimento visual e tontura logo antes da queda. Era diabética e hipertensa há 20 anos, com tratamento irregular. Possuía doença renal crônica (estádio 3) e gastroparesia diabética. Fazia uso de hidroclorotiazida, atenolol e metformina. Ao exame físico, estava alerta, orientada, corada, hidratada. PA (deitada): 130 x 80mmHg, FC: 103bpm, FR: 17ipm, SpO2 98%, Glicemia Capilar: 168mg/dL. Os exames respiratório, cardiovascular e abdominal resultaram normais. O exame neurológico revelou hipoestesia em botas nos pés. Observe o eletrocardiograma a seguir: Sobre o caso descrito, assinale a alternativa CORRETA:

A) Trata-se de um caso de crise convulsiva atônica e a paciente deve ser tratada com fenitoína IV.

B) Trata-se de um caso de síncope cardiogênica por arritmia e a paciente deve ser submetida à avaliação cardiológica.

C) Trata-se de um caso de síncope vasovagal e a paciente deve realizar um tilt test.

D) Trata-se de um caso de síncope postural e deve ser considerado o uso de meias elásticas compressivas e fludrocortisona.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199633)

Enunciado: Pré-escolar, masculino, 5 anos de idade, está internado para a correção cirúrgica de hérnia inguinal. Ao ser examinado, notou-se que a frequência cardíaca era irregular, sem outras anormalidades no exame físico. O Eletrocardiograma (ECG) demonstra o seguinte traçado. Após análise do eletrocardiograma, o diagnóstico é:

A) Arritmia sinusal.

B) Bloqueio AV de 1º grau.

C) Bloqueio AV de 2º grau.

D) Bloqueio de ramo direito.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196806)

Enunciado: Um dos muitos acrósticos usados em medicina é o CHADS 2, (evoluiu para CHA2 DS2-VASC), usado para avaliar risco de acidente vascular cerebral em pessoas com fibrilação atrial, medida importante para médicos que atuam em Atenção Primária à Saúde (APS). Entre as opções abaixo qual a condição clínica é pontuada nesta avaliação de risco? Marque a CORRETA:

A) Crise hipertensiva.

B) Hipertensão intracraniana.

C) Alteração de ritmo cardíaco.

D) Diabetes mellitus.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172784)

Enunciado: Homem de 56 anos chega ao pronto-socorro com quadro súbito de palpitações e dispneia. Ao exame físico apresenta frequência cardíaca de 145 bpm, pressão arterial de 112 x 75 mmHg, e o seguinte traçado eletrocardiográfico. São fatores de risco para o quadro clínico citado:

A) Consumo de bebida alcoólica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

B) Apneia obstrutiva do sono, obesidade.

C) Hipertensão arterial, tabagismo.

D) Insuficiência cardíaca, hipotireoidismo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172544)

Enunciado: Na reanimação cardiopulmonar:

A) A vasopressina mostrou-se claramente superior à adrenalina, mas seu custo bastante superior inviabiliza seu emprego na maior parte dos hospitais públicos e ou filantrópicos do Brasil

B) A amiodarona pode ser usada em determinado momento do protocolo de atendimento da fibrilação ventricular (FV), apesar de não haver nenhum estudo que mostre sua real capacidade de prevenção de morte súbita, por exemplo, em pacientes portadores de miocardiopatia isquêmica grave.

C) A amiodarona foi abolida na revisão mais recente do protocolo de FV feita pela American Heart Association, visto a falta de evidências claras que dêem suporte ao seu uso.

D) A atropina deve ser usada imediatamente após a assistolia ter sido detectada na monitorização cardíaca, uma vez que a demora tornará inútil o emprego nesses casos.

E) A intubação orotraqueal não poderá ser realizada em hipótese alguma antes do segundo ciclo de reanimação, independentemente do diagnóstico inicial e causa da parada cardiorrespiratória.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155343)

Enunciado: A fibrilação atrial ocorre com certa frequência em pacientes com insuficiência cardíaca, podendo ser uma das causas de descompensação clínica do paciente. Quando necessário, a reversão dessa arritmia deve ser feita com um antiarrítmico com pouco ou nenhum efeito inotrópico negativo. Qual opção abaixo indica o fármaco preferido para restaurar e manter o ritmo sinusal nesses casos?

A) Digoxina.

B) Quinidina.

C) Disopiramida.

D) Amiodarona.

E) Flecainida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155370)

Enunciado: Em paciente com fibrilação atrial aguda e sem cardiopatia estrutural, caso o médico opte por reversão da arritmia com droga, qual das abaixo seria a de primeira escolha?

A) Amiodarona.

B) Propafenona.

C) Adenosina.

D) Quinidina.

E) Sotalol.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155467)

Enunciado: Dentre as opções abaixo, é causa de parada cardiorrespiratória:

A) Hipercalcemia.

B) Hiperglicemia.

C) Trombose venosa profunda.

D) Hipertermia.

E) Intoxicação por Organofosforado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155419)

Enunciado: No idoso, a diminuição das respostas cronotrópicas e inotrópicas aos beta-agonistas deve-se à(ao):

A) Redução da responsividade dos receptores beta-adrenérgicos.

B) Aumento do número de receptores adrenérgicos.

C) Aumento da responsividade dos receptores beta-adrenérgicos.

D) Redução do número de receptores alfa-adrenérgicos.

E) Aumento da responsividade dos receptores alfa e beta-adrenérgicos > plasmática.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127150)

Enunciado: Paciente de 52 anos chega ao pronto socorro com dor precordial e durante o atendimento médico apresenta parada cardiorespiratória. Nesta situação, a primeira conduta a ser tomada deve ser:

A) Abertura de vias aéreas.

B) Intubação orotraqueal.

C) Compressões torácicas ritmadas.

D) Cardiodesfibrilação.

E) Ventilação com dispositivo bolsa-máscara.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127178)

Enunciado: Paciente admitido na emergência trazido pelos familiares 10 minutos após ser encontrado inconsciente em casa. Constata-se arresponsividade, ausência de pulso e de respiração. Ritmo apresentado ao monitor: (VER IMAGEM) Assinale a conduta mais apropriada:

A) Iniciar compressões torácicas e ventilação adequada na relação 30:2.

B) Desfibrilar imediatamente.

C) Ventilar e iniciar imediatamente as compressões torácicas.

D) Administrar 1 mg de adrenalina por via endovenosa.

E) Administrar imediatamente amiodarona iniciando as compressões torácicas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126896)

Enunciado: Uma pessoa de aproximadamente 50 anos perde a consciência em um shopping, cai e você vai ajudá-la. No seu exame inicial o paciente está imóvel, sem movimentos respiratórios, sem pulso central. Não há desfibrilador no local e a ambulância do SAMU só chegará em 12 minutos. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA a ser adotada até a chegada da Unidade Móvel.

A) Realizar suporte básico de vida (30 compressões torácicas intercaladas com 2 ventilações) até a chegada de um desfibrilador.

B) Realizar um soco precordial para simular a desfibrilação, pois este paciente provavelmente teve uma PCR por fibrilação ventricular.

C) Realizar imediatamente 2 ventilações de resgate e se o paciente não recuperar a consciência iniciar as compressões torácicas.

D) Realizar suporte básico de vida (15 compressões torácicas intercaladas com 2 ventilações) até a chegada de um desfibrilador.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131651)

Enunciado: No tratamento da parada cardíaca, em pacientes que continuam a ter fibrilação ventricular, apesar da desfibrilação com corrente direta após epinefrina, pode ser administrado o seguinte agente intravenoso:

A) Metoprolol;

B) Verapamil;

C) Flecainide;

D) Digoxina;

E) Amiodarona.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106418)

Enunciado: Em pacientes com flutter atrial, onde optamos por reversão da arritmia para ritmo sinusal, qual a maneira mais efetiva para reversão?

A) Amiodarona venosa.

B) Digital venoso.

C) Ibutilide.

D) Cardioversão elétrica.

E) Manobra vagal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102765)

Enunciado: Paciente de 41 anos, sexo feminino, evoluindo com dispneia (NYHA II) nos últimos 3 meses, procura Pronto Atendimento devido à piora aguda do quadro e palpitações. Relata ter feito uso de antibiótico injetável até os 17 anos (não sabe o motivo), mas interrompeu por conta própria. Não faz acompanhamento médico desde então e desconhece outras comorbidades. Não está em uso de nenhum medicamento. Ao exame físico, apresentava FC: 168 bpm, PA: 130 x 70 mmHg, FR: 26 irpm. Jugulares planas, sem edema periférico. Pulsos arrítmicos, cheios e de amplitude variável. Ritmo cardíaco irregular em 3 tempos, B1 hipofonética e presença de 3ª bulha, com sopro holossistólico grau III/VI irradiando para axila. MVF com discretas crepitações em bases. Demais sistemas sem alterações. Com relação ao manejo da Fibrilação Atrial - FA - dessa paciente, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Trata-se de uma FA aguda, devendo-se, portanto, realizar cardioversão elétrica imediata.

B) Caso a cardioversão não seja bem sucedida, deve-se optar por anticoagulação com varfarina, dabigatrana ou rivaroxabana.

C) Não se pode determinar o tempo de início da FA, por isso, a cardioversão só é segura após realização de ecocardiograma transesofágico.

D) Caso o controle do ritmo cardíaco não seja possível, além da anticoagulação, deve ser realizado controle da frequência cardíaca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102756)

Enunciado: Paciente admitido no pronto-socorro após tentativa de autoextermínio, apresentando sonolência, bradicardia, pupilas puntiformes bilateralmente, hipersalivação, tosse com secreção hialina e diarreia aquosa profusa, sem controle esfincteriano. Considerando o caso descrito, além das medidas básicas iniciais de suporte à vida, assinale a alternativa que apresenta a MELHOR conduta para tentar reverter esse quadro.

A) Administrar atropina EV 1 mg, de 10 em 10min, até a recuperação dos valores normais e dos níveis séricos de acetilcolinesterase.

B) Administrar epinefrina EV 1 mg, de 10 em 10min, até correção completa da bradicardia, miose e sonolência.

C) Administrar atropina EV 1 mg, de 10 em 10min, até melhorar a hipersalivação, broncorreia e diarreia.

D) Administrar neostigmina EV 1 mg, de 10 em 10min, até a recuperação dos valores normais e dos níveis séricos de acetilcolinesterase.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102759)

Enunciado: Assinale a alternativa que NÃO representa um efeito colateral típico da amiodarona.

A) Hipotireoidismo.

B) Bloqueio atrioventricular.

C) Necrose tubular aguda.

D) Pneumonite intersticial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

100977)

Enunciado: Em relação ao manejo da Parada Cardiorrespiratória (PCR), assinale a alternativa INCORRETA:

A) Quando a monitorização com desfibrilador manual revela ritmo de Fibrilação Ventricular/ Taquicardia Ventricular Sem Pulso (FV/TVSP), a prioridade deve ser a desfibrilação o mais precoce possível.

B) Em qualquer ritmo de PCR, a primeira droga a ser utilizada deve ser um vasopressor.

C) O atraso no início da administração de vasopressores para além dos primeiros dois minutos de PCR, bem como a demora em instalar via aérea avançada, podem estar associados a pior prognóstico.

D) Monitorização do dióxido de carbono exalado (> 10 mmHg) é um bom indicador da qualidade da reanimação.

E) Atropina não é recomendada em caso de parada cardíaca em assistolia ou atividade elétrica sem pulso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

77323)

Enunciado: Conforme o último guideline de atendimento da parada cardiorrespiratória da American Heart Association, em que momento do protocolo de atendimento da assistolia a atropina deve ser usada?

A) Assim que identificada no monitor.

B) Após o primeiro ciclo de ressuscitação cardiopulmonar.

C) Após a passagem do marca-passo transvenoso.

D) Não deve ser usada rotineiramente neste protocolo.

E) Após a passagem do marca-passo transcutâneo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

77343)

Enunciado: Qual das afirmações sobre os efeitos da epinefrina durante a tentativa de ressuscitação é verdadeira?

A) A epinefrina reduz a resistência vascular periférica e diminui a pós-carga miocárdica, de modo que as contrações ventriculares são mais eficazes.

B) A epinefrina melhora a pressão de perfusão da artéria coronária e estimula as contrações espontâneas quando há assistolia.

C) A epinefrina é contraindicada na fibrilação ventricular, pois aumenta a irritabilidade miocárdica.

D) A epinefrina reduz o consumo de oxigênio miocárdico.

E) Nenhuma das respostas acima.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88890)

Enunciado: Amiodarona é um antiarrítmico muito usado na prática clínica, porém pode causar efeitos colaterais importantes. Qual evento adverso abaixo não pode ser atribuído à Amiodarona?

A) Fibrose pulmonar.

B) Hipotireoidismo.

C) Síndrome do QT longo.

D) Convulsões.

E) Hipertireoidismo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88888)

Enunciado: Paciente de 21 anos com episódios de pré-síncopes e síncopes, associados à sudorese fria e náuseas. ECG normal. Qual exame deve ser solicitado para elucidar o diagnóstico?

A) Holter.

B) Tilt-Test.

C) Ecocardiograma com Doppler.

D) Estudo eletrofisiológico.

E) RM cardíaca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88886)

Enunciado: Paciente de 30 anos, admitido com mal-estar, dispneia e síncope. ECG mostra supradesnivelamento de segmento ST em V1 e V2, e padrão de BRD em V1. Cateterismo realizado, imediatamente, foi normal. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

A) Síndrome de Dressler.

B) Síndrome do QT longo.

C) Síndrome de Brugada.

D) Displasia arritmogênica do VD.

E) Síndrome do QT curto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

59336)

Enunciado: Em relação aos novos anticoagulantes orais marque a alternativa CORRETA:

A) Apesar de apresentarem a comodidade posológica de não ser necessário o controle de RNI, ainda não conseguiram comprovar em estudos randomizados uma eficácia semelhante à warfarina na prevenção de fenômenos tromboembólicos em portadores de fibrilação atrial.

B) Apresentam taxas de sangramento maior (hemorragia intracraniana, por exemplo) superiores à warfarina, por isso nenhum deles foi liberado ainda para uso em idosos acima de 80 anos.

C) A dabigratana (Pradaxa) é o único já liberado para uso na prevenção de fenômenos cardioembólicos relacionados à fibrilação atrial.

D) Podem ser usados em pacientes com próteses cardíacas metálicas para prevenção de trombose, com eficácia comprovadamente não inferior à warfarina.

E) A rivaroxabana (Xarelto) além de poder ser usada na prevenção de fenômenos tromboembólicos relacionados à fibrilação atrial, apresenta estudos bem conduzidos no tratamento de pacientes com embolia pulmonar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

44005)

Enunciado: Paciente masculino, 04 anos, internado na enfermaria de pediatria com diagnóstico de pneumonia e derrame pleural à esquerda, de pequeno volume sem indicação de drenagem. Ao ser examinado, foi auscultado ritmo cardíaco irregular. O restante do exame não demonstrou anormalidades, além da taquidispneia leve e crepitações em base esquerda. No traçado eletrocardiográfico observa-se: (VER IMAGEM). Qual o diagnóstico?

A) Se esse achado for associado com crossa da aorta posicionada à direita da traqueia visto ao raio X de tórax, o diagnóstico provável é de tetralogia de Fallot.

B) Se houver história pregressa de prematuridade, o diagnóstico provável é de canal arterial persistente.

C) Esse achado eletrocardiográfico é compatível com situs inversus.

D) Provavelmente o paciente apresenta alteração no estímulo parassimpático para o coração resultando em aumento da frequência cardíaca na inspiração e diminuição na expiração.

E) Se houver história pregressa de síncope, o diagnóstico provável é de síndrome de Wolff-Parkinson-White.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

23070)

Enunciado: Mulher de 25 anos é atendida no pronto-socorro com história de palpitações taquicárdicas, de início súbito, após discussão familiar, associada a mal-estar geral, sem sinais de baixo débito. PA = 110/70 mmHg. Frequência Cardíaca = 180 bpm e eletrocardiograma demonstrando taquicardia de QRS estreito. Qual a primeira conduta a ser tomada?

A) Amiodarona 300 mg endovenosa

B) Propafenoma 600 mg via oral

C) Cedilanide meia ampola endovenosa

D) Manobra vagal

E) Adenosina 02 ampolas endovenosa

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

23171)

Enunciado: Na fibrilação atrial crônica, há fatores considerados de fraco, moderado e elevado risco para complicações trombo-embólicas. Nas alternativas abaixo, marque aquela em que os 3 fatores de risco são classificados como elevados:

A) ataque isquêmico transitório prévio, idade avançada, hipertensão arterial.

B) embolia arterial periférica prévio, prótese valvular mitral, coronariopatia.

C) idade avançada, cononariopatia, baixa fração de ejeção do ventrículo esquerdo.

D) AVC isquêmico prévio, baixa fração de ejeção do ventrículo esquerdo, estenose mitral.

E) embolia arterial prévia, prótese valvular mitral, estenose mitral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9392)

Enunciado: Em um paciente idoso com hipotensão arterial postural sintomática idiopática, qual medicamento poderá ser empregado?

A) Amiodarone.

B) Aminofilina.

C) Codeína.

D) Midodrine.

E) Cloridrato dietilefedrina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

8164)

Enunciado: Qual a conduta imediata preconizada para um paciente que chega à emergência queixando-se de palpitação súbita há 25 minutos, encontrando-se taquicárdico (FC = 200 bpm), dispneico (FR > 30 ipm, presença de estertores em bases), sudorese fria, leve letargia e hipotenso (PA = 70/50 mmHg) com ECG mostrando quadro de Fibrilação Atrial?

A) Desfibrilação imediata com 360 Joules.

B) Cardioversão Elétrica Sincronizada iniciando-se com 100 Joules.

C) Bolus de 150 a 300 mg de Amiodarona EV, seguida de posterior infusão contínua de droga (01 mg/min primeiras 6 horas e 0,5 mg/mn nas 18 horas seguintes).

D) Digitálico EV.

E) Betabloqueador EV (Metoprolol 05mg EV em bollus, podendo-se repetir até dose máxima de 15 mg).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

363960)

Enunciado: Para qual destas situações há indicação CLASSE I de implante de marcapasso definitivo?

A) Doença do nó sinusal em pacientes em uso de amiodarona.

B) Bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz I (Wenckebach) durante o sono.

C) Sincope recorrente, > 40 anos de idade e documentação de pausa sintomática espontânea maior que 6 segundos

D) Pacientes com miocardiopatia hipertrófica forma obstrutiva, mesmo com gradiente de via de saída de ventrículo esquerdo baixo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

330059)

Enunciado: Com relação à classificação dos sopros cardíacos, é INCORRETO afirmar:

A) Os sopros fisiológicos mais comuns são: o sopro sistólico pulmonar, o sopro musical de Still, o sopro cardiovascular e o sopro venoso.

B) Os sopros de Flint são originados no aparelho cardiovascular por aumento da velocidade do sangue ou por alterações anatômicas dos aparelhos orovalvares.

C) Os sopros na anemia originam-se na artéria pulmonar e são decorrentes do aumento da velocidade do sangue, causado pela diminuição de sua viscosidade.

D) Os sopros orgânicos ocorrem quando existir uma comunicação anormal entre as várias cavidades cardíacas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

331961)

Enunciado: Mulher, 73 anos, tem diagnóstico de fibrilação atrial paroxística. Antecedentes pessoais: hipertensão controlada com medicação. Nega diabetes, outras doenças ou internações prévias. Radiograma de tórax: área cardíaca normal, sem calcificações vasculares. Em relação à abordagem terapêutica da fibrilação atrial nesta paciente, é correto:

A) O escore de CHADS-VASC é de 3, sem indicação de terapia antitrombótica, pela ausência de evidência de eventos prévios.

B) O escore de CHADS-VASC é de 2, sendo que um ponto é pelo gênero, sem indicação de terapia antitrombótica.

C) O escore de CHADS-VASC é de 3, com indicação de terapia antitrombótica.

D) O escore de CHADS-VASC não se aplica nessa situação, por se tratar de arritmia paroxística

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

330063)

Enunciado: O eletrocardiograma, também chamado de ECG, é o registro gráfico dos fenômenos elétricos do músculo cardíaco ou do coração. Com base no tema, é CORRETO afirmar:

A) O complexo QRS representa a despolarização e a condução do impulso nos ventrículos.

B) O ECG é registrado em papel gráfico, na velocidade (linha vertical) de 20 mm/s, ou 1mm a cada 0,04 segundos.

C) As derivações periféricas são obtidas no plano horizontal, pela colocação de eletrodos no tórax do paciente.

D) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial V4 deve ser de 4° espaço intercostal à direita, próximo ao esterno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

330069)

Enunciado: Dispneia é um termo que indica uma experiência subjetiva de dificuldade ou desconforto respiratório, que consiste em sensações qualitativamente distintas, de intensidade variável, e é traduzida por diferentes sinais semiológicos. Podem acontecer manifestações de dispneia quando o paciente assume uma posição reclinada, comum em portadores de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC). Esta afirmação refere-se a:

A) Ortopneia.

B) Trepopneia.

C) Platipneia.

D) Disparapneia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

342615)

Enunciado: As arritmias cardíacas são decorrentes, basicamente, de alterações na geração do impulso (automatismo anormal e atividade deflagrada) e/ou na condução do impulso (reentrada). Sobre os principais mecanismos de taquiarritmia mais prevalentes na população pediátrica, sua classificação e tratamento, não podemos afirmar que:

A) as células miocárdicas atriais e ventriculares normalmente não apresentam atividade de marca-passo

B) a reentrada é o mecanismo gerador de taquiarritmias supraventriculares e ventriculares mais frequente e relevante, podendo ser anatômica ou funcional

C) as arritmias cardíacas podem ser classificadas, quanto à repercussão clínica, em estável ou instável

D) cicatrizes (fibroses) miocárdicas secundárias à cardiopatia estrutural não favorecem o desenvolvimento de reentrada

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

330088)

Enunciado: Com relação às arritmias cardíacas em Pediatria, é CORRETO afirmar:

A) A taquicardia ventricular tem início geralmente abrupto, exceto em lactentes, que apresentam irritabilidade, inapetência e dispneia enquanto evoluem para insuficiência cardíaca congestiva.

B) O paciente com bloqueio atrioventricular deve ser submetido diretamente à cardioversão elétrica sincronizada ou à cardioversão química com adenosina, o que for mais rápido na situação.

C) A taquicardia sinusal é definida como frequência cardíaca maior do que 220 bpm no lactente e maior do que 180 bpm nas crianças maiores, com complexo QRS estreito e ausência de onda P.

D) Os sinais clínicos associados à bradiarritmia podem ser choque com hipotensão, perfusão ineficiente de órgão- alvo, alteração do nível de consciência ou colapso súbito.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300803)

Enunciado: O eletrocardiograma realiza a reprodução gráfica da atividade elétrica do coração durante o seu funcionamento, registrada a partir da superfície do corpo. Quanto às principais alterações eletrocardiográficas, onda P com orientação normal e frequência cardíaca < 50 bpm denotam:

A) Parada sinusal.

B) Bloqueio sinoatrial (BSA).

C) Bradicardia sinusal.

D) Bloqueio de ramo esquerdo (BRE).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300914)

Enunciado: O uso de betabloqueadores via oral ou intravenosa após a PCR por FV/TVSP mostrou reduzir mortalidade 72 horas após e em 6 meses. Está CORRETO o item:

A) Não podem levar à piora hemodinâmica, exacerbar sinais de Insuficiência Cardíaca (IC) e causar arritmias.

B) No entanto, podem levar à piora hemodinâmica, e nunca exacerbar sinais de Insuficiência Cardíaca (IC) e causar arritmias.

C) No entanto, podem levar à piora hemodinâmica, exacerbar sinais de Insuficiência Cardíaca (IC) e causar arritmias.

D) No entanto, podem levar à piora hemodinâmica, exacerbar sinais de Insuficiência Cardíaca (IC) e não causar arritmias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313197)

Enunciado: Com relação à Fibrilação Atrial (FA), assinale a alternativa correta:

A) a FA paroxística diminui sua incidência com o aumento da idade

B) a FA apresenta baixa morbimortalidade em mulheres hipertensas acima de 80 anos

C) a FA persistente é a forma mais comum de apresentação

D) a FA paroxística que apresenta reversão espontânea apresenta baixa taxa de recorrência, e o paciente pode ser mantido sem anticoagulação, independentemente de outros fatores de risco

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

317939)

Enunciado: A melhor conduta diante de uma idosa com doença de Chagas que apresenta taquicardia ventricular sustentada, FC 155bpm e PA 85x55mmHg é:

A) amiodarona endovenosa.

B) lidocaína endovenosa.

C) cardioversão elétrica.

D) implante imediato de cardiodesfibrilador.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

295354)

Enunciado: Dentre as arritmias conhecidas, qual é a mais comum durante atendimentos de emergência?

A) Extrassistolia ventricular.

B) Taquicardia sinusal.

C) Fibrilação atrial.

D) Taquicardia ventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300916)

Enunciado: Em adultos com FV/TVSP, observou-se que a administração de amiodarona 300 mg ou 5 mg/kg melhorou a sobrevida à admissão hospitalar, quando comparada com placebo ou administração de lidocaína. No entanto, não houve melhora do prognóstico neurológico. Podemos indicar como CORRETO que:

A) A amiodarona não pode ser considerada para FV/TVSP que não responde à RCP, desfibrilação e terapêutica vasopressora.

B) A amiodarona pode ser considerada para FV/TVSP que responde à RCP, desfibrilação e terapêutica vasopressora.

C) A amiodarona pode ser considerada para FV/TVSP que não responde à RCP, desfibrilação e não a terapêutica vasopressora.

D) A amiodarona pode ser considerada para FV/TVSP que não responde à RCP, desfibrilação e terapêutica vasopressora.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

317940)

Enunciado: A melhor conduta diante de um idoso com fibrilação atrial sem data certa de início, FC = 110 BPM e PA 130x85 mmHg é:

A) cardioversão química.

B) cardioversão elétrica.

C) controle de frequência cardíaca e anticoagulação.

D) estudo eletrofisiológico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300917)

Enunciado: Para pacientes com disfunção ventricular sistólica, a amiodarona e a digoxina são as drogas mais utilizadas como Drogas Antiarrítmicas (DAA). Sendo ADEQUADO nesse contexto o item:

A) Bloqueadores de canal de cálcio e betabloqueadores intravenosos não devem ser evitados quando houver esta suspeita clínica (área cardíaca aumentada, edema de membros inferiores, hepatomegalia, turgência jugular a 45º e história clínica de IC).

B) Bloqueadores de canal de cálcio e betabloqueadores intravenosos devem ser evitados quando houver esta suspeita clínica (área cardíaca aumentada, edema de membros inferiores, hepatomegalia, turgência jugular a 45º e história clínica de IC).

C) Bloqueadores de canal de cálcio e betabloqueadores intravenosos devem ser evitados quando não houver esta suspeita clínica (área cardíaca aumentada, edema de membros inferiores, hepatomegalia, turgência jugular a 45º e história clínica de IC).

D) Bloqueadores de canal de cálcio e betabloqueadores intravenosos devem ser utilizados quando houver esta suspeita clínica (área cardíaca aumentada, edema de membros inferiores, hepatomegalia, turgência jugular a 45º e história clínica de IC).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

317162)

Enunciado: Com base no traçado do Eletrocardiograma abaixo, assinale a correta:

A) A frequência cardíaca é de 100 bpm.

B) O ritmo não é sinusal

C) Observa-se um desvio do eixo elétrico para esquerda

D) Provável síndrome coronariana aguda

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300920)

Enunciado: A atropina antagoniza a ação da acetilcolina, um neurotransmissor parassimpático, nos receptores muscarínicos. Está CORRETO que:

A) Dessa forma, ela não bloqueia o efeito do nervo vago tanto no nó sinoatrial como no nó atrioventricular, aumentando a frequência de disparos do nó sinusal e facilitando a condução atrioventricular.

B) Dessa forma, ela bloqueia o efeito do nervo vago tanto no nó sinoatrial como no nó atrioventricular, reduzindo a frequência de disparos do nó sinusal e facilitando a condução atrioventricular.

C) Dessa forma, ela bloqueia o efeito do nervo vago tanto no nó sinoatrial como no nó atrioventricular, aumentando a frequência de disparos do nó sinusal e dificultando a condução atrioventricular.

D) Dessa forma, ela bloqueia o efeito do nervo vago tanto no nó sinoatrial como no nó atrioventricular, aumentando a frequência de disparos do nó sinusal e facilitando a condução atrioventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300922)

Enunciado: Diversos sistemas manifestam sinais e sintomas como os listados a seguir relacionados a ritmos com taquicardia, que são indicativos deste comprometimento hemodinâmico, sendo CORRETO o item:

A) Alteração no nível de consciência; hipotensão arterial sistêmica (Pressão Arterial Sistólica - PAS < 70 mmHg) ou choque circulatório com alteração da perfusão periférica; congestão pulmonar; e dor precordial anginosa.

B) Alteração no nível de consciência; hipotensão arterial sistêmica (Pressão Arterial Sistólica - PAS < 90 mmHg) ou choque circulatório com alteração da perfusão periférica; congestão pulmonar; e dor precordial anginosa.

C) Alteração no nível de consciência; hipotensão arterial sistêmica (Pressão Arterial Sistólica - PAS < 90 mmHg) ou choque circulatório sem alteração da perfusão periférica; congestão pulmonar; e dor precordial anginosa.

D) Alteração no nível de consciência; hipotensão arterial sistêmica (Pressão Arterial Diastólica - PAD < 90 mmHg) ou choque circulatório com alteração da perfusão periférica; congestão pulmonar; e dor precordial anginosa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300926)

Enunciado: Adenosina é uma droga que diminui a condução pelo nó atrioventricular e promove vasodilatação coronária. Sendo CORRETO que:

A) Possui meia-vida de menos de 5 a 10 minutos, tendo efeito fugaz, porém efetivo no término da maioria das taquicardias de QRS estreito.

B) Possui meia-vida de menos de 5 a 10 segundos, tendo efeito fugaz, porém efetivo no término da maioria das taquicardias de QRS estreito.

C) Possui meia-vida de menos de 5 a 10 segundos, tendo efeito fugaz, e inefetivo no término da maioria das taquicardias de QRS estreito.

D) Possui meia-vida de menos de 5 a 10 segundos, tendo efeito fugaz, porém efetivo no término da maioria das taquicardias de QRS largo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300927)

Enunciado: As contraindicações absolutas à adenosina são listadas adequadamente na alternativa:

A) Bloqueio atrioventricular de primeiro grau, disfunção do nó sinusal e FA pré-excitada.

B) Bloqueio de ramo direito, disfunção do nó sinusal e FA pré-excitada.

C) Bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro graus, disfunção do nó sinusal e FA pré-excitada.

D) Bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro graus, disfunção do nó átrio ventricular e FA pré-excitada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

311919)

Enunciado: Mulher, 61 anos, solteira, procura um pronto atendimento de uma unidade hospitalar após perceber, de forma ocasional, uma redução da sua frequência cardíaca. Dá entrada na unidade com frequência cardíaca de 40bpm, PA de 120x80mmHg, tempo de enchimento capilar de um segundo, consciente, negando dispneia ou dor torácica. Após avaliação do D2 longo no ECG, qual é a conduta imediata?

A) Monitorizar e administrar atropina.

B) Monitorizar e programar passagem de marcapasso definitivo.

C) Monitorizar e passar marcapasso transvenoso.

D) Monitorizar e iniciar dopamina em BIC.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300930)

Enunciado: Verapamil e diltiazem mostraram-se efetivos em reversão para ritmo sinusal em diversos ensaios clínicos e nesse contexto, assinale a alternativa correta:

A) Permanecem como tratamento de segunda linha para o tratamento das taquicardias supraventriculares.

B) Permanecem como tratamento de primeira linha para o tratamento das taquicardias ventriculares.

C) Permanecem como tratamento de primeira linha para o tratamento das bradicardias supraventriculares.

D) Permanecem como tratamento de primeira linha para o tratamento das taquicardias supraventriculares.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

311923)

Enunciado: Utilizando como base o BLS/ACLS, como deve orientar sua equipe em vigência de uma parada cardiorrespiratória, visando a uma reanimação de qualidade?

A) Velocidade de compressão até 100 vezes por minuto.

B) Administrar adrenalina a cada 2 minutos.

C) Se houver via área avançada, manter massagem cardíaca contínua com ventilações a cada 6 segundos.

D) Profundidade de compressão entre 5-7 cm.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300933)

Enunciado: Em pacientes estáveis com Fibrilação Atrial e Flutter Atrial, dados como Fração de Ejeção de Ventrículo Esquerdo (FEVE), tempo de duração da arritmia (menor ou maior que 48 horas) e presença de pré-excitação ventricular (síndrome de Wolf-Parkinson-White) estão de acordo com o item:

A) São dispensáveis para tomada de decisões acerca de indicação de anticoagulação, reversão do ritmo ou controle da resposta ventricular e avaliação da segurança para reversão do ritmo.

B) São imprescindíveis para tomada de decisões acerca de indicação de anticoagulação, reversão do ritmo ou controle da resposta ventricular e avaliação da segurança para reversão do ritmo.

C) São imprescindíveis para tomada de decisões acerca de indicação de anticoagulação, reversão do ritmo e não do controle da resposta ventricular e avaliação da segurança para reversão do ritmo.

D) São imprescindíveis para tomada de decisões acerca de indicação de anticoagulação, reversão do ritmo ou controle da resposta ventricular e nunca da avaliação da segurança para reversão do ritmo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

308286)

Enunciado: Paciente é encontrado não responsivo em leito de enfermaria pela equipe de enfermagem que, de imediato, aciona o código azul. Você se dirige para avaliação do caso e percebe que o paciente não responde e não apresenta pulso. O carrinho de parada já se encontra no cenário. Neste contexto, a melhor conduta imediata é:

A) Desfibrilação com 200 J.

B) RCP por 2 minutos seguida de avaliação de ritmo.

C) Amiodarona EV 300mg em bolus.

D) Cardioversão com 200 J.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273122)

Enunciado: A anamnese possui elementos estruturais que buscam trazer fatos e dados de grande relevância para a construção do raciocínio diagnóstico que, a partir da história clínica do paciente, bem como do conhecimento de determinados fatores a ele relacionados, possibilitam a definição da estratégia a ser utilizada para exames complementares e procedimentos medicinais adequados diante do diagnóstico do paciente. Faz parte da estrutura da anamnese:

A) O reconhecimento.

B) Histórico de doenças futuras.

C) Queixa e duração.

D) Hábitos religiosos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

285058)

Enunciado: Uma paciente de 26 anos procurou a emergência com queixas de pal pitações e dispneia aos esforços, iniciadas há três dias. Ao exame, apresenta-se eupneica, conscien te e orientada, com turgência jugular, estertores fi nos em bases pulmonares, ritmo cardíaco irregu larmente irregular com frequência de 120 bpm e sopro diastólico no ictus cordis. PA 120x70mmHg. Qual a medida recomendada nesse momento?

A) Diltiazem.

B) Amiodarona.

C) Ecocardiograma transesofágico.

D) Cardioversão elétrica.

E) Warfarin.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

258162)

Enunciado: Durante uma partida de futebol em um clube da cidade, um jogador cai no gramado espontaneamente, ou seja, sem contato com outro jogador ou objeto. À avaliação inicial, encontrava-se irresponsivo, sem ventilação espontânea e sem pulso. Foram iniciadas manobras de reanimação. Em menos de três minutos houve a chegada da caixa de socorro com ambu e máscara facial e dispositivo automático externo (DEA), que estavam bem próximos ao campo de futebol. Nesse caso, qual deverá ser a próxima conduta?

A) Manter massagem cardíaca externa e ventilação com máscara e ambu na frequência 30:2, sem interrupções enquanto aguarda-se o socorro médico.

B) Instalar o DEA, de acordo com as instruções, e aguardar até 15 segundos para leitura do ritmo.

C) Instalar o DEA e após cinco segundos, se o ritmo não for identificado, reiniciar a massagem cardíaca externa.

D) Realizar ajuste manual para desfibrilação com 200J, caso o ritmo não for identificado pelo DEA após cinco segundos e o paciente continuar sem pulso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

257720)

Enunciado: Homem de 44 anos, obeso, fumante e dislipidêmico, apresenta um episódio de fibrilação atrial após ingesta excessiva de bebida alcoólica. De acordo com a classificação de CHA2DS2-VASc, qual o tratamento adequado para prevenção de fenômeno tromboembólico?

A) Orientação e acompanhamento.

B) Aspirina 100 mg, ao dia.

C) Warfarina.

D) Rivaroxabana 20 mg, ao dia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

258171)

Enunciado: Os betabloqueadores pertencem a qual classe de antiarrítmicos?

A) V.

B) IV.

C) III.

D) II.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

265855)

Enunciado: A terapia farmacológica também pode ser recomendada para se restaurar o ritmo sinusal de Fibrilação Atrial e Flutter Atrial de início < 48 horas, sendo ADEQUADO o item:

A) É a primeira escolha (reservar para casos em que a CVE e seu preparo - sedação - impõem risco alto para o paciente). Vários estudos foram realizados para definir a eficácia de medicações na cardioversão química da FA.

B) Não é a primeira escolha (exceto para casos em que a CVE e seu preparo - sedação - impõem risco alto para o paciente). Vários estudos foram realizados para definir a eficácia de medicações na cardioversão química da FA.

C) Não é a primeira escolha (reservar para casos em que a CVE e seu preparo - sedação - impõem risco alto para o paciente). Não existem estudos realizados para definir a eficácia de medicações na cardioversão química da FA.

D) Não é a primeira escolha (reservar para casos em que a CVE e seu preparo - sedação - impõem risco alto para o paciente). Vários estudos foram realizados para definir a eficácia de medicações na cardioversão química da FA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

265856)

Enunciado: Evidências recentes mostraram que a lidocaína apresentou mesma taxa de sobrevida quando comparada à amiodarona em PCR extra-hospitalar. Podemos indicar como CORRETO que:

A) A dose inicial recomendada é de 1,0 a 1,5 mg/kg por via intravenosa. Se a FV/TVSP não persistir, uma segunda dose de 0,5 a 0,75 mg/kg pode ser administrada. Seu uso pode ser considerado após a PCR em FV/TVSP em infusão contínua.

B) A dose inicial recomendada é de 1,0 a 1,5 mg/kg por via intravenosa. Se a FV/TVSP persistir, uma segunda dose de 0,5 a 0,75 mg/kg pode ser administrada. Seu uso não pode ser considerado após a PCR em FV/TVSP em infusão contínua.

C) A dose inicial recomendada é de 1,0 a 1,5 mg/kg por via intravenosa. Se a FV/TVSP persistir, uma segunda dose de 0,5 a 0,75 mg/kg pode ser administrada. Seu uso pode ser considerado após a PCR em FV/TVSP em infusão não contínua.

D) A dose inicial recomendada é de 1,0 a 1,5 mg/kg por via intravenosa. Se a FV/TVSP persistir, uma segunda dose de 0,5 a 0,75 mg/kg pode ser administrada. Seu uso pode ser considerado após a PCR em FV/TVSP em infusão contínua.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274767)

Enunciado: Paciente de 76 anos, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus, descobre recentemente ser portador de fibrilação atrial. Sobre a profilaxia de acidente vascular cerebral nesses pacientes:

A) não está indicado o uso de anticoagulantes orais após a cardioversão e manutenção do ritmo sinusal.

B) apesar da necessidade de monitorização da sua atividade, a varfarina apresenta menor risco de sangramento intracraniano nesses pacientes.

C) antiagregantes plaquetários não são eficazes, e não devem ser utilizados para profilaxia de AVC.

D) os anticoagulantes orais diretos (DOAC) são mais eficazes que a varfarina em previnir AVC, independente da droga e a dose escolhida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

265858)

Enunciado: Estudos observacionais mostraram que a administração de sulfato de magnésio por via intravenosa pode finalizar TV polimórfica do tipo TdP, podemos indicar como CORRETO que:

A) É efetiva para TV polimórfica em pacientes com intervalo QT normal.

B) Não é efetiva para TV polimórfica do tipo TdP.

C) Não é efetiva para TV polimórfica em pacientes com intervalo QT normal.

D) Não é efetiva para TV polimórfica em pacientes com intervalo QT padrão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

265859)

Enunciado: Em relação à orientação do uso de drogas e manobras no Suporte Avançado de Vida em adultos, indique o item ERRADO:

A) Amiodarona ou lidocaína devem ser considerados como antiarrítmico de primeira escolha para FV/TVSP que não responde a RCP, desfibrilação e vasopressor.

B) O uso de lidocaína pode ser considerado alternativa na PCR em FV/TVSP.

C) O uso precoce de betabloqueadores pode ser considerado em pacientes pós-RCE por ritmos de FV/TVSP

D) O soco precordial pode ser considerado na TV instável em pacientes monitorizados, quando um desfibrilador está imediatamente pronto para uso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

265861)

Enunciado: O cálcio apresenta papel no mecanismo celular de contração miocárdica e da musculatura lisa vascular. Indique o item com ERRO:

A) Não há evidências científicas que deem suporte ao uso rotineiro do cálcio na RCP.

B) Seu uso pode ser considerado, na dose de 0,5 a 1 g (gluconato de cálcio 10%, de 15 a 30 mL, ou cloreto de cálcio 10%, de 5 a 10 mL).

C) Seu uso pode ser considerado nas seguintes condições de PCR: hiperpotassemia, hipocalcemia e intoxicação por agentes bloqueadores dos canais de cálcio.

D) Utilizar soluções de cálcio e bicarbonato de sódio simultaneamente na mesma via de administração.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281992)

Enunciado: Em relação à prevenção de fenômenos tromboembolicos na fibrilação atrial, é correto afirmar que:

A) Os NOACs (novos anticoagulantes orais) reduzem as taxas de acidente vascular encefálico hemorrágico ao serem comparados aos antagonistas da vitamina K.

B) A anticoagulação plena só é indicada nas formas persistente e permanente da fibrilação ou flutter.

C) O escore CHADSVASC é usado para avaliar risco tromboembólico, sendo indicada anticoagulação com escores acima de 3 pontos.

D) O anticoagulante de preferência em pacientes com prótese valvar mecânica aórtica é o dabigatrana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

265865)

Enunciado: Na Massagem do Seio Carotídeo (MSC), temos esse mesmo reflexo, sendo CORRETO que:

A) Inibido pela pressão externa no bulbo carotídeo, estimulando seus barorreceptores.

B) Deflagrado pela pressão externa no bulbo carotídeo, reprimindo seus barorreceptores.

C) Deflagrado pela pressão interno no bulbo carotídeo, estimulando seus barorreceptores.

D) Deflagrado pela pressão externa no bulbo carotídeo, estimulando seus barorreceptores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281996)

Enunciado: O ano de 2020 foi um ano marcado por diversas atualizações publicadas pela AHA (American Heart Association) em que houve algumas modificações. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta:

A) Os elos da cadeia de sobrevivência bem como as medidas de cuidados pós-parada cardíaca foram ratificados em 2020, por recentes estudos e níveis de recomendações cada vez mais elevados.

B) Nos ritmos em assistolia ou atividade elétrica sem pulso (AESP), a prioridade é a administração precoce de adrenalina 1 mg. Além disso, o acesso intravenoso se tornou definitivamente a preferência, só devendo o intraósseo ser utilizado se não houve sucesso. A busca por causas reversíveis pelo 5H/5T não foram modificadas.

C) No algoritmo das bradicardias instáveis foi dobrada a dose de atropina para 1mg a cada 3 a 5min, assim como a dose mínima de dopamina de 2 para 5Mcg/kg/min.

D) No caso da FV/TV, a prioridade é realizar desfibrilação elétrica na carga recomendada pelo fabricante (em geral 200J bifásico, mas na dúvida coloque a carga máxima do seu aparelho) e reiniciar a massagem cardíaca. A sequência de drogas, adrenalina e amiodarona, está mantida, bem como os ciclos de 30:2 compressão/ventilação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274478)

Enunciado: Paciente sexo feminino, 55 anos, chega ao pronto atendimento com queixa de palpitação. Ao avaliar paciente você não identifica nenhum sinal de instabilidade clínica. Saturação adequada na oximetria. Ao monitorá-la, percebe uma taquicardia monomórfica de complexo largo. Paciente se mantém comunicando normalmente. Dentro deste contexto a conduta inicial MAIS ADEQUADA é:

A) Amiodarona venosa 300 mg em bolus.

B) Amiodarona venosa 150 mg em 10 minutos.

C) Milrinone venoso 300 mg em 10 minutos.

D) Milrinone venoso 150 mg em bolus.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

265869)

Enunciado: São antecedentes familiares importantes na avaliação de crianças e adolescentes que apresentam síncope, EXCETO:

A) Doença cardíaca congênita.

B) Arritmias.

C) Doenças metabólicas.

D) História de pneumonia com derrame em pais ou irmãos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

265884)

Enunciado: Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao exame físico de crianças com síncope:

A) Os sinais vitais devem ser registrados exclusivamente com o paciente em posição ortostática.

B) Se a pressão sistólica de adolescentes, após a realização dos dois registros dos sinais vitais, for menor do que 80 mmHg ou houver variação de mais de 30mmHg, a etiologia provável é vagal mediada.

C) A palpação do precórdio na avaliação cardiológica pode sugerir doenças cardíacas estruturais.

D) Qualquer deficiência focal ou anormalidade no exame neurológico deve alertar o pediatra para possibilidade convulsão ou outra doença neurológica como causa da síncope.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274834)

Enunciado: Adolescente, sexo masculino, 12 anos, comparece a consulta solicitando atestado para prática de natação. Assintomático, sem história familiar de risco para doença cardiovascular. Exame físico: dados vitais e exame segmentar normais. Traz eletrocardiograma realizado há um ano para avaliação pré-operatória de cirurgia ortopédica com laudo de arritmia sinusal. A conduta indicada neste caso é:

A) indicar Tilt teste.

B) realizar ecocardiograma.

C) liberar para prática de natação.

D) solicitar novo eletrocardiograma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

229491)

Enunciado: Para os pacientes estáveis, com FA (Fibrilação Atrial) persistente, que vão se submeter à cardioversão elétrica ou química, recomenda-se a ACO (Anticoagulante Oral) por pelo menos 3 semanas antes e 4 semanas após cardioversão na faixa terapêutica (RNI entre 2 a 3). Somente está ERRADO o item:

A) Após 2 semanas, a manutenção da ACO deve ser de acordo com score de risco de CHA2 DS2 VASC.

B) O uso de ACO está indicado para os pacientes com flutter atrial nas mesmas considerações que na FA.

C) A dose preferencial de rivaroxabana deve ser de 20 mg/dia, desde que tenham baixo risco de sangramento.

D) A dose preferencial de dabigatrana deve ser de 150 mg 2x/dia, desde que tenham baixo risco de sangramento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

229495)

Enunciado: Para paciente submetidos à cardioversão elétrica guiada por ECOTE e sem trombos, recomenda-se a HNF EV (bolus seguido de infusão contínua) antes da cardioversão e deve-se mantê-la até que a ACO plena seja atingida. Somente devemos indicar como ERRADO:

A) Para pacientes com FA que necessitam de cardioversão elétrica de emergência, recomenda-se a HNF EV (bolus seguido de infusão intermitente).

B) Para paciente submetidos à cardioversão elétrica guiada por ECOTE e sem trombos, recomenda-se a HBPM antes da cardioversão e deve-se mantê-la até que a anticoagulação oral plena seja atingida.

C) Para pacientes com FA que necessitam de cardioversão elétrica de emergência, recomenda-se dose plena de HBPM.

D) Se for identificado trombo, anticoagulação dever ser mantida por 3 semanas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249464)

Enunciado: Para que ocorra uma melhoria nas estruturas e nos sistemas de saúde, que é um dos pontos essenciais no sucesso do atendimento da parada cardiorrespiratória (PCR), sendo inadequado apenas:

A) Criação de um sistema integrado com treinamento de pessoas.

B) Auxílio de materiais de emergência.

C) Transportes para um atendimento unificado.

D) Disponibilidade de DEA em locais públicos com baixa movimentação de pessoas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249467)

Enunciado: Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia ? 2019. Listamos abaixo itens referentes à cadeia de elos de sobrevivência diferenciadas no contexto de uma parada cardiorrespiratória (PCR) intra-hospitalar, determine o item que não pode ser considerado como parte da mesma:

A) RCP imediata de alta qualidade.

B) Rápida desfibrilação.

C) Suporte básico de Vida.

D) Cuidados pós-PCR.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249468)

Enunciado: A Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares inseridos nos Cuidados pós-PCR, apresenta como importante ponto o item:

A) Ênfase na avaliação neurológica, cumprimento das metas hemodinâmicas e controle térmico, com maior tolerância na variação de temperatura e prevenção de febre.

B) Ênfase na avaliação neurológica, cumprimento das metas hemodinâmicas e controle térmico, com menor variação de temperatura e prevenção de febre.

C) Ênfase na avaliação neurológica, cumprimento das metas hemodinâmicas e controle térmico, com menor variação de temperatura e sem prevenção de febre.

D) Ênfase na avaliação neurológica, sem o cumprimento das metas hemodinâmicas e controle térmico, com menor variação de temperatura e prevenção de febre.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249471)

Enunciado: A adequada abordagem de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares com ênfase nos cuidados após o retorno à circulação espontânea trouxe melhorias nos resultados, contribuído ao prognóstico dos pacientes. Podemos assim determinar como adequado que:

A) O reconhecimento precoce das causas desencadeantes, orientando a intervenção para cada cenário clínico.

B) O reconhecimento tardio das causas desencadeantes, orientando a intervenção para cada cenário clínico.

C) O reconhecimento precoce das causas desencadeantes, desorientando a intervenção para cada cenário clínico.

D) O reconhecimento precoce das causas desencadeantes, não orientando a intervenção para cada cenário clínico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

248912)

Enunciado: As arritmias cardíacas são decorrentes, basicamente, de alterações na geração do impulso (automatismo anormal e atividade deflagrada) e/ou na condução do impulso (reentrada). Sobre os principais mecanismos de taquiarritmia mais prevalentes na população pediátrica, sua classificação e tratamento, não podemos afirmar que:

A) as células miocárdicas atriais e ventriculares normalmente não apresentam atividade de marca-passo

B) a reentrada é o mecanismo gerador de taquiarritmias supraventriculares e ventriculares mais frequente e relevante, podendo ser anatômica ou funcional

C) as arritmias cardíacas podem ser classificadas, quanto à repercussão clínica, em estável ou instável

D) cicatrizes (fibroses) miocárdicas secundárias à cardiopatia estrutural não favorecem o desenvolvimento de reentrada

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249477)

Enunciado: O algoritmo do protocolo no atendimento de uma PCR é formado pela cadeia de elos de sobrevivência diferenciadas, está de acordo com o item:

A) O protocolo no atendimento de uma PCR segue uma sequência lógica e fundamentada de condutas que melhoram as taxas de reversibilidade do processo inicial que desencadeou o evento.

B) O protocolo no atendimento de uma PCR segue uma sequência lógica, mas não fundamentada de condutas que melhoram as taxas de reversibilidade do processo inicial que desencadeou o evento.

C) O protocolo no atendimento de uma PCR segue uma sequência lógica e fundamentada de condutas que melhoram as taxas de reversibilidade do processo final que desencadeou o evento.

D) O protocolo no atendimento de uma PCR segue uma sequência lógica e fundamentada de condutas que melhoram as taxas de reversibilidade do processo inicial que não desencadeou o evento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

247411)

Enunciado: Paciente de 57 anos, sexo masculino, é admitido no pronto-socorro com dor torácica em queimação, retroesternal, de início há três horas, de forte intensidade, associada à sudorese e palpitações. Ao ser monitorizado, seus sinais vitais revelam PA = 164/98 mmHg, Frequência Cardíaca (FC) de 172bpm, Frequência Respiratória (FR) de 24 irpm e Saturação de Oxigênio (SaO?) em 94%. O ritmo ao monitor é o seguinte: A conduta imediata é:

A) cardioversão elétrica sincronizada.

B) adenosina 6 mg IV.

C) amiodarona 150mg IV.

D) metoprolol 5mg IV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249870)

Enunciado: Pediatra recebe no pronto-socorro, trazida pelos bombeiros, uma criança, vítima de afogamento, em apneia, porém, com pulso central. Qual é a classificação do afogamento desta criança?

A) Grau 2.

B) Grau 4.

C) Grau 5.

D) Grau 6.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

229547)

Enunciado: Paciente feminina, 35 anos, sem comorbidades, admitida em leito de terapia intensiva após laparotomia exploradora por cisto de ovário roto. Após 12 horas de observação clínica, apresenta dor torácica de forte intensidade, palpitações, associada a dispneia súbita. Nega vômitos. Permanece estável hemodinamicamente, sem alterações neurológicas. Realizado eletrocardiograma abaixo. A conduta MAIS adequada neste caso é:

A) amiodarona 300mg em bolus.

B) amiodarona 150mg em bolus.

C) metoprolol 25mg via oral.

D) cardioversão elétrica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

229888)

Enunciado: Durante uma reanimação cardiopulmonar, qual recomendação de massagem cardíaca e ventilação, após a obtenção de via aérea avançada:

A) 1 ventilação a cada 30 compressões torácicas.

B) 2 ventilações a cada 30 compressões torácicas.

C) 1 ventilação a cada 6 segundos e compressões torácicas contínuas.

D) 1 ventilação a cada 10 segundos e compressões torácicas contínuas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

229889)

Enunciado: Você está tratando um indivíduo que apresentou uma fibrilação ventricular. Após reanimação cardiopulmonar e uma tentativa de desfibrilação, seu novo ritmo é um bloqueio atrioventricular de 3º grau. O próximo passo no manejo é

A) repetir desfibrilação.

B) vasopressina.

C) marca-passo transcutâneo.

D) epinefrina alta dose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

246606)

Enunciado: A atividade física compreende qualquer movimento corporal produzido por músculos esqueléticos e que resulta em dispêndio de energia. Assinale, a seguir, uma atividade considerada de alta intensidade.

A) Movimentar móveis.

B) Limpar a casa.

C) Realizar exercícios de alongamento.

D) Executar trabalho de carpintaria.

E) Caminhar lentamente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

210541)

Enunciado: Considere: paciente em consulta ambulatorial de Cardiologia, sexo masculino, 63 anos, portador de fibrilação atrial crônica, sem antecedentes de hipertensão arterial, diabetes ou doença coronariana, apresenta história de ataque isquêmico transitório no ano anterior. Sobre o manejo clínico, assinale a afirmativa correta.

A) A seleção da terapia antitrombótica independe da forma de apresentação da FA.

B) O paciente apresenta 2 fatores de risco maiores pelo escore CHA2DS2VASc.

C) Se portador de prótese mitral mecânica, é recomendada varfarina e manter RNI>2.

D) Pode ser indicada neste caso a dabigatrana, na dose preferencial de 110mg 2x/dia.

E) A combinação AAS + clopidogrel pode ser feita, com eficácia similar à da varfarina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

218214)

Enunciado: Em relação ao tratamento da fibrilação atrial aguda, assinale a alternativa correta:

A) A cardioversão elétrica não sincronizada está indicada na presença de QT longo.

B) A administração de amiodarona intravenosa alcança taxas de reversão em torno de 99% em 24 horas.

C) Quanto maior o átrio esquerdo, menor a chance de sucesso na cardioversão elétrica.

D) O Sotalol por via oral é a droga de escolha para reversão em pacientes com insuficiência cardíaca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

217036)

Enunciado: Paciente de 57 anos, sexo feminino, com queixa de mal-estar súbito há 1 hora, estável hemodinamicamente, admitida com o seguinte ECG: no caso apresentado, é recomendado o uso de qual fármaco?

A) Procainamida.

B) Adenosina.

C) Verapamil.

D) Cardizem.

E) Digoxina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

202630)

Enunciado: A adrenalina quando administrada como terapia na reanimação de parada cardíaca tem como objetivo promover:

A) Vasoconstrição venosa.

B) Aumento da resistência vascular arterial.

C) Efeito beta-adrenérgico periférico.

D) Aumento dos efeitos broncodilatadores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

202712)

Enunciado: Do ponto de vista do ciclo cardíaco,

A) o componente tricuspídeo (T1) da primeira bulha ocorre antes do componente mitral (M1), pois a pressão diastólica final do átrio direito é menor que a do átrio esquerdo.

B) o componente aórtico (A2) da segunda bulha ocorre antes do componente pulmonar (P2), pois a pressão gerada pela contração do ventrículo esquerdo é maior que a gerada pelo ventrículo direito.

C) o desdobramento fisiológico da segunda bulha ocorre durante a expiração.

D) o bloqueio de ramo direito é o responsável pelo desdobramento paradoxal da segunda bulha.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

201700)

Enunciado: Em pacientes idosos com fibrilação atrial paroxística, a melhor e mais segura maneira de reduzir a recorrência de AVC é:

A) Aspirina, 325 mg ao dia.

B) Aspirina, 325 mg ao dia, e clopidogrel, 75 mg ao dia.

C) Apixabana.

D) Warfarin.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

202643)

Enunciado: O escore CHADS? é utilizado na avaliação da necessidade de anticoagulação nos pacientes com fibrilação atrial de etiologia não valvular. Um paciente do sexo masculino, de 76 anos, com fibrilação atrial, hipertenso crônico adequadamente tratado, obeso, antecedente de infarto agudo sem disfunção sistólica de VE e sem outras comorbidades, apresenta qual valor no escore CHADS??

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

205562)

Enunciado: Um menino de um ano é levado ao pronto-socorro para ser avaliado por inapetência, agitação e sudorese. Na impressão inicial, ele se mostra letárgico, mas consegue despertar, tem dificuldade para respirar e apresenta-se cianótico. A primeira avaliação releva frequência respiratória de 68 irpm, frequência cardíaca de 300 bpm que não varia com atividade ou sono, pressão arterial de 70 x 45 mmHg, pulso braquial fraco e pulso radial ausente, enchimento capilar de 6 segundos, SatO2 de 85% em ar ambiente e ruídos respiratórios bilaterais bons. Você administra oxigênio de alto fluxo e coloca a criança no monitor cardíaco. Não há histórico de doença cardíaca congênita. Você observa o seguinte ritmo com pouca variabilidade da frequência cardíaca entre batimentos: o acesso EV foi estabelecido. Qual das seguintes terapias é a mais adequada para esta criança?

A) Marcar uma consulta com o cardiologista pediátrico para o fim da semana.

B) Infusão rápida de adenosina 0,1 mg/Kg EV; se a adenosina não estiver disponível imediatamente, realizar cardioversão sincronizada.

C) Realizar desfibrilação imediata sem esperar por acesso IV.

D) Estabelecer acesso IV e administrar um bolus de 20 ml/Kg de fluido cristalóide isotônico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215454)

Enunciado: São fatores que podem precipitar o evento sincopal em crianças, EXCETO

A) hiperextensão do pescoço.

B) uso abusivo de celular.

C) emoções.

D) desidratação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

217056)

Enunciado: Nas Diretrizes de 2010 da American Heart Association (AHA) para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em pediatria, alguns algoritmos foram estabelecidos. Assinale a alternativa que não expressa o que foi exposto por tais diretrizes.

A) Em se tratando de profissional de saúde no socorro à vítima de PCR, pulso e respiração devem ser checados concomitantemente.

B) Se o socorro à vítima de PCR está sendo prestado por um leigo, sozinho, é preferível que o mesmo acione o serviço de emergência antes de iniciar a RCP.

C) Se a vítima encontra-se inconsciente, com respiração irregular e pulso acima de 60 batimentos/minuto, o profissional de saúde pode realizar ventilações, sem compressões torácicas, durante 2 minutos, ao fim dos quais deve reavaliar o paciente.

D) Mesmo na presença de pulso detectável na vítima pediátrica, caso a frequência seja inferior a 60 batimentos/minuto, o profissional de saúde deve realizar compressões torácicas.

E) A proporção de compressões: ventilações na população pediátrica é de 30:2, quando o socorrista está sozinho, e de 15:2, quando há mais de 1 socorrista proficiente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174400)

Enunciado: A desfibrilação e cardioversão elétrica consistem na aplicação de corrente elétrica de alta energia para reversão de arritmias cardíacas geradas pelo mecanismo de reentrada. Somente apresenta dados considerados inadequados a alternativa:

A) Na desfibrilação, esta corrente elétrica é aplicada em qualquer momento do ciclo cardíaco, enquanto na cardioversão elétrica, esta corrente é sempre sincronizada com os complexos QRS do eletrocardiograma para que não seja administrada durante o período vulnerável da repolarização ventricular (onda T), quando pode potencialmente desencadear uma fibrilação ventricular.

B) Os desfibriladores/cardioversores podem ser classificados de acordo com o modo de operação em: a) manuais, no qual o reconhecimento do ritmo cardíaco e a administração do choque dependem do operador; b) semiautomáticos, também,
conhecidos como DEA, nos quais o reconhecimento do ritmo é realizado pelo dispositivo que informa se o choque elétrico é
recomendado ou não no tratamento do paciente, sendo que a decisão de aplicar o choque continua sendo do operador.

C) Desfibriladores também podem ser classificados em externos e internos. Nos externos, a corrente elétrica é aplicada através da superfície externa do tórax do paciente por meio de pás manuais ou adesivas, enquanto, nos internos, a corrente elétrica é aplicada por cabos eletrodos geralmente implantados através do sistema venoso.

D) Na cardioversão a corrente elétrica é aplicada em qualquer momento do ciclo cardíaco, esta corrente é sempre sincronizada para que não seja administrada durante o período refratário da repolarização ventricular (onda T), quando pode potencialmente desencadear uma arritmia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175381)

Enunciado: O átrio direito é a câmara cardíaca que normalmente recebe o sangue venoso sistêmico. Nessa câmara, encontra-se a valva de Eustáquio, que se relaciona com:

A) veia cava inferior

B) crista terminalis

C) veia cava superior

D) seio coronário

E) junção átrio ventricular direita

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175387)

Enunciado: Um homem de 54 anos, portador de doença arterial coronariana crônica, apresenta, após intensa emoção, dor torácica precordial e perda da consciência. Os pulsos periféricos não são perceptíveis, e a pressão arterial não foi percebida. O mecanismo provável da parada é:

A) assistolia

B) atividade elétrica sem pulso

C) taquicardia supraventricular

D) fibrilação ventricular

E) fibrilação atrial

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183254)

Enunciado: O ECG é um exame simples, barato e não invasivo. Permite uma ideia da condição cardíaca do indivíduo e pode eventualmente identificar situações de risco de morte súbita. Dentro da Definição do ritmo sinusal, sendo que podem ocorrer modificações de sua morfologia dependentes da FC, apenas não podemos considerar como sendo cabível o que se afirma na alternativa:

A) O Ritmo Sinusal (RS) é um ritmo fisiológico do coração.

B) Origina-se no átrio direito baixo.

C) Observado no ECG de superfície pela presença de ondas P positivas nas derivações D1, D2 e aVF.

D) O eixo de P pode variar entre -30° e +90°.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175405)

Enunciado: Qual das afirmações a seguir sobre os efeitos da epinefrina durante a tentativa de ressuscitação é verdadeira?

A) a epinefrina reduz a resistência vascular periférica e diminui a pós-carga miocárdica, de modo que as contrações ventriculares são mais eficazes

B) a epinefrina melhora a pressão de perfusão da artéria coronária e estimula as contrações espontâneas quando há assistolia

C) a epinefrina é contraindicada na fibrilação ventricular, pois aumenta a irritabilidade miocárdica

D) a epinefrina reduz o consume de oxigênio miocárdico

E) nenhuma das respostas acima

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183321)

Enunciado: Para os paciente que apresentam parada cardíaca antes de receber qualquer abordagem, a medida mais importante e de maior impacto seria a difusão global do conhecimento sobre atendimento básico da parada cardíaca. Sobre esse assunto, podemos considerar como INCORRETO apenas o item:

A) O reconhecimento e o tratamento da Fibrilação Ventricular (FV) por profissional da saúde (Médico ou Enfermeiro com treinamento em ACLS, sigla do inglês Advanced Cardiac Life Support) são seguramente excelentes instrumentos para melhorar os resultados pré-hospitalares no IAM, mas apenas na possibilidade de ter uma aplicabilidade difusa, por meio de programas de atendimento de urgência em unidades móveis que estejam equipadas e disponíveis para cobertura global da população.

B) A importância da FV como mecanismo de óbito precoce e a habilidade na ressuscitação e na desfibrilação foram os fatores que propiciaram o desenvolvimento de programas de tratamento pré-hospitalar do IAM.

C) Estima-se que a desfibrilação salve cerca de duas vezes mais vidas que o tratamento trombolítico, mas depende de sua rápida aplicação ao paciente.

D) Identificar o perfil dos casos de IAM que não chegam aos hospitais, qualificando o estado atual de atendimento e quantificando o impacto de uma nova estratégia de grande difusão na população..

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

178802)

Enunciado: O ECG acima demonstra:

A) taquicardia vetricular polimórfica.

B) taquicardia vetricular monomórfica.

C) fibrilação ventricular.

D) taquicardia paroxística supraventricular.

E) extrassístoles ventriculares.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174502)

Enunciado: Quando da opção para tratamento farmacológico, os principais medicamentos utilizados em pacientes portadores de fibrilação atrial, apresentam efeitos adversos. Sobre isso, assinale a alternativa que demonstra INCORRETA correlação:

A) Propafenona: depressão grave da contratilidade miocárdica, gosto metálico, visão borrada, náusea, diarreia aquosa, tontura, agranulocitose.

B) Betabloqueadores: bradicardia, broncoespasmo, erupção cutânea, fadiga, depressão mental, pesadelos.

C) Amiodarona: pneumonite (1-23%), neuropatia periférica, tremor, insônia e ataxia, fotossensibilização (90%), depósitos na córnea,
com repercussões visuais (3-13%), insuficiência cardíaca, bradicardia, intolerância digestiva, hepatite medicamentosa, coloração azulada da pele, exacerbação de asma brônquica, alterações no metabolismo dos glicídios e triglicerídeos, epididimite, disfunção renal.

D) Sotalol: torsades de pointes (2,4%), bradicardia, fadiga, astenia, dispneia, tontura (2-4%).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

178810)

Enunciado: Em relação à arritmia encontrada no eletrocardiograma, são condutas possíveis as listadas a seguir, exceto uma. Qual?

A) Sulfato de magnésio.

B) Lidocaína.

C) Isoproterenol.

D) Marca-passo provisório com aumento da frequência cardíaca (Overdrive Pacing).

E) Amiodarona.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174405)

Enunciado: Podemos obter o controle do ritmo na Fibrilação Atrial por diversas condutas, clínicas ou intervencionistas. Indique a alternativa que apresenta conduta INADEQUADA:

A) Evidências sólidas indicam que a ablação da Fibrilação Atrial é mais eficaz do que as drogas antiarrítmicas para controle do ritmo.

B) A ablação está indicada como opção para a falência de uma droga antiarrítmica e também como primeira escolha em pacientes selecionados com FA paroxística, sem doença estrutural.

C) Pacientes com cardiopatia estrutural e FA paroxística igualmente podem ser considerados para ablação como terapia inicial, desde que se suspeite de taquicardiomiopatia e que o paciente deseje realizar ablação.

D) A eficácia da ablação da FA não varia conforme as características clínicas da arritmia e a extensão da cardiopatia de base.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

173565)

Enunciado: Paciente de 55 anos deu entrada no pronto-socorro e foi diagnosticada uma Parada Cardiorrespiratória (PCR) por Fibrilação Ventricular (FV). Qual é o melhor momento para iniciar epinefrina 1 mg?

A) Imediatamente, antes da primeira desfibrilação.

B) Imediatamente, depois da primeira desfibrilação.

C) Após reiniciada a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), depois da segunda desfibrilação.

D) Durante a RCP e imediatamente antes da segunda desfibrilação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174468)

Enunciado: Paciente apresentando quadro de Fibrilação Atrial solicita sua orientação quanto às opções de tratamento disponíveis atualmente, seus riscos e benefícios. Dentre as alternativas abaixo, existe uma INCORRETA, assinale-a:

A) As evidências mais robustas de benefício e os melhores resultados são obtidos nos pacientes jovens com FA paroxística/persistente sintomática sem cardiopatia estrutural relevante.

B) Existem evidências de que a intervenção seja superior à dos fármacos AA, no tocante à redução de desfechos duros, como mortalidade, IC e acidentes vasculares cerebrais.

C) Nesse perfil de pacientes, a intervenção proporciona melhora significativa da sintomatologia e da qualidade de vida.

D) Porém, faltam dados que comprovem o benefício do procedimento nos pacientes muito idosos, com FA persistente de longa duração, ou IC avançada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174506)

Enunciado: Dentre os conceitos sobre o tratamento híbrido da Fibrilação Atrial, somente pode ser considerado INADEQUADO o seguinte conceito ou afirmativa:

A) Os chamados ?procedimentos híbridos? combinam cirurgia epicárdica minimamente invasiva com mapeamento eletrofisiológico e ablação por cateter endocárdico.

B) O objetivo dessa técnica mista é tratar, em especial, pacientes com FA persistente, nos quais essas técnicas utilizadas isoladamente teriam resultados insatisfatórios.

C) O objetivo dessa técnica mista é tratar, em especial, pacientes com FA persistente, nos quais essas técnicas utilizadas isoladamente teriam resultados satisfatórios.

D) No geral, os resultados com os procedimentos híbridos são expressivos, principalmente considerando a maior complexidade da população tratada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182497)

Enunciado: Com relação à fibrilação atrial, assinale a alternativa incorreta:

A) devido à ação inotrópica negativa dos betabloqueadores, devem ser evitados nos pacientes com fibrilação atrial

B) hipertireoidismo e intoxicação alcoólica aguda são causas bem definidas de fibrilação atrial

C) idade >75 anos é um fator de risco para acidente vascular cerebral no paciente portador de fibrilação atrial

D) os bloqueadores dos canais de cálcio verapamil e diltiazem podem ser utilizados para o controle da frequência cardíaca nos pacientes com fibrilação atrial

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182494)

Enunciado: Qual das doenças a seguir cursa mais habitualmente com pulso paradoxal?

A) estenose aórtica

B) pericardite constritiva

C) insuficiência aórtica

D) estenose mitral

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183271)

Enunciado: Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao paciente vítima de acidente por submersão:

A) Afogamentos em piscinas têm alto potencial de desenvolver infecção pulmonar precoce.

B) O diagnóstico de pneumonia muitas vezes é feito de forma equivocada, por exames de radiografia solicitados no início do quadro, em decorrência da presença de opacificações que correspondem à água nos pulmões.

C) Antes de tomar a decisão de iniciar a antibióticoterapia, recomenda-se observar o paciente clinicamente por meio da presença de

febre, leucocitose, novos infiltrados pulmonares na radiografia e exames de culturas.

D) Na prática, a origem da água em que ocorreu o acidente, salgada ou doce, não diferencia a clínica de edema pulmonar ou os distúrbios eletrolíticos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

185159)

Enunciado: Você atende um paciente que está arresponsivo e sem pulsos. Uma vez iniciadas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), ao chegar o monitor-desfibrilador bifásico, você identifica o ritmo a seguir. A próxima conduta deve ser:

A) desfibrilação a 200 Joules, reiniciar a RCP imediatamente.

B) RCP por 2 minutos e, então, desfibrilação a 200 Joules.

C) desfibrilação a 200 Joules, e reavaliar o ritmo em seguida.

D) manter a RCP e infundir adrenalina 1mg IV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

185123)

Enunciado: Mulher de 32 anos é atendida no pronto-socorro com queixa de palpitações taquicárdicas. Tem apresentado episódios frequentes de taquiarritmia que revertem espontaneamente e duram aproximadamente 10 minutos. O episódio de hoje iniciou há 30 minutos, o que a fez procurar atendimento. Ela está lúcida e orientada, sem outras queixas, a PA = 132/76mmHg, FC 176bpm, saturação de oxigênio 97%. O ECG realizado revela o seguinte ritmo: Dentre as opções abaixo, a conduta indicada para o caso deve ser?

A) administrar atropina IV.

B) administrar adenosina IV.

C) realizar cardioversão elétrica sincronizada.

D) administrar amiodarona IV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174527)

Enunciado: Paciente de 76 anos, pós-operatório imediato de gastrectomia subtotal por Adenocarcinoma Gástrico. Apresenta-se com PA=80x40mmHg Pulso=161bpm Sat=91% FR=27irpm, associado a sudorese, palidez cutânea. Apresentando o seguinte Eletrocardiograma: Em relação ao quadro clínico, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta:

A) Cardioversão Elétrica.

B) Amiodarona.

C) Adenosina.

D) Lidocaína.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

178858)

Enunciado: Paciente, 67 anos, chega à Unidade de Emergência referindo que apresentou um episódio de sincope em sua residência, mal-estar geral e sudorese intensa. Na avaliação, observa-se que o paciente está com PA =84 x 62 mmHg, dispneia (saturação de oxigênio = 89%) e edema em membros inferiores, Com a suspeita de alguma patologia cardiológica, é solicitado um eletrocardiograma (ECG), do qual se obteve o seguinte traçado. Após análise do traçado e mediante os sinais e os sintomas do paciente, assinale a alternativa correta quanto ao ritmo obtido no ECG e quanto à conduta mais adequada.

A) Ritmo: bloqueio atrioventricular de segundo grau (Mobitz II / Wenckebach). Conduta: iniciar manobra vagal; caso não haja resposta, prosseguir com adenosina 6 mg.

B) Ritmo: bloqueio atrioventricular de segundo grau (Mobitz I / Wenckebach). Conduta: iniciar atropina 0,5 mg e titular até no máximo 3 mg de 3 a 5 minutos, caso não haja resposta, prosseguir com marcapasso transcutâneo ou dopamina ou epinefrina.

C) Ritmo: bradicardia sinusal, Conduta: observar e, se necessário, chamar o especialista ou encaminhar para uma unidade especializada.

D) Ritmo: bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Conduta: iniciar atropina 0,5 mg e titular até no máximo 3 mg de 3 a 5 minutos; caso não haja resposta, prosseguir com adenosina 6 mg e titular até no máximo 12 mg.

E) Ritmo: bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Conduta: cardioversão sincronizada iniciando com carga de 50 J e aumentando progressivamente até 150 J; caso não haja resposta, prosseguir infusão de dopamina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174426)

Enunciado: Estudos epidemiológicos demonstram clara associação entre Fibrilação Atrial e risco de morbimortalidade por diversos fatores. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA:

A) Estudos epidemiológicos demonstram clara associação entre Fibrilação Atrial e risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC), isquêmico somente, sem alterar mortalidade.

B) Alterações cognitivas, Insuficiência Cardíaca (IC) e implicações socioeconômicas também são consequências importantes da FA.

C) Em estudos clínicos envolvendo pacientes com IC, a FA não foi considerada fator de risco independente para mortalidade.

D) IC e FA coexistem em uma alta porcentagem de pacientes (22 a 42%). Além disso, o aparecimento de FA em pacientes portadores de IC não está associado à elevação de do risco de morte em comparação com os indivíduos sem o distúrbio do ritmo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174517)

Enunciado: Muitos fatores de risco clínicos estão associados ao aumento no risco de FA e, possivelmente, participam da elevação na prevalência observada nas últimas décadas, somente não podemos considerar completamente correta a alternativa:

A) Fatores clínicos predisponentes a FA ocorrem quando anormalidades eletrofisiológicas alteram o tecido atrial e promovem formação/propagação anormal do impulso elétrico.

B) Muitos fatores de risco clínicos clássicos estão associados, tais como hipertensão, diabetes, doença valvar, infarto do miocárdio e Insuficiência Cardíaca (IC).

C) Podemos observar novos fatores de risco como presença de Apneia Obstrutiva do Sono (AOS), obesidade, uso de bebidas alcoólicas, exercício físico, história familiar e fatores genéticos.

D) Na prática clínica, a influência da obesidade e da AOS parece impactar muito pouco na abordagem terapêutica dos pacientes portadores de FA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157328)

Enunciado: Sobre as principais mudanças no ACLS 2015, qual recomendação é INCORRETA?

A) Em via aérea avançada, preconizam-se 10 ventilações por minuto (1 ventilação a cada 6 segundos).

B) A vasopressina não é mais utilizada no protocolo ACLS.

C) Em via aérea avançada, ETCO2 menor que 10 mmHg na capnografia após 10 minutos de ressuscitação pode ser utilizado para determinar fim dos esforços.

D) Utilização precoce da adrenalina em pacientes com ritmo não chocável.

E) Está recomendado o uso de circulação extracorpórea para ressuscitação em pacientes que não respondem à ressuscitação convencional e que possam apresentar algum benefício.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150265)

Enunciado: Na semiologia do tórax, qual é o ponto anatômico que serve de referência para a identificação e a contagem dos espaços intercostais, que é importante na ausculta cardíaca (focos de ausculta) e na realização de procedimentos invasivos, como toracocentese e drenagem torácica?

A) Ângulo esternal.

B) Linha hemiclavicular.

C) Linha paraesternal.

D) Linha axilar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157433)

Enunciado: A desfibrilação é uma aplicação de corrente elétrica de alta energia para reversão de arritmias cardíacas geradas pelo mecanismo de reentrada. Na desfibrilação, esta corrente elétrica é aplicada em qualquer momento do ciclo cardíaco, enquanto na cardioversão elétrica esta corrente é sempre sincronizada com os complexos QRS do eletrocardiograma para que não seja administrada durante o período vulnerável da repolarização ventricular (onda T), quando pode potencialmente desencadear uma fibrilação ventricular. A desfibrilação está indicada no tratamento da fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sem pulso, ambas em situações compatíveis com parada cardiorrespiratória. Este procedimento também está indicado para reversão de taquicardia ventricular polimórfica sustentada devido à dificuldade de sincronização com os diferentes complexos QRS observados nesta arritmia. Em relação à necessidade de adequada classificação da arritmia para sua correta indicação, aponte a alternativa que se mostra INADEQUADA na classificação ou uso da desfibrilação.

A) Nos desfibriladores externos, a corrente elétrica é aplicada através da superfície externa do tórax do paciente por meio de pás manuais ou adesivas.

B) Nos desfibriladores internos, a corrente elétrica é aplicada por cabos eletrodos geralmente implantados através do sistema venoso.

C) Quanto ao formato da onda, podem ser classificados em monofásicos ou bifásicos. Nos monofásicos, toda a energia elétrica selecionada é aplicada em duplo único sentido vetorial.

D) Nos desfibriladores bifásicos, parte da corrente é administrada em um sentido e a outra parte, no sentido inverso (inversão de polaridade).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157439)

Enunciado: Desfibrilação precoce é o tratamento de escolha para vítimas em Fibrilação Ventricular de curta duração, como vítimas que apresentaram colapso súbito, sendo este o principal ritmo de parada cardíaca. Podemos alegar, como uma conduta INADEQUADA, uma das opções a seguir. Assinale-a.

A) Nos desfibriladores externos, o choque elétrico é aplicado por intermédio das pás manuais, as quais o operador posiciona sobre o tórax, exercendo pressão de aproximadamente 13 kg.

B) Deve-se ter o cuidado de colocar gel na interface entre as pás e o tórax, visando diminuir a resistência à passagem da corrente elétrica; já as pás adesivas são coladas sobre o tórax do paciente, dessa maneira dispensando a utilização do gel e da compressão.

C) Em relação ao posicionamento das pás manuais e adesivas, o local mais adequado é a posição anterolateral, onde uma das pás é colocada na região infraclavicular direita e a outra pá na região precordial.

D) Posições alternativas, como anteroposterior e laterolateral, podem ser utilizadas em situações especiais, como presença de marca-passo ou cardioversor-desfibrilador implantável, no qual as pás devem ser obrigatoriamente posicionadas por, pelo menos, 3 cm de distância do gerador.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157448)

Enunciado: Ocorre grande importância a tomada de decisão a respeito de terapêutica elétrica, sendo que a cardioversão elétrica está indicada para a reversão das taquiarritmias com instabilidade hemodinâmica. Considera-se como critérios de instabilidade a presença de pelo menos um dos critérios seguintes, EXCETO por:

A) Hipotensão mesmo sem sinais de choque circulatório.

B) Dor torácica anginosa.

C) Dispneia associada à congestão pulmonar.

D) Rebaixamento do nível de consciência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157455)

Enunciado: A estimulação cardíaca temporária, através do Marca-Passo Transcutâneo (MPTC), é um procedimento de emergência que tem a vantagem de ser uma técnica não invasiva e de instalação praticamente imediata. O MPTC é um dispositivo que pode estimular o ritmo cardíaco pelo fornecimento de corrente elétrica por eletrodos colados na pele. Há despolarização elétrica, que levará à contração cardíaca. Dentre as suas indicações e características, DESCONSIDERE, apenas, o contido em uma das alternativas. Assinale-a.

A) A principal indicação de seu uso é em pacientes com bradicardia sintomática.

B) A vantagem do MPTC é a necessidade de baixa energia em razão da necessidade de fazer a energia aplicada chegar ao miocárdio.

C) Pode também ser utilizado na superestimação para supressão de taquicardias refratárias com o intuito de eliminar taquicardia supraventricular (TSV) e taquicardias ventriculares (TV) malignas.

D) O aumento das placas de eletrodos para oito ou dez centímetros de diâmetro minimizam a densidade de corrente elétrica, além da melhor condução.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157460)

Enunciado: O Marca-Passo Transcutâneo (MPTC), é um procedimento de emergência que tem a vantagem de ser uma técnica não invasiva e de instalação praticamente imediata. Mas, como por definição, é utilizado através da parede torácica, apresentando diversas interferências em seu uso e indicação, NÃO sendo uma delas o contido em uma das opções. Aponte-a.

A) A impedância transtorácica consiste na resistência da parede torácica ao fluxo da corrente elétrica e pode também ser influenciada pelo tamanho dos eletrodos.

B) O aumento das placas de eletrodos para oito ou dez centímetros de diâmetro minimizam a densidade de corrente elétrica, além da melhor condução.

C) Pode também ser utilizado na superestimulação para supressão de taquicardias refratárias.

D) O MPTC é um dispositivo que, em geral, não causa desconforto e dor ao paciente, visto que correntes elétricas de 50 a 100 miliampéres (mA) são necessárias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

160550)

Enunciado: Homem de 52 anos é admitido com história de náuseas, vômitos e desconforto torácico. A triagem encaminha o paciente rapidamente para a sala de emergência para monitorização, pois detectou FC = 160 bpm e PA = 80/50 mmHg. O ECG realizado é mostrado a seguir (conforme imagem do caderno de questões). A conduta imediata mais apropriada é:

A) Realizar cardioversão elétrica sincronizada com 100 joules.

B) Realizar desfibrilação com 200 joules.

C) Prescrever amiodarona endovenosa.

D) Prescrever diltiazem endovenoso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157464)

Enunciado: Durante o seu último plantão, ocorreu um caso de parada cardíaca que não se conseguia acesso a drogas, e um membro da equipe pediu para deixar de realizar a RCP por alguns instantes para se obter uma via central. Entretanto, podemos considerar que durante a parada cardíaca, a prioridade sempre será administrar RCP de boa qualidade e desfibrilação imediata; a administração de drogas será secundária. Depois da tentativa de desfibrilação, os socorristas devem estabelecer um acesso para a medicação. A respeito disso, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Deve-se escolher, de preferência, o acesso venoso periférico nos membros superiores (veia antecubital). O acesso periférico é de fácil obtenção, fácil aprendizado, apresenta menor risco de complicações e não necessita de interrupção das manobras de RCP.

B) Se não for possível estabelecer acesso IV, a via intraóssea (IO), para administração de drogas, pode proporcionar concentrações plasmáticas adequadas, similares às alcançadas pelo acesso intravenoso.

C) A administração de medicamentos por um acesso central pode ser considerada se não houver nenhuma contraindicação. Essa via de administração de medicamentos oferece a vantagem de viabilizar maior concentração plasmática apesar de um maior tempo para circulação, além de permitir a determinação da saturação venosa central e estimar a pressão de perfusão coronariana durante a RCP.

D) Estudos relatam que drogas como lidocaína, adrenalina, atropina e naloxone podem ser absorvidas por via endotraqueal. A administração dessas drogas pela via endotraqueal, durante a RCP, resulta em menores concentrações plasmáticas quando comparadas com as mesmas doses administradas por via IV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157454)

Enunciado: Das condutas frente à parada cardíaca, as intervenções medicamentosas têm sido indicadas no manuseio da PCR desde longa data, porém ocorrem muitas controvérsias, e dificuldades de indicações mudam constantemente, sendo o uso de Bicarbonato de Sódio uma das condutas mais controversas, mas podemos admitir:

A) Que o melhor tratamento da acidose na PCR é a compressão torácica adequada, além disso, não ocorre benefício ganho com a ventilação.

B) Que o uso de bicarbonato pode ter alguns efeitos benéficos, tais como aumento na geração de CO2.

C) Bicarbonato de sódio exacerbando a acidose intracelular; efeito inotrópico negativo no miocárdio isquêmico.

D) Bicarbonato de sódio, aumento da osmolaridade sérica e desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a direita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149168)

Enunciado: Idosa, 67 anos de idade, foi trazida por familiares ao hospital, desacordada. Logo na sua chegada, o caso foi reconhecido como de parada cardíaca, provavelmente decorrente de ataque cardíaco em que ela se queixou de fortes dores no tórax logo quando iniciou o mal-estar, antes que perdesse a consciência. Foi iniciado manobras, com uso do CAB, dando grande ênfase nas compressões torácicas que foram vigorosas, com profundidade, a uma frequência, em média, de 145 por minuto. Sobre essa situação clínica, pode-se afirmar que:

A) Essa frequência foi abaixo do necessário.

B) A conduta foi inadequada, por comprometer a profundidade das compressões.

C) Melhora fortemente as chances de se obter sucesso na RCP conforme o protocolo atual de frequência.

D) Somente foi possível graças ao grande treinamento técnico da equipe, que se atualizou sobre o tratamento adequado a PCR.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157458)

Enunciado: Das medicações utilizadas em emergência, a atropina foi uma das que mais perdeu indicações e apresenta controvérsias. A respeito dela, marque a opção considerada INCORRETA:

A) A atropina é agonista da ação da acetilcolina, um neurotransmissor parassimpático nos receptores muscarínicos.

B) Atropina bloqueia o efeito do nervo vago, tanto no nó sinoatrial (NSA) como no nó atrioventricular (NAV).

C) Atropina aumenta a frequência de disparos do nó SA.

D) Atropina facilitando a condução atrioventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149173)

Enunciado: Podemos considerar como boas práticas, durante as manobras de reanimação cardiorrespiratória, diversos itens como, por exemplo, frequência respiratória e massagem cardíaca, com EXCEÇÃO do contido em uma das opções a seguir. Assinale-o.

A) Permitir o retorno do tórax à sua posição sempre.

B) Comprimir o tórax minimamente 6 cm.

C) Realizar a compressão entre 100 e 120 por minuto.

D) Minimizar as interrupções torácicas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157379)

Enunciado: Paciente, sabidamente cardiopata, foi ao hospital trazido por familiares, que o consideraram prostado nesta manhã. Foi deixado na sala de emergência e monitorizado, seu eletrocardiograma demonstrava uma baixa frequência cardíaca. Foi, então, solicitado avaliação da cardiologia e o colega o solicitou para discutir e decidir sobre as condutas, inadequadamente fundamentada na seguinte alternativa. Indique-a.

A) Os sinais e sintomas, mesmo leves, e os pacientes assintomáticos necessitam de tratamento. Os pacientes devem ser monitorados à procura dos sinais de deterioração das condições. Deve-se fornecer terapia imediata antes que os pacientes
tenham hipotensão, convulsões e outros sinais de choque relacionados à bradicardia.

B) A bradicardia é definida como uma frequência cardíaca inferior a 60 bpm; quando a bradicardia é a causa de sintomas, a frequência geralmente é menor que 50 bpm. Este limite é individual e frequências menores do que essas podem ser
consideradas fisiológicas para alguns pacientes e inadequadas para outros.

C) As causas podem ser: não cardíacas, como uso de drogas; causas metabólicas ou endócrinas, especialmente na tireoide; distúrbio eletrolítico, fatores neurológicos e reflexos autonômicos; fatores situacionais, como o repouso prolongado no leito; e autoimunidade. As causas de origem cardíaca incluem a doença cardíaca isquêmica aguda ou crônica, doença cardíaca vascular, doença cardíaca valvular, ou doença degenerativa primária elétrica.

D) Os pacientes assintomáticos não devem receber nenhum tratamento. O tratamento é indicado somente nos casos em que a bradicardia, independente do seu tipo ou causa, provoca uma redução significativa da pressão arterial sistêmica com sinais clínicos de baixo débito cardíaco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149179)

Enunciado: Durante as manobras de reanimação cardiotorácicas, devemos nos atentar a diversos fatores, como a frequência das compressões e a qualidade delas. Além de uma frequência de 100 até 120 bpm e uma profundidade de 5 a 6 cm, podemos, também, considerar que:

A) Se apoiar sobre o tórax, entre as compressões, melhora e promove otimização da pressão torácica.

B) Aumenta em muito o achado de lesões fatais e promove o apoio do socorrista no tórax entre as compressões.

C) A pressão intratorácica negativa relativa melhora o fluxo cardiopulmonar.

D) O retorno intratorácico parcial não causa mudança de fluxo circulatório.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157392)

Enunciado: As arritmias cardíacas apresentam importante conhecimento médico, sendo que apenas uma das alternativas abaixo se apresenta como ADEQUADA para o correto entendimento do Bloqueio Atrioventricular de primeiro grau. Assinale-a.

A) Caracteriza-se pela aceleração na chegada do estímulo aos ventrículos. A relação atrioventricular permanece 1:1, uma onda P para um complexo QRS. O intervalo PR é fixo, mas não varia, medindo mais de 0,20 segundos, ou 200 milissegundos.

B) A maioria localiza-se no nó sinusal e casionalmente nos átrios, raramente sendo infranodal.

C) As síndromes coronárias agudas envolvendo a artéria coronária direita podem afetar a circulação para o nó AV, levando à isquemia do nó AV e retardando a condução.

D) Agentes que atuam no NAV, como betabloqueadores, digitálicos, bloqueadores dos canais de cálcio e outros, podem acelerar o intervalo PR.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157416)

Enunciado: Do ponto de vista eletrocardiográfico, os Bloqueios Atrioventriculares (BAV) podem ser divididos de acordo com a gravidade. Referente aos chamados BAV do segundo grau, aponte a alternativa INCORRETA:

A) No BAV de segundo grau, ocorre a interrupção na condução do estímulo para os ventrículos, alterando a relação P: QRS usual, que é de 1:1.

B) Bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo I ? Mobitz I ou Wenckebach

Eletrocardiograficamente, caracteriza-se pelo aumento progressivo do intervalo PR, acarretando em uma onda P ?bloqueada?, ou isolada, gerando uma pausa no traçado. Sua totalidade se origina na região infranodal.

C) No ECG, surgem ondas P isoladas, ditas "bloqueadas?, porque aparecem isoladas, sem o complexo QRS correspondente.

D) O digital, por sua ação vago mimética e sua ação indireta no nó AV, também pode causar esse tipo de alteração. É necessária a atenção para a associação desses fármacos, principalmente nos pacientes idosos, em função da ação sinérgica sobre o nó atrioventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149204)

Enunciado: Diversos são os fatores listados como adequados ou mesmo prejudiciais às condutas de reanimação cardiorrespiratória. Assim, podemos adequar as nossas condutas ao melhor possível em termos de sobrevivência da vítima. Dentre as afirmações a seguir, indique aquela que NÃO se enquadra nesse conceito.

A) Apresenta grande importância o achado de lesões fatais, ocorridas quando da profundidade de massagem cardíaca acima de 6 cm.

B) Manter uma frequência de compressões torácicas adequadas aumenta o percentual de massagem efetivamente eficiente.

C) Permitir fluxo sanguíneo torácico com a massagem cardíaca adequada melhora as chances de sucesso.

D) Hiperventilação se mostra prejudicial durante as manobras de reanimação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157426)

Enunciado: Sobre os estudos eletrocardiográficos do dito bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo I ? Mobitz I ou Wenckebach, marque a alternativa CORRETA:

A) Eletrocardiograficamente, caracteriza-se pelo aumento fixo do intervalo PR, acarretando em uma onda P ?bloqueada?, ou isolada, gerando uma pausa no traçado. Em torno de 85 a 90% desses bloqueios localizam-se no nó AV, sendo o restante infranodal.

B) Ocorrem nas situações em que há redução importante do tônus vagal, como no atleta bem-condicionado, nas crianças e durante o repouso. Nestes casos, observa-se desaparecimento do bloqueio durante o exercício, quando o tônus simpático é aumentado e o vagal é diminuído.

C) Os fármacos que atuam no NAV como os betabloqueadores, os bloqueadores dos canais de cálcio, os agentes da classe III, como a amiodarona, e os da classe IC, como a propafenona, reduzem a velocidade de condução do NAV, causando BAV do segundo grau tipo I.

D) A pausa caracteriza-se por ser menor que dois ciclos básicos menores, e o PR pós-pausa é sempre igual ou menor que o intervalo PR do início de cada sequência. Sequências variadas podem ocorrer como 3:2, 4:3, 5:4, significando que há sempre um complexo QRS a menos, uma vez que sempre existe uma onda P bloqueada, sem o QRS correspondente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149210)

Enunciado: Quando avaliamos o tratamento de taquiarritmias, diversos fatores inerentes às alternativas medicamentosas, bem como ao caso clínico, devem ser consideradas quanto à tomada da decisão. Dessa maneira, podemos considerar como fatores importantes nesse contexto, especificamente da Fibrilação Atrial, os listados abaixo, com EXCEÇÃO:

A) Da apneia obstrutiva do sono.

B) Da obesidade.

C) Do uso de bebidas alcoólicas.

D) Do uso de anti-inflamatórios.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157442)

Enunciado: Durante o último plantão de interno no hospital, você foi chamado em caráter de emergência na sala de recuperação anestésica, por complicação cardíaca no pós-operatório imediato de cardiopata que fez laparotomia exploradora de emergência. Tanto o monitor cardíaco quanto o ECG demonstrava um padrão de bloqueio do segundo grau avançado. Sobre o caso, aponte a alternativa que é considerada INADEQUADA:

A) O BAV avançado do segundo grau é classificado como do tipo 2:1 e 3:1 etc., ou seja, para cada complexo QRS, existem duas ou três ondas P, respectivamente. Isso significa que não há intervalos PR consecutivos para serem comparados, ou seja, não é possível avaliar se o intervalo PR mantém-se constante ou prolonga-se antes de surgir a onda P bloqueada.

B) Cerca de dois terços dos BAV avançados são localizados abaixo do NAV, no sistema His-Purkinje, de onde talvez se origine a concepção equivocada de classificá-los como BAV tipo II.

C) Nos casos em que está associado a complexos QRS finos, que são a maioria, está localizado no sistema His-Purkinje.

D) O BAV avançado pode ser assintomático ou sintomático, apresentando-se sob a forma de tontura, pré-síncope ou mesmo episódios sincopais intermitentes. Em geral, é secundário à lesão anatômica bem-definida do sistema de condução, como na cardiopatia isquêmica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149221)

Enunciado: Além de aspectos cardiológicos com importantes complicações, a Fibrilação Atrial causa enormes outras complicações à distância, entre elas os fenômenos emboligênicos. Sobre isso, concluímos que:

A) O escore de risco para hemorragia não contraindica o uso de anticoagulante oral, mas orienta quanto à necessidade de cuidados especiais para tornar o tratamento mais seguro.

B) Não ocorre risco de interação de anticoagulação e consumo de álcool.

C) Não há necessidade de avaliar, concomitantemente, risco emboligênico e de sangramento.

D) O conceito ?benefício líquido? não leva em consideração os aspectos positivos da redução de risco de tromboembolismo bem como de hemorragia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157446)

Enunciado: Sobre as bradiarritimias, assinale a alternativa CORRETA:

A) Todo BAVT significa dissociação atrioventricular, mas nem toda dissociação AV significa BAVT.

B) Nos casos de BAVT, a frequência atrial é sempre menor que a ventricular.

C) A frequência atrial pode ser somente o de ritmo sinusal, no achado de bloqueio atrioventricular total.

D) Na ECG, observam-se ondas P bloqueadas, dissociadas do complexo QRS, que pode ser somente alargado com padrão de bloqueio de ramo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149232)

Enunciado: Quando avaliamos o tratamento da Fibrilação Atrial, devemos considerar, quanto ao tratamento proposto, o seguinte, com EXCEÇÃO de uma das alternativas a seguir. Indique-a.

A) O uso de carvedilol associado à digoxina não auxiliou no controle da frequência, bem como na melhora da função ventricular de pacientes portadores de IC.

B) Os bloqueadores de canais de cálcio não diidropiridínicos, como o verapamil e o diltiazem, bloqueiam os canais de cálcio do tipo L do sistema de condução cardíaco, principalmente no nó AV.

C) O verapamil e o diltiazem podem ser utilizados em associação com outro fármaco (digital, por exemplo), podendo permitir doses menores com consequente melhor tolerância.

D) O uso intravenoso de esmolol, propranolol e metoprolol foi efetivo em casos de FA aguda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157452)

Enunciado: Em termos de conduta de emergência, no caso do encontro das taquiarritmias, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Pode-se, de um ponto de vista prático, classificar inicialmente as taquicardias em dois grupos, independente do diagnóstico eletrocardiográfico: instáveis e estáveis.

B) As taquiarritmias instáveis são aquelas que apresentam frequência cardíaca geralmente superior a 150 bpm (caso não haja disfunção ventricular acentuada).

C) Independente do diagnóstico eletrocardiográfico, a cardioversão elétrica sincronizada deve ser prontamente instituída de modo a restaurar um ritmo cardíaco organizado e com frequência menor capaz de produzir débito cardíaco mais efetivo.

D) Do ponto de vista de atendimento emergencial, podemos dividi-las em dois tipos, de acordo com a duração do complexo QRS: QRS estreito (< 140 ms) e QRS largo (=140 ms).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157466)

Enunciado: O Bloqueio Atrioventricular Total adquirido no nosso meio é mais comumente causado por cardiopatia chagásica, além de doença isquêmica, cardiopatia dilatada, pós-cirurgia cardíaca, causa degenerativa, entre outros. O nível do bloqueio é baixo, frequentemente infranodal, e o foco de escape, às vezes, fornece frequência muito baixa, como 15 a 20 bpm, configurando quadro de emergência, NÃO relacionado a uma das opções apresentadas a seguir. Indique-a.

A) A sintomatologia vai depender da frequência ventricular. Com a interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro, o indivíduo pode apresentar tontura, vertigem, pré-síncope e síncope.

B) A síncope do BAVT é conhecida como ataque de Stokes-Adams, em homenagem aos dois cientistas que a descreveram. A síncope cardiológica provoca a perda total dos sentidos por curto período de tempo, sem aviso prévio, acarretando, frequentemente, lesão corporal, e o paciente recupera-se imediatamente, sem ter noção do que aconteceu.

C) Podem ser assintomáticos. Com frequência, o BAVT congênito só causa repercussão clínica na adolescência ou no adulto jovem.

D) Os estímulos gerados na região supraventricular não são todos bloqueados, causando uma dissociação atrioventricular parcial de modo que os átrios tenham sua frequência própria, sendo sinusal ou não.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157471)

Enunciado: Você foi chamado a explicar a um amigo de outra especialidade o porquê de o paciente dele ser considerado como de alto risco para a cirurgia e, assim, indicado pós-operatório de UTI. Isso ocorreu devido a um lado de ECG que indicou internação imediata não para a cirurgia, e sim para a cardiologia. No laudo, estava escrito Bloqueio Atrioventricular Total (BAVT). A respeito dessa situação, aponte a alternativa considerada INADEQUADA:

A) O BAVT ou BAV de terceiro grau é a interrupção completa do estímulo de condução para os ventrículos. Os estímulos gerados na região supraventricular são todos bloqueados, causando uma dissociação atrioventricular completa de modo que os átrios tenham sua frequência própria, sendo sinusal ou não, e completamente independente da frequência ventricular.

B) Quando os ventrículos ficam privados de sua fonte estimuladora, tornam-se dependentes de outro grupo de células, que assume a função de marca-passo, sendo chamado de foco de escape. A frequência ventricular é completamente dissociada da atrial e depende exclusivamente da capacidade cronotrópica do foco de escape.

C) À medida que se aproximam do nó sinusal em direção aos ventrículos, as células especializadas apresentam frequências de despolarização cada vez menores.

D) As células do sistema His-Purkinje, como o próprio feixe, têm frequência em torno de 35 bpm, e os ramos do feixe de His, de 25 a 30 bpm. Logo, quanto mais baixo for o bloqueio, menos confiável e mais instável será o foco de escape, além de apresentar frequências baixas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157474)

Enunciado: Recentemente um tio de seu colega de clube apresentou uma palpitação e teve muito mal-estar. Como você era o único médico que ele conhecia, pediu para convencer o tio de que devia ir a um cardiologista. Sobre esse caso, você o orientou ADEQUADAMENTE, conforme uma das alternativas apresentadas. Assinale-a.

A) A menos que disfunção ventricular importante esteja presente, é consenso entre os especialistas que somente ritmos acima de 120 batimentos por minuto causam sintomas de comprometimento hemodinâmico.

B) Nos pacientes sintomáticos, há que se estabelecerem dois aspectos fundamentais. O primeiro diz respeito à intensidade dos sintomas. Assim, pacientes sintomáticos podem apresentar sintomas desconfortáveis, como palpitações, tontura e/ou dispneia leve, mas não apresentar qualquer sinal clínico de comprometimento hemodinâmico.

C) Um aspecto fundamental é o estabelecimento de uma relação causal entre a presença das taquiarritmias e os sintomas. Em que pese o fato de existir comprometimento hemodinâmico que necessite de tratamento imediato, sempre é possível estabelecer uma relação direta para o tratamento.

D) Em indivíduos assintomáticos, uma ampla gama de taquiarritmias pode ser identificada e sempre vão necessitar de tratamento específico imediato, já que não determinam alterações clínicas, mas podem degenerar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149261)

Enunciado: O exame de eletrocardiograma pode ser capaz de determinar suspeitas e diagnósticos de diversas doenças, tanto cardíacas como à distância, NÃO sendo listado, entre estas capazes de alterar o ECG:

A) Hipotermia.

B) Hipertensão intracraniana.

C) Glaucoma.

D) Obesidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157467)

Enunciado: As taquicardias de QRS estreito podem, para melhor raciocínio terapêutico, também ser possível dividi-las de acordo com a dependência do nó AV para seu início e manutenção. Assim, temos as taquicardias em que o circuito da arritmia utiliza o nó, muitas das vezes sendo indicada terapêutica farmacológica. Dessa forma, aponte a alternativa INCORRETA:

A) Adenosina é uma droga que diminui a condução pelo NAV e que promove vasoconstricção coronária.

B) Possui meia-vida de menos de 5 a 10 segundos, tendo assim efeito fugaz, porém efetivo no término da maioria das taquicardias de QRS estreito.

C) Efeitos colaterais podem ocorrer em até 60% dos casos.

D) É importante orientar previamente o paciente que poderá apresentar pressão torácica importante com sensação de ?morte? iminente, porém tais efeitos são transitórios.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157470)

Enunciado: A respeito do tratamento de emergência de taquiarritmias, marque a alternativa INCORRETA:

A) Drogas antiarrítmicas têm potencial pró-arrítmico e causam hipotensão arterial e bradicardias após reversão de uma arritmia, quando vários antiarrítmicos são utilizados em sequência.

B) Com exceção da adenosina, não se recomenda a administração sucessiva de várias drogas antiarrítmicas sequenciais.

C) Após a adequada utilização de uma droga até sua dose máxima, se não houver reversão da arritmia ou comprometimento hemodinâmico, o paciente deve ser considerado como ?instável? e a desfibrilação elétrica deve ser realizada.

D) Para pacientes com disfunção ventricular sistólica, a amiodarona e a digoxina são as drogas mais utilizadas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149216)

Enunciado: Dentre as seguintes complicações do afogamento, assinale a mais CORRETA.

A) A pneumonia ocorre em 100% dos casos e necessita de tratamento imediato à chegada do paciente na emergência.

B) O vômito é a complicação mais frequente no período pré-hospitalar.

C) Nas primeiras 48 horas, a febre e a leucocitose representam infecção.

D) A lesão pulmonar do afogamento pode ser reduzida com o uso de corticoide iniciado nas primeiras 48 horas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

141558)

Enunciado: No atendimento de um paciente com assistolia ou atividade elétrica sem pulso, deve-se:

A) Realizar desfibrilação cardíaca imediata com carga máxima do desfibrilador.

B) Checar os cabos, a derivação e o ganho do monitor em caso de assistolia.

C) Usar atropina no tratamento da parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso.

D) Utilizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar sem valorizar as causas da parada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127652)

Enunciado: Paciente de 62 anos dá entrada no serviço de emergências referindo sensação de palpitações há uma semana, com piora após realização de esforço físico. Ao exame, apresenta-se consciente, orientado, eupneico, ritmo cardíaco irregular, pressão arterial de 140 x 80 mmHg e frequência cardíaca de 128 bpm. O ritmo cardíaco está ilustrado no ECG abaixo. (VER IMAGEM) A conduta a ser tomada é:

A) Cardioversão elétrica imediata.

B) Cardioversão química imediata.

C) Controle da frequência cardíaca e anticoagulação por 3-4 semanas, seguidos de cardioversão.

D) Controle da frequência cardíaca seguido de ablação do nó atrioventricular e implante de marca-passo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129828)

Enunciado: Paciente de 31 anos, do sexo masculino, dá entrada no pronto-socorro a noite vindo de uma festa onde consumiu bebida alcoólica em grande quantidade associada com energéticos. Referia palpitações de início súbito e tonteira não rotatória, com PA na avalição inicial de 100/60 mmHg e FC de 140 bpm com ritmo irregular. O diagnóstico mais provável é:

A) Taquicardia sinusal.

B) Fibrilação atrial.

C) Taquicardia ventricular monomórfica.

D) Taquicardia por reentrada nodal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

136883)

Enunciado: Você está atendendo um paciente inconsciente em parada cardiorrespiratória. Assim que o monitor fica disponível, o ritmo verificado é o seguinte: (VER IMAGEM) Nesse caso, o próximo passo deve ser:

A) amiodarona em bolus intravenoso.

B) cardioversão elétrica sincronizada com carga de 100J.

C) epinefrina em bolus intravenoso.

D) desfibrilação com carga bifásica de 200J.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

136618)

Enunciado: Recentemente houve uma importante atualização de protocolos de manejo das emergências cardiovascular, como parada cardíaca. Caso seja necessária a aplicação dessas manobras, podemos considerar ADEQUADO

A) Manter uma frequência de massagem cardíaca acima de 120 por minuto.

B) Verificar o pulso após desfibrilação.

C) Limitar a profundidade da massagem cardíaca a 6 cm.

D) Aplicar sempre Amiodarona EV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

136623)

Enunciado: A Amiodarona é das medicações mais utilizadas como antiarrítmicos, durante as emergências. Não sendo, entretanto, verdadeiro quanto a ela o seguinte. Aponte-o.

A) Apresenta segurança de uso em Bolus.

B) Piora a disfunção tireoidiana.

C) Pode levar a Bloqueio Atrioventricular.

D) Deprime o miocárdio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137015)

Enunciado: Mulher de 82 anos, em acompanhamento regular no ambulatório por hipertensão arterial, vem para consulta de rotina queixando palpitações, ECG com fibrilação atrial e FC entre 100 e 110 bpm. Nesse caso, a melhor conduta é:

A) anticoagulação por via oral e cardioversão elétrica eletiva.

B) encaminhar ao pronto-socorro para cardioversão elétrica imediata.

C) controlar a frequência cardíaca, anticoagulação por via oral, e cardioversão elétrica eletiva.

D) controlar a frequência cardíaca e não anticoagular pelo risco de sangramento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127365)

Enunciado: Paciente feminina de 60 anos de idade deu entrada na sala de emergência se queixando de intensa dor torácica, evoluindo com mal-estar geral e dispneia. Ao realizar ECG, foi demonstrado padrão de supra de ST nas derivações V1 até V5. Subitamente, apresentou síncope, sendo que seu monitor cardíaco apresentava padrão de linha reta. Qual das condutas abaixo enumeradas, iniciadas frente à parada cardíaca em assistolia, apresenta efeito inotrópico negativo?

A) Adrenalina.

B) Atropina.

C) Bicarbonato de Sódio

D) Vasopressina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

136620)

Enunciado: Durante manobras de reanimação cardiorrespiratória, você observou o colega socorrista se esforçando para ventilar o paciente com máscara e ambu + Oxigênio, o mais rápido possível. Das alternativas apresentadas, aponte aquela contendo a conduta que o colega socorrista conseguiu devido ao seu esforço.

A) Melhorar o prognóstico do paciente em PCR.

B) Piorar o retorno venoso.

C) Melhorar a oxigenação do paciente.

D) Reduzir o tempo de parada cardíaca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127367)

Enunciado: Paciente apresenta súbito mal-estar de início há algumas horas, embora tenha acordado se sentindo bem. Refere ser tabagista e hipertenso com controle inadequado por uso irregular de betabloqueador que alega lhe causar mal-estar. Durante seu exame físico, é notada alteração no ritmo cardíaco e por isso solicitado ECG. Realizado o exame, é notado padrão de QRS fino, ritmo irregular e uma FC de 140 bpm. Ocorre, então, uma grande piora do paciente, que apresenta agora dispneia com queda da SPO2, ausculta pulmonar e edema agudo de pulmão. A respeito do caso e da conduta, indique a alternativa CORRETA.

A) Trata-se de parada cardíaca, portanto iniciar CAB.

B) O diagnóstico é o de Insuficiência Coronariana com TV a seguir, portanto desfibrilar.

C) Fibrilação Atrial Aguda, portanto fazer Desfibrilação Química com Lidocaína.

D) Fibrilação Atrial, portanto, como evolui com instabilidade, Cardioversão Elétrica está indicada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

136640)

Enunciado: Paciente foi trazido por resgate sem sinais vitais. Iniciado protocolo CAB. Qual dos aspectos abaixo é considerado, a fim de evitar perda de efetividade da massagem cardíaca?

A) Limitar a frequência de massagem a 120 por minuto.

B) Limitar a massagem a 5 cm no tórax.

C) Limitar a troca de quem está fazendo rcp ao menor número de vezes possíveis.

D) Limitar as vezes que se apoia sobre o tórax no momento do retorno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127360)

Enunciado: Quando das manobras de reanimação, seguindo o protocolo do CAB, a hiperventilação com AMBU pode ocorrer, caso esta ultrapasse a frequência de 10 por minutos. Qual é a POSSÍVEL consequência dessa manobra?

A) Melhora com hiperoxia.

B) Aumento da pressão sistólica.

C) Dificuldade de retorno venoso.

D) Piora da hipercapnia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127254)

Enunciado: A principal terapêutica atual para correção de arritmias ventricular, que levam à Parada Cardíaca, é a Desfibrilação. Qual das alternativas listadas mostra-se INADEQUADA para esse caso?

A) Checar pulso após aplicar o choque.

B) Indicar monofásico, caso bifásico não esteja disponível.

C) Iniciar com maior carga disponível.

D) Reiniciar o ciclo, quando indicado cada dois minutos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127255)

Enunciado: Existem diversos achados no ECG que direcionam ao diagnóstico correto. Essa correlação se mostra INCORRETA no seguinte exemplo. Aponte-o.

A) Variação de amplitude na mesma derivação, no caso de derrame pericárdico.

B) Supra do segmento ST regional na pericardite.

C) Baixa voltagem no hipotireoidismo.

D) Alteração de repolarização ventricular, no caso de intoxicação digitálica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127262)

Enunciado: Indique os antiarrítmicos contidos em uma das alternativas, que estão correlacionados com modulação dos canais de sódio para seu efeito:

A) Lidocaína e propafenona.

B) Amiodarona e metoprolol.

C) Diltiazem e verapamil.

D) Deslanosídeo e esmolol.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127264)

Enunciado: A correta interpretação do eletrocardiograma se mostra importante para o correto diagnóstico etiológico, ou mesmo para a suspeita clínica de diversas síndromes cardíacas e até extracardíacas. O achado de variações de amplitude do complexo QRS, no derrame pericárdico, é ADEQUADAMENTE explicado da seguinte forma. Aponte-a:

A) Ectopia do marca passo.

B) Origem abaixo do nó átrio ventricular.

C) Proximidade da massa muscular ventricular.

D) Reentrada nodal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

136547)

Enunciado: Das drogas abaixo, quais podem ser administradas via endotraqueal?

A) Naloxone e atropina.

B) Epinefrina e gluconato de cálcio.

C) Lidocaína e bicarbonato.

D) Atropina e gluconato de cálcio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111453)

Enunciado: Sobre a disposição correta dos eletrodos de ECG sobre o tórax, que alternativa está incorreta?

A) V1 - 4° espaço intercostal direito.

B) V2 - 4° espaço intercostal esquerdo.

C) V4 - 5° espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda.

D) V5 - 5° espaço intercostal na linha axilar anterior.

E) V6 - 5° espaço intercostal na linha axilar posterior.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111455)

Enunciado: Durante a interpretação de um ECG, a onda P está bem evidente. Neste caso, que arritmia podemos descartar?

A) Bloqueio sinoatrial.

B) Bradicardia sinusal.

C) Fibrilação atrial.

D) Taquicardia atrial multifocal.

E) Taquicardia sinusal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

112350)

Enunciado: Na fibrilação atrial permanente, a estratégia de reversão para ritmo sinusal foi abandonada. Nesta situação,

A) o risco de fenômenos tromboembólicos é pequeno e dispensa tratamento profilático.

B) o controle da frequência cardíaca pode ser obtido com utilização de betabloqueadores.

C) o uso de aspirina impede a ocorrência de um acidente vascular cerebral isquêmico.

D) o tratamento com estatinas concorre para a redução da morbimortalidade dos pacientes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109305)

Enunciado: Qual é a alteração eletrocardiográfica mais frequente na doença de Chagas?

A) Bloqueio de ramo esquerdo.

B) Bloqueio de ramo direito associado a bloqueio divisional anterossuperior esquerdo.

C) Bloqueio de ramo direito associado a bloqueio divisional posteroinferior esquerdo.

D) Bloqueio atrioventricular do 1° grau.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109317)

Enunciado: Homem de 66 anos apresenta perda súbita de consciência após dar entrada no pronto-socorro com queixa de dor torácica. Ao exame físico, se apresenta arresponsivo, sem respiração e sem pulso. Pressão arterial inaudível. O traçado eletrocardiográfico no monitor é apresentado na figura a seguir. (VER IMAGEM) Dentro do tratamento ideal para este paciente, qual deve ser o primeiro fármaco a ser utilizado?

A) Atropina 1 mg IV.

B) Amiodarona 300 mg IV.

C) Epinefrina 1 mg IV.

D) Bicarbonato de sódio 1 mEq/kg EV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103731)

Enunciado: Paciente feminina de 58 anos, deu entrada no Hospital se queixando de mal estar e discreto desconforto torácico de início nessa tarde, após discussão familiar. Logo após realização de ECG, apresentou síncope e dispneia, logo a seguir seu pulso central desapareceu. Qual das afirmativas abaixo pode ser considerada INADEQUADA?

A) Primeira atitude é intubar a paciente devido à dispneia.

B) Dentro da cadeia de sobrevivência, devemos solicitar por socorro.

C) Iniciado manobras de reanimação, a sequência se dá utilizando ciclo de C-A-B.

D) Iniciado manobras de reanimação, a sequência se dá utilizando ciclos de 30 massagens e duas ventilações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103741)

Enunciado: Paciente deu entrada na sala de emergência sem pulso central, trazido por familiares que encontraram o mesmo desacordado no seu quarto. Iniciado protocolo de parada cardíaca, são realizados massagem cardíaca externa em ritmo de aproximadamente 100 por minuto, a seguir duas ventilações, trocando após dois minutos quem realiza a massagem, simultaneamente checando pulso. Prioridade para massagem cardíaca. Dessa descrição, qual dos critérios de qualidade da reanimação necessita ser MELHOR explicado?

A) O tempo que ocorreu a parada cardíaca.

B) Apesar da prioridade de realizar a massagem cardíaca externa, a mesma deve obedecer a relação de 30 massagens para duas

ventilações; na explicação, dá a impressão de se ter realizado 100 massagens antes de ventilar.

C) Não é necessária a troca de quem realiza a massagem cardíaca tão rapidamente, a mesma ocorre somente após 5 minutos.

D) Não foi avaliado o ritmo que se encontra o paciente em parada cardíaca, não se pode iniciar o protocolo sem essa informação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103661)

Enunciado: Atualmente, uma das medicações mais utilizadas em emergências cardíacas é a Amiodarona. Dentre as alternativas abaixo, qual NÃO podemos considerar adequada?

A) Quando utilizada via oral, pode levar semanas para obter efeito.

B) Não têm atividade em arritmias supraventriculares.

C) Somente pode ser utilizada em bolus, em arritmias ventriculares sem pulso.

D) Causa potencialmente deterioração de disfunção tiroidiana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103685)

Enunciado: Paciente referia dor torácica típica ao dar entrada no hospital e, enquanto aguardava seu atendimento para realizar ECG, apresentou síncope, sendo, então, levada à sala de emergência. Na avalição inicial da sala de emergência, foi diagnosticado PCR em ritmo de fibrilação ventricular, iniciado, então, ciclo de massagem cardíaca. Qual das alternativas de conduta NÃO se mostra adequada, segundo as atuais normas de abordagem da parada cardíaca?

A) Caso a Desfibrilação elétrica não seja efetiva, opção por Amiodarona em dose de 300 mg em bolus.

B) Checar pulso logo após desfibrilação monofásica de 360 J.

C) Desfibrilação bifásica de 120 J.

D) Adrenalina a cada 3 minutos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86335)

Enunciado: Um paciente portador de Doença de Chagas foi admitido no pronto-socorro torporoso, com sudorese fria, pele pegajosa e dispneia intensa. Ao exame físico se constatou: pressão arterial 80/50 mmHg, frequência cardíaca 220 bpm. A melhor conduta a ser realizada nesse caso é:

A) administração endovenosa de metoprolol em bolus.

B) cardioversão elétrica sincronizada.

C) administração endovenosa de estreptoquinase 1500000UI em 40 minutos.

D) administração endovenosa de amiodarona 900 mg em bomba de infusão continua a 10 ml/hora.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

89995)

Enunciado: Sobre arritmias cardíacas, é incorreto afirmar:

A) Podem surgir sem doença cardíaca estrutural.

B) Hipertireoidismo e uso de bebidas alcoólicas são causas.

C) Pode haver palpitações, dor precordial e/ou dispneia.

D) ECG não é suficiente para o diagnóstico.

E) A Síndrome de Wolff-Parkinson-White é uma doença por alteração de condução.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

78125)

Enunciado: A perda súbita de consciência na síndrome de Stokes-Adams é devido:

A) A espasmos vasculares cerebrais decorrentes de crises hipertensivas.

B) A acidente vascular cerebral isquêmico por liberação de trombos de cavidades cardíacas.

C) A baixo fluxo cerebral por presença de estenose valvar aórtica severa.

D) À diminuição do débito cardíaco por bloqueio atrioventricular total intermitente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

83819)

Enunciado: Faz parte da síndrome de Wolff-Parkinson-White, EXCETO:

A) Intervalo PR < 0,12 segundos.

B) QRS > 0,12 segundos.

C) Não progressão das ondas R.

D) Onda delta.

E) Presença de alterações secundárias da onda T.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84609)

Enunciado: Qual a melhor conduta, segundo o último consenso da American Heart Association 2010 e ACLS Advanced Cardiovascular Life Support a ser imediatamente realizada em um paciente com este eletrocardiograma com QRS regular e com os sintomas de pele fria, diaforético, adinamia, episódios de síncope e pressão arterial de 60 x 30? (VER IMAGEM)

A) Manobra Vagal.

B) Adenosina 6 mg.

C) Desfibrilação com 360 J.

D) Cardioversão Sincronizada entre 50 - 100 J.

E) Amiodarona endovenosa 150 mg em soro 100 ml e correr em 10 minutos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

85808)

Enunciado: Para um paciente com ECG acima , que dá entrada na emergência apresentando sinais de instabilidade como nível de consciência alterado, hipotensão e choque , está correto iniciar tratamento imediato com: (VER IMAGEM)

A) cardioversão

B) amiodarona

C) atropina

D) desfibrilação

E) estreptoquinase

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

85401)

Enunciado: Diretrizes da American Heart Association 2010 para RCP (Reanimação Cardiopulmonar) e ACE (Atendimento Cardiovascular de Emergência) trouxeram algumas mudanças. Essas alterações foram concebidas para simplificar o treinamento do profissional de saúde e continuar enfatizando a necessidade de aplicar a RCP de alta qualidade, o quanto antes, em vítimas de PCR. Marque a alternativa CORRETA sobre os principais componentes de SBV (Suporte Básico de Vida) para profissionais de saúde.

A) A frequência de compreensão deve ser de aproximadamente 100/minuto.

B) Inicialmente, deve-se empregar o "ver, ouvir e sentir se há respiração".

C) A relação compressão-ventilação, até a colocação da via aérea avançada é de 15:2 quando estão presentes dois socorristas profissionais de saúde.

D) Iniciar RCP após verificação da ausência do pulso por 30 segundos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61717)

Enunciado: Em um paciente com síndrome de Wolff-Parkinson-White, durante um episódio de FA, deve-se evitar a administração de:

A) lidocaína.

B) procainamida.

C) ibutilide.

D) digital.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61719)

Enunciado: Considera-se recomendação classe III para manejo da fibrilação atrial na síndrome de Wolff-Parkinson-White, EXCETO:

A) Digital.

B) Adenosina.

C) Verapamil.

D) Betabloqueador.

E) Procainamida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61722)

Enunciado: Paciente de 17 anos, portador de WPW, deu entrada na emergência hemodinamicamente estável, com taquicardia, com QRS largo irregular e R-R mais curto medindo 180 ms. Entre as drogas abaixo assinale aquela mais adequada para esta situação.

A) Verapamil.

B) Adenosina.

C) Esmolol.

D) Procainamida.

E) Digital.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

69210)

Enunciado: Uma mulher com 48 anos tem fibrilação atrial com frequência ventricular de 140 bpm. Está levemente tonta, com pressão arterial 77 x 48 mmHg. Dos seguintes passos, qual é o mais adequado?

A) Digoxina intravenosa.

B) Cardioversão elétrica.

C) Iniciar manobras vagais.

D) Cardizem (diltiazem) intravenoso.

E) Sotalol intravenoso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

63670)

Enunciado: Você está em um banco pagando a inscrição de um dos concursos de residência médica que irá prestar, quando uma senhora ao seu lado tem um colapso. Ela aparenta ter uns 45 anos de idade e está desacompanhada. Ao chegar junto a ela e chamando-a, a mesma não responde a qualquer chamado. Qual deve ser sua conduta visto tratar-se de uma situação que necessita suporte básico de vida?

A) Virar a paciente de lado em posição de espera e chamar o SAMU, checando seu pulso a cada 2 minutos e monitorar o nível de consciência.

B) Solicitar ajuda (acionamento do SAMU e localização do DEA). Enquanto o socorro não chega, checar pulso central da paciente por não mais que 10 segundos. Se não houver pulso, iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, iniciando pelas compressões torácicas. Lembrar-se que o foco no suporte básico é uma RCP eficaz e desfibrilação precoce se choque indicado.

C) Solicitar ajuda (acionamento do SAMU e localização do DEA). Enquanto o socorro não chega, checar pulso central da paciente por não mais que 10 segundos. Se não houver pulso, iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, iniciando pelas manobras de ventilação. Lembrar-se que o foco no suporte básico é uma RCP eficaz e desfibrilação precoce se choque indicado.

D) Solicitar ajuda (acionamento do SAMU e localização do DEA). Enquanto o socorro não chega, checar pulso central da paciente por não mais que 5 segundos. Se não houver pulso, iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, iniciando pelas compressões torácicas. Lembrar-se que o foco no suporte básico é a chegada de recursos para acesso venoso precoce para administração de adrenalina e intubação orotraqueal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

63687)

Enunciado: Num plantão no pronto-socorro, em seu primeiro dia de residência, chega trazido pelo SAMU um paciente de 30 anos, com queixa de palpitação. O paciente nega doenças prévias, referindo apenas estar dormindo mal nos últimos dias por ansiedade, devido a compromissos profissionais. Na avaliação, o paciente está lúcido, orientado, eupneico, ausculta pulmonar normal. Na ausculta cardíaca, paciente tem frequência de 170 bpm com bulhas hiperfonéticas e ritmo regular. PA 120/80 mmHg. Ao realizar um ECG, você percebe frequência de 170 bpm, RR regular, ausência de onda P, QRS estreito (< 0,12 segundos). Você monitoriza, solicita acesso venoso e colocação de cateter de O2. Em seguida, realiza manobra vagal sem sucesso. Qual seria a melhor conduta no atendimento sequencial do caso e qual a hipótese diagnóstica mais provável?

A) Sedação com propofol e analgesia com fentanil. Realização de cardioversão sincronizada, pois trata-se de uma fibrilação atrial com sinais de instabilidade hemodinâmica.

B) Sedação com midazolam e analgesia com fentanil. Realização de cardioversão não sincronizada com 100 J, pois trata-se de uma fibrilação atrial com sinais de instabilidade hemodinâmica.

C) Administração EV em bolus de 6 mg de adenosina avisando para o paciente que ele terá uma sensação tensitória de mal-estar. Trata-se de um caso de taquicardia paroxística supraventricular por provável reentrada nodal. Betabloqueador ou bloqueador do canal de cálcio são outras opções possíveis no caso.

D) Administração EV em bolus de 6 mg de adenosina avisando para o paciente que ele terá uma sensação transitória de mal-estar. Trata-se de um caso de taquicardia paroxística supraventricular por provável reentrada nodal. Betabloqueador ou bloqueador do canal de cálcio são drogas proscritas e aumentam a mortalidade em casos como esse.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61790)

Enunciado: Reconheça o ritmo do traçado eletrocardiográfico e conduta terapêutica (VER IMAGEM):

A) Taquicardia sinusal, pesquisar causas.

B) Taquicardia sinusal, amiodarona 5 mg/kg.

C) Taquicardia supraventricular, adenosina 0,1 mg/kg.

D) Taquicardia ventricular, cardioversão sincronizada 0,5-1 J/kg.

E) Taquicardia ventricular, desfibrilação 2 J/kg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

63480)

Enunciado: Paciente, 45 anos, masculino, com quadro de palpitação há 20 minutos chega ao pronto-socorro e ao exame físico apresenta sudorese fria, pele pegajosa, desconforto torácico opressivo com irradiação para ombro esquerdo. PA = 90 x 50 mmHg e FC = 182 bpm, QRS menor do que 0,12 segundos; irregular. Qual a melhor conduta, de acordo com o guideline 2010 da American Heart Association?

A) Manobra Vagal, Adenosina 6 mg e Betabloqueador.

B) Manobra Vagal, Adenosina 12 mg e Bloqueador de Canal de Cálcio.

C) Desfibrilação 360 J monofásico, Adenosina 12 mg e nipride 1 mcg/kg/min.

D) Cardioversão Sincronizada 120 Joules bifásico podendo chegar até 200 Joules.

E) Cardioversão Sincronizada 100 Joules, Adenosina 6 mg, Procainamida 20 mg/min até supressão da arritmia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61818)

Enunciado: A Síndrome da Apneia-Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) é uma doença de grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. Dentre as comorbidades a seguir, qual NÃO tem relação com esta doença?

A) Hipertensão arterial.

B) DPOC.

C) Dislipidemia.

D) Alterações no metabolismo da glicose.

E) NDA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61801)

Enunciado: Uma situação de Parada Cardiorrespiratória (PCR) representa prioridade e rapidez de atendimento na prática médica. Considerando as diretrizes atuais da American Heart Associacion (AHA) sobre Suporte Avançado de Vida Cardiovascular, pode-se afirmar que:

A) O exame clínico é o método mais confiável para monitorar a posição adequada do tubo endotraqueal, não sendo mais recomendado a capnografia com forma de onda contínua.

B) As causas mais comuns da AESP (Atividade Elétrica Sem Pulso) são os 5 Hs (Hipovolemia, Hipóxia, Hipo/Hipercalemia, Hipoglicemia, Hipotermia) e 5 Ts (Pneumotórax, Tamponamento cardíaco, Toxinas, Trombose pulmonar ou coronária).

C) As vias de acesso para os medicamentos durante uma PCR, em ordem de prioridade, são: endovenosa, endotraqueal e intraóssea; devendo-se evitar esta última em crianças menores de 5 anos.

D) No algoritmo de cuidados imediatos pós-PCR do adulto, deve-se otimizar o estado ventilatório e hemodinâmico do paciente: não hiperventilar, manter a saturação de oxigênio "maior ou igual a" 90% e tratar hipotensão (PA sistólica < 90 mmHg).

E) A hipotermia terapêutica é a única intervenção que mostrou ter melhorado a recuperação neurológica após uma PCR com duração ideal de, no mínimo, 12 horas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

48303)

Enunciado: Paciente de 42 anos, branco, ao realizar caminhada matinal, cai subitamente ao solo e fica imóvel. A primeira conduta é:

A) Respiração boca a boca ou boca-nariz

B) Soco precordial

C) Massagem cardíaca externa

D) Avaliar responsividade e chamar ajuda

E) Nenhuma das alternativas anteriores

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

47666)

Enunciado: Para tratar de fibrilação ventricular, num paciente adulto, as diretrizes de 2010 sobre reanimação cardiopulmonar (RCP) preconizam:

A) Relação compressão-ventilação única (15:2);

B) Inserção imediata de via aérea avançada;

C) Choque (desfribilação) único seguido de início imediato de massagem cardíaca;

D) Imediata utilização de drogas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

53603)

Enunciado: Fibrilação atrial com episódios que duram até mais de sete dias e sem resposta à cardioversão é classificada como:

A) Paroxística.

B) Permanente.

C) Persistente.

D) Terminal.

E) Subaguda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

48486)

Enunciado: O Tilt teste positivo demonstra:

A) Susceptibilidade do paciente diábético em desenvolver úlceras em membros inferiores.

B) Tendência em apresentar hemorragia digestiva de origem alta ou baixa, no paciente renal crônico.

C) Comprometimento renal no Diabetes Mellitus tipo II.

D) Confirmação do diagnóstico de hipertensão arterial essencial.

E) Vulnerabilidade do indivíduo em apresentar episódios de síncope devido o comprometimento da inervação autonômica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

48498)

Enunciado: Analise os traçados e escolha os diagnósticos correspondentes, respectivamente (VER IMAGEM).

A) Fibrilação ventricular, Taquicardia ventricular monomórfica e Fibrilação ventricular.

B) Taquicardia ventricular monomórfica, Taquicardia ventricular polimórfica e Fibrilação ventricular.

C) Taquicardia ventricular monomórfica, Taquicardia ventricular polimórfica e Fibrilação atrial.

D) Taquicardia supraventricular paroxística, Fibrilação ventricular e Fibrilação ventricular.

E) Taquicardia supraventricular paroxística, Taquicardia ventricular polimórfica e Fibrilação ventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

48503)

Enunciado: Toxicômano dá entrada na emergência com crise convulsiva. O médico que o atende suspeita de intoxicação aguda por cocaína, porque há concomitantemente:

A) Hipotermia e nistagmo.

B) Arritmia cardíaca e nistagmo.

C) Arritmia cardíaca e hipertermia.

D) Hipotermia e hipertensão arterial.

E) Hipotermia e hipotensão arterial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

48868)

Enunciado: Em relação ao uso de medicações no atendimento da parada cardiorrespiratória, podemos afirmar que:

A) o bicarbonato de sódio deve ser administrado logo no início do atendimento dos pacientes em parada cardíaca

B) o cálcio é essencial no manuseio da parada cardíaca por hipopotassemia ou hipomagnesemia

C) a atropina é a droga de escolha nas paradas cardíacas em assistolia ou atividade elétrica sem pulso (dissociação eletromecânica), devendo ser repetida quantas vezes for necessário, sem limitação de dose

D) drogas vasopressoras como a adrenalina e/ou vasopressina são fundamentais, devendo ser usadas no atendimento da parada cardiorrespiratória com a finalidade de aumentar a pressão de perfusão coronariana

E) a amiodarona deve ser usada nos casos de parada cardíaca por fibrilação ventricular, podendo-se postergar a desfibrilação elétrica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35612)

Enunciado: Um homem de 24 anos dá entrada no pronto-socorro com queixa de dor em aperto na região retroesternal. Relata ter usado cocaína inalatória há cerca de 40 minutos. Está sudoreico, com extremidades frias, pupilas dilatadas e fasciculações na pálpebra esquerda; pulso = 124 bat/min, PA = 180 x 90, T = 36,9ºC, frequência respiratória de 24 mr/min, com ausculta cardíaca e pulmonar normais, pulsos centrais e periféricos palpáveis e simétricos. O médico deve de imediato:

A) Administrar betabloqueador VO ou EV.

B) Administrar flumazenil EV.

C) Confirmar a intoxicação através de exame de urina.

D) Solicitar eletrocardiograma.

E) Administrar naloxona IM ou EV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35626)

Enunciado: Homem de 56 anos, hipertenso e diabético deu entrada no Pronto-Socorro com duas horas de dor precordial de forte intensidade, irradiada para membro superior esquerdo e acompanhada de sudorese. O eletrocardiograma apresentava 2 mm de supradesnivelamento do segmento ST em DII, DIII e AVF. Ao exame, estava em bom estado geral com palidez cutânea +/++, PA = 100 x 70 mmHg, P = 60 (2 extrassístoles por minuto). Coração e pulmão sem alterações. Nega cirurgias ou traumas recentes. Teve infarto há cerca de 4 meses quando recebeu estreptoquinase. Após ter recebido 5 mg de Isordil sublingual e 1 mg de morfina endovenosa, o paciente evoluiu com confusão mental, queda da pressão para 50 x 30 mmHg e no eletrocardiograma apresentou bloqueio A-V total. Qual conduta imediata mais adequada dentre as alternativas abaixo?

A) Cateterismo de emergência.

B) Marca-passo externo transcutâneo.

C) Atropina 0,25 mg intravenosa.

D) Dobutamina 2,5 mg/kg/min intravenosa.

E) Nitroglicerina intravenosa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35627)

Enunciado: Considere o caso de uma jovem senhora de 36 anos, portadora de estenose da valva mitral com área valvar de 1,5 cm^2 e fribilação atrial crônica em uso de digoxina e que procura médico para prosseguir o acompanhamento. A paciente não apresenta limitação física ou sintomas e sua frequência cardíaca média é 72 batimentos por minuto. Qual das drogas abaixo deve ser associada ao tratamento?

A) Warfarina.

B) Captopril.

C) Amiodarona.

D) Quinidina.

E) Diurético tiazídico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35846)

Enunciado: O tratamento de pacientes com fibrilação atrial (FA) varia de acordo com a manifestação clínica, mas envolve três componentes: (1) avaliação da necessidade para restauração do ritmo sinusal, (2) anticoagulação para prevenir AVC e (3) droga para controle da FC. Marque a opção verdadeira em relação ao manuseio da FA.

A) Os resultados do estudo AFFIRM demonstram que a estratégia de manutenção do ritmo sinusal com antiarrítmicos é superior sobre a estratégia de controle da FC.

B) Nos pacientes com FA < 48 horas de duração, pode-se realizar a cardioversão elétrica sem necessidade de anticoagulação prolongada.

C) Nos pacientes com FA > 48 horas de duração recomenda-se a anticoagulação com aspirina pelo menos três semanas antes de cardioversão elétrica.

D) Nos pacientes com FA e WPW a reversão química pode ser realizada com verapamil.

E) Se a existência de trombo atrial for excluída por ecocardiograma transtorácico, pode-se efetuar a cardioversão nestes pacientes mais rapidamente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35852)

Enunciado: Paciente portador de Síndrome de WPW que apresenta taquicardia supraventricular de QRS estreito com instabilidade hemodinâmica. A melhor opção para reversão da arritmia em ambiente hospitalar é:

A) Amiodarona endovenosa administrada lentamente.

B) Adenosina endovenosa administrada em bolus.

C) Cardioversão elétrica.

D) Manobra vagal com compressão do globo ocular.

E) Conduta expectante, pois o índice de reversão espontânea das arritmias supraventriculares é alto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

26938)

Enunciado: Maria, 40 anos, sem antecedentes patológicos, apresentou súbita tontura seguida de pré-síncope após caminhada de 30 minutos no plano. Avaliada em ambulatório, constatou-se apenas ritmo cardíaco irregular e pulso de 170bpm. O ECG demonstrou ausência de onda P e intervalo RR irregular. Qual dos exames abaixo é mais importante na avaliação da causa desta arritmia.

A) dosagem sérica de potássio e de magnésio

B) Holter cardíaco de 24 horas

C) ecocardiograma de estresse

D) teste ergométrico

E) dosagem sérica de TSH

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27200)

Enunciado: Maiores causas de morte súbita em atletas:

A) infarto agudo do miocárdio; doença de Chagas; crise hipertensiva.

B) infarto agudo do miocárdio; estenose aórtica; taquicardia supraventricular.

C) miocardiopatia hipertrófica, displasia arritmogênica de VD; WPW.

D) estenose subaortica; doença de Chagas; tromboembolismo.

E) displasia arritmogênica de VD; acidente vascular cerebral; ICC.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27150)

Enunciado: Em qual situação não se deve indicar marcapasso definitivo:

A) Doença do nódulo sinusal.

B) Bloqueio infra hissiano.

C) BAV total.

D) Síndrome taquibradi.

E) Bloqueio supra Hissiano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27151)

Enunciado: Qual a melhor maneira para diagnóstico de uma síndrome taquicárdica:

A) Holter 24h.

B) Gravador de eventos.

C) Teste de esforço.

D) ECG durante a arritmia.

E) Cintilografia miocárdica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

11090)

Enunciado: Os novos conceitos em reanimação cardiopulmonar tem mudado constantemente. Dentre as últimas recomendações está a técnica para massagem cardíaca externa e a ventilação pulmonar. Com relação a estas recomendações podemos afirmar que:

A) A massagem cardíaca externa deve ser realizada numa relação de 15:1 ventilação quando existem dois reanimadores.

B) Independente do número de reanimadores a relação será sempre de 15:1.

C) A relação massagem cardíaca:ventilação recomendada é de 30:2

D) A ventilação só será iniciada após a massagem cardíaca desde o primeiro atendimento.

E) N.r.a.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

11107)

Enunciado: Qual é a arritmia mais frequente nos quadros pós-operatórios:

A) Fibrilação atrial

B) Taquicardia ventricular

C) Extrassístole ventricular

D) Fibrilação ventricular

E) N.r.a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

16029)

Enunciado: Com o tratamento da parada cardíaca pela Fase 1 (suporte básico) e Fase 2 (suporte avançado), pode-se recuperar a respiração e a circulação espontânea e chega-se à Fase 3, que é a da recuperação cerebral. Todos os esforços no tratamento da parada cardiorrespiratória devem visar à preservação do sistema nervoso central e suas funções, no período crítico em que este sistema sofre os efeitos da hipóxia. Uma série de medidas deve ser tomada, algumas já provadas na prática, enquanto que outras possuem somente bases teóricas. Dentre essas medidas, destaca-se a diminuição:

A) da pressão arterial com expansores plasmáticos.

B) do consumo de oxigênio por hipotermia.

C) do aporte de oxigênio ao cérebro.

D) do edema cerebral com transfusão de sangue.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274007)

Enunciado: O uso da adrenalina na parada cardiorrespiratória tem como objetivo principal:

A) Aumentar a pressão diastólica e automaticidade miocárdica melhorando a perfusão renal.

B) Restabelecer a circulação espontânea e melhorar a sobrevida pós-parada cardíaca.

C) Aumentar o consumo de oxigênio pelo miocárdio e, assim, restabelecer o débito cardíaco.

D) Restabelecer a circulação espontânea através do aumento da pressão de perfusão coronária e manter a perfusão cerebral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250228)

Enunciado: Paciente 65 anos, avaliado em consulta ambulatorial, apresenta antecedente de acidente vascular encefálico isquêmico e fibrilação atrial. Previamente hipertenso e com doença vascular periférica. Exames laboratoriais: creatinina: 1,1 mg/dl, hemoglobina: 12 g/dl, plaquetas: 260.000/mm^3, ecocardiograma: estenose mitral moderada a grave. Com base nas informações, assinale a alternativa CORRETA:

A) Está indicada a anticoagulação com antagonistas da vitamina K.

B) A rivaroxabana 20 mg é o anticoagulante de escolha.

C) Está indicado o uso de dupla antiagregação: aspirina 100 mg e clopidogrel 75 mg.

D) Não está indicado o uso de terapia antiagregante ou anticoagulante nesse caso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

216386)

Enunciado: Paciente de 35 anos, sexo feminino, apresentando queixa de palpitações há alguns dias. História pregressa de febre reumática. À ausculta, ritmo cardíaco irregular. Realizado ECG que mostrou: QRS estreito, intervalos R-R variáveis e ausência de onda P identificável. A arritmia MAIS PROVÁVEL para essa paciente é:

A) Flutter atrial.

B) Fibrilação atrial.

C) Taquicardia por reentrada nodal atrioventricular.

D) Taquicardia ortodrômica por via acessória.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176124)

Enunciado: Ao avaliar o ritmo de um paciente em assistolia e atividade ele trica sem pulso (AESP), a presença de QRS estreitos, com taquicardia, sugere como causa, entre as apresentadas:

A) Infarto agudo do miocárdio

B) Hiperpotassemia

C) Toxicidade por drogas

D) Hipoxemia

E) Hipovolemia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176131)

Enunciado: As arritmias cardíacas são decorrentes, basicamente, de alterações na geração do impulso (automatismo anormal e atividade deflagrada) e/ou na condução do impulso (reentrada). Sobre os principais mecanismos de taquiarritmia mais prevalentes na população pediátrica, sua classificação e tratamento, podemos afirmar, EXCETO:

A) As células miocárdicas atriais e ventriculares normalmente não apresentam atividade de marca-passo.

B) A reentrada é o mecanismo gerador de taquiarritmias supraventriculares e ventriculares mais frequente e relevante, podendo ser anatômica ou funcional.

C) As arritmias cardíacas podem ser classificadas quanto à repercussão clínica em estável ou instável.

D) A distinção entre taquicardia supraventricular e taquicardia ventricular é de fundamental importância, não somente para a reversão aguda, mas para adoção de estratégias para a prevenção de recorrências em longo prazo.

E) Cicatrizes (fibrose) miocárdicas secundárias à cardiopatia estrutural não favorecem o desenvolvimento de reentrada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155255)

Enunciado: Sobre a Fibrilação Atrial é correto afirmar, EXCETO:

A) Essa arritmia se apresenta obrigatoriamente com taquicardia.

B) Os pacientes com fibrilação atrial, mesmo quando paroxística, podem ter indicação para anticoagulação, mantida indefinidamente naqueles sem contraindicação e com pelo menos um fator de risco CHADS2

C) É a arritmia crônica mais comum, com incidência e prevalência que aumentam com a idade.

D) Um paciente masculino, 60 anos, diabético, portador de fibrilação atrial, sem outras comorbidades, poderá trocar a anticoagulação oral pelo AAS.

E) A rivaroxabana foi aprovada para anticoagulação em pacientes com fibrilação atrial não valvar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155261)

Enunciado: Mãe traz à emergência criança de 6 meses com queixa de irritabilidade há dois dias, vômitos, recusa alimentar e cansaço que piorou nas últimas 12 horas associada à palidez. Ao exame físico, é observado desconforto respiratório, pulsos finos, gemência, tiragem inter e subcostal. Paciente é colocado com máscara de oxigênio não reinalante a 10 litros/min e monitorizado. Observado no monitor ritmo cardíaco sem onda p, duração do QRS de 70ms, frequência cardíaca de 260 bpm, sem variações durante todo o atendimento. Qual a medida MAIS ADEQUADA para restabelecer a estabilidade hemodinâmica desse paciente?

A) Adenosina - 0,1 mg/kg máximo 6mg.

B) Cardioversão elétrica - Choque inicial de 0,5 a 1 J/kg.

C) Amiodarona - 5mg/kg EV.

D) Cardioversão elétrica - Choque inicial de 2J/kg.

E) Procainamida - 15mg/kg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131920)

Enunciado: Ao avaliar um adulto de 41 anos com síncope, assinale qual dos achados fala a favor de síncope de bom prognóstico e NÃO indicaria necessidade de internação para avaliação adicional.

A) Síncope ocorrida durante atividade física.

B) Síncope desencadeada por odor específico.

C) Presença de anemia importante ao hemograma.

D) Palpitações precedendo a síncope.

E) História familiar de morte cardíaca súbita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131862)

Enunciado: Mulher, 68 anos, hipertensa, com AIT há 40 dias, em pré-operatório de angioplastia carotídea, procura emergência com palpitações, sem tonteira ou dispneia e com nível de consciência preservado. Corada, PA 140 x 80 mmHg, FC em 140 bpm. Ausculta pulmonar limpa. ECG de 12 derivações mostra taquicardia com complexos QRS estreitos, R-R regular, sem onda P aparente, FC de 136 bpm. A MELHOR CONDUTA a ser tomada neste momento é?

A) Encaminhamento imediato à sala de hemodinâmica para estudo eletrofisiológico e ablação do foco arritmogênico por cateter de radiofrequência.

B) Manobra de compressão de seio carotídeo.

C) Cardioversão elétrica com 50-100J.

D) Lorazepam 1mg via oral e alta da emergência.

E) Adenosina 6mg IV em bolus.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80850)

Enunciado: Assinale a alternativa que caracteriza o bloqueio atrioventricular de 3º grau.

A) Aumento fixo do intervalo PR.

B) Aumento progressivo do intervalo PR até interrupção do estímulo, com onda P sem preceder o complexo QRS.

C) Ocorre interrupção da condução AV sem prévio alongamento do intervalo PR.

D) Toda onda P é seguida de complexo QRS.

E) Inexistência de relação entre atividade atrial e ventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

47395)

Enunciado: Entre as causas reversíveis de fibrilação atrial, encontram-se:

A) Hipotireoidismo e infarto agudo do miocárdio.

B) Uso de ácido acetilsalicílico e embolia pulmonar.

C) Miocardite e labirintite.

D) Choque elétrico e ingesta de álcool.

E) Pericardite e hipotireoidismo.

Gabarito

345439.

Comentário: A sistematização do atendimento às vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR) proposta pelo American Heart Association (AHA) visa implementar medidas para aumento de sobrevida e redução de morbidades relacionadas ao evento. É importante observar que o protocolo difere em função do ritmo em que desenvolve-se a a PCR. Assim, estes são agrupados em chocáveis, nos quais são incluídos fibrilação e taquicardia ventricular (FV TV) ou não chocáveis, determinados por atividade elétrica sem pulso (AESP) e assistolia. Vamos estudar as condutas do Advanced Cardiovascular Life Suport (ACLS) quanto ao uso de vasopressores nas alternativas Letra A incorreta. A epinefrina representa a primeira droga a ser administrada no manejo da PCR, independente do ritmo. Recomenda-se a dose de um miligrama, preferencialmente pela via intravenosa, com repetições a cada três a cinco minutos, e não a cada dois minutos. Letra B correta. Nesta alternativa encontra-se uma importante diferença referente ao uso de vasopressores durante o curso do ACLS à depender do ritmo. Durante a AESP e assistolia, a epinefrina deve ser infundida assim que possível , isto é, tão logo obtenha-se um acesso. Já nos ritmos de FV TV orienta-se que o vasopressor seja administrado após o segundo choque de desfibrilação dentro da condução sistematizada. Tal conduta objetiva valorizar as medidas que efetivamente demonstram aumento de sobrevida, sendo elas a desfibrilação precoce e a massagem cardíaca eficaz. Letra C incorreta. Documentada a FV, o choque de desfibrilação deverá ser imediato ou no exato momento em que o desfibrilador esteja preparado, seguindo-se, sem interrupções, por um ciclo de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ressuscitação cardiopulmonar (RCP). No momento que o último estiver completo, o ritmo e o pulso podem ser reavaliados, dando-se início a um segundo choque em casos de manutenção da FV. Neste momento reinicia-se a RCP e administra-se a epinefrina, logo, após a segunda tentativa de desfibrilação. Letra D incorreta. No passado a vasopressina já foi recomendada em substituição a primeira ou segunda dose de adrenalina, porém foi retirada da sistematização do ACLS na atualização de 2015. Estudos não demonstraram vantagens significativas com está permutação, o que implicou em exclusão da droga a fim de simplificar o protocolo. Resposta letra B.

345451.

Comentário: A segunda bulha cardíaca representa um som de média frequência produzido pelo fechamento das valvas aórtica e pulmonar, sendo a vibração, portanto, fruto da desaceleração da coluna líquida nos vasos da base. Esta bulha marca o início da diástole, podendo ser influenciada ainda por outros fatores, desde a mobilidade dos folhetos das valvas semilunares, a contratilidade cardíaca, o posicionamento do coração e a composição dos elementos interpostos entre a origem do ruído e os focos de ausculta. Dado que a hipofonese refere-se a menor intensidade sonora, vamos avaliar a causa estabelecida por redução da pressão ventricular, entre as citadas Letra A correta. O estado de baixo débito cardíaco, relacionado a eventos como choque e miocardiopatias, implicam em menor volume de sangue ejetado para a circulação pulmonar e sistêmica. Consequentemente, a baixa pressão ventricular determina menor coluna de sangue retomando às valvas semilunares, minorando a tensão de seu fechamento. Letra B incorreta. O enfisema pulmonar constitui causa de redução da ausculta cardíaca como um todo, e não somente da B2. O aumento da aeração pulmonar e as deformidades torácicas associadas diminuem a transmissibilidade dos sons cardíacos. Isto posto, trata-se de um mecanismo anatômico na gênese da hipofonese. Letra C incorreta. O edema agudo de pulmão pode ser originado por mais de uma etiologia, sendo a fonese das bulhas influenciada por estes. Porém, como contexto geral, a ruidosidade da ausculta pulmonar provoca abafamento dos componentes de escuta cardiológica. Letra D incorreta. A hipertensão arterial sistêmica aumenta a pressão ventricular ao invés de reduzi-la. O elevados valores de pressão sistêmica fazem com que o componente aórtico da B2,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

denominado A2, seja amplificado em decorrência do aumento da força para fechamento valvar. Resposta letra A.

343854.

Comentário: Diretamente ao ponto, vamos avaliar as opções de diagnóstico para nosso eletrocardiograma (ECG) Letra A incorreta A fibrilação atrial (FA) é caracterizada por QRS estreito, com R-R irregular e ausência de onda P ou qualquer atividade elétrica atrial. A regularidade do ritmo no ECG disposto exclui esta possibilidade. Letra B correta A taquicardia supraventricular corresponde à arritmia com QRS estreito, R-R regular e ausência de onda P aparente, tal qual demonstrado na questão. Em D2 é possível observarmos um padrão de pseudo-S, visto por uma discreta inscrição negativa ao final do QRS, representativo da ativação atrial retrógrada. Letra C incorreta Nesta alternativa cabe uma boa discussão. Diante de uma taquicardia supraventricular com frequência ventricular próxima à 150 bpm é possível a suspeita de flutter atrial. Muitas vezes este diagnóstico diferencial só poderá ser feito após redução da FC, para que possamos observar a onda F . Agora veja que, habitualmente, o nodo atrioventricular filtra a frequência atrial do flutter na razão de 2 1. No entanto, este bloqueio pode ocorrer de forma variável . Nestes casos a arritmia ocorrerá com R-R irregular, fazendo assim diagnóstico diferencial com FA, sendo possível a distinção justamente pela visualização da onda F. Letra D incorreta A taquicardia ventricular traduz-se no ECG por QRS largo e aberrante, sendo o R-R regular. O complexo QRS é igual ou maior que 120ms nesta arritmia, o que torna esta alternativa inadequada. Resposta letra B.

283271.

Comentário: A presença de encurtamento do intervalo PR (120ms) mostra a existência de uma via anômala que intercomunica átrios e ventrículos, caracterizando a chamada síndrome de Wolf-Parkinson-White. Portadores desta condição possuem incidência aumentada de taquiarritmias supraventriculares, com risco de morte súbita cardíaca por fibrilação ventricular caso desenvolvam fibrilação atrial (até 30% dos pacientes com SWPW fazem FA). No caso em tela, a taquicardia é do tipo instável, pois está causando dor torácica e supra de ST, devendo ser revertida imediatamente. Resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281110.

Comentário: Com o paciente em decúbito dorsal, idealmente sob superfície rígida, devemos aplicar compressões a uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto, procurando deprimir ativamente o esterno, no mínimo, com 5 cm de profundidade (1 3 do diâmetro AP do tórax), evitando excesso na profundidade (superiores a 6 cm). Caso seja possível, as compressões devem ser alternadas com as ventilações, na relação 30 2, ou seja, 30 compressões seguidas por duas ventilações. Essa proporção é utilizada em adultos, sendo definido 1 ciclo de RCP como a execução de 30 compressões e 2 ventilações. Geralmente, pelo menos 5 ciclos de RCP devem ser realizados antes de qualquer nova medida de reanimação. Resposta letra E. Obs. a banca não liberou gabarito oficial. Este comentário representa o gabarito MEDGRUPO.

281119.

Comentário: A onda P corresponde à despolarização dos átrios Lembre-se que a ativação do átrio direito forma a sua parte inicial, havendo, em seguida, um período de interseção dos dois átrios, enquanto somente o átrio esquerdo é responsável por gerar a parte final. A despolarização do átrio tem um sentido da direita para a esquerda e de cima para baixo , ou seja, exatamente a orinetação da derivação DII, que une o braço direito à perna esqeurda. Justamente por isso, a onda P é melhor visualizada nessa derivação. A sua morfologia habitual é arredondada e monofásica, mas pode se alterar na presença de doenças atriais. A despolarização ventricular como um todo corresponde ao complexo QRS, ficando alargada na presença de bloqueios de ramo. Resposta letra D (a banca não liberou um gabarito oficial)

283367.

Comentário: Questão um tanto sem pé nem cabeça sobre um caso clínico específico. Temos um paciente idoso, em tratamento de hipertensão arterial com um esquema absolutamente comum de associação (IECA anlodipina). Um novo quadro surge no meio do tratamento, descrito no enunciado como uma taquicardia supraventricular . Ora, o que exatamente isso quer dizer Será uma fibrilação atrial (a arritmia supraventricular mais comum) Um flutter atrial Uma taquicardia atrial Uma taquicardia supraventricular paroxística (por reentrada nodal ou atrioventricular) Perceba que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

as possibilidades diagnósticas são inúmeras, e o tratamento correto depende inteiramente da etiologia da arritmia. Contudo, podemos utilizar o bom senso para perceber que esse indivíduo no momento encontra-se normotenso, e portanto o acréscimo de diuréticos ou aumento de dose do enalapril não fazem absolutamente nenhum sentido. O problema principal a ser tratado é a taquicardia, e não a hipertensão. (B, C e D INCORRETAS) Em vigência de uma taquicardia supraventricular não identificada, considerando provavelmente um aspecto de QRS estreito regular, as opções indicadas para reversão são primeiramente uma tentativa de manobra vagal, que caso não for bem-sucedida pode ser seguida de adenosina. Em caso de nova falha, podem então ser utilizados bloqueadores de canais de cálcio de ação central (verapamil ou diltiazem) ou betabloqueadores. Portanto, a única opção entre as alternativas que indica o uso de uma medicação com ação cronotrópica negativa é a letra A, e embora absolutamente insuficiente, poderia ser ao menos uma parte da conduta para controle da frequencia cardíaca em algumas arritmias supraventriculares como a fibrilação e flutter atrial, além de uma segunda ou terceira linha de tratamento para as taquicardias supraventriculares paroxísticas. Esse é o clássico exemplo de questão preguiçosa, que cobrou conhecimento tão raso e utilizou termos tão vagos, que acabou gerando mais dúvidas do que respostas. É nosso papel na hora da prova não brigar com a questão, e responder o que a pergunta quer ouvir. Nesse caso, a única alternativa que faz um fiapo de sentido é a letra A, portanto é ela que sobrou como resposta. Resposta letra A

182678.

Comentário: Vítima de parada em atividade elétrica sem pulso não deve ser desfibrilado (A errada). O protocolo da linha reta deve ser aplicado em traçados compatíveis com assistolia (B errada). O atendimento deve ser prioritariamente realizado com reanimação cardiopulmonar. A adrenalina deve ser infundida, mas entre ela e as compressões torácicas, essas últimas têm prioridade (D errada). Resposta C.

159034.

Comentário: Quando ocorre Parada Cardiorrespiratória (PCR) presenciada em ritmo de Fibrilação Ventricular (FV) ou Taquicardia Ventricular (TV) sem pulso, a medida de maior impacto e que deve

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ser prontamente instituída é a desfibrilação elétrica com carga de 200 J nos desfibriladores bifásicos ou 360 J nos monofásicos. Após a aplicação do choque devem ser iniciadas prontamente as compressões torácicas. A amiodarona somente está indicada nas PCR por FV TV refratárias à desfibrilação e adrenalina. Neste caso, como a provável etiologia da PCR é a isquemia miocárdica, o serviço de hemodinâmica deve ser contactado de modo emergencial, pois faz parte do plano de cuidados pós-parada a revascularização miocárdica do paciente. A letra C é a única correta.

50075.

Comentário: Estamos diante de um primeiro episódio de FA , de início recente, com o paciente sintomático (devido à elevada resposta ventricular), porém, clinicamente estável. Não há, portanto, nenhuma urgência em cardioverter eletricamente o paciente, o que significa que dá tempo de avaliar com calma a melhor estratégia terapêutica de longo prazo É claro que diversos exames complementares idealmente devem ser realizados neste momento, como hemograma , eletrólitos , dosagem de hormônio tireoideano e ecocardiograma . Dependendo dos resultados, mesmo em pacientes idosos, muitos médicos optam por dar uma chance para a estratégia de controle de ritmo , avaliando a possibilidade de cardioversão eletiva e manutenção do ritmo sinusal (ex. eco normal e presença de algum fator desencadeante da arritmia, como o hipertireoidismo subclínico). Em outros casos (ex. eco muito alterado, com átrios já grandes, ausência de fator desencadeante reversível) pode ser preferível à estratégia de controle de frequência cardíaca e anticoagulação plena. Logo, a melhor conduta perante o paciente em tela é interná-lo para a realização dos exames e definição da estratégia terapêutica, se possível, cardiovertendo-o eletivamente (com fármacos e ou eletroterapia). Resposta certa B.

37083.

Comentário: Na estenose mitral (ex. sequela de febre reumática) espera-se uma sobrecarga crônica de pressão sobre o átrio esquerdo, o que promove dilatação e hipertrofia desta câmara. Ora, dilatação e hipertrofia são eventos adaptativos que, quando exagerados, alteram as propriedades eletrofisiológicas do miocárdio atrial, predispondo à formação de múltiplos circuitos de reentrada que, em conjunto, favorecem o surgimento de fibrilação atrial. Desse modo, a FA é a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

taquiarritmia mais comum na estenose mitral Resposta certa C.

37111.

Comentário: A principal arritmia em crianças se chama arritmia sinusal , uma variação da normalidade em que a frequência cardíaca se modifica em função da fase do ciclo respiratório. Quando o paciente inspira, a FC aumenta, e quando ele expira, a FC diminui. Excluída esta entidade (que é benigna e comumente assintomática, não necessitando de tratamento), temos como distúrbio arrítmico mais prevalente o grande grupo das Taquicardias Supraventriculares (TSV) Este termo inclui diversas arritmias com origem acima dos ventrículos, sendo a mais comum na criança a taquicardia supraventricular por reentrada em via acessória. A taquicardia supraventricular por reentrada nodal é rara em crianças, assim como as demais entidades citadas nas alternativas. Resposta certa A.

37108.

Comentário: A intoxicação sistêmica por anestésicos locais pode levar à parada cardiorrespiratória, pois na maioria das vezes essas drogas são bloqueadores de canais de sódio (isto é, canais de despolarização celular) que inibem não apenas os neurônios dos nervos periféricos mas também as células de condução elétrica do miocárdio... Vale ressaltar que a sensibilidade dos nervos ao efeito inibitório dos anestésicos locais é relativamente maior que a sensibilidade das células cardíacas, isto é, quem primeiro experimenta o efeito dessas drogas são as células neuronais... Assim, quando o paciente inadvertidamente recebe uma dose muito alta de anestésicos locais (o que tem mais chance de acontecer nos bloqueios de plexo braquial, onde é maior o risco de infusão do anestésico numa das veias cervicais calibrosas, dada a proximidade destas com os nervos do plexo), ele pode apresentar assistolia ou mesmo arritmias por reentrada (ex fibrilação ventricular)... Não existe um antídoto específico... Se o paciente evoluir com PCR, a conduta mandatória é fazer massagem cardíaca enquanto durar a meia-vida do anestésico Se a intoxicação foi por lidocaína, menos mal a meia-vida da lidocaína é de 15-20 minutos . Por outro lado, fármacos de duração mais prolongada, como a ropivacaína (cuja meia-vida é de 3-15 horas), podem manter o paciente em PCR irreversível por todo o tempo que durar o efeito... Assim, a chance de reversão bem-sucedida

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de uma PCR por toxicidade dos anestésicos locais é comparativamente maior com a lidocaína do que com a ropivacaína. Resposta certa D.

343157.

Comentário: Vamos às definições Taqui Ventricular Não Sustentada (TVNS) episódios de TV que duram menos de 30s E não cursam com instabilidade hemodinâmica. Pode ser monomórfica ou polimórfica. Geralmente são identificados no monitor cardíaco ou no ECG-Holter. Por definição, mais de três extrassístoles ventriculares no traçado indicam taqui ventricular Taqui ventricular sustentada o episódio de TV dura mais de 30s OU leva à instabilidade hemodinâmica. Podemos ter Taqui Ventricular Monomórfica Sustentada (TVMS) ou uma Taqui Ventricular Polimórfica Sustentada (TVPS) Resposta letra C.

343164.

Comentário: De acordo com a Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre a Análise e Emissão de Laudos Eletrocardiográficos 2022, consideramos como critério para sobrecarga atrial esquerda o aumento da duração da onda P igual ou superior a 120 ms, na derivação D2, com intervalo entre os componentes atriais direito e esquerdo maior ou igual a 40 ms. A Onda P deve ter componente negativo aumentado (final lento e profundo) na derivação V1. A área da fase negativa deve ter pelo menos 0,04 mm s, ou igual ou superior a 1 mm2, o que constitui o Índice de Morris, que apresenta melhor sensibilidade que o critério isolado de duração aumentada. Resposta letra D.

343169.

Comentário: A despolarização atrial inicia-se no átrio direito, onde encontra-se o nodo sinusal, e corre para o átrio esquerdo. Assim, a onda P, representativa deste evento, tem em D2 o vetor que melhor sintetiza a direção dos fenômenos elétricos implicados. Dado isto, considera-se a duração normal da onda P até 110ms e a amplitude até 2,5 mm ou 0,25 mV em um eletrocardiograma padrão, sendo a letra D incorreta. O aumento da duração de P é encontrada nas sobrecargas atriais esquerdas (SAE), enquanto o aumento da amplitude é encontrada nas sobrecargas atriais direitas (SAD). Este aumento de amplitude dá o aspecto de onda P apiculada, o que torna a alternativa A incorreta. Logo, na sobregarga atrial direita a onda P apresenta-se com amplitude

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

acima de 0,25 mV ou 2,5 mm, sendo a letra B correta e a letra C incorreta. Indo além, descreve-se uma manifestação indireta de SAD denominada sinal de Peñaloza-Tranchesi, caracterizada por aumento importante da amplitude do QRS em V2 em relação ao V1. Resposta letra B.

313441.

Comentário: Vamos analisar as alternativas A) Correta. A avaliação cardiológica basal de pacientes que irão se submeter a terapias potencialmente cardiotóxicas deve inicialmente incorporar a realização de anamnese e exame físico, focados para a área cardiovascular, um eletrocardiograma de 12 derivações em repouso e avaliação basal da função ventricular esquerda pela ecocardiografia preferencialmente. B) Correta. Por intermédio do ECG basal, a identificação prévia de alguma alteração do ritmo indica a realização de Holter 24 horas. Recomenda-se a realização do ECG antes de cada ciclo quimioterápico e monitorização contínua nos pacientes com alteração. C) Correta. Nesse sentido, é especialmente importante o ECG especialmente nas drogas quimioterápicas de alto risco, como trióxido de arsênio, aprovado para o tratamento das recaídas de leucemia promielocítica aguda (LMA-M3). Essa droga leva ao prolongamento do intervalo QT em até 63% dos pacientes e Torsades de Pointes , arritmia ventricular de difícil tratamento e potencialmente fatal. D) Incorreta. Em crianças, a dose recomendada de de sulfato de magnésio para o torsades de pointes é 25 a 50 mg kg dose (dose máxima 2.000 mg dose). Resposta letra D.

279028.

Comentário: Segundo o Posicionamento para Ressuscitação Cardiopulmonar de Pacientes com Diagnóstico ou Suspeita de COVID-19, publicado em 2020, no que diz respeito a ressuscitação em posição prona Caso o paciente já esteja sob intubação orotraqueal e ventilação mecânica, recomenda-se iniciar as manobras de RCP com o paciente ainda em posição prona. O ponto de referência para posicionamento das mãos segue a projeção do mesmo lugar das compressões torácicas, na região interescapular. Recomenda-se que tentativas de retorno do paciente para posição supina sejam executadas com o máximo de segurança ao despronar, evitando a desconexão do ventilador e o risco de aerossolização. Se houver disponibilidade de pás adesivas do desfibrilador, deve se colá-las em posição anteroposterior. Resposta letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

279031.

Comentário: De acordo com a I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia Existem evidências insuficientes para recomendar o momento específico e a sequência de obtenção de acesso venoso e via aérea avançada. Muitas vezes, o momento destas intervenções depende do número de socorristas envolvidos no atendimento. O atraso no início da administração de vasopressores para além dos primeiros cinco minutos de PCR, bem como a demora em instalar via aérea avançada, pode estar associado a pior prognóstico. Assim, pode-se sugerir o início do uso de vasopressores nos primeiros dois ciclos de RCP. Resposta letra B.

278612.

Comentário: Questão retirada na íntegra da A tualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2019) . Segundo este documento O uso de hipotermia atua como SUPRESSOR das vias facilitadoras da morte cerebral e da apoptose celular (A incorreta). Há uma diminuição de 6% na taxa de metabolismo cerebral de oxigênio na redução da temperatura corpórea a cada 1 C. Existe evidência de uma diminuição dos radicais livres durante o controle da temperatura (B correta). Há um bloqueio à ação intracelular da exposição às excitotoxina (acionadas pelo aumento do cálcio e do glutamato), reduzindo a resposta inflamatória na síndrome pós-PCR (C e D corretas). Portanto, a única assertiva incorreta e resposta da questão é a letra A.

279032.

Comentário: Questão retirada da I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Veja o trecho abaixo Quando a monitorização com desfibrilador manual revela ritmo de FV TVSP, a prioridade deve ser a desfibrilação o mais precoce possível, assim que disponível, uma vez que a duração da arritmia é fator prognóstico para o sucesso da desfibrilação, sendo máximo se a desfibrilação ocorre em até 10 a 30 segundos do início da FV, devido ao grau de organização do impulso elétrico. Resposta letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

279033.

Comentário: De acordo com a I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no que se refere a assistolia e a atividade elétrica sem pulso, temos que São ritmos em que a desfibrilação não está indicada. Deve-se, então, promover RCP de boa qualidade, aplicar as drogas indicadas e procurar identificar e tratar as causas reversíveis. Portanto, resposta letra B.

278084.

Comentário: Considerando que a ressuscitação cardiopulmonar é um procedimento máximo de emergência e passível de ocorrência em pacientes portadores de COVID-19, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em conjunto com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira e a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, elaborou algumas recomendações para ressuscitação cardiopulmonar de pacientes com diagnóstico ou suspeita de COVID-19. Neste documento, uma das recomendações é O uso de escores de gravidade e sistemas de rastreamento e disparo de códigos amarelos permitem a detecção precoce de pacientes graves e pode otimizar o atendimento de eventuais PCRs. Resposta letra B.

279034.

Comentário: Para responder essa questão, vamos ver o que a I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia tem a dizer sobre o uso de vasopressores na RCP O racional para o uso de vasopressores durante a RCP é aumentar a pressão de perfusão coronariana, definida como a diferença entre a pressão aórtica e a pressão no átrio direito durante a fase de relaxamento (descompressão) torácico. Uma pressão de perfusão coronariana 15mmHg é preditiva do RCE, correlacionando-se também com uma melhora da taxa de sobrevida de 24 horas em animais. No entanto, até a presente data, nenhum estudo placebo-controlado evidenciou que a administração de qualquer tipo de medicação vasopressora, durante as manobras de RCP, aumente as taxas de sobrevida na alta hospitalar com estado neurológico intacto. Resposta letra C.

249382.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Considerando a alta incidência de Fibrilação Ventricular (FV) e Taquicardia Ventricular (TV) como ritmo de parada cardiorrespiratória em ambiente hospitalar, que ocorre por diferentes etiologias, a criação de um sistema integrado de treinamento, com auxílio de materiais de emergência e transportes para um atendimento unificado possui impacto importante na redução da mortalidade desses pacientes. No entanto, não há justificativa para disponibilizar um Desfibrilador Externo Automático (DEA) em locais com baixa circulação de pessoas, devendo o dispositivo, de baixa complexidade de uso e alta chance de reversão dos ritmos chocáveis (TV e FV), ser disponibilizado em locais de alta circulação de pessoas. Gabarito alternativa D.

249385.

Comentário: Segundo a Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2019, os elos de sobrevivência para um bom atendimento ao indivíduo em parada cardiorrespiratória são - Vigilância e prevenção - Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência - RCP imediata de alta qualidade - Rápida desfibrilação, Suporte Avançado de Vida e cuidados pós-PCR, ou uma PCR extra-hospitalar, Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência - RCP imediata de alta qualidade e rápida desfibrilação - Serviços médicos básicos e avançados de emergência - Suporte Avançado de Vida e cuidados pós-PCR. Assim, faz parte dos elos de sobrevivência o suporte AVANÇADO de vida. Gabarito Alternativa C.

249389.

Comentário: No manejo do paciente pós PCR que retoma ritmo próprio, devemos considerar a presença de hipoperfusão orgânica, com hipofluxo cerebral. Por essa razão, existem medidas que reduzem o impacto sobre o sistema nervoso central, como prevenção de febre, manutenção de metas hemodinâmicas e controle da temperatura corporal Gabarito Alternativa B.

249393.

Comentário: As paradas cardiorrespiratórias podem ocorrer por condições reversíveis em grande parte dos casos, que devem ser prontamente reconhecidas e corrigidas para reversão do quadro, como a hipercalemia, acidose metabólica, obstrução coronariana, tamponamento cardíaco,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

hipotermia, hipoxemia, intoxicação por drogas ou toxinas, entre outros. Gabarito Alternativa A.

249216.

Comentário: Questão que parece ter vindo de uma das nossas provas de semiologia do 4º ano de faculdade Vamos, então, aprender com a questão Afinal, as letras A, C e D estão absolutamente certas. Letra B Na verdade, bem como evidenciado na letra D, sinal é tudo que podemos avaliar no paciente através dos nossos sentidos. Ou seja, tudo de anormal que vemos, ouvimos ou sentimos. INCORRETA Resposta letra B.

249228.

Comentário: Nesta questão, vamos por partes... Primeiro, o eletrocardiograma observa-se taquicardia sem onda P, QRS estreito e RR regular, traduzindo taquicardia supraventricular. Em seguida, o estado clínico nosso paciente está instável, tendo em vista a dor torácica e a dispneia. Assim, nossa conduta admite duas possibilidades a clássica cardioversão elétrica ou infusão de adenosina (6 mg seguidos por 12 mg, se necessário A, C e D erradas). A taquicardia supraventricular, perceba, é a arritmia híbrida porque, sempre admite duas condutas na estabilidade, pode ser feita manobra vagal ou adenosina na instabilidade, adenosina ou cardioversão elétrica. Resposta B.

216246.

Comentário: A taquicardiomiopatia é uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo decorrente da sobrecarga crônica de frequência , que naturalmente tem seu prognóstico melhorado com a resolução do problema original. Resposta certa LETRA A.

216263.

Comentário: O cardiodesfibrilador implantável é um dispositivo extremamente útil na prevenção de morte súbita em pacientes portadores de alto risco de desenvolvimento de taquiarritmias malignas, como em indivíduos com cardiopatia estrutural. Dada a prevalência de doença arterial coronariana isquêmica na população, a principal causa de desenvolvimento deste tipo de arritmia é a doença isquêmica. Gabarito Alternativa A.

216318.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão copiada e colada das Diretrizes brasileiras de Insuficiência Cardíaca aguda e crônica de 2018. Nesse documento, textualmente é colocado a amiodarona é eficaz para reverter quimicamente a FA para ritmo sinusal, reduzir os paroxismos de FA e ajudar na manutenção do ritmo sinusal, após a reversão espontânea ou elétrica. Resposta certa LETRA A.

216233.

Comentário: Sabemos que crianças portadoras de cardiopatias congênitas podem apresentar arritmias secundárias a anormalidades estruturais, à intervenção cirúrgica ou a repercussões hemodinâmicas crônicas. Assim, após a cirurgia, as arritmias mais frequentes são a taquicardia supraventricular, a Taquicardia Juncional Ectópica (TJE), o BAV completo, a TV e a Fibrilação Atrial (FA). No período pós-operatório tardio, a incidência de arrtimais depende da complexidade do procedimento, do número de intervenções, da presença de sequelas e resíduos, e do comprometimento hemodinâmico prévio à cirurgia, ou logo após a mesma. Observam-se frequentemente taquiarrtmias atriais, que podem surgir meses a anos após a cirurgia, principalmente após as correções de Fontan, Mustard, Senning e para tetralogia de Fallot. Nesses casos, muitas vezes, ocorrem mecanismos de reentrada em torno das cicatrizes cirúrgicas. A sequência normatizada no manejo desses pacientes envolve, na ordem - sedação adequada - normalização de eletrólitos - diminuição de inotrópicos - RESFRIAMENTO (COOLING) Numa segunda etapa, se as medidas iniciais falharem, aí sim utilizamos drogas, cuja primeira linha seria a amiodarona. Resposta letra A.

215530.

Comentário: Todas as medicações acima são utilizadas no suporte avançado de vida em Pediatria, com as respectivas indicações. Dentre elas, a única que não deve ser administrada por cânula orotraquel é o bicarbonato de sódio, inclusive podendo ocasionar lesões no trato respiratório. Resposta letra C.

201758.

Comentário: Paciente com uma das apresentações clássicas de fibrilação atrial - após libação alcoólica, surge palpitação... Neste caso, como o paciente encontra-se estável

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

hemodinamicamente, não há indicação de cardioversão elétrica imediata (D e E incorretas). O que fazer neste momento Primeira coisa controle da frequência cardíaca, que foi o que levou o paciente ao hospital, idealmente feito com betabloqueador (A e C incorretas). Em seguida qualquer paciente com FA de duração 48 horas início indeterminado alto risco para eventos tromboembólicos deve ser submetido a eco transesofágico para pesquisar trombo. Se trombo ausente, anticoagular o paciente, reverter a arritmia e anticoagular posteriormente por no mímino 4 semanas. Resposta B.

219902.

Comentário: Chamamos de acentuação do desdobramento fisiológico da segunda bulha quando ouvimos os dois componentes deste som o ártico (A2) e pulmonar (P2) ainda mais afastados na inspiração (como descrito no caso), passando a ter também uma distância na expiração. Essa acentuação é decorrente de um atraso significativo no fechamento da valva pulmonar. A principal causa para essa condição é o bloqueio do ramo direito (letra A correta). Neste, há um alentamento na condução elétrica pelo feixe de His à direita do coração, o que irá atrasar a sístole do VD. Também pode ocorrer na insuficiência mitral. Gabarito A.

183596.

Comentário: Vejamos cada uma das alternativas A - Correta. O quadro inflamatório decorrente da miocardite pode desencadear arritmias, que tendem a desaparecer com a resolução da inflamação. B - Correta. Cerca de 30% do débito cardíaco depende de uma contração atrial efetiva. Dessa forma, as arritmias atriais podem agravar os quadros de insuficiência cardíaca. C - Correta. A TSV sustentada tem como tratamento a restauração ao ritmo sinusal, podendo esta ser realizada eletricamente, por cardioversão, ou quimicamente, através da adenosina. D - Incorreta. Dada a benignidade das extrassístoles atriais e ou ventriculares, não é recomendado tratamento específico para pacientes assintomáticos. Gabarito Alternativa D.

183611.

Comentário: A taquicardia ventricular sustentada, mesmo que assintomática, deve ser tratada no contexto da miocardite, pois possui efeito deletério no débito cardíaco, potencial de isquemia miocárdica e risco de evolução para fibrilação ventricular (A incorreta). As arritmias ventriculares

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

devem ser tratadas prontamente com cardioversão elétrica e caso haja recorrência, com drogas antiarrítmicas (B correta). Na necessidade de drogas antiarritmicas as opções incluem amiodarona, dofetilida e em pacientes sem insuficiência cardíaca NYHA IV, uso cauteloso de beta bloqueadores ou bloqueadores dos canais de cálcio (C incorreta). Devido ao efeito pró arritmico e inotrópico negativo, outras drogas de classe I e III são evitadas em pacientes com miocardite (D correta). Questão que possui duas respostas incorretas (A e C). O gabarito liberado foi letra A.

182822.

Comentário: O fenômeno de Ashman ocorre por um prolongamento do período refratário do sistema de condução ventricular provocado por um intervalo R-R longo do batimento precedente. Quando um estímulo supraventricular prematuro atinge ao Feixe de His pode encontrar um dos ramos em período refratário e, portanto, somente ser conduzido aos ventrículos pelo outro ramo. Isto provoca no eletrocardiograma um complexo QRS com morfologia de bloqueio de ramo. Como o período refratário do ramo direito é maior que o do ramo esquerdo, é mais frequente observar morfologia de bloqueio de ramo direito que pode ser associado a bloqueios divisionais esquerdos. Gabarito Alternativa C.

182729.

Comentário: Essa questão foi baseada na III Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia para Análise e Emissão de Laudos Eletrocardiográficos. Mesmo quem não leu esse documento é capaz de acertar essa. Quando o paciente apresenta tremores musculares no parkinsonismo, por exemplo, o traçado eletrocardiográfico apresenta variações devido à movimentação dos eletrodos (aderidos à pele) em relação ao coração. Dessa forma, a linha de base fica distorcida, com ondulações que podem se assemelhar a um traçado de Fibrilação Ventricular (FV) ou de Flutter Atrial (FLA). Sendo assim, a resposta correta é a alternativa (D).

182732.

Comentário: A lesão cerebral aguda, como na hemorragia intracraniana, pode causar disfunção autonômica intensa. As ondas T cerebrais são ondas T gigantes, negativas e difusas, em geral acompanhadas de desnivelamento de ST e aumento do intervalo QT, sendo as lesões passíveis de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

reversão com o tratamento adequado da causa base. Gabarito Alternativa B.

183588.

Comentário: Síncope é definida pela perda transitória da consciência ocasionado por hipoperfusão cerebral global, caracterizada pelo rápido inicio, curta duração e recuperação completa e espontânea. De uma maneira geral podemos dividir as causas de sincope da seguinte forma 1- Síncope neutralmente mediada (as mais comuns), dentre as quais podemos citar a vasovagal, situacional e síncope do seio carotídeo 2- Síncope por hipotensão ortostática 3- Sincope cardiaca, dentre as quais podemos citar as arritmias ou as doenças estruturais (valvopatia, isquemia, doença do pericárdio, tamponamento, cardiomiopatia hipertrófica, anomalias congênitas, embolia pulmonar, dissecção aortica e hipertensão pulmonar. Como a questão pede a opção que NÃO representa uma causa cardiaca de sincope, gabarito D.

183598.

Comentário: A síncope vasovagal (neurocardiogênica) é uma condição mais frequente em mulheres jovens, caracterizada por síncope precedida de sinais sintomas prodrômicos típicos sudorese, náuseas, mal-estar, palidez. Ela ocorre quase sempre em posição ortostática por situações como dor, estresse emocional ou físico. Seu diagnóstico é essencialmente clínico, mas podemos abrir mão de exames complementares quando há dúvidas diagnósticas, como o teste de inclinação (tilt test). A sonolência não faz parte dos pródromos da síncope vasovagal. Resposta certa letra A.

183115.

Comentário: A forma mais comum de síncope é a chamada síncope vasovagal, mediada por um aumento súbito e excessivo do tônus vagal (colinérgico) sobre o coração e os vasos (componentes cardio e vasodepressor, respectivamente). Vários fatores podem desencadear este fenômeno além da mudança brusca de posição, como dor, ansiedade, medo, micção, tosse entre outros. Duas características distintivas desta forma de síncope são (1) a perda de consciência não é exatamente súbita , sendo geralmente precedida por pródromos como tonteira e escurecimento visual (pré-síncope ou lipotímia) (2) o paciente recupera de forma rápida a consciência após permanecer em decúbito. Logo, a melhor resposta aqui seria a letra A. A banca deu como gabarito a letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182746.

Comentário: Vamos analisar as alternativas A) Correta. A ativação do SRAA acarreta uma piora no remodelamento. B) Incorreta. A inibição do SRAA leva a melhora da evolução dos pacientes com IC tanto em remodelamento e diminui a mortalidade. C) Correta. DM causa ativação do SRAA. D) Correta. O sistema adrenérgico piora o prognóstico dos pacientes com ICC. Resposta letra B.

161170.

Comentário: O enunciado dessa questão conta a história de um paciente que começou a apresentar mal estar, prostração e dispnéia súbitos e identificaram pelo eletrocardiograma que tratava-se de uma taquiarritmia. Foi então decidido realizar uma terapia elétrica que culminou em grave complicação instantânea que precisou de algumas manobras para ser revertida. O que o autor da questão está querendo dizer é que o médico decidiu fazer erroneamente uma desfibrilação para tratar a taquiarritmia, no lugar de fazer uma cardioversão. Ao fazer a desfibrilação, ele fez um efeito R sobre T, oferecendo corrente elétrica num momento vulnerável da repolarização ventricular, o que fez com que o paciente entrasse em parada cardíaca em fibrilação ventricular. Então, foi preciso realizar uma desfibrilação, para reverter o quadro. Nós apenas realizamos desfibrilação quando o paciente está em parada cardíaca, ou seja, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Nas taquicardias com pulsos devemos sempre realizar cardioversão e a carga elétrica dependerá do tipo de taquicardia. A diferença entre a desfibrilação e a cardioversão é que a cardioversão é sincronizada com o QRS, evitando que a corrente elétrica seja fornecida em cima da onda T. Dessa forma, a explicação foi a realização de uma desfibrilação, uma terapia elétrica na qual a corrente elétrica é aplicada em qualquer momento do ciclo cardíaco, afirmativa presente na letra B.

161176.

Comentário: Essa questão fala sobre a cardioversão elétrica. A força que nós devemos aplicar sobre o torax com as pás é entre 7 e 11kg. Na fibrilação atrial oferecemos de 120 a 200J na cardioversão, enquanto no flutter atrial e na taquicardia supraventricular oferecemos de 50J a 100J. Na taquicardia ventricular com pulso oferecemos 100J de cardioversão. Na fibrilação ventricular e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

taquicardia ventricular sem pulso oferecemos 200J de desfibrilação no bifásico e 360J no monofásico. Dessa forma, a resposta da questão é letra D.

161330.

Comentário: Boa questão... Existem algumas situações especiais para a utilização do DEA que devemos conhecer - Portador de marcapasso (MP) ou cardioversor-desfibrilador implantável se estiver na região onde é indicado o local para aplicação das pás, afaste-as, pelo menos, 8 cm ou opte por outro posicionamento das pás (anteroposterior, por exemplo), pois, estando muito próximas, pode prejudicar a análise do ritmo pelo DEA. - Excesso de pelos no tórax remova o excesso de pelos, somente da região onde serão posicionadas as pás, com uma lâmina que geralmente está no Kit DEA outra alternativa é depilar a região com um esparadrapo ou com as primeiras pás e, depois, aplicar um segundo jogo de pás. - Tórax molhado seque por completo o tórax da vítima se a mesma estiver sobre uma poça dágua não há problema, porém se essa poça dágua também envolver o socorrista, remova a vítima para outro local, o mais rápido possível. Resposta D.

161185.

Comentário: Essa é uma questão sobre cardioversão que solicita a afirmativa incorreta. A letra D afirma que precisamos permanecer com a pá minutos sobre o tórax do paciente, mas essa afirmação é falsa, pois assim que o choque for dado as pás podem ser retiradas e antes do choque, a sincronização não atrasa minutos para emissão da corrente elétrica, mas apenas irá aguardar o próximo QRS identificado para emitir o choque. A diferença entre a cardioversão e a desfibrilação é apertar o botão sinc do desfibrilador. Com isso, o aparelho irá emitir a corrente elétrica quando identificar o QRS, evitando o efeito R sobre T que pode precipitar uma fibrilação ventricular. A pressão sobre as pás deve ser de 7 a 11 kg e tanto o desfibrilador quanto o cardioversor precisam ser carregados para que possamos apertar o botão e liberar a corrente elérica. É bem importante avisar a todos da equipe que precisam se afastar do paciente e do mobiliário que encosta no paciente devido ao risco de condução elétrica. Dessa forma, a afirmativa incorreta e resposta da questão é a letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161290.

Comentário: Frente a uma bradicardia sinusal persistente (FC 60 bpm), na ausência de causas reversíveis (ex. medicamentos), particularmente em se tratando de paciente idoso, a principal hipótese diagnóstica é de D oença do Nódulo Sinusal (DNSA) de causa intrínseca, geralmente por fibrodegeneração das células do NSA, a chamada doença de Lenègre . É notório que essa fibrodegeneração com grande frequência afeta também as células do miocárdio atrial adjacente, o que predispõe ao surgimento do fenômeno de reentrada e, consequentemente, aumenta a chance de taquiarritmias atriais (ex. fibrilação atrial, flutter). De fato, estima-se que cerca de metade dos portadores de DNSA se apresente com a chamada síndrome bradi-taqui , isto é, bradicardia sinusal persistente associada a episódios recorrentes de taquiarritmias atriais paroxísticas... Na completa ausência de sintomas (o que é raro), a doença do nódulo sinusal teoricamente pode ser apenas observada, porém, se for demonstrado que o paciente tem síndrome bradi-taqui ou sintomas de baixo débito cardíaco associados à bradicardia (ex. através de um ECG-Holter que correlaciona os episódios de piora transitória da bradicardia com a ocorrência de queixas como fadiga, dispneia, pré-síncope ou mesmo síncope), está indicado o tratamento específico, que consiste no implante de marca-passo (preferencialmente um DDDR, que é o modo de funcionamento mais fisiológico que existe). O MP não diminui a taxa de mortalidade desses pacientes, que já é naturalmente elevada por conta da idade avançada e comorbidades, porém, é comprovado que na DNSA sintomática seu uso resulta em importante melhora dos sintomas e da qualidade de vida Resposta certa B.

161337.

Comentário: Questão batida... Na desfibrilação, que certamente é a medida prioritária num paciente com FV ou TV sem pulso, deve-se utilizar a máxima energia do aparelho sendo aplicada 360 J no desfibrilador monofásico e de 120 a 200 J no desfibrilador bifásico, conforme orientação do fabricante. Resposta B.

161221.

Comentário: Questão específica... Na doença do nó sinusal, o implante de marcapasso é indicado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

nos casos de 1. disfunção do nó sinusal com bradicardia sintomática documentada, incluindo pausas sinusais 2. incompetência cronotrópica sintomática 3. bradicardia sinusal sintomática, secundária ao uso de fármacos indispensáveis 4. síncope de origem indeterminada, com evidências eletrocardiográficas de disfunção do nó sinusal documentada ou provocada no estudo eletrofisiológico 5. disfunção do nó sinusal com frequência cardíaca 40 bpm em vigília, sem correlação clara entre os sintomas e a bradicardia documentada. Resposta D.

161231.

Comentário: A doença do nodo sinusal caracteriza-se por disfunção, usualmente degenerativa, do nodo sinoatrial ou de seu tecido miocárdico circunjacente. Em função deste processo ocorrem anormalidades na geração ou condução do estímulo sinusal, com consequente bradicardia. Fatores extrínsecos, como o uso de fármacos ou distúrbios endócrino-metabólicos também podem influenciar na frequência cardíaca, a reduzindo. A doença do nodo sinusal associa-se a ocorrência de sintomas de baixo débito cardíaco de graus variados, sendo os pacientes raramente assintomáticos. As causas fisiológicas de bradicardia, como a vagotonia, são habitualmente assintomáticas e benignas, expressando-se especialmente nas formas de bradicardia sinusal e bloqueio atrioventricular de primeiro grau ou segundo grau Mobitiz 1. A terapia das bradicardias sintomáticas irreversíveis é realizada por meio de implante de marcapasso definitivo. A alternativa B está incorreta.

161201.

Comentário: Nas bradicardias nós podemos utilizar o marca-passo ou administrar atropina. A atropina é administrada na dose de 0,5 mg repetida a cada 3 a 5 minutos até uma dose máxima total de 3,0 mg ou 0,04 mg Kg. Doses de sulfato de atropina menores do que 0,5 mg, paradoxalmente podem provocar uma maior redução na freqüência cardíaca. O marcapasso transcutâneo deve ser usado rapidamente naquelas bradiarritmias refratárias à atropina, naquelas com BAV severo (Mobitz II e terceiro grau) e nos pacientes com sintomas de baixo débito muito severos. Nem sempre o uso do marcapasso é efetivo e ele pode ser bastante doloroso se o paciente estiver consciente, podendo ser necessário sedação e analgesia para controle da dor. Os

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

marcapassos podem ser usados para trarar bradicardia ou para fazer uma superestimulação para supressão de taquicardias refratárias. Nesse caso, o marcapasso tem que ser programado para bater numa frequencia maior que a da arritmia e com isso ganhar o controle do ritmo cardíaco, para depois conseguirmos ir normalizando a frequência cardíaca. O marcapasso transcutâneo não é um procedimento eletivo, ele apenas é usado em situações de emergência, até que posssamos instalar o marcapasso transvenoso. Os marcapassos não devem ser utilizados para pacientes em assistolia. Um paciente em assistolia está em parada cardiorrespiratória e por ser um ritmo não chocável, o paciente será submetido as manobras de reaminação com administração de epinefrina e tratamento para as causas reversíveis de parada.

161355.

Comentário: A energia para reverter flutter e taqui supra é bem menor que a necessária para reverter uma FA (50 x 200 J) - A correta. Qualquer taquiarritmia instável deve ser tratada agudamente com eletroterapia. Lembre-se que o conceito de instabilidade é angina, edema pulmonar, choque circulatório. A parada cardiorrespiratória configura outro tipo de situação, que TAMBÉM pode (ou não, dependendo do ritmo) ser manejada com eletroterapia - B correta e C errada. Nas arrtimias ventriculares o QRS pode ser muito largo, impossibilitando a sincronização do choque com a onda R do intervalo QRS. Tal evento tende a ocorrer principalmente nas TVs polimórficas. Se este for o caso, o choque será aplicado SEM SINCRONIZAÇÃO (desfibrilação), porém, sempre que possível, o ideal é cardioverter a arritmia (choque SINCRONIZADO)... Logo, a letra D não pode ser considerada correta, pois existem situações onde é possível (e recomendável) sincronizar o choque na reversão da TV. A banca deu como gabarito a letra C. Ao nosso ver, a questão merecia ter sido anulada por possuir duas respostas possíveis (C e D).

161205.

Comentário: O marca-passo transcutâneo é um tipo de marca-passo provisório que deve ser utilizado em situações emergenciais de bradiarritmia associada à instabilidade hemodinâmica enquanto se providencia (em 30-60min, não mais que isso) o implante de um marca-passo transvenoso e, posteriormente, se for o caso, um marca-passo definitivo. O MP transcutâneo tem

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

um prazo de validade relativamente curto pelo fato de, passados alguns minutos de uso, ocorrer aumento na impedância das pás e da parede torácica, fenômeno que acaba comprometendo a captura das espículas pelo miocárdio ventricular, quanto maior a energia necessária para a captura, maior é a tendência desse prazo de validade ser menor, por isso programamos a menor energia possível que, em geral, significa uma energia ao redor de 10 a 20% do limiar de estimulação. (letra A errada). Lembre-se de que o termo captura se refere à efetiva estimulação do miocárdio pela corrente elétrica liberada pelo aparelho (que se inscreve no traçado eletrocardiográfico como uma espícula vertical). Pois bem, o primeiro passo é colocar as pás autoadesivas no tórax despido do paciente (se houver pelos, estes não devem ser raspados, e, sim, cortados rente à pele a raspagem promove lesão local e aumenta a impedância da pele), que devem ser preferencialmente posicionadas numa configuração anteroposterior, conforme descrito na letra B. Feito isso, determinamos a frequência cardíaca desejada (geralmente entre 60-80 bpm) e começamos a fornecer estímulos com energia progressivamente mais alta (o output do MP), até que ocorra a captura da espícula pelo miocárdio ventricular (complexos QRS alargados, com onda T de polaridade oposta a do QRS). Evidentemente, o paciente precisa ser sedado e receber analgesia, a fim de diminuir o desconforto dos choques e da contratura da musculatura peitoral que os acompanha. Além disso, é preciso avaliar clinicamente a eficácia do procedimento, ou seja os parâmetros hemodinâmicos estão respondendo de forma favorável .

161250.

Comentário: A doença do nodo sinusal caracteriza-se por disfunção do nodo sinusal ou do tecido atrial circunjacente, suscitando dificuldade na geração ou condução de impulsos dentro dos átrios e para o sistema de condução cardíaco. Devido a resistência a passagem do estímulo do nó sinusal para o tecido atrial, os pacientes desenvolvem graus variados de bradicardia, sendo comuns as pausas sinusais. Esta entidade usualmente se desenvolve em função de processo degenerativo senil, estando entre seus mecanismos processos fibróticos, inflamatórios e ateroscleróticos. A degeneração do miocárdio atrial predispõe também a ocorrência de focos arritmogênicos, com consequentes taquiarritmias. Desta forma, pode ocorrer a chamada síndrome bradi-taqui, com

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

coexistência em um mesmo paciente de períodos de bradicardia e taquicardia. A alternativa A é a incorreta.

161258.

Comentário: A doença do nodo sinusal é caracterizada por alterações fibro-degenerativas do nodo sinusal e do tecido perinodal. Como o miocárdio atrial pode ser afetado, além de diferentes graus de bradicardia, taquicardias atriais são frequentemente encontradas. Adicionalmente ao processo senil, o uso de medicamentos ou distúrbios eletrolíticos estão implicados em sua gênese. Os sintomas são, em geral, intermitentes e relacionam-se a baixo débito cardíaco. A doença afeta especialmente idosos, mas não é exclusiva desta faixa etária. Pode ocorrer em indivíduos mais jovens em consequência de cardiopatia chagásica e isquêmica, doenças inflamatórias agudas ou desordens metabólicas. Há ainda uma forma familiar, que acomete crianças, relacionada a mutações em canais cardíacos de sódio. Alternativa incorreta letra A.

161368.

Comentário: Questão conceitual. Vejamos as alternativas A- Incorreta. No caso de choques sequenciais, a carga despejada é ascendente e não decrescente como sugere a opção B- O sucesso da reversão para o ritmo sinusal depende da cardiopatia de base e da densidade de corrente elétrica recebida pelo miocárdio atrial. Choques monofásicos iniciais de 100 J geralmente são ineficazes para a CV da FA sendo recomendado iniciar-se com energia igual ou superior a 200 J. Logo, opção coreta C- Incorreta. A CV elétrica envolve a liberação de um choque elétrico sincronizado com a atividade intrínseca do coração, para evitar a indução de fibrilação ventricular que geralmente ocorre quando o choque incide sobre a fase ascendente da onda T D- Incorreta. Está indicada a CARDIOVERSÃO Muito diferente da desfibrilação... Resposta B.

161175.

Comentário: Questão muito mal-feita Ele quer saber qual assertiva está correta em relação às desvantagens do marca-passo transcutâneo, e a verdade é que TODAS as opções descrevem claramente as principais desvantagens e limitações deste método... Só pra lembrar o MPTC é um método transitório que serve como ponte até a implantação de um MP transvenoso ou definitivo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Seu uso requer analgesia e sedação do paciente, pois são necessárias correntes elétricas elevadas (que causam dor) para vencer a impedância da parede torácica e promover a captura do estímulo pelo coração. Nem todo equipamento desfibrilador permite a opção de instalar um MPTC... O gabarito oficial da banca foi a letra B, mas a questão merecia ter sido anulada

161374.

Comentário: Esse conceito volta e meia é cobrado nas provas de residência médica. Em um paciente com taquiarritmia associado a sinais de instabilidade hemodinâmica a terapia adequada consiste em cardioversão elétrica sincronizada. A desfibrilação (choque não sincronizado) não deve ser realizado em pacientes com pulso pelo risco do fenômeno R sobre T. Neste evento o choque pode incidir sobre os miócitos ao final do período refratário, em que já há excitabilidade de algumas fibras cardíacas, predispondo a reentrada e surgimento de fibrilação ventricular. A desfibrilação só se aplica aos paciente em parada cardiorrespiratória por fibrilação ou taquicardia ventricular. A maior hipótese é de que o paciente da questão tenha desenvolvido PCR por fenômeno R sobre T associado ao choque desfribrilatório. A letra A é o gabarito.

161326.

Comentário: O período mínimo para avaliar o prognóstico de um desfecho neurológico ruim por meio de exame clínico em pacientes não tratados com controle direcionado de temperatura é de 72 horas após a PCR (A incorreta), mas esse período pode ser ainda maior após a PCR se houver suspeita de que o efeito residual da sedação ou paralisia possa confundir o exame clinico (C incorreta). Em estudos sobre pacientes após a PCR, constatou-se que a pressão arterial sistólica inferior a 90 mmHg ou a pressão arterial média inferior a 65 mmHg está associada ao aumento da mortalidade e à redução da recuperação funcional, enquanto a pressão arterial sistólica superior a 100 mmHg está associada a uma melhor recuperação (B correta). Embora valores de pressão mais elevados pareçam melhores, não foi possível identificar os alvos específicos das pressões arteriais sistólica e média, já que nos ensaios, normalmente, estudou-se um conjunto de várias intervenções, inclusive o controle hemodinâmico. Além disso, como a pressão arterial basal varia de paciente para paciente, diferentes pacientes podem apresentar diferentes necessidades para

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

manter a perfusão ideal dos órgãos (D incorreta). Portanto, resposta correta LETRA B.

161190.

Comentário: O treinamento da população geral, e não só de profissionais de saúde, é uma ferramenta importante para a redução da mortalidade do infarto agudo do miocárdio (IAM). Quanto mais cidadãos saibam praticar o BLS (Basic Life Support), quanto mais desfibriladores externos automáticos sejam disponibilizados, maiores serão as chances de um paciente sobreviver a essa condição, concorda A identificação do perfil dos casos de IAM no ambiente extra-hospitalar também é importante, visando a implementação de estratégias voltadas a esse grupo. Sendo assim, a única alternativa incorreta é a opção (B).

161341.

Comentário: Vamos analisar as assertivas A Correta e conceitual. B Incorreta. Na desfibrilação, deve-se utilizar a máxima energia do aparelho sendo aplicada 360 J no desfibrilador monofásico e de 120 a 200J no desfibrilador bifásico, conforme orientação do fabricante. Se esta orientação é desconhecida deve ser administrado choque de 200J. C Incorreta. Naturalmente, a posição adequada das pás não é o único determinante do sucesso do choque. D Incorreta. A desfibrilação está indicada apenas em dois tipos de ritmo de parada cardíaca fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sem pulso. Nos demais ritmos (assistolia e AESP), não há indicação de choque. Portanto, apenas a letra A está correta.

161149.

Comentário: A parada cardiorrespiratória é uma emergência médica, devendo ser prontamente reconhecida e abordada para uma maior chance de reversão do quadro, com perda de 10% das chances de sucesso a cada minuto sem que sejam iniciadas as manobras (alternativa A correta). A assistolia é o ritmo de parada mais frequente, sendo responsável pelas menores índices de sobrevida (alternativa B correta e alternativa C incorreta), com diversos fatores colaborando para o estabelecimento dessas taxas (alternativa D correta). Gabarito Alternativa C.

161159.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas A) incorreta a máscara laríngea não protege as vias

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

aéreas, não sendo considerada uma via aérea definitiva. B) incorreta a IOT acaba sendo superior pois protege a via aérea do paciente, minimizando o escape. C) incorreta a máscara laríngea consegue uma boa ventilação inicial durante a RCP e por não necessitar de laringoscopia, muitas vezes é escolhida. D) correta apesar de não necessitar de laringoscopia, a passagem da máscara laríngea deve ser feita por profissional treinado. Gabarito D.

161167.

Comentário: O dióxido de carbono exalado no final da expiração (a sigla ideal seria PETCO2, e não PETCO) tem relação com a qualidade das manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), com o retorno da circulação espontânea e com a pressão de perfusão coronariana. Em pacientes intubados, esse parâmetro pode ser mensurado através da capnografia. Quando seu valor encontra-se 10 mmHg, a técnica da RCP deve ser melhorada. Durante uma parada cardiorrespiratória (PCR) não tratada, a produção de gás carbônico se mantém. Contudo, não há liberação desse gás pelos pulmões, sendo o débito cardíaco o maior determinante do PETCO2. A questão poderia ser anulada, já que a opção (B) traz a sigla errada de gás carbônico - CO é monóxido (e não dióxido) de carbono De qualquer forma, esse foi o gabarito oficial.

161401.

Comentário: Condições que aumentam a distância entre os eletrodos e o coração e seu sistema de condução podem levar a um padrão de baixa voltagem no eletrocardiograma (nesses casos, as ondas ficam pequenas, com amplitude reduzida). Quando há derrame pericárdico associado à pericardite, o líquido inflamatório acumulado promove um aumento dessa distância O mesmo pode se dizer quando o paciente é obeso e ou quando possui mamas volumosas. Na embolia pulmonar, não esperamos observar o padrão de baixa voltagem Os achados clássicos, porém nem sempre presentes, são taquicardia sinusial, bloqueio de ramo direito, sobrecarga de átrio direito, padrão S1Q3T3, entre outros. Resposta (A).

161172.

Comentário: O dióxido de carbono exalado no final da expiração (a sigla ideal seria PETCO2, e não PETCO) tem relação com a qualidade das manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), com

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

o retorno da circulação espontânea (RCE) e com a pressão de perfusão coronariana. Em pacientes intubados, esse parâmetro pode ser mensurado através da capnografia. Quando seu valor encontra-se 10 mmHg, a técnica da RCP deve ser melhorada. A partir desses dados, podemos concluir alguns fatos. Se o paciente mantiver níveis baixos de PETCO2 por longos períodos mesmo após a realização de manobras de RCP corretas, deduzimos que o RCE não será facilmente atingido. Níveis reduzidos de PETCO2 podem ser levados em consideração para definir a cessação das manobras de RCP. Por outro lado, se houver aumento abrupto dos seus valores, é possível considerar que houve RCE. Para finalizar como já mencionado, o PETCO2 é mensurado em pacientes intubados. Sendo assim, não há evidências da utilidade da capnografia em pacientes não intubados. Dessa forma, a única alternativa incorreta é a opção (A).

161406.

Comentário: A síndrome de Wolf-Parkinson-White (WPW) consiste em um feixe anômalo que provoca pré-excitação ventricular, isto é, o ventrículo começa a despolarizar por uma via que não passa pelo NAV. Não há defeito nos canais de sódio, mas a síndrome leva ao portador um aumento do potencial arritmogênico. Resposta B.

161415.

Comentário: O conhecimento dos desdobramentos da fibrilacão atrial são de suma importância, visto que trata-se da taquiarritmia crônica mais comum da prática clínica, acometendo 1-2% da população. A grande preocupação nos portadores de FA é com a ocorrência de fenômenos tromboembólicos. A formação intra-atrial de trombos decorre da conjunção de uma série de mecanismos, entre os quais -Estase sanguínea derivada da perda da contração rítmica dos átrios -Lesão endotelial consequente ao atrito do sangue com o endocárdio -Aumento da trombogenicidade sanguínea em função de elevação plasmática dos níveis de fator de Von Wilebrand. A FA corresponde a fonte de cerca de 45% dos casos de cardioembolismo, sendo a principal. A principal região acometida pelo deslocamento de trombos é o cérebro, em cerca de 80% dos casos , motivo pelo qual em muitos casos o acidente vascular encefálico isquêmico é a primeira manifestação desta arritmia. Gabarito letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161416.

Comentário: Na fibrilação atrial ocorre perda da contração rítmica dos átrios, gerando um ambiente de estase sanguínea que predispõe a formação de trombos. Neste ambiente de estase há elevação dos nívies plasmáticos do fator de Von Willebrand, gerando aumento de agregação plaquetária. O aumento da agregação plaquetária gera produtos do sistema fibrinolítico endógeno, estando fatores como o fibrinogênio aumentado nesses pacientes. Os estado pró-inflamatórios tendem a AUMENTAR (e não diminuir) a aderência das plaquetas e a ocorrência de trombos (estado hipercoagulável). A letra B é a incorreta.

161417.

Comentário: Os fatores de risco para ocorrência de eventos tromboembólicos na fibrilação atrial podem ser determinados através das letras da sigla CHA2DS2-VASC, a qual determina um escore de pontos. Vamos rever seus elementos C insuficiência Cardíaca 1 ponto H Hipertensão arterial sistêmica 1 ponto A Age idade 75 anos 2 pontos D Diabetes mellitus 1 ponto S2 Stroke AIT AVE prévio 2 pontos V doença Vascular 1 ponto A Age idade 65-74 anos 1 ponto Sc Sexo feminino 1 ponto. O sexo masculino não representa fator de risco. A letra A é o gabarito.

161327.

Comentário: A ação anticoagulante da varfarina pode ser aumentada quando grandes quantidades de álcool são consumidas (de forma aguda ou crônica), especialmente em pacientes com algum grau de disfunção hepática Os antiinflamatórios não esteroidais também são capazes de potencializar o efeito dessa droga, elevando o risco de sangramento. Além desses, a hipertensão também é um fator de risco para as hemorragias. Contudo, o fator mais comum que leva ao sangramento relacionado ao uso de antagonistas da vitamina K é a instabilidade do INR Por isso, devemos controlá-lo de forma precisa, visando um alvo entre 2,0-3,0 para a maioria dos pacientes. Também são fatores de risco para o sangramento variações da quantidade de vitamina K consumida nas refeições, idade avançada, diabetes mellitus, uso concomitante de AAS, adesão irregular ao tratamento, entre outros. Dessa forma, a única resposta incorreta é a opção (B).

161340.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: No manejo da fibrilação atrial é de suma importância levar em consideração a causa do evento arrítimico. Naqueles pacientes que apresentam episódios de FA em surtos autolimitados com causas secundárias reversíveis, após a reversão para o ritmo sinual e controle da etiologia não há necessidade de manutenção de antiarrítmico. Nenhuma droga é necessária a longo prazo, embora seja possível a necessidade de medicamentos (betabloqueadores, por exemplo) por período limitado. A letra B está incorreta.

161347.

Comentário: De acordo com as II Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial, o controle da frequência cardíaca em pacientes com fibrilação atrial é importante para a prevenção de sintomas (por exemplo palpitações, cansaço e redução da capacidade de exercício B correta), redução da morbidade associada à doença (C correta), e principalmente prevenção de taquicardiomiopatia (D correta), o que impacta na qualidade de vida do paciente. Entretanto, não é capaz de impedir lesão endotelial. Resposta A.

161247.

Comentário: A distribuição dos acidentes por submersão é bimodal o primeiro pico de incidência ocorre nos menores de 4 anos de idade, e o segundo pico, entre adolescentes de 15 a 19 anos. De forma geral, ocorre predomínio do sexo masculino numa relação masculino feminino de 3 1 entre crianças, e de 6 1 entre adolescentes. A) CORRETA. É recomendado fazer dosagem de glicemia frequentemente, mantendo-se valores de normoglicemia, para evitar a acidose cerebral e agravamento do coma. B) CORRETA. Todas crianças que sofreram afogamento e apresentam sinais de hipóxia, devem ser submetidas a exame de imagem e, aquelas que apresentam tomografia computadorizada alterada geralmente tem pior prognóstico. Especialmente, as crianças que sofreram parada cardiorrespiratória apresentam um risco maior de lesão potencialmente irreversível do SNC. C) CORRETA. A pressão arterial deve ser continuamente monitorizada, uma vez que a diminuição do débito cardíaco e a hipotensão pioram a hipóxia e acidose. Diante disso, gabarito letra A.

134046.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Na parada cardiorrespiratória não há fluxo sanguíneo, logo, os tecidos periféricos entram em anaerobiose absoluta, produzindo acidose lática. O melhor tratamento para esta situação extrema será aquele que efetivamente conseguir restaurar a perfusão tecidual em qualquer grau. Num primeiro momento, frente à PCR, este tratamento é sem dúvida a massagem cardíaca (A correta). No entanto, é importante ter em mente que os resultados de uma gasometria coletada durante a PCR não são plenamente confiáveis, quer dizer, o grau de acidose lática verificado na gaso não corresponderá à verdadeira acidose lática do paciente mesmo que a RCP seja perfeita , o fluxo sanguíneo produzido está sempre abaixo do normal, logo, os tecidos periféricos não são adequadamente lavados , o que significa que o ácido lático se acumula em algum grau nesses tecidos, gerando o que se chama de acidose oculta (o verdadeiro grau de acidose lática só será expresso após retorno da circulação espontânea e retomada da perfusão normal) - B correta. Ao ministrarmos HCO3 na veia de um paciente muito acidótico, é esperado um aumento imediato na geração de CO2, pelo fato de o HCO3 se combinar quimicamente ao H formando ácido carbônico que logo se dissocia em CO2 e água (D correta). Enfim, a infusão de HCO3 é benéfica como tratamento da acidose extrema e também da hipercalemia grave o HCO3, ao tamponar o H e assim elevar o pH do meio extracelular, faz com que o H retido no interior das células extravase para o extracelular no sentido de seu gradiente eletroquímico. Acontece que para cada H que sai da célula, algum cátion tem que entrar no citoplasma em seu lugar. Que cátion é esse O K , que representa o principal cátion do meio IC Assim, a infusão de HCO3 consegue reduzir os níveis de K sérico, ajudando a combater a hipercalemia e a acidose ao mesmo tempo, o que pode favorecer o retorno da circulação espontânea numa situação de PCR. Resposta certa C.

134793.

Comentário: Quando falamos de taquiarritmia de QRS estreito estamos falando de 3 arritmias principais, a fibrilação atrial, o flutter atrial e taquicardia supraventricular. No caso da taquicardia supraventricular, o tratamento é feito com adenosina em bolus, administrando na primeira dose 6 mg e na segunda dose, caso necessário, 12 mg. A adenosina tem meia vida muito curta (menos de 10 segundos) por sua rápida metabolização endotelial, por isso devemos administrá-la em bolus,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

realizar um flush com soro após sua administração e preferencialmente levantar o braço onde está localizado o acesso usado para administração. A Amiodarona é feita em bolus na parada cardiorrespiratória, primeira dose de 300 mg, segunda dose de 150 mg. Caso seja optado pelo uso de Amiodarona para tratar uma taquiarritmia de QRS estreito será feita uma dose de ataque e uma de manutenção, não bolus. Não está indicada a cardioversão química sempre, pois em caso de instabilidade hemodinâmica realizaremos a cardioversão elétrica e caso a arritmia seja uma fibrilação atrial ou flutter, sempre iremos ponderar se há indicação de estabelecer um ritmo sinusal e se é necessário anticoagulação ou ecocardiografia transesofágica antes. Dessa forma, a resposta certa é a letra A.

134053.

Comentário: A adenosina é um inibidor do nódulo AV de ação rápida e efeito de curta duração. Como todas as drogas que inibem o nódulo AV (independente de sua farmacocinética), deve ser evitada diante de uma taquiarritmia supraventricular em pacientes que possuem a síndrome de Wolff-Parkinson-White (pré-excitação ventricular). Neste caso, existe uma via acessória átrio-ventricular, e a inibição do nódulo AV favorece a condução dos estímulos supraventriculares através dessa via acessória, sem passar pelo filtro do nódulo AV, acarretando maior chance de degeneração para fibrilação ventricular (C correta). Na disfunção do nódulo sinusal, foi demonstrado que a adenosina pode induzir pausas sinusais muito prolongadas, que podem resultar em síncope (B correta). E nos bloqueios atrioventriculares de 1º e 2º grau, a inibição promovida pela adenosina pode resultar em acentuação do bloqueio, que assim pode se tornar COMPLETO (3º grau) - A correta. Enfim, as arritmias que têm na adenosina seu tratamento de escolha, como a taquicardia supraventricular por reentrada nodal, não acarretam risco aumentado de trombose atrial, logo, interrromper essas arritmias mesmo após muitas horas de seu início não traz aumento no risco de cardioembolismo (diferentemente da FA, onde uma duração 48h indica risco significativo de formação de trombos atriais e consequente cardioembolismo se a arritmia for terminada inadvertidamente)... Resposta certa D.

134076.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão muito interessante... As drogas antiarrítmicas do grupo IB (lidocaína, fenitoína, mexiletine e tocainida) bloqueiam os canais de sódio responsáveis pela fase zero do potencial de ação (despolarização). No entanto, seu efeito é extremamente rápido, isto é, a ligação aos referidos receptores é de curtíssima duração, e só ocorre quando o canal de sódio se abre , desfazendo-se quando o canal de sódio se fecha . Na prática, isso significa que o bloqueio só acontece durante a sístole cardíaca... Ora, para que o efeito de bloqueio aos canais de sódio seja clinicamente significativo, a fase zero do potencial de ação TEM QUE ESTAR PATOLOGICAMENTE AUMENTADA (o que se traduz por um QRS largo, ou então quando existe ISQUEMIA MIOCÁRDICA). Arritmias com QRS estreito (e sem isquemia miocárdica), não são afetadas pelo uso de antiarrítmicos do grupo IB, como a lidocaína. Resposta certa A.

134079.

Comentário: TV (taquicardia ventricular) e TSV (taquicardia supraventricular) conduzida com aberrância (como um bloqueio de ramo, por exemplo) são condições que, por definição, apresentam QRS largo (120 ms). Uma TSV na presença de um distúrbio eletrolítico grave capaz de alterar as propriedades eletrofisiológicas do coração (ex. hipercalemia, que pode alterar tanto a repolarização quanto a despolarização ventricular) também vai cursar com QRS largo. Agora, uma taquicardia atrial, por si só, seja uni ou multifocal, cursará com QRS estreito caso não haja bloqueio de ramo ou distúrbios eletrolíticos. Os estímulos se originam no miocárdio atrial, e são normalmente filtrados pelo nódulo AV, abaixo do qual a condução é rápida e ativa ambos os ventrículos pelo sistema de His-Purkinje quase que de forma instantânea (inscrição rápida do QRS). Logo, resposta certa C.

134083.

Comentário: Numa TV monomórfica sustentada (TVMS), a ausência de instabilidade hemodinâmica permite a tentativa de tratamento clínico com drogas antiarrítmicas (ex. amiodarona 150 mg IV em 10 min), sem necessidade de cardioversão elétrica imediata Nesta situação, obviamente, podemos dar início à investigação do diagnóstico etiológico enquanto o paciente ainda apresenta a arritmia (ex. exames laboratoriais, ecocardiograma, exames toxicológicos para a pesquisa de cocaína). A

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

lidocaína não faz mais parte do rol de drogas de primeira linha para tratamento da TVMS (amiodarona, procainamida, sotalol), a não ser que se trate de TVMS na fase aguda de um IAM (amiodarona, procainamida e lidocaína). Resposta certa C.

134116.

Comentário: A conduta que salva vidas e que começa o atendimento às paradas cardiorrespiratórias é a compressão torácica (D errada) que, segundo os novos guidelines de 2015, devem ser feitas com as seguintes características frequência entre 100 e 120 por minuto (C errada), rebaixando o esterno entre 5 e 6 centímetros, permitindo, após cada compressão, o retorno do tórax à sua posição original. A vasopressina foi sepultada dos algoritmos de parada (A errada). Resposta B.

134860.

Comentário: A paciente chegou ao hospital apresentando queixas sugestivas de síndrome coronariana aguda e, durante o atendimento inicial, evoluiu com parada cardiorrespiratória (PCR). O que devemos fazer Lembre-se que a primeira conduta a ser tomada após o reconhecimento de uma PCR é chamar ajuda. No hospital, isso equivale a acionar toda a equipe disponível e trazer o carrinho de parada , que contém o desfibrilador. A segunda conduta, em termos de prioridade, é dar início às manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), que serão mantidas até que o desfibrilador esteja pronto. Tais manobras se iniciam com a sequência CAB, isto é, o primeiro passo é a realização de compressões torácicas de qualidade (frequência entre 100-120, depressão do esterno entre 5-6 cm, permitir o retorno completo do tórax entre as compressões, evitar interrupções desnecessárias). Se o paciente não estiver intubado, realizam-se ciclos de 30 compressões para 2 ventilações, alternando os operadores das manobras a cada 5 ciclos (ou 2 minutos). A obtenção de via aérea definitiva (ex. IOT ou máscara laríngea) pertence ao ACLS, quer dizer, não faz parte das manobras iniciais (BLS). O ACLS começa com a chegada do desfibrilador... Quando este aparelho chega, verificamos se o ritmo é chocável ou não. Caso seja, um choque desfibrilatório é ministrado, e na sequência a RCP é retomada, obtendo-se, ao mesmo tempo, se possível, um acesso venoso periférico e uma via aérea definitiva. Caso o ritmo não seja chocável ,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

a mesma conduta descrita no pós-choque é tomada (continuar RCP, acesso venoso periférico, via aérea definitiva). Como o momento da questão se refere ao INÍCIO DO BLS, resposta certa A.

134122.

Comentário: Muitas vezes, enquanto não se obtém um acesso venoso adequado (que é via de escolha - D errada), pode-se administrar certas drogas, no paciente em parada cardiorrespiratória (PCR), através do tubo endotraqueal Que drogas podem entrar por essa via Vasopressina (que saiu do algoritmo de PCR), naloxona, epinefrina e lidocaína (B certa). Precisamos apenas lembrar que teremos de fazer 2-2,5x a dose normal quando utilizarmos essa via (A certa). Um dos inconvenientes é a chegada de subdoses das drogas à circulação. Um bom exemplo é a adrenalina que, a depender da dose, pode ter efeitos beta ou alfa. Os efeitos beta - que levam à vasodilatação - são indesejáveis no contexto da PCR (C certa). Resposta D.

134128.

Comentário: Na intoxicação por bloqueadores de canais de cálcio (que diminuem a atividade biológica do cálcio no organismo), o tratamento consiste de... REPOSIÇÃO DE SAIS DE CÁLCIO, como o gluconato (A correta) O mesmo raciocínio é válido para a HIPOcalcemia sintomática (C correta). Na hipercalemia, o cálcio é importante para proteger eletricamente o miocárdio, ainda que não seja uma medida que reduza diretamente os níveis séricos de K (B correta). Enfim, não há indicação de gluconato de cálcio de forma rotineira em TODAS as formas de parada cardíaca. No entanto, como já dissemos, em se tratando da hipercalemia como causa de parada, após reanimação o gluconato pode ser utilizado para proteger eletricamente o miocárdio dos efeitos pró-arrítmicos de uma hipercalemia persistente... Resposta certa D.

134032.

Comentário: O magnésio é indicado como terapia antiarrítmica para tratar o torsades des pointes , isto é, a taquicardia ventricular polimórfica associada a intervalo QT longo. Tal substância consegue encurtar o intervalo QT e, na realidade, é indicada mesmo quando não existe hipomagnesemia Resposta certa B.

134340.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A hiperventilação inadvertida é uma das principais complicações durante as manobras de RCP (quase todo mundo, se não tomar cuidado, acaba hiperventilando o paciente)... Ela promove aumento da pressão intratorácica, o que por sua vez diminui o retorno venoso ao coração, comprometendo a eficácia da própria RCP. Durante a RCP devemos ventilar o paciente com AMBU numa frequência de 1 ambuzada a cada 6 segundos, isto é, FR em torno de 10 rpm. A ambuzada deve durar cerca de 1 segundo, e tem que ser suficiente para promover uma discreta elevação da parede torácica. Resposta certa A.

110058.

Comentário: Na fibrilação atrial, especialmente, mas não exclusivamente nos pacientes com a arritmia durando mais de 48 horas (B, C e D erradas), há possibilidade de haver formação de trombo em átrio esquerdo (por conta da ESTASE SANGUÍNEA intracavitária, já que o átrio perde as suas contrações efetivas na fibrilação). Lembre-se da TRÍADE DE VIRCHOW, a qual marca um aumento na formação de trombos (1) estase sanguínea, (2) lesão endotelial e (3) hipercoagulabilidade. Resposta A.

109980.

Comentário: Em cerca de 70% dos casos de parada cardiorrespiratória, o ritmo observado será de fibrilação ventricular. Nesses casos, quando a parada é assistida e realizada compressão torácica eficiente (FORTE E RÁPIDA) e ACIONAMENTO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, com DESFIBRILAÇÃO PRECOCE, a chance de reversão existe e não é baixa. Lembre-se se for escolher um ritmo de parada, escolha fibrilação ventricular . Resposta B.

286702.

Comentário: A taquicardia por reentrada nodal é uma condição que acontece devido à existência de uma dupla via congênita anômala no nódulo atrioventricular. As demais opções representam condições que afetam diretamente o nódulo sinusal. Resposta C.

286704.

Comentário: A pressão arterial deve ser medida de rotina em crianças a partir de 3 anos de idade, logo, A e B corretas No obeso com braço de formato cônico, aceita-se a medida da PA no punho,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

mas a preferência continua sendo pelo método auscultatório tradicional (C errada). Os idosos representam o principal grupo que desenvolve hiato auscultatório , logo, a verficação da PA sistólica pelo método palpatório é essencial (D errada). Questão que merecia anulação, mas a banca manteve como gabarito a letra A.

286705.

Comentário: As doenças que acometem o nódulo AV podem comprometer a região supra-hissiana ou intra infra-hissiana. No primeiro grupo em geral não é preciso o uso de marcapasso definitivo, ainda que em casos selecionados este possa ser o tratamento. Por outro lado, nas doenças associadas a lesões intra ou infra-hissianas o uso de marcapasso é regra, pois o prognóstico de tais condições é pior, além de geralmente serem alterações irreversíveis e progressivas. A, B C são condições intra ou infra-hissianas, enquanto a letra D nos traz uma condição, por definição, supra-hissiana. Resposta D.

107648.

Comentário: Uma boa questão da prova da CERMAM sobre reanimação cardiopulmonar. Vamos às opções. O soco precordial não deve ser usado em PCR extra-hospitalar não presenciada. O soco precordial poderá ser considerado para pacientes com TV instável (inclusive TV sem pulso) presenciada e monitorizada se não houver um desfibrilador imediatamente pronto para uso. No entanto, ele não deverá retardar a RCP nem a aplicação dos choques. A opção A é INCORRETA pois trata de PCR NÃO presenciada, na qual o soco precordial NÃO deve ser usado. Séries de casos empregando dispositivos com pistão mecânico relatam graus variados de êxito. O uso de tais dispositivos pode ser considerado quando for difícil manter a RCP convencional. Porém o uso de pistão não é superior à RCP padrão. Opção B INCORRETA. A escolha do melhor método de ventilação deve basear-se na experiência do socorrista, sendo aceitável a utilização do dispositivo de bolsa-válvula-máscara, isoladamente ou em combinação com o cânula orotraqueal, assim como a máscara laríngea, o combitube ou o tubo laríngeo. Opção C CORRETA e autoexplicativa (gabarito). A capnografia quantitativa contínua com forma de onda é, agora, recomendada para pacientes intubados ao longo de todo o período peri-PCR. No uso adulto de capnografia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

quantitativa com forma de onda, as aplicações, agora, contêm recomendações para confirmar o posicionamento do tubo traqueal e monitorar a qualidade da RCP e detectar o RCE com base em valores do dióxido de carbono no final da expiração PETCO2. Contudo são níveis SUPERIORES a 20 mmHg que se relacionam à qualidade da RCP e ao retorno da circulação espontânea. D INCORRETA. Gabarito, portanto, opção C.

103807.

Comentário: Vamos rever os critérios de Síndrome Metabólica que são propostos pelo National Cholesterol Education Program - ATP III. - Circunferência abdominal -Mulheres 88 cm -Homens 102 cm - Pressão arterial sistólica 130 ou diastólica 85 mmHg - Triglicerídeos 150 mg dl - HDL-Colesterol -Mulheres 50 mg dl -Homens 40 mg dl -Glicemia de jejum 100 mg dl Pelo NCEP ATP III na presença de três dos cinco critérios, o paciente é classificado como portador de síndrome metabólica. Os valores de LDL n o fazem parte dos critérios.

81006.

Comentário: Bem, todos os pacientes descritos apresentam sinais e sintomas de uma síndrome de insuficiência cardíaca, com algumas pequenas diferenças entre cada caso. O primeiro paciente, por exemplo, por ser etilista pesado, pode possuir como etiologia para o seu quadro clínico um diagnóstico de miocardiopatia alcoólica. O segundo paciente, tabagista pesado e com murmúrio vesicular difusamente reduzido, apresenta sinais de disfunção predominante do ventrículo DIREITO (ex. importante congestão venosa sistêmica, inclusive com pletora facial), além de hiperfonese de B2 sugerindo hipertensão arterial pulmonar. Logo, trata-se de um provável caso de IC por cor pulmonale num paciente com DPOC avançada. A paciente número 3, que não fuma e não bebe, apresenta um sinal que evidentemente não possui especificidade suficiente para firmar o diagnóstico de qualquer etiologia, porém, em nosso país (que possui diversas regiões endêmicas para doença de Chagas), deve levantar tal suspeita diagnóstica estamos nos referindo ao bloqueio de ramo direito, que é característico da cardiopatia chagásica (juntamente com os aneurismas de ponta do VE). Enfim, a última paciente apresenta onda Q (necrose transmural) no eletrocardiograma. O mais provável, portanto, é que sua síndrome de insuficiência cardíaca seja

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

secundária a um acúmulo de infartos isquêmicos associados à doença coronariana. Resposta certa D.

61525.

Comentário: Se o paciente está em FV (Fibrilação Ventricular) a conduta prioritária (a única que pode reverter essa situação) é a DESFIBRILAÇÃO, que deve ser ministrada o quanto antes. Logo, para este paciente que recebeu adequadamente as manobras do protocolo BLS (Basic Life Support) isto é, compressões torácicas, com ou sem ventilações alternadas, até a chegada do desfibrilador a confirmação do ritmo de FV demanda imediata aplicação do choque desfibrilatório. A carga da corrente nos desfibriladores bifásicos varia entre 120-200 J, sendo recomendado optar pelo valor de 200 J inicialmente. Cargas superiores a 200 J são reservadas para os desfibriladores monofásicos (ex. 360 J) - A ERRADA a administração de drogas faz parte do protocolo ACLS (Advanced Cardiac Life Support), o qual terá início, somente, após a constatação de que a primeira tentativa de desfibrilação não foi eficaz - B, D e E ERRADAS. Resposta certa C.

49803.

Comentário: Questão clássica. Na estenose mitral existe um importante impedimento à passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo - isto é, a própria estenose mitral, que dificulta o esvaziamento do átrio esquerdo Durante uma taquiarritmia qualquer (como a FA, cujo risco encontra-se aumentado no portador de estenose mitral), o aumento da frequência cardíaca resulta numa diminuição do tempo de enchimento diastólico ventricular, o que por si só já dificulta o esvaziamento do átrio esquerdo. Ora, combinando as duas coisas, ou seja (1) o menor tempo de enchimento diastólico e (2) a própria sobrecarga pressórica típica da estenose mitral, temos como resultado principal uma súbita sobrecarga pressórica do átrio esquerdo. O aumento de pressão no átrio esquerdo se reflete retrogradamente para a circulação venocapilar pulmonar, uma vez que não há válvulas nas veias pulmonares para impedir o refluxo de sangue e pressão. A consequência final é o surgimento de um edema agudo de pulmão . Resposta certa D.

26689.

Comentário: Quando se refere à embolia sistêmica (Acidente vascular encefálico, infarto

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

mesentérico, etc) a principal fonte é, sem dúvida alguma, a cardiogênica. Os locais onde esses êmbolos sofrem impactação são diversos e incluem território da artéria cerebral média, da artéria mesentérica superior e de artérias que nutrem os membros inferiores (bifurcação da femoral). A condição cardíaca mais comum que causa êmbolos é a fibrilação atrial crônica ou paroxística. Outras etiologias descritas são Trombo intracardíaco, Cardiomiopatia dilatada, Doença valvar Reumática, válvula protética e IAM com aneurisma de ventrículo. O mixoma atrial é uma causa bem rara de embolia de origem cardíaca. Os mixomas são os tumores cardíacos primários mais comuns Estes tumores são benignos e costuma gerar sintomas de acordo com sua localização anatômica. 80% dos mixomas se localizam no átrio e geram, além de sintomas constitucionais (como febre e perda de peso), obstrução valvar mitral e embolização sistêmica. O tratamento é cirúrgico com ressecção da lesão tumores múltiplos podem necessitar de transplante cardíaco. Resposta Letra B.

324810.

Comentário: Se a banca descreve em seu enunciado que o paciente precisou de choque , então o ritmo de parada ou foi uma fibrilação ventricular, ou foi uma taquicardia ventricular sem pulso o choque desfibrilatório é a única medida confiável capaz de reverter esses ritmos. Para os cardiodesfibriladores tradicionais (monofásicos), o choque aplicado para reverter a FV ou a TV sem pulso deve ser de 360 J, sempre dessincronizado. Para os mais modernos (bifásicos) a carga gira em torno de 120 a 200 J, ficando na dependência do tipo de onda bifásica (retilínea 120 J ou exponencial 150 a 200 J). Na prática, se você dispõe de um cardiodesfibrilador bifásico e não sabe o tipo de onda, dê um choque de 200 J. Um conceito muito importante preconiza-se apenas um choque, seguido imediatamente da continuação da RCP (compressão ventilação). Nem o ritmo, nem o pulso devem ser checados depois do choque, mas apenas após dois minutos de RCP. GABARITO OFICIAL Fibrilação ventricular OU FV E Taquicardia ventricular OU Taquicardia ventricular sem pulso OU TV OU TVSP.

324811.

Comentário: Se a banca descreve em seu enunciado que o paciente precisou de choque , então o ritmo de parada ou foi uma fibrilação ventricular, ou foi uma taquicardia ventricular sem pulso o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

choque desfibrilatório é a única medida confiável capaz de reverter esses ritmos. Qual seria a causa mais provável Sem dúvida é a doença coronariana aterotrombótica oclusiva Dos pacientes com morte súbita e idade 30 anos, a doença coronariana é responsável por 75% dos casos. Outras cardiopatias, distúrbios elétricos primários (não estrutural) e causas também podem ser incriminadas. Cabe dizer que em pacientes jovens, a cardiomiopatia hipertrófica aparece como campeã nas estatísticas americanas (neste grupo de pacientes, as doenças elétricas primárias e não estruturais aumentam o seu percentual como causa de morte súbita). GABARITO OFICIAL Síndrome coronariana aguda OU Infarto agudo do miocárdio OU Doença arterial coronariana OU Isquemia cardíaca OU Oclusão coronariana aguda OU Infarto OU Infarto do miocárdio OU Oclusão da coronária OU Isquemia miocárdica.

324812.

Comentário: Se a banca descreve em seu enunciado que o paciente precisou de choque , então o ritmo de parada ou foi uma fibrilação ventricular, ou foi uma taquicardia ventricular sem pulso o choque desfibrilatório é a única medida confiável capaz de reverter esses ritmos. Os fármacos que entram no atendimento desses tipos de parada são os seguintes - Adrenalina (epinefrina) durante a RCP, logo após o segundo choque e a obtenção de acesso venoso periférico, faz-se adrenalina 1 mg (uma ampola) pela veia periférica, infundindo em seguida cerca de 20 ml de soro fisiológico ou água destilada e elevando o braço do paciente. A adrenalina deve ser repetida a cada 3-5min durante todo o ACLS. Trata-se de um vasopressor muito potente, capaz de aumentar o fluxo coronariano e cerebral, reduzindo a hipóxia e acidose teciduais e facilitando a desfibrilação. O paciente reanimado menos de cinco minutos após infusão de adrenalina pode voltar hipertenso porém a hipertensão desaparece em muito pouco tempo. - Amiodarona é o antiarrítmico utilizado na FV TV sem pulso que não responde ao choque e à adrenalina (refratária), facilitando o sucesso da desfibrilação. Pode ser feita duas vezes na primeira, a dose é de 300 mg (duas ampolas) e na segunda, de 150 mg (uma ampola). - Lidocaína assim como a amiodarona, este é um antiarrítmico que pode ser utilizado no manejo da FV TV sem pulso refratária. A dose é de 1-1,5 mg kg em bolus (5 ml 100 mg). Pode ser repetida (0,5-0,75 mg kg, a cada 5-10min) até a dose cumulativa de 3 mg

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

kg. GABARITO OFICIAL Adrenalina E Amiodarona OU Lidocaína. Adrenalina E Amiodarona. Adrenalina E Lidocaína.

294394.

Comentário: O enunciado descreve uma mulher com história de diabetes que evoluiu com síncope. Até aqui, não temos muitos dados que nos ajudem com o diagnóstico diferencial das possíveis etiologias Porém, quando vemos os sinais vitais, algo deve chamar atenção FC 34 bpm com PA 86 x 52 mmHg Ou seja, muito provavelmente estamos diante de uma bradiarritmia maligna O próximo passo, sem dúvida, é realizar um eletrocardiograma para melhor avaliação. Entretanto, ao invés de colocar a imagem do exame, a banca optou por descrevê-lo a presença de ondas P completamente dissociadas dos complexos QRS é compatível com o diagnóstico de bloqueio atrioventricular total Nesta condição, a onda P aparece em várias posições com relação ao QRS (dentro, logo antes, logo depois, no segmento ST, em cima da onda T etc.). Resposta bloqueio atrioventricular total.

294395.

Comentário: De forma resumida, o enunciado descreve um paciente com BAVT e instabilidade (síncope, hipotensão e bradicardia grave). A conduta ideal para a bradicardia sintomática é a colocação de um marca-passo provisório, o qual, na maioria das vezes, acaba sendo um transcutâneo pela maior rapidez de implante. Absolutamente nenhuma medida deve adiar a instalação da estimulação cardíaca artificial. Mas, como a preparação do marca-passo, em geral, leva alguns minutos, podemos administrar fármacos para elevar a frequência cardíaca. Neste cenário, a droga de escolha, a princípio, é a atropina, mas com algumas ressalvas se a origem da bradicardia for abaixo do feixe de His (evidenciado pela presença de complexo QRS largo), a atropina é pouco confiável. Entenda o nodo AV recebe ampla inervação vagal (parassimpática), enquanto o feixe de His e os ramos direito e esquerdo não são inervados por este sistema. Essa característica neurológica já nos transmite uma importante implicação terapêutica os BAVs que surgirem exatamente no nodo AV (chamados de bloqueios proximais ou supra-hissianos) responderão à atropina (droga anticolinérgica, que bloqueia ação parassimpática), o mesmo não acontecendo com os BAVs que ocorrerem do feixe de His para baixo (bloqueios distais ou intra

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

infra-hissianos). Nos casos em que a atropina é inapropriada ou ineficaz, opta-se por beta-adrenérgicos, especialmente dopamina e epinefrina. Portanto, no caso da questão, por ser um BAVT com FC 40 bpm, existe uma grande chance de não responder a atropina. Mas com os dados que nós temos, não dá pra cravar que a origem dessa bradicardia é infra-hissiana (veja que não há relato de QRS alargado) e, por isso, pelo algoritmo do ACLS, a droga de escolha inicial seria a atropina. Resposta atropina.

294396.

Comentário: Temos uma paciente com quadro de bloqueio atrioventricular total, evoluindo com síncope e hipotensão o que constitui um sinal de instabilidade hemodinâmica. Nestes casos, a atropina deve ser administrada enquanto não é possível realizar a estimulação cardíaca temporária imediata (transvenosa, se disponível imediatamente, ou transcutânea) e ou infusão de um agente cronotrópico (adrenalina ou dopamina) se os sintomas forem muito significativos. Portanto, assim que disponível, devemos implantar um marca-passo (transcutâneo ou transvenoso). Resposta implantação de marca-passo transcutâneo ou marca-passo transvenoso.

106584.

Comentário: Os possíveis ritmos para uma parada cardiorrespiratória são assistolia, Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP), Taquicardia Ventricular (TV) e Fibrilaç o Ventricular (FV). No manejo dos pacientes em PCR é muito importante identificarmos adequadamente os ritmos, pois temos intervenções diferentes para AESP assistolia e FV TV. Nas PCR por FV TV o foco é na desfibrilação precoce.

106585.

Comentário: Um paciente com DPOC descompensado que evolui com PCR deve ter a hipóxia como etiologia do ocorrido. Um ritmo caracterizado por QRS largo e FC 54 bpm configura atividade elétrica sem pulso. A AESP engloba um grupo heterogêneo de ritmos organizados e semiorganizados, mas sem pulso palpável. Esta compreende ritmos idioventriculares ritmos de escapes ventriculares ritmos idioventriculares pós-desfibrilação ritmo sinusal. Todo ritmo organizado sem pulso configura AESP. Os ritmos sem pulso excluídos por definição são FV, TV e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

assistolia. GABARITO OFICIAL AESP (Atividade Elétrica Sem Pulso).

106541.

Comentário: Um paciente com DPOC descompensado que evolui com PCR deve ter a hipóxia a como etiologia do ocorrido. Um ritmo caracterizado por QRS largo e FC 54 bpm configura atividade elétrica sem pulso. A AESP e assistolia s o abordadas da mesma forma pelo ACLS. Devemos iniciar imediatamente massagem cardíaca externa com compressões eficazes (no mínimo 100 por minuto), alternando 30 compressões com 2 ventilações com ambu e máscara até a instituição de uma via aérea definitiva. Deve ser obter um acesso venoso rapidamente para administração de vasopressor, sendo a adrenalina a primeira escolha. Após instituição da via aérea definitiva não há mais necessidade de sincronização entre massagem cardíaca e ventilação, com compressões torácicas mantidas em no mínimo 100 minuto e 8-10 ventilações minuto.

49365.

Comentário: Após a reversão de uma FV para o ritmo sinusal, o paciente deve receber amiodarona por 24 a 48h como profilaxia da recidiva. A dose recomendada é de 150 mg ao longo de 10 minutos, seguidos de 1 mg min nas primeiras 6h e 0,5 mg min pelas próximas 18h. Resposta certa letra B.

35000.

Comentário: Inicialmente, a banca deu como gabarito a letra D. No entanto, este foi trocado para a letra C após os pedidos de recurso. E qual é a nossa impressão Primeiramente, a letra D, de fato, não está correta. O RIVA (Ritmo Idioventricular Acelerado) é uma arritmia relativamente BENIGNA associada à reperfusão mecânica ou química de um miocárdio agudamente isquêmico. Seu mecanismo é o aumento do automatismo nas fibras de Purkinje devido à maior entrada de cálcio no citoplasma das células reperfundidas, resultando, em geral, numa frequência cardíaca entre 60-100 bpm (dentro do normal, porém, acima do esperado para o foco nas fibras de Purkinje por isso ele também pode ser chamado de taquicardia ventricular lenta). A FC do nosso paciente está em torno de 150 bpm, um pouco acima da FC do RIVA habitual. Os pacientes com RIVA apresentam no ECG um QRS de morfologia ventricular (alargado, isto é, duração 120ms ou 3 quadradinhos), e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

quase nunca desenvolvem instabilidade hemodinâmica Pacientes com RIVA instabilidade são abordados com administração de atropina 1 mg IV (pois em geral a instabilidade se dá por frequências cardíacas mais baixas). Sua duração tende a ser limitada, e a resolução, espontânea. O que este paciente apresenta é uma taquicardia ventricular sustentada (duração 30s ou presença de instabilidade hemodinâmica). A TV, no caso, é claramente monomórfica (QRS de aspecto idêntico). Ora, o tratamento imediato, em vista da instabilidade, é a eletroterapia Contudo, a forma de eletroterapia a ser empregada neste caso NÃO É a desfibrilação, e sim a cardioversão elétrica sincronizada (a desfibrilação choque não sincronizado acarretaria um risco de fibrilação ventricular neste doente). Se a TV fosse polimórfica, aí sim haveria indicação de desfibrilação. Após a cardioversão, deve-se iniciar um antiarrítmico de manutenção para evitar a recidiva no período precoce pós-IAM (no primeiro ECG vemos supradesnível de ST na parede anterior). Logo, nem mesmo a letra C se salva nessa questão, que merecia, na verdade, ter sido ANULADA. A banca manteve mesmo assim a letra C como gabarito.

11133.

Comentário: Muita gente reclamou dessa questão achando que a letra B estava correta... Mas não, ela não está... O uso de DEA requer treinamento em suporte básico de vida (BLS), pois além de ser necessário saber como manipular o aparelho (e sua própria utilidade), de nada adianta ter um DEA e não saber fazer RCP (ressucitação cardiopulmonar, isto é, massagem cardíaca)... A literatura afirma que o DEA pode ser manipulado por socorristas LEIGOS, e muita gente interpreta esse termo da maneira errada leigo , neste caso, quer dizer apenas não médico ... Enfermeiros, paramédicos, técnicos de enfermagem, bombeiros, seguranças, policiais, recepcionistas todas essas pessoas não são médicas (e receberam essa infeliz denominação preconceituosa leigo), e para utilizar um DEA elas precisam de um mínimo de treinamento (precisam conhecer as indicações do DEA, isto é, precisam saber identificar a parada, e precisam conhecer a conduta (ex chamar ajuda) além de, fundamentalmente, devem saber aplicar as compressões torácicas da maneira correta)... A eletroterapia não é útil na assistolia (A errada) e já vimos porque a letra D também está errada (é mandatório realizar 5 ciclos de RCP após o choque, mesmo que a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

desfibrilação seja bem-sucedida). Um dos grandes problemas do DEA é seu alto custo, o que impede que a maioria dos locais públicos com grandes aglomerações humanas (por exemplo um shopping center ou uma rua comercial movimentada) possua um DEA sob a responsabilidade de alguém treinado (E errada)... Sabemos que o maior determinante da sobrevida numa PCR por FV é o tempo até a desfibrilação. Estima-se que o índice de sobrevivência diminua em torno de 7-10% a cada minuto que se passa após o início do quadro... A RCP reduz a queda do índice de sobrevivência para 3-4% por minuto, o que é capaz de duplicar ou até triplicar a chance de sobrevida se a desfibrilação for realizada a tempo... Entretanto, essa queda é inexorável, e após 5 minutos de uma PCR é muito pouco provável que uma pessoa sobreviva sem sequelas neurológicas, mesmo que venha a ser desfibrilada com sucesso (o choque bem-sucedido nos primeiros 5 minutos pode evitar sequelas neurológicas, isto é, modifica o prognóstico)... Resposta certa letra C.

13296.

Comentário: Esta paciente provavelmente está intoxicada pelo betabloqueador presente no colírio para tratamento do glaucoma (ex timolol 0,25-0,5% duas vezes ao dia). Tal medicação tem o efeito de reduzir a pressão intraocular, contribuindo para o controle clínico dessa doença, e mesmo na forma de colírio pode causar efeitos colaterais sistêmicos Repare como ela está bradicárdica no momento do exame se fizermos um ECG agora, talvez se observe um BAV de segundo grau ou mesmo uma bradicardia sinusal... Uma das principais formas de toxicidade dos betabloqueadores é o excesso de cronotropismo negativo. Tais drogas inibem tanto o nódulo sinusal quanto o nódulo AV, o que tende a ser especialmente intenso caso o paciente já possua uma doença prévia no sistema de condução (ex doença do nódulo sinusal, a qual é mais comum em idosos), bem como se houver uso concomitante de outra droga com propriedades inibitórias (ex digital, diltiazem, verapamil)... O fato é que apesar de estar confusa, esta alteração do estado mental não tem qualquer relação com o status hemodinâmico ATUAL, e, portanto, não há indicação imediata de marca-passo transitório Uma PA de 120 x 60 mmHg é perfeitamente normal para um indivíduo previamente normotenso Por outro lado, como a FC está muito baixa (40 bpm), é mandatório

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

realizar alguma forma de estimulação, a qual pode ser levada a cabo pela administração de atropina (vagolítico aumenta a estimulação endógena dos nódulos sinusal e AV), a qual contrabalança os efeitos inibitórios do betabloqueador (o qual deverá ser suspenso imediatamente). As demais alternativas não nos podiam deixar em dúvida (1) a epinefrina é usada na parada cardíaca e na anafilaxia, (2) a noradrenalina é usada no tratamento da hipotensão arterial refratária, (3) o manitol é útil na hipertensão intracraniana. Resposta certa letra A.

13297.

Comentário: Fácil Um intervalo PR de 0,13s é incompatível com BAV de 1º grau (B errada). O PR aparentemente regular fala contra Mobitz I e também BAVT - no primeiro caso, o PR aumentaria até a ocorrência do bloqueio (fenômeno de Wenckebach), e no segundo caso, o PR é totalmente irregular (C errada)... A ausência de ondas P antes da pausa fala contra Mobitz II, assim como BAV avançado (A errada). O autor da questão não identifica P de morfologia variável, logo, não há nada que sugira um possível marca-passo migratório (D errada)... Assim, a melhor resposta, neste caso, é mesmo bradicardia sinusal com pausas sinusais - quadro compatível com intoxicação pelo betabloqueador presente no colírio, haja vista os demais dados da história clínica Resposta certa letra E

13298.

Comentário: Esta paciente provavelmente está intoxicada pelo betabloqueador presente no colírio para tratamento do glaucoma (ex timolol 0,25-0,5% duas vezes ao dia). Tal medicação tem o efeito de reduzir a pressão intraocular, contribuindo para o controle clínico dessa doença, e mesmo na forma de colírio pode causar efeitos colaterais sistêmicos Uma das principais formas de toxicidade dos betabloqueadores é o excesso de cronotropismo negativo. Tais drogas inibem tanto o nódulo sinusal quanto o nódulo AV, o que tende a ser especialmente intenso caso o paciente já possua uma doença prévia no sistema de condução (ex doença do nódulo sinusal, a qual é mais comum em idosos), bem como se houver uso concomitante de outra droga com propriedades inibitórias (ex digital, diltiazem, verapamil). IAM também seria uma hipótese, mas a ausência de dor típica e alterações eletrocardiográficas características falam contra este diagnóstico...

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

11136.

Comentário: Segundo fontes seguras como o Harrison, a primeira alteração eletrocardiográfica da hipercalemia é a mudança no padrão de repolarização ventricular, com aumento na amplitude e formato pontiagudo das ondas T. Tal alteração começa a ser notada quando o potássio ultrapassa a cifra de 6,0 mEq L. O achatamento da onda P (átrios progressivamente menos excitáveis) costuma ser observado quando o potássio ultrapassa 8,0 mEq L, e os átrios podem vir a abolir por completo sua contratilidade muscular. O aumento de duração (alargamento) do QRS também já pode ser visto a partir desse mesmo nível sérico. Na apostila encontramos dois quadrinhos mostrando a evolução eletrocardiográfica da hipo e da hipercalemia.

18042.

Comentário: Questão conceitual o intervalo QT corresponde ao início do complexo QRS (com ou sem onda Q) até o final da onda T, cujo valor varia inversamente com a frequência cardíaca. Por isso, um parâmetro mais fidedigno do que o intervalo QT isolado é o QTc (corrigido), que leva em consideração a frequência cardíaca através da fórmula de Bazzet QTc QT R-R. O QTc normal não deve ultrapassar 440-450 ms, pois acima deste valor há risco de desenvolvimento de taquicardia ventricular polimórfica do tipo torsade de pointes (ECG abaixo). Veja na tabela a seguir as principais causas adquiridas de prolongamento do intervalo QTc (VER IMAGEM)

18050.

Comentário: Questão antiga, que de acordo com a penúltima versão das diretrizes do BLS ACLS (2005) teria como resposta a letra A (gabarito oficial da banca)... Veja bem segundo as diretrizes atuais (2010), uma vez constatada a PCR, após chamar ajuda, a conduta imediata deve ser iniciar a massagem cardíaca de qualidade. Não há mais a recomendação de abrir as vias aéreas e administrar duas ventilações de resgate antes do início da massagem Lembre-se que o intervalo de tempo entre a constatação da PCR (paciente não responde e não respira, ou apresenta apenas gasping) e o início da massagem deve sempre ser o mais breve possível... Como o paciente está dentro do hospital, enquanto um socorrista providencia a massagem cardíaca outros podem realizar, ao mesmo tempo, as demais manobras indicadas para uma perfeita reanimação obtenção

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de acesso venoso, ventilação (inicialmente com máscara-bolsa) e, neste caso, confirmação do ritmo de assistolia (checagem dos fios dos eletrodos, para verificar se não há qualquer fio desplugado ou mal posicionado). Logo, esta questão, nos dias de hoje, não possuiria resposta certa...

343338.

Comentário: Os padrões de sobrecarga dos átrios direito e esquerdo podem ser melhor avaliados nas derivações que representam seu vetor de ativação, tais como V1 e D2. A sobrecarga atrial esquerda (SAE) implica em mudanças no direcionamento habitual de sua despolarização, passando a apontar mais para trás, para cima e para a esquerda. De acordo com a posição convencionada para a derivação V1, tal alteração implica em aumento da área da fase negativa da onda P, tornando-se igual ou maior que 0,04 mm s ou 1 mm2 , sendo as letras A e B incorretas. Denomina-se este achado de índice de Morris. Em D2 a SAE manifesta-se por aumento da duração da onda P acima de 2,5 mm, podendo gerar aspecto bífido. O último possui menor sensibilidade em relação ao primeiro como critério isolado para determinação do crescimento atrial esquerdo, o que torna a alternativa C incorreta e D correta. Resposta letra D.

343343.

Comentário: O eletrocardiograma (ECG) de superfície representa um exame complementar simples, barato, rápido e muito informativo. Suas derivações aludem pontos de referências em diferentes eixos, que nos permitem estudar as câmaras cardíacas. Em um ECG padrão, com velocidade de 25 mm s, cada quadrado pequeno na horizontal corresponde a 40ms, com consequente duração de 200ms dos quadrados grandes. Já verticalmente, determina-se amplitude de 0,1 mV para cada um milímetro. Por sua direção, o vetor de ativação dos átrios possui excelente correlação com as derivações D2 e V1, o que as torna preferenciais para sua observação. Dado que a despolarização atrial tem início no nodo sinusal, seu vetor médio corre da direita para esquerda e de cima para baixo. Nos cenários de sobrecarga do átrio direito este vetor é deslocado para frente e para a direita, resultando em aumento da amplitude da P em D2, acima de sua medida normal de 2,5 mm, sendo as letras C e D incorretas. Esta alteração gera um aspecto de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

onda apiculada, tornando a alternativa A errada. Dado que 2,5 mm representam 0,25 mV, a letra B é a única adequada. Resposta letra B.

249970.

Comentário: Apesar dos dados da literatura acerca das paradas cardiorrespiratórias em ambiente extra hospitalar serem pobres, sabemos que os ritmos de parada mais frequentes são a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular, alcançando 80% dos eventos. Por se tratarem de ritmos chocáveis, há um grande índice de reversão em pacientes prontamente tratados, tendo o desfibrilador externo automático (DEA) um papel essencial nesse contexto, resultando em uma sobrevida superior a 50%. Gabarito Alternativa A.

215593.

Comentário: Para a adequada abordagem e manutenção dos pacientes em ventilação mecânica domiciliar, deve-se disponibilizar - Reanimador Manual (Ambu). - Aspiradores de secreção a vácuo - Oxímetro de pulso portátil, conforme avaliação de necessidade a ser julgada pela equipe de atendimento domiciliar - Cilindro de oxigênio com umidificador, fluxômetro, extensões, máscaras e catéteres nasais - Materiais de reserva para intercorrências - Cânulas de traqueostomia (diâmetro menor que a utilizada) - Sondas de aspiração - Circuito ventilatório de reserva. Resposta letra B.

215568.

Comentário: O suporte ventilatório em caráter domiciliar é um grande obstáculo a ser vencido tanto no serviço privado, nos embates com os planos de saúde, quanto no serviço público, em que temos que remar contra a morosidade do sistema. Independente de onde estivermos trabalhando, ao escolher uma modalidade ventilatória para o paciente utilizar em domicílio, devemos responder algumas perguntas O paciente tem estrutura familiar, domiciliar e seguimento assegurado pela equipe de saúde (A correta). O paciente tem condições clínicas de ir para casa sem suporte ventilatório (B correta). O paciente conseguirá se adaptar ao ventilador domiciliar (D correta). Todas estas questões devem ser abordadas antes da alta do paciente. No entanto, é de suma importância que o paciente esteja realizando fisioterapia motora e respiratório durante TODO o processo de internação e não quando decidirmos pela alta. A ideia é preparamos este paciente para alta com

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

suporte. Resposta C.

181186.

Comentário: O paciente afogado deve, sempre, ser colocado em monitorização, com avaliação de saturação de O2, frequência cardíaca e medidas de pressão arterial. Além disso, é necessário controle com gasometrias e avaliação do sensório. Resposta, portanto letra B.

181192.

Comentário: As vítimas de afogamento frequentemente necessitam de cuidados médico-hospitalares após o evento agudo. No entanto, na avaliação desses pacientes, alguns cuidados devem ser considerados A lesão cerebral ocorre por dois mecanismos, um precoce, durante a submersão, resultando em lesão mínima, e outro tardio, secundário a alterações metabólicas que devem ser identificadas precocemente e tratadas, tais como febre, hipotensão, crise convulsiva, hipóxia e distúrbios eletrolíticos (alternativa A correta). Quanto ao desenvolvimento de infecções pulmonares após o afogamento, a radiografia isoladamente não deve fornecer o diagnóstico (alternativa B correta), uma vez que a água que alcança os alvéolos pode ser confundida radiograficamente com consolidação pneumônica. Portanto, a análise clínica, laboratorial e radiológica, de forma conjunta, deve guiar o início do tratamento antimicrobiano (alternativa D correta). Gabarito Alternativa C.

181195.

Comentário: Questão tranquila que nos pergunta qual das opções não corresponde a uma medida de prevenção de afogamentos. Percebam, portanto, que as letras B, C e D estão corretas e são conceituais. Entretanto, a letra A não. Vamos lembrar que a maioria dos afogamentos acontece justamente em quem se julga habilitado e com boa capacidade para o nado. Lembrem-se a confiança pode ser uma grande armadilha. Resposta letra A.

181147.

Comentário: Questão sobre afogamento. Letra A Pelo contrário. Em áreas sem salva-vidas os afogamentos são mais graves. INCORRETA Letra B Pessoas sem treinamento devem priorizar a solicitação de ajuda, em lugar de tentar ajudar, minimizando os riscos ao indivíduo afogado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

INCORRETA Letra C Compressões torácicas nunca devem ser realizadas na água. Afinal, é essencial uma superfície rígida por trás do paciente. CORRETA Letra D A imobilização cervical deve ser feita com parcimônia. Separando cada caso de acordo com a dinâmica do acidente. INCORRETA Resposta letra C.

157591.

Comentário: Vamos analisar as assertivas em relação à anticoagulação em pacientes com fibrilação atrial. A. Correta. Pela estase sanguínea atrial, existe um risco importante de formação de trombo no átrio esquerdo (em torno de 10-15%), especialmente no apêndice atrial esquerdo. Daí a necessidade de instituirmos a terapia antitrombótica na maioria dos pacientes com FA, visando à prevenção dos eventos tromboembólicos, principalmente o AVE isquêmico. B. Correta. A escolha do anticoagulante warfarina ou novos anticoagulantes orais (NACOs) não faz grande diferença nos desfechos do paciente. É importante que o paciente tenha boa adesão e saiba dos cuidados necessários ao tomar tais medicamentos (ex. interações medicamentosas e com alimentos da warfarina necessidade de acompanhamento do INR). C. Incorreta. Embora o alvo terapêutico da warfarina seja de fato um INR de 2,0-3,0, após estabelecimento da dose que mantém esse alvo, o paciente pode fazer controles mais espaçados (ex. mensalmente) não há necessidade de coletas diárias D. Correta. Os NACOs são contraindicados em pacientes com insuficiência renal - a warfarina é a preferência quando o clearance de creatinina é 30 ml min (25 ml min para o apixabana). Portanto, antes de iniciarmos os NACOs, a função renal deve ser sempre avaliada Resposta letra C

157745.

Comentário: Os efeitos colaterais mais importantes da hipotermia terapêutica (HT) estão relacionados à coagulopatia e ao aumento do risco de infecções. O surgimento da coagulopatia ocorre porque algumas enzimas e fatores da coagulação passam a atuar de forma mais lenta em temperaturas reduzidas. Além disso, a função plaquetária também encontra-se mais diminuída. A HT também induz uma disfunção leucocitária, aumentando a suscetibilidade a infecções, principalmente quando as baixas temperaturas são mantidas por mais de 24 horas. A condução

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

cardíaca se torna mais lenta, levando à bradicardia e prolongamento do intervalo QT. Alguns distúrbios metabólicos como hipocalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia e hiperglicemia (causada por resistência à ação da insulina) também podem ser observados. Resposta (A).

157704.

Comentário: A taquicardia por reentrada atrioventricular nodal é a principal taquiarritmia da infância, após a taquicardia sinusal. Logo, está errado dizer que esta entidade ganha importância na adolescência ela já é muito importante desde antes As demais assertivas são conceituais e estão corretas. Resposta certa C.

157732.

Comentário: O principal grupo de arritmias na faixa etária pediátrica é o grupo das TAQUIarritmias. As bradiarritmias são menos frequentes, aparecendo em situações específicas como aquelas citadas na letra D. Lembre-se que o grupo das bradiarritmias em geral se relaciona com distúrbios degenerativos do sistema de condução, como a doença de Lev-Lenégre , que é típica do idoso... Nas crianças, os três principais mecanismos de taquiarritmia são frequentes (1) reentrada, (2) aumento do automatismo, (3) pós-potenciais tardios. A principal forma é taquicardia sinusal, seguida pela taquicardia supraventricular por reentrada nodal (taqui supra). As taquicardias ventriculares também são frequentes, aparecendo nas cardiopatias congênitas. Resposta certa B.

157743.

Comentário: A adenosina é um inibidor do nódulo AV, e só consegue reverter taquiarritmias supraventriculares simples, como a taqui supra por reentrada nodal (A errada). O digital é um inibidor do nódulo AV e inotrópico positivo. Ele não possui ação propriamente antiarrítmica, apenas é útil para controle da frequência cardíaca em portadores de taquiarritmias supraventriculares associadas à insuficiência cardíaca (B errada). A lidocaína só é empregada no tratamento de arritmias ventriculares, e não nas supraventriculares (D errada). Enfim, a amiodarona é um dos antiarrítmicos mais utilizados na prática justamente por ser útil no tratamento das taquiarritmias tanto supraventriculares quanto ventriculares, além de ser uma medicação relativamente mais segura em comparação com a maioria dos demais antiarrítmicos (ex. pode ser usada por

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

portadores de cardiopatia estrutural). Resposta certa C.

157714.

Comentário: Vamos avaliar cada uma das assertivas a)Correta Os ritmos de fibrilação e taquicardia ventriculares são passíveis de desfibrilação elétrica durante o manejo da parada cardiorrespiratória. O choque deve ser administrado o mais precocemente possível, seguindo-se de dois minutos de massagem cardíaca externa. Somente após um ciclo completo de ressuscitação cardiopulmonar está indicada a verificação de ritmo e pulso, com aplicação de nova carga de choque em caso de manutenção de ritmo chocável. b)Incorreta A cardioversão elétrica deve sempre ser realizada com sincronização do aparelho a fim de evitarmos o fenômeno R sobre T, o qual acarreta possibilidade de degeneração da arritmia inicial para fibrilação ventricular. c)Incorreta Na desfibrilação elétrica devemos utilizar a carga máxima do aparelho disponível, sendo esta, em geral, de 360J para os monofásicos e 200J para os bifásicos. d)Incorreta Nos casos de fibrilação atrial a carga energética inicial indicada é de 100-200J, sendo habitualmente aplicados 120J. Em caso de manutenção do ritmo, um choque sequencial com nível escalonado de energia pode ser aplicado. A alterativa A é o gabarito.

157729.

Comentário: A principal diferença entre CARDIOVERSÃO e DESFIBRILAÇÃO é que a primeira é sincronizada ao QRS enquanto a segunda não... A sincronização é importante para evitar a ocorrência do fenômeno R-sobre-T , isto é, o choque de despolarização ventricular incidindo justamente durante a fase de repolarização do ventrículo, num momento em que parte do ventrículo já recuperou sua excitabilidade (saindo do período refratário) e outra parte ainda está refratária. Essa heterogeneidade eletrofisiológica cria condições para a ocorrência de reentrada ventricular, com risco de degeneração para taquiarritmias malignas, como a fibrilação ventricular (FV) - A correta... Nos desfibriladores monofásicos a energia é direcionada em apenas um sentido. Nos bifásicos a energia passa duas vezes pelo miocárdio uma ida e uma volta, graças à inversão automática das polaridades das pás. Desse modo, os aparelhos bifásicos são mais eficazes que os monofásicos, e podem utilizar energias menores - B e C corretas... Na técnica de desfibrilação o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

operador posiciona as pás com gel sobre o tórax, exercendo uma leve pressão (não é preciso aplicar uma força tão grande quanto o equivalente a 23 kg)... Resposta certa D.

157659.

Comentário: A adenosina é uma droga que bloqueia exclusivamente o nódulo AV, interrompendo as vias de reentrada que se formam nessa estrutura cardíaca na vigência da famosa taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal AV . As demais medicações atuam tanto no miocárdio atrial quanto no miocárdio ventricular. Resposta certa D.

157688.

Comentário: Temos uma taquiarritmia com instabilidade (perda da consciência baixo débito cardíaco). Logo, temos uma situação emergencial que requer eletroterapia imediata Em qual das opções citadas podemos escalonar a dose do choque, isto é, iniciamos com determinada dose e, se não funcionar, podemos tentar uma dose mais alta Trata-se da fibrilação atrial, cuja dose inicial do choque no desfibrilador monofásico é de 120-200 joules, podendo-se aumentar para doses superiores a 200 joules em caso de insucesso. Nas demais arritmias a dose inicial é 360 joules (no monofásico), devendo-se repetir o choque com a mesma dose, em caso de insucesso (não se usa mais aumentar a dose para além de 360 joules)... Resposta certa A.

157723.

Comentário: Vamos de baixo pra cima... Os ramos direito e esquerdo são estruturas infra-hissianas, logo, a presença de BAV bloqueio de ramo é indício de lesão extensa do sistema de condução, comprometendo o His-Purkinje de forma ampla (D incorreta). Os BAV de segundo grau tipo Mobitz II indicam lesão intra ou infra-hissiana e, por isso, são alterações graves, geralmente sintomáticas e de péssimo prognóstico, dado o elevado risco de evolução para BAVT e assistolia (C e B incorretas). A letra A descreve o fenômeno de Wenckebach , que caracteriza o BAV de segundo grau Mobitz I, uma lesão supra-hissiana, habitualmente assintomática, que se relaciona com aumento do tônus vagal. Resposta A.

157734.

Comentário: Em bradicardias sintomáticas, especialmente de origem sinusal ou nos bloqueios AV

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

até o segundo grau, Mobitz I, a atropina pode ser eficaz em aumentar a frequência cardíaca. Seu efeito é em bloquear o tônus do nervo vago sobre o nó sinoatrial, por isso não funciona em transplantados cardíacos (C errada), em que o coração do doador acaba sendo desnervado. Na síndrome coronariana aguda, prefere-se utilizar marca-passo para esse fim, já que a atropina pode acelerar exageradamente o coração, aumentando muito o consumo miocárdico de oxigênio (B errada). Em pacientes com bloqueios AV mais avançados e instáveis hemodinamicamente, é preferível prescrever-se dopamina ou adrenalina em bomba infusora até a chegada do marca-passo. Resposta A.

157739.

Comentário: O enunciado é impreciso, e não permite um diagnóstico específico. Logo, vamos ver, individualmente, as alternativas, procurando por aquela que expresse um conceito errado... Antagonistas de canais de cálcio não-diidropiridínicos podem restaurar o ritmo sinusal em taquiarritmias atriais, como a TAM (Taquicardia Atrial Multifocal) - A correta. A adenosina é um inibidor do nódulo AV de meia-vida muito curta (segundos), e seu efeito é causar um bloqueio transitório do NAV, o que geralmente é sentido pelo paciente como um aperto no peito e sensação de morte iminente, pois ele sente que seu coração literalmente parou de bater por alguns segundos - C correta e B errada... Na presença de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo devemos evitar as drogas que têm ação inotrópica negativa, como betabloqueadores e antagonistas de canais de cálcio (particularmente o verapamil). Para estes pacientes, os principais inibidores do nódulo AV (cujo intuito é controlar a frequência cardíaca numa taquiarritmia supraventricular, como a FA) passam a ser a amiodarona e a digoxina - D correta... Resposta certa B.

134686.

Comentário: A recomendação de permitir o retorno completo do esterno tem por finalidade garantir que o coração consegue se encher entre as compressões, de modo que, quando a compressão for novamente aplicada, exista sangue suficiente para produzir débito sistólico. Assim, esta recomendação visa otimizar o desfecho da massagem cardíaca (A errada), melhorando o retorno venoso ao coração parado (B errada). Outra vantagem fisiológica é uma melhora teórica da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

perfusão miocárdica, que só ocorre na diástole - na RCP, a diástole corresponde ao retorno do tórax (D errada). Enfim, nas manobras iniciais de RCP (isto é, no BLS) a prioridade máxima está nas compressões torácicas, e não na ventilação. O retorno completo do esterno nada tem a ver com ventilação, até porque, durante as compressões, não estamos ventilando o doente sem via aérea definitiva (lembre-se nesta fase a regra é fazer 30 compressões para duas ventilações, quer dizer, a ventilação é feita num momento em que o doente não está sendo massageado). Resposta certa C.

134684.

Comentário: O grupo de drogas antiarrítmicas com ação mais ampla é o grupo III, cujo principal representante é a amiodarona . Tais drogas bloqueiam canais de K da repolarização, aumentando a duração do potencial de ação, tanto no miocárdio atrial quanto no miocárdio ventricular. Além disso, a amiodarona bloqueia canais de sódio e exerce efeito betabloqueador, reduzindo o automatismo. Uma vantagem até mesmo em relação aos demais membros do grupo III é que a amiodarona, apesar de poder alargar o intervalo QT, raramente se associa com torsades des pointes , ou seja, trata-se de uma droga antiarrítmica de ação ampla e bastante segura, com pouco efeito pró-arrítmico . Resposta certa C.

134700.

Comentário: A amiodarona é um dos principais antiarrítmicos utilizados na prática clínica e questões sobre seus efeitos adversos com o uso crônico são clássicas. A toxicidade pulmonar é uma preocupação e se correlaciona com a dose total cumulativa os pacientes estão sujeitos a fibrose pulmonar intersticial, bronquiolite obliterante com pneumonia organizante (BOOP), dentre outras complicações desse órgão (A correta). Outro efeito comum é a disfunção tireoidiana, tanto hipo como hipertireoidismo. Distúrbios pró-arrítmicos podem ocorrer, mais comumente bradiarritmias como bradicardia sinusal e BAV (B incorreta), embora QT longo e torsades de pointes também possam estar associados. Outros paraefeitos não cardíacos da amiodarona são microdepósitos na córnea fotossensibilidade cutânea hepatite e elevação das aminotransferases sintomas gastrointestinais (anorexia, náusea e constipação) ataxia cerebelar e neuropatia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

periférica. A perversão visual tipo xantocromia (visão amarelada) é um efeito clássico da intoxicação digitálica (D incorreta). A descompensação da glicemia não é um efeito descrito (C incorreta). Alternativa correta A

139777.

Comentário: A qualidade da reanimação cardiopulmonar é determinada pelas seguintes características (1) frequência entre 100-120 por minuto (A correta e B errada) (2) depressão do esterno entre 5-6 cm (C correta e D errada) (3) permitir o retorno completo do esterno entre as compressões (4) no hands off , quer dizer, só interrompa as compressões se estritamente necessário. Logo, existem duas respostas possíveis aqui A e C. A banca ANULOU a questão após os pedidos de recurso

139785.

Comentário: A frequência das massagens está dentro do preconizado, ou seja, entre 100 e 120 por minuto. Também está dentro do esperado, a descrição do movimento, que explicita o retorno completo do tórax sem apoiar sobre ele. Dessa forma, as letras A,C e D estão erradas. Por exclusão, compreendemos que a letra B é a única opção que está correta. Ela pode estar se referindo a algum erro não descrito na aplicação da manobra (como dobrar cotovelos por exemplo) ou ao fato do socorrista responsável pela execução da manobra apresentar sinais de cansaço ou ainda, já ter transcorrido o tempo máximo preconizado para cada socorrista realizar as manobras. A diretriz recomenda que a cada 2 minutos, troque o profissional responsável pela manobra cardíaca, mesmo que o próprio negue cansaço. Essa regra visa manter o padrão de eficácia da massagem cardíaca.

111837.

Comentário: Hiperventilar um paciente durante uma parada cardiorrespiratória é um erro comum e muito grosseiro. A hiperventilação é comprovadamente maléfica na RCP e reduz a chance de retorno à circulação espontânea. Quando o paciente é hiperventilado ocorre aumento da pressão intratorácica, fazendo com que haja redução do retorno venoso e consequente diminuição do débito cardíaco. A frequência da ventilação depende da via aérea instituída. Se ventilamos o paciente de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

forma não invasiva devemos manter uma relação de 30 compressões cardíacas para 2 ventilações. Quando uma via aérea definitiva está instituída a frequência de ventilações torna-se independente da massagem cardíaca e passa a ser de 8-10 por minuto. Letra C correta.

350882.

Comentário: Vamos analisar as assertivas a respeito de medidas preventivas do afogamento na Pediatria. Letra A incorreta. As boias de ar não devem ser usadas no lugar dos coletes salva-vidas, pois podem desinflar, furar, sair e não são projetadas para manter os nadadores seguros. Por outro lado, os coletes salva-vidas comprovadamente previnem mortes por afogamento. Devem ser certificados de acordo com a NORMAM (Norma de Autoridade Marítima da Marinha do Brasil) e SOLAS (Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar). Letra B correta. A instalação de grades e cercas de proteção previne mais de 50% dos afogamentos em piscina. As grades e as cercas devem ser instaladas em torno de toda a piscina, com no mínimo 1,5m de altura e portões com fechamento e travamento automáticos, impedindo assim o seu acesso às crianças. Coberturas retráteis ou redes de piscina, que suportam o peso das crianças, são descritas como barreiras eficazes para prevenção de afogamento, entretanto não devem ser usadas como substitutos de grades e cercas de proteção. Letra C incorreta. Alguns dados revelam que as aulas de natação podem diminuir as taxas de afogamento entre crianças de 1 a 4 anos de idade. Porém, alguns estudos mostram que as aulas de natação dão uma falsa sensação de segurança, levando a uma supervisão inadequada dos pais sobre seus filhos. Aprender a nadar deve ser visto como um componente da competência na água que inclui conhecimento e consciência dos perigos e ou riscos locais e de suas próprias limitações, uso do colete salva-vidas e habilidade para reconhecer e responder a um nadador em perigo. As crianças precisam ser ensinadas a nunca nadar sem supervisão de um adulto. Letra D incorreta. A supervisão inadequada é frequentemente citada como um fator contribuinte para afogamento na infância, principalmente nos menores, que não sabem nadar. A supervisão deve ser próxima, constante e atenta, mesmo que um salva-vidas esteja presente. Resposta letra B.

321298.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O eletrocardiograma mostra uma taquicardia de QRS estreito, sem onda P e com ritmo irregular (observando o DII longo, percebemos um intervalo R-R que varia a cada batimento cardíaco). Estamos diante de uma fibrilação atrial (FA). Nesse sentido, a primeira pergunta a ser feita é existe instabilidade hemodinâmica Dizemos que sim na presença de qualquer um dos fatores a seguir (1) rebaixamento do nível de consciência ou síncope (2) hipotensão arterial sintomática (3) edema agudo de pulmão (ou descompensação da IC) (4) dor torácica anginosa. Uma PA de 90x50 mmHg em um paciente previamente hipertenso já é capaz de definir instabilidade. No paciente com FA e instabilidade hemodinâmica, devemos reverter a arritmia com cardioversão elétrica emergencial. O choque deve ser sincronizado (é uma cardioversão, não uma desfibrilação) com carga inicial de 120-200 J (se bifásico) ou 200 J (se monofásico). Como não dá tempo de anticoagular por três semanas ou de fazer um ECO transesofágico, o paciente deve apenas ser heparinizado junto com a reversão e anticoagulado por, no mínimo, quatro semanas após, seguido da terapia anticoagulante crônica apropriada de acordo com o grupo de risco. Pelo escore CHADS-VASC, a idade e a hipertensão arterial já indicam a necessidade de anticoagulação ad aeternum . A manobra vagal, colocada na letra A, pode ser empregada em pacientes com taquicardia supraventricular paroxística, não sendo tradicionalmente usada na FA. Não há nada no enunciado também que sugira DPOC, embora o paciente seja tabagista. O hipertireoidismo, citado na letra D, pode até ser fator desencadeante de FA, mas a conduta citada nessa alternativa não pode ser considerada correta. Resposta letra B.

321313.

Comentário: Nosso paciente apresenta traçado compatível com uma TV polimórfica em particular a torsades de pointes (repare que a polaridade do QRS muda a toda hora, dando a impressão de que alguém torceu o eletrocardiograma em suas pontas). Qual seria o substrato arritmogênico aqui É importante lembrar que o alargamento do intervalo QT é condição sine qua non para a gênese dessa arritmia (inclusive, a ausência de documentação do prolongamento do QT inviabiliza afirmar que se trata de uma torsades de pointes) mas por que nosso paciente fez um QT longo Atenção ao uso de haloperidol, um dos muitos medicamentos relacionados a prolongamento do intervalo QT.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Pois bem, qual deve ser a nossa conduta imediata Diante de um paciente com claros sinais de instabilidade, devemos seguir com desfibrilação cardíaca. Não faremos uma cardioversão elétrica, ou seja, o choque NÃO é sincronizado. Sincronizar significa colocar o choque bem em cima da onda R do complexo QRS... mas aqui o traçado é muito bagunçado, motivo pelo qual precisamos de um choque dessincronizado Entenda que sulfato de magnésio faz parte da nossa conduta... inclusive, a literatura até cita que o medicamento entra até JUNTO com o choque, mas como a banca coloca que quer a melhor conduta, precisamos concordar que o choque é prioritário. A banca liberou a letra C como gabarito inicial, mas trocou para a letra D após pedidos de recurso. Resposta letra D.

292822.

Comentário: A questão traz paciente de 70 anos com história recente de acidente vascular encefálico (AVE) de etiologia cardioembólica, associado a fibrilação atrial (FA) diagnosticada na investigação subsequente. Neste caso, o principal cuidado em relação à profilaxia secundária, isto é, evitar episódios subsequentes de AVE cardioembólico, é iniciar a anticoagulação oral, que em geral é avaliada pelo escore CHA 2 DS 2 -VASC. No entanto, há um detalhe importante no caso trata-se de paciente com história de implante de válvula metálica no passado. Todo paciente com prótese mecânica cardíaca já tem, por si só, risco tromboembólico aumentado e, ainda que o paciente não tivesse o diagnóstico recente de FA, ele já deveria estar em uso de anticoagulante oral para prevenir o PRIMEIRO episódio de AVE, isto é, profilaxia PRIMÁRIA O AAS e o clopidogrel são agentes antiplaquetários muito pouco efetivos em reduzir o risco tromboembólico e por isso NÃO recomendados rotineiramente para esse fim (LETRAS A e B INCORRETAS). Os agentes orais de ação direta, incluindo os inibidores do fator Xa (ex. apixabana, rivaroxabana) ou inibidores da trombina (ex. dabigatrana), são as drogas consideradas de PRIMEIRA LINHA como anticoagulantes orais na maioria dos cenários clínicos, devido à sua boa eficácia e praticidade em termos de não necessidade de monitorização dos valores de INR. No entanto, pacientes portadores de válvula metálica como no caso da questão NÃO possuem aprovação para o uso dos anticoagulantes de ação direta, uma vez que não há estudos clínicos que comprovem a sua

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

eficácia e segurança nesse contexto (LETRA C INCORRETA). O anticoagulante oral de escolha passa a ser o antagonista da vitamina K, mais especificamente a WARFARINA, que no cenário em tela servirá como profilaxia SECUNDÁRIA de futuros episódios de AVE, tanto pela presença de válvula, como pela presença de FA. No entanto, há dois problemas na questão (1) Em pacientes de elevado risco cardioembólico como este, o ideal é que não se perca tempo até o que a warfarina inicie sua ação terapêutica, o que depende do INR no alvo terapêutico em torno de 3,0 e pode demorar alguns dias. Enquanto isso, o paciente deve iniciar heparina de baixo peso molecular subcutânea (ex. enoxaparina) para que haja anticoagulação imediata (com suspensão da heparina após). (2) O paciente possui problemas importantes de adesão medicamentosa, o que gera dúvidas quanto à segurança da liberação do uso crônico de warfarina neste idoso, já que é uma droga com potenciais riscos, tanto pela subdose (falta de anticoagulação) como dose supraterapêutica (risco de hemorragia). Por tais problemas, podemos ver que a questão se construiu em um cenário hipotético ruim e com diversos pontos que a tornaram incorreta e fizeram com que a banca do concurso a anulasse.

292823.

Comentário: O quadro clínico é de paciente de 56 anos, hipertensa, diabética, há três dias com taquicardia (FC 140 bpm) e eletrocardiograma compatível com o diagnóstico de fibrilação atrial taquiarritmia, ausência de ondas P e intervalos R-R irregulares. Como há estabilidade hemodinâmica, a primeira estratégia terapêutica a ser adotada é tratar os sintomas por meio do controle da frequência cardíaca . A droga mais indicada para isso é o betabloqueador , como metoprolol, propranolol ou esmolol, por via endovenosa. O uso de bloqueador de canal de cálcio como verapamil ou diltiazem é uma alternativa. Além disso, está indicada a anticoagulação crônica pela presença de um escore CHA2DS2-VASC 3 pontos. Vamos revisar esse escore insuficiência cardíaca (1 ponto) hipertensão arterial (1 ponto) idade 75 anos (2 pontos) diabetes (1 ponto) AVE, AIT ou tromboembolismo (2 pontos) doença vascular infarto do miocárdio, doença arterial prévia, placa aórtica (1 ponto) idade 65 74 anos (1 ponto) sexo feminino (1 ponto). Escore 2 em homens ou 3 em mulheres indica anticoagulação. Como a paciente possui três pontos (sexo feminino 1 ponto

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

hipertensão 1 pontos diabetes 1 ponto), não há dúvidas de que se indica a anticoagulação (LETRA C correta). Uma opção dentro do manejo da FA recém-diagnosticada é tentar revertê-la para o ritmo sinusal por meio do uso de antiarrítmicos como amiodarona ou cardioversão elétrica. No entanto, tal conduta deve ser realizada apenas APÓS o controle inicial da frequência cardíaca com betabloqueadores e anticoagulação por no mínimo três semanas ou exclusão de trombos cardíacos por análise com ecocardiograma transesofágico (LETRAS A, B e D incorretas). Resposta letra C.

234032.

Comentário: Temos um paciente com estenose mitral associada à fibrilação atrial. A abordagem da questão é sobre a anticoagulação desse paciente, que deve ser realizada ambulatorialmente com warfarin, independentemente do CHA2DS2VASc, visto que se trata de fibrilação atrial de etiologia valvar, estando contraindicados os anticoagulantes orais de ação direta. Vamos aproveitar essa questão para lembrar que apesar de a gravidade anatômica da valvopatia ter sido definida como moderada, a presença de fibrilação atrial de início recente representa um complicador da valvopatia, estando indicada a abordagem cirúrgica. Gabarito alternativa B.

199664.

Comentário: Seja qual for o tipo de afogamento, o órgão alvo de maior comprometimento é o pulmão A aspiração de água promove insuficiência respiratória e consequentes alterações na troca gasosa alvéolo-capilar, além distúrbios no equilíbrio ácido-base. As alterações fisiopatológicas que ocorrem dependem da composição e da quantidade de líquido aspirado. A aspiração de ambos os tipos de água promove alveolite, edema pulmonar não cardiogênico e aumento do shunt intrapulmonar, que levam à hipoxemia. O edema cerebral é uma possível consequência em curto prazo, mas a encefalopatia é a manifestação cardinal relacionada ao SNC. Esta é a causa mais comum de morbimortalidade em hospitalizados afogados. Melhor resposta letra D.

150870.

Comentário: Pelo CHA^2DS^2VASc esse paciente pontuaria 2, hipertensão e doença vascular, o que já indicaria anticoagulação e não antiagregação. A doença vascular está caracterizada pelo índice tornozelo-braquial menor que 0,9 ou maior que 1,3. Se o escore fosse 1, poderíamos avaliar as

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

duas terapias . No entanto, no enunciado há a indicação de que o paciente não procura o serviço de saúde, mora em área rural de difícil acesso, apresenta função renal alterada e história atual de abuso de álcool, ou seja, inúmeros fatores que indicam risco muito aumentado de sangramento e de complicações graves em caso de sangramento. Essa questão foi muito polêmica, pois pelo escore o paciente deveria ser anticoagulado, mas a banca compreendeu que devido às questões sociais, a dupla anti-agregação seria o melhor tratamento. Dessa forma, a banca considerou como resposta letra C, mas a equipe do Medgrupo acredita que a letra D também está correta.

102088.

Comentário: Estamos na emergência diante de uma paciente idosa, hipertensa, com taquiarritmia de pulso irregular, FC em torno de 150 bpm e o mais importante instabilidade hemodinâmica A taquiarritmia mais comum nesta faixa etária (e na população geral) e que vem a ser o diagnóstico mais provável é a fibrilação atrial. Infelizmente a banca não forneceu o traçado eletrocardiográfico, mas é bastante provável que esta paciente seja portadora de FA. Como sabemos, FA mais instabilidade hemodinâmica é igual à cardioversão elétrica imediata. Resposta D.

81319.

Comentário: Olhando a prescrição deste paciente, o primeiro item que nos salta aos olhos considerando que se trata de um IDOSO é a dose elevada de digoxina que ele está usando. Sabemos que a digoxina é uma das drogas com menor índice terapêutico da prática médica (lembre-se índice terapêutico diferença entre a dose terapêutica e a dose tóxica). Inclusive, referências em geriatria e atenção primária sugerem que a digoxina nunca seja utilizada em doses superiores a 0,125 mg dia nesses pacientes, pois diversos estudos evidenciaram que acima dessa dose a digoxina representa uma das principais causas de iatrogenia farmacológica em idosos. Como ele necessita utilizar digoxina, seria interessante também retirar a hidroclorotiazida. Sabemos que um dos principais fatores de risco para intoxicação digitálica é a hipocalemia, já que a digoxina atua na bomba de sódio e potássio competindo pelo sítio de ligação do potássio. Na vigência de hipocalemia, por conseguinte, o efeito digitálico é exacerbado, o que em idosos se acompanha de grande probabilidade de provocar intoxicação. Como o paciente é portador de ICC, o ideal,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

inclusive, é que ele esteja em uso de furosemida (diurético de alça). Lembre-se de que a furosemida também pode causar hipocalemia, no entanto, o risco é bastante inferior quando comparada à hidroclorotiazida. Resposta certa C.

65699.

Comentário: A questão aborda um idoso que apresenta uma das principais síndromes geriátricas instabilidade queda. Vamos avaliar as alternativas A ERRADA a furosemida não é considerada um fator de risco independente para queda e, nesse caso, ainda é um medicamento importante para as doenças de base do idoso. B ERRADA obviamente, os protetores pélvicos (pequenos dispositivos acolchoados na parte lateral da vestimenta) reduzem o risco de fraturas femorais. C e E ERRADAS as atividades instrumentais são aquelas que permitem ao idoso uma vida mais independente, como usar o telefone, fazer compras, preparar a própria refeição, arrumar a casa, executar pequenas tarefas domésticas. A realização de exercício físico, preferencialmente com a supervisão de profissional habilitado, consegue fortalecer a musculatura, melhorando o equilíbrio e a marcha, aspectos fundamentais na prevenção de queda. D CERTA naturalmente, a queda pode ter sido provocada apenas por instabilidade postural, mas a hipótese de síncope não pode ser ainda excluída.

51234.

Comentário: A cirurgia de tireoidectomia total carrega um risco da retirada concomitante das glândulas paratireoides. Sem elas, o paciente desenvolve hipocalcemia, cuja umas das manifestações clínicas pode ser o Sinal de Trousseau, onde se observa um espasmo carpal após aplicação do esfigmomanômetro de pressão cerca de 20 mmHg acima da pressão sistólica por 3 minutos. Com relação ao comportamento eletrocardiográfico, uma hipocalcemia pode causar aumento do intervalo QT. Resposta Letra D.

51259.

Comentário: Questão clássica O ECG nos mostra um traçado de fibrilação atrial com alta resposta ventricular (taquicardia, ausência de ondas P e ondas F, complexos QRS estreitos, intervalos RR irregularmente irregulares). Até aí nenhuma surpresa, uma vez que se trata de paciente idoso e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

previamente hipertenso (grupo com alta prevalência de FA) Mas como o paciente está francamente INSTÁVEL (edema agudo de pulmão, dor torácica anginosa) é mandatório proceder à cardioversão elétrica sincronizada, com o objetivo de abortar a FA, não esquecendo, é claro, de sedar o paciente antes da aplicação do choque. Resposta A.

30842.

Comentário: Sabemos que a síndrome metabólica (SM) agrupa um conjunto de fatores associados primordialmente à resistência insulínica e, por conta disso, à hiperinsulinemia, hiperglicemia, obesidade abdominal, alterações lipídicas e elevação dos níveis pressóricos. Graças à liberação de citocinas pelas células adiposas acumuladas, desenvolve-se disfunção endotelial, inflamação vascular e aterosclerose, daí a relação da síndrome como fator de risco para doenças cardiovasculares (risco 2,5 vezes maior). Além destas clássicas relações, a SM também está associada a (1) hiperuricemia e gota (2) distúrbios do sono (3) doença renal crônica (4) síndrome do ovário policístico (5) declínio cognitivo e demência e (6) doença hepática gordurosa. Sendo assim, percebemos que temos aqui duas respostas possíveis disfunção endotelial e esteatose hepática. Inicialmente a banca optou pela letra (A), mas depois da fase de recursos, reconsiderou e tornou a opção E também correta.

32514.

Comentário: Questão clássica. Na síndrome de Wolf-Parkinson-White existe uma curiosa predisposição à fibrilação atrial (10-30% dos doentes desenvolvem esta taquiarritmia), que com frequência aparece de forma paroxística num coração sem outras alterações estruturais. O grande problema da FA na SWPW é a degeneração para fibrilação VENTRICULAR, o que pode ser facilitado caso o doente faça uso de drogas inibidoras do nódulo AV (a inibição da condução AV favorece a condução pela via acessória). Por conseguinte, devemos evitar drogas controladoras da FC como os betabloqueadores, antagonistas do cálcio e o digital. A droga de escolha para reverter a FA no paciente com SWPW é a procainamida, e em segundo lugar temos a ibutilida. A amiodarona também pode ser usada, mas como última opção (pois também pode bloquear o nódulo AV). Logo, resposta certa A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

32528.

Comentário: O antídoto de primeira linha para tratar a intoxicação por betabloqueadores é o glucagon (que deve ser ministrado em bolus IV de 5 mg durante 1 minuto, seguido de infusão contínua a 2-5 mg h, objetivando manter a PAM em torno de 60 mmHg) O glucagon consegue estimular a adenilato-ciclase intracelular a despeito do bloqueio desta enzima pelo excesso de betabloqueadores. A adenilato-ciclase é responsável pela formação do AMP cíclico intracelular, um importante segundo mensageiro que estimula, entre outros eventos, a liberação de cálcio no citoplasma das células musculares lisas durante o ciclo de despolarização contração. Os sais de cálcio (gluconato ou cloreto) também podem ser usados para tratar a intoxicação por BB, porém, são considerados agentes de segunda linha, reservados aos casos de não resposta ao glucagon (quando então são associados a este último). Resposta certa B.

36981.

Comentário: Vamos lá Mulher jovem, 25 anos, com queixa de palpitação e com um ECG sem evidência de onda P e ritmo irregular. Que arritmia é essa FIBRILAÇÃO ATRIAL. Agora, por que uma mulher jovem apresenta um quadro de FA O autor da questão já excluiu para a gente uma das principais causas uso de drogas ilícitas e ainda nos dá uma pista ela é portadora de vitiligo, uma doença autoimune geralmente associada a uma série de outras doenças. Bom, concluindo o raciocínio Mulher jovem com FA sem uso de drogas ilícitas portadora de doença autoimune HIPERTIREOIDISMO, POR PROVÁVEL DOENÇA DE GRAVES. Portanto, melhor resposta, item B.

37640.

Comentário: Veja bem, a banca deu como gabarito a letra D, do que não discordamos NÃO há qualquer contraindicação à utilização concomitante de heparina e warfarin, pelo contrário De um modo geral, o paciente deve começar a anticoagulação com heparina, a fim de se proteger do efeito pró-trombótico inicial do warfarin Lembre-se de que, antes de reduzir a síntese dos fatores de coagulação vitamina K dependentes, o warfarin reduz a síntese dos fatores anticoagulantes vitamina K dependentes (proteína C e proteína S), o que explica este efeito pró-trombótico inicial...

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Se o motivo da anticoagulação for uma trombose aguda (ex TVP) é mandatório iniciar com heparina, e só introduzir o warfarin quando tivermos certeza de que o paciente está devidamente anticoagulado (ex se a heparina for enoxaparina, uma heparina de baixo peso molecular, assumimos que o paciente está plenamente anticoagulado após a primeira dose de 1 mg kg SC)... Se o motivo for um risco aumentado de trombose embolia (ex FA crônica assintomática) é aceitável começar a anticoagular direto com warfarin (ex prescrever warfarin isolado a um paciente ambulatorial)... Pois bem, mas então qual é o problema da questão Ora, a letra C está claramente incorreta... A dose inicial de warfarin deve ser empiricamente selecionada com base numa avaliação individualizada do paciente. A literatura descreve doses inciais de 2 mg até 10 mg, e a escolha por uma dose específica deve levar em conta fatores como a provável taxa de metabolização da droga (ex usuários de fenobarbital necessitam de doses mais altas de warfarin, por maior metabolização da droga secundária à indução do citocromo P 450 no fígado), o aporte de vitamina K na dieta e fatores de risco para sangramento (ex idade avançada). Para a maioria dos pacientes exceto idosos, hepatopatas, indivíduos desnutridos ou portadores de ICC grave ou outros fatores para sangramento a dose inicial preconizada é 5 mg dia. Doses entre 5 e 10 mg (ex 7,5 mg), podem ser ministradas quando o paciente tem história prévia de anticoagulação com altas doses de warfarin ou quando há obesidade importante. De um modo geral, não se recomenda iniciar a anticoagulação oral com warfarin em doses acima de 10 mg dia... Logo, existe sim diferença no risco de excesso de anticoagulação e sangramento iatrogênico com a dose inicial de warfarin, bem como existe diferença no risco de eventos tromboembólicos induzidos pelo efeito pró-trombótico da droga (doses mais altas reduzem mais intensamente os fatores anticoagulantes dependentes de vitamina K, exacerbando o período pró-trombótico inicial)... Gabarito oficial D.

GABARITO MEDGRUPO C D.

30871.

Comentário: Um ruflar diastólico representa o sinal mais clássico da estenose mitral. Trata-se de um sopro meso ou holodiastólico, localizado no ápice (foco mitral), de baixa frequência (melhor audível com a campânula do estetoscópio e em decúbito lateral esquerdo), sem irradiação. O sopro

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

se exacerba ao esforço físico e se reduz ao handgrip , manobra de Valsalva e inspiração profunda. A concomitância de hiperfonese de B1 corrobora o diagnóstico, sendo decorrente do súbito tensionamento dos folhetos valvares durante a sístole, uma vez que esses folhetos estão sendo empurrados contra um átrio esquerdo hipertenso e sobrecarregado . A onda P de duração prolongada (isto é, entalhada na derivação D2, como se houvesse uma onda P para cada átrio direito e esquerdo) e o famoso sinal de Morris (onda P bifásica em V1, com o componente negativo 1 quadradinho) são evidências eletrocardiográficas típicas de sobrecarga do átrio esquerdo, achado esperado na estenose mitral. Por fim, a queixa de palpitação também é condizente com o quadro, uma vez que a sobrecarga atrial induzida pela estenose mitral com frequência produz instabilidade elétrica do miocárdio naquela região e posterior degeneração para fibrilação atrial (que pode ser intermitente ou permanente em particular quando o átrio está aumentado, com mais de 4 cm de diâmetro). Resposta certa E.

24299.

Comentário: Questão mal-feita e maldosa, por não exigir do aluno nenhuma forma de raciocínio, pelo contrário aqueles que raciocinaram acabaram se confundindo É claro que a rabdomiólise é uma causa de hipercalemia de início rápido, inclusive desproporcional ao grau de injúria renal. A insuficiência renal aguda, inquestionavelmente, é outra causa de hipercalemia de início rápido Mas como o que vale nos concursos de residência é o que está escrito nas referências, e como esta questão caiu na parte de cirurgia da prova do IJF, temos que marcar a letra C por um simples motivo está escrito no Sabiston (cap. 5, pág. 77) que a injúria renal aguda é a principal causa de hipercalemia de início agudo . Resposta certa letra C. Só uma observação não existe nenhuma classificação da hipercalemia em relação ao tempo de seu aparecimento, isto é, nenhum livro sistematiza o conceito de hipercalemia hiperaguda , aguda , subaguda ou crônica Não perca mais seu tempo com essa questão.

24358.

Comentário: A morte súbita cardíaca é definida como o óbito decorrente de parada cardíaca que ocorre até 1 hora após a primeira alteração do estado clínico que prenunciou o início do evento

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

clínico final e a própria parada cardíaca. Segundo a última edição de Harrison, até 80% dos casos de morte súbita cardíaca são decorrentes da doença arterial coronariana Em 10 a 15% dos casos a etiologia é uma miocardiopatia e em 5 a 10% dos casos outras etiologias. Entretanto, quando levamos em conta só os adolescentes e adultos jovens, a síndromes arrítmicas hereditárias (Brugada, QT longo, etc) são as causas mais comuns... A Síndrome de Brugada é uma entidade com transmissão autossômico dominante caracterizada por padrão pseudo-BRD supradesnível de ST nas derivações V1, V2 e V3 propensão à fibrilação ventricular espontânea e ausência de cardiopatia estrutural. Esta síndrome é bem mais comum no sexo masculino e nos indivíduos de origem asiática. Estes pacientes possuem um defeito nos canais de sódio de alguns miócitos (principalmente do VD) que predispõe à arritmias. A Síndrome de Wolff-Parkinson-White é uma das causas mais comuns de morte súbita em pacientes jovens. Os pacientes com esta síndrome apresentam uma via acessória com período refratário curto que predispõe a episódios de fibrilação atrial paroxística. Há risco de geração de uma Taquicardia de QRS alargado com posterior degeneração para FV se os impulsos passarem todos pela via acessória rápida. A Síndrome do QT longo congênita apresenta 7 subtipos, sendo três mais importantes. Tipo 1 de transmissão autossômico dominante, onde há um defeito genético no canal de potássio lento que pode ou não associar-se à surdez congênita (que neste caso é chamada de Síndrome de Jervell-Lange-Nielsen) Tipo 2 onde o problema está no canal de potássio rápido e Tipo 3, que possui um defeito de inativação do canal de sódio... Lembre-se que o intervalo QT mede o período refratário dos miócitos ventriculares e quando os miócitos ficam despolarizados por muito tempo, podem surgir pequenos picos transitórios de despolarização (pós-potenciais precoces) que eventualmente podem gerar uma extrassístole ventricular. Vários estímulos surgindo podem dar origem a uma TV não sustentada e se houver uma dispersão importante de períodos refratários no miocárdio ventricular pode surgir um circuito de reentrada funcional gerando uma TV polimórfica. Resposta Letra D.

24323.

Comentário: Questão basal... A hipercalemia produz um padrão progressivo de alterações eletrocardiográficas, de acordo com a gravidade e a rapidez de instalação (figura). A primeira

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

alteração é a diminuição do intervalo QT, associada a uma onda T alta e apiculada . A explicação é a repolarização ventricular precoce. Em seguida, a lentificação da condução miocárdica manifesta-se com o aplainamento da onda P e o alargamento do QRS. No final, a onda P desaparece, tornando o ritmo semelhante a um ritmo idioventricular (dando a impressão que o estímulo se origina abaixo do nódulo AV, sem ativação atrial). Entretanto, o ritmo continua a ser sinusal, porém, sem atividade miocárdica atrial (acredita-se que existam vias internodais ligando os nódulos sinoatrial a atrioventricular, que seriam as responsáveis por tal fenômeno). Este é o denominado ritmo sinoventricular . Listamos, por ordem de gravidade, as principais alterações eletrocardiográficas da hipercalemia a) Redução do intervalo QT, com ondas T altas e apiculadas b) Achatamento da onda P c) Alargamento do QRS d) Desaparecimento da onda P. Logo, resposta certa A.

25326.

Comentário: A manobra mostrada é a manobra de Heimlich. Trata-se do melhor método pré-hospitalar para desobstrução das vias aéreas por corpo estranho. Para menores de 1 ano, deve-se posicionar o bebê em prono, sobre o antebraço da pessoa que executa a manobra, a qual deve lhe aplicar 5 pancadas com a região inferior da palma da mão no dorso caso o corpo estranho não seja removido com a manobra inicial, posicionar a criança em posição supina, colocando 2 dedos no centro do esterno e pressionando na direção anteroposterior, apontando para a via aérea superior. Nos pacientes adultos esta manobra é realizada na posição supina através de uma compressão abdominal... A pessoa a aplicar a manobra deverá posicionar-se atrás da vítima, fechar o punho e posicioná-lo com o polegar para dentro entre o umbigo e o osso esterno. Com a outra mão, deverá segurar o seu punho e puxar ambas as mãos em sua direção, com um rápido empurrão para cima e para dentro a partir dos cotovelos. Deve-se comprimir a parte superior do abdomen contra a base dos pulmões, para expulsar o ar que ainda resta e forçar a eliminação do bloqueio. É essencial repetir-se a manobra acerca de cinco a oito vezes. Cada empurrão deve ser vigoroso o suficiente para deslocar o bloqueio Resposta Letra B.

13406.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A causa mais comum de morte súbita em portadores de doença coronariana (que era o que esse paciente com importantíssimos fatores de risco provavelmente tinha) é a fibrilação ventricular. Mas como explicar o encontro de ASSISTOLIA no ECG Ora, sem nenhuma manobra de ressucitação cardiopulmonar, após alguns minutos a FV naturalmente degenera para assistolia... Inclusive este é um dos sinais mais sugestivos de que a chance de sobrevida de um paciente em PCR realmente já passou Agora é muito importante que você tenha claro em sua mente (se você está em dúvida vale a pena dar uma revisada no tópico atestado de óbito , no material de preventiva) a entidade parada cardíaca nunca deve ser considerada a causa mortis em nenhuma hipótese...

9060.

Comentário: A avaliação diagnóstica dos casos de síncope é um verdadeiro desafio clínico. Com frequência nenhuma alteração é detectada no primeiro encontro com o médico, pois muitas de suas etiologias são essencialmente fenômenos episódicos, não deixando qualquer pista no período entre as crises... O passo crucial da avaliação que serve como guia para a conduta subsequente é a realização de história e exame físico completos. A principal pergunta que devemos nos fazer é se o paciente tem algum problema cardíaco... Um exame complementar que TODOS os pacientes devem ter é o ECG, o qual muitas vezes demonstra a existência de transtornos de base no sistema de condução (bloqueios de ramo, bloqueio AV)... O que acabamos de citar é o básico do básico, aquilo que deve ser obtido em todos os casos de síncope. E é justamente isso que o enunciado nos fornece A partir daí, os passos seguintes serão razoavelmente variáveis, na dependência dos principais achados dessa etapa inicial... Fato é que o paciente usa amiodarona há 5 anos por apresentar aquele famoso probleminha no coração No momento não temos como saber o que é isso, pois o paciente não sabe informar especificamente... Quando o paciente aparenta possuir, de fato, um problema cardíaco, dois exames complementares que devem ser obrigatoriamente solicitados (após o ECG), são a monitorização eletrocardiográfica ambulatorial o famoso HOLTER-24h e o Ecocardiograma... O tilt test seria uma alternativa se o doente não tivesse dados que sugerissem a existência de cardiopatia, mas mesmo no doente cardiopata o tilt test também é

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com frequência realizado Mas não podemos marcar a letra B, porque segundo os principais livros de medicina interna, NO PACIENTE CARDIOPATA OU PROVAVELMENTE CARDIOPATA é obrigatório solicitar um Holter-24h, ao passo que nem sempre solicitaremos um tilt test ... Exames de avaliação neurológica (como angiorressonância cerebral e eletroencefalograma) não costumam ter indicação de rotina na avaliação da síncope, pois (guarde bem essa regra prática) a imensa maioria dos casos de síncope não tem etiologia neurológica (basicamente todos os doentes têm algum distúrbio cardiovascular).

8844.

Comentário: Questão clássica... Se o átrio está fibrilando , ele não tem a menor possibilidade de produzir uma contração coordenada e efetiva... Ora, o que é a B4 Não é justamente o som produzido pela contração atrial jogando o sangue no interior de um ventrículo duro Pois bem é impossível haver FA e B4 ao mesmo tempo

13407.

Comentário: Vamos começar a questão calculando o eixo médio de despolarização ventricular. Lembre-se de que, quando o vetor de despolarização ventricular caminha em direção a um eletrodo, temos um QRS positivo naquela derivação. Por outro lado, se o vetor estiver se afastando desse eletrodo, o QRS será negativo. E ainda se o eixo da derivação e o eixo do vetor formarem um ângulo de 90º entre si, teremos um QRS isodifásico (uma metade é positiva e a outra negativa) ou mesmo isoelétrico (linha reta). Agora, acompanhe o raciocínio com a imagem da rosa dos ventos abaixo. Com o QRS positivo em D1 e negativo em aVF, sabemos em que quadrante o eixo se encontra entre 0º e -90º. Como o QRS é isodifásico em aVR, sabemos que ele está perpendicular a esta derivação. Logo, o eixo elétrico do QRS está em -60º, ou seja, com um importante desvio para a esquerda (letra D certa e letra A e B erradas). E a frequência cardíaca Lembra-se da Regra dos 1500 FC 1500 número de quadradinhos entre RR. Esse número de quadradinhos entre duas ondas R é o intervalo RR em mm Na questão, 1500 15 100. De fato, a FC é de 100 bpm, mas não há sinais de sobrecarga de VD (letra C errada). A descrição do ECG também não traz qualquer critério de Doença do Nodo Sinusal, como Síndrome Bradi-Taqui, pausa

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sinusal 3 segundos, bradicardia sinusal inapropriada ou bloqueio sinoatrial (letra E errada). Resposta certa letra D.

17794.

Comentário: Vamos analisar as assertivas em relação a intervenção do modelo Sanitarista A) Incorreta. O modelo sanitarista foca em algumas situações doenças B) Correta. O modelo sanitarista concentra sua atenção no controle de certos agravos específicos. C) Incorreta. Preocupam-se com alguns determinantes específicos. D) Incorreta. Enfatiza ações focais e pontuais e não integral de saúde. E) Incorreta. É um modelo extremamente centralizado. Ou seja, o nosso gabarito é a letra B.

17804.

Comentário: Questão fácil A atividade elétrica atrial caótica característica da fibrilação atrial resulta numa perda da despolarização organizada proporcionada normalmente pelo ritmo sinusal, causando uma resposta ventricular completamente irregular. Entretanto, se esta resposta for muito rápida ou muito lenta pode ser difícil definir pelo exame físico se o ritmo está realmente irregular ou não (opção A incorreta). Se a sequência correta de ativação for respeitada, a contração atrial ocorrerá na fase pré-sistólica do ciclo cardíaco. Quando há uma disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, poderá ser auscultada uma quarta bulha exatamente no momento correspondente à contração atrial, por consequência da desaceleração súbita do sangue contra a parede ventricular pouco complacente. Na fibrilação atrial, a desorganização elétrica impede que haja uma contração atrial eficaz, e, portanto é impossível que seja gerada uma B4 ou uma onda a no pulso venoso (opção B incorreta E CORRETA). A terceira bulha é um sinal de disfunção ventricular sistólica e ocorre na fase de enchimento rápido da diástole, não sendo influenciada pela fibrilação atrial (opção C errada).

17868.

Comentário: No estudo da hipertensão arterial na gravidez, Page (1972) considera para aferir a pressão arterial médica PAM PAS 2xPAD 3. Lembrando que para ser dado o diganóstico de hipertensão arterial na gravidez, a pressão deve ser aferida ao menos duas vezes com um intervalo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

mínimo de 4 horas entre elas. Ou seja, o nosso gabarito é a letra C.

349742.

Comentário: A questão traz paciente com quadro clínico de palpitações intensas e frequência cardíaca aumentada (150 bpm), associada a sinais de instabilidade hemodinâmica nesse contexto hipotensão arterial, dor torácica e dispneia. Vamos aplicar o algoritmo das taquiarritmias para chegar ao diagnóstico eletrocardiográfico mais provável - Primeira pergunta existe taquicardia Sim, pois a distância entre duas ondas R é menor do que 3 quadradões no eletrocardiograma, indicando que a frequência cardíaca é maior do que 100 bpm. - Segunda pergunta existe onda P Não é possível identificar a presença de ondas P o que vemos após o complexo QRS são ondas T, de repolarização ventricular. - Terceira pergunta existe onda F de flutter atrial Não. As ondas de flutter típicas aparecem nitidamente nas derivações DII, DIII e aVF, com o aspecto em dente de serra e negativas. Elas possuem uma frequência em torno de 300 bpm, distando 1 quadrado entre si. - Quarta pergunta QRS é estreito ou alargado (120 ms) Estreito Se fosse alargado, pensaríamos numa taquicardia ventricular. - Quinta e última pergunta R-R é regular o irregular Irregular Observe que a distância entre duas ondas R varia discretamente a cada batimento, indicando que estamos diante de uma FIBRILAÇÃO ATRIAL (FA) Se fosse regular, pensaríamos na taquicardia supraventricular. Sendo assim, vamos analisar as alternativas. Letra A incorreta. O diagnóstico não é de taquicardia supraventricular e sim de FA, uma vez que o ritmo é irregular. Letra B correta. Como vimos, trata-se de uma FA associada à instabilidade hemodinâmica O que fazer nesse caso No paciente com FA e instabilidade hemodinâmica, devemos reverter a arritmia com cardioversão elétrica emergencial (choque sincronizado), utilizando a mesma técnica para a cardioversão elétrica eletiva, o que inclui uma sedação leve. Como não dá tempo de pensar em anticoagulação, caso seja de alto risco tromboembólico, o paciente pode apenas ser heparinizado junto com a reversão (ou receber um anticoagulante de ação direta), seguido da terapia anticoagulante crônica apropriada de acordo com o grupo de risco. Letra C incorreta. O diagnóstico não é flutter e, ainda que fosse, o tratamento seria com cardioversão elétrica (sincronizado) e não desfibrilação (dessincronizado). Letra D incorreta. Não é taquicardia sinusal, pois o paciente não tem onda P

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sinusal. Além disso, é claro que a conduta não pode ser expectante Letra E incorreta. Embora seja uma FA, o tratamento de escolha em pacientes com instabilidade hemodinâmica é o CHOQUE sincronizado, e não a cardioversão química. Resposta letra B.

349739.

Comentário: Para o ideal atendimento da RCP, deve-se atentar ao papel de cada um na equipe de ressuscitação. O treinamento do atendimento de em equipe minimiza erros e é recomendado. Os dois princípios fundamentais do bom trabalho em equipe são liderança e comunicação efetiva. Assim, a cada atendimento, deve haver um profissional que assuma o papel de líder na condução do caso. Esta pessoa deve garantir que todas as tarefas foram compreendidas e executadas pelos diferentes membros da equipe, incorporar novas informações, reavaliar o caso e centralizar a comunicação entre os membros da equipe. É seu papel, também, avaliar o desempenho de seus colegas, garantindo RCP de boa qualidade, controle adequado da via aérea e segurança na manipulação do desfibrilador. Vamos analisar as assertivas. Letra A incorreta. Embora o líder da equipe tenha um papel crítico na coordenação dos esforços de ressuscitação, a comunicação entre todos os membros da equipe é essencial para o sucesso do atendimento. Cada membro deve ter a capacidade de verbalizar observações importantes, como mudanças no estado do paciente, resultados de exames ou preocupações durante o procedimento. Letra B incorreta. O líder deve transmitir mensagens sequenciais (e não simultâneas) a cada membro da equipe, de modo a garantir o perfeito entendimento de cada ação. Letra C correta. A comunicação efetiva deve se dar em alça fechada , ou seja, cada membro repete a ordem compreendida antes de executá-la e sinaliza a ação após tê-la realizado. Intervenções construtivas pertinentes devem ser dirigidas ao líder, que, por sua vez, deve abrir espaço aos membros da equipe para sugestões durante o atendimento. Letra D incorreta. Elevar o tom de voz pode ser interpretado como agressivo e pode aumentar a tensão e a ansiedade dentro da equipe, o que pode prejudicar o desempenho do grupo e a segurança do paciente. Letra E incorreta. Embora o reconhecimento positivo seja uma parte importante da construção de uma equipe eficaz e do reforço de boas práticas, o aspecto da repreensão, especialmente em alto tom de voz, não é apropriado no contexto do ACLS ou de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

qualquer ambiente clínico profissional. Resposta letra C.

365613.

Comentário: Existem basicamente quatro ritmos possíveis em uma parada cardiorrespiratória (PCR) Fibrilação Ventricular (FV) Taquicardia Ventricular sem pulso (TV sem pulso) Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP ou PEA Puseless Electrical Activity) Assistolia. A FV e a TV sem pulso são ritmos chocáveis, enquanto a AESP e a assistia são ritmos não-chocáveis. No caso da questão, durante o atendimento da PCR foi identificado um ritmo organizado, logo, o próximo passo é checar pulso. Se ausente, o diagnóstico é de AESP e devemos retornar imediatamente para as manobras de RCP. Se pulso presente, indica que o paciente retornou à circulação espontânea e a conduta é seguir para os cuidados pós-parada. Resposta letra B.

365612.

Comentário: O tratamento farmacológico da parada cardiorrespiratória (PCR) vai depender de ritmo em que o paciente se encontrar Ritmos chocáveis (FV e TV sem pulso) adrenalina e antiarritmico (amiodarona ou lidocaína) Ritmos não-chocáveis (assistolia e AESP) apenas adrenalina. Analisando o traçado da questão, vemos que se trata de um ritmo organizado, aparentemente sinusal. No contexto da PCR, qualquer ritmo que não seja classificado como FV, TV ou assistolia é considerado AESP (atividade elétrica sem pulso). Portanto, a única medicação que poderia ser usada é a adrenalina (1 mg a cada 3-5 minutos). A atropina não é mais recomendada no tratamento da PCR. Resposta letra D.

365635.

Comentário: Antes de partir para as alternativas, vamos aproveitar o momento para definir alguns conceitos sobre os diferentes tipos de bloqueio atrioventricular BAV de 1º grau i ntervalo PR 200ms (ou 0,2s). Na verdade, o BAV de 1 grau não é propriamente um bloqueio e sim um alentecimento atrioventricular. BAV de 2º grau Mobitz I eventuais ondas P bloqueadas (sem QRS) com fenômeno de Wenckebach, marcado pelo aumento progressivo do PR até o bloqueio da P, geralmente com uma redução também progressiva do intervalo R-R até o bloqueio BAV de 2º grau Mobitz II eventuais ondas P bloqueadas (sem QRS), mas os intervalos PR antes do bloqueio da P são iguais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

entre si BAV total Completa dissociação atrioventricular (entre P e QRS), na qual podemos ver a onda P em várias posições em relação ao QRS (dentro do complexo, logo antes e logo depois, no segmento ST, em cima da onda T, etc). Temos intervalos P-P na frequência sinusal e intervalos R-R regulares, respeitando a frequência de escape. O escape pode ser juncional (QRS estreito, FC 40 bpm) ou ventricular (QRS alargado, FC 40 bpm). Vamos, agora, para as alternativas Letra A incorreta. O ritmo sinusal é o ritmo fisiológico do coração, se origina no átrio direito alto e é observado no ECG pela presença de ondas P positivas nas derivações D1, D2 e aVF. Não sabemos nem a derivação do traçado colocado no enunciado, mas podemos perceber um claro alargamento do intervalo PR, ficando complicado definir esse ritmo como normal. Letra B correta. O bloqueio atrioventricular (BAV) de primeiro grau é diagnosticado pelo alargamento isolado do intervalo PR no ECG, sem perda de condução atrial para os ventrículos, ou seja, sem ondas P bloqueadas, justamente o que é visto ao eletro da paciente. Letra C incorreta. No BAV de segundo grau, espera-se encontrar ondas P bloqueadas, indicando que alguns impulsos atriais não estão atingindo os ventrículos, o que não foi visto ao ECG apresentado. Letra D incorreta. BAV total, ou de terceiro grau, é quando não há condução alguma das ondas P para os ventrículos, levando a total dissociação atrioventricular. No traçado da nossa paciente, todas as ondas P conduzem. Resposta letra B.

322152.

Comentário: Neste momento, não podemos afirmar absolutamente nada sobre o quadro apresentado Pode ser uma síndrome coronariana com equivalente anginoso, não é Nesse sentido, o eletrocardiograma cairia muito bem (até a própria avaliação de um especialista seria interessante). Pode ser também que o paciente esteja em parada cardiorrespiratória, situação na qual compressões torácicas e epinefrina deverão ser empregadas. Entretanto, há uma prioridade indiscutível diante de um colapso checar a responsividade para garantir mesmo que o paciente está inconsciente A partir daí, daremos seguimento ao nosso atendimento na ausência de responsividade, deveremos checar pulso central e respiração por 10 segundos, o que definirá se o paciente está ou não em PCR. Resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337519.

Comentário: Paciente idoso que perdeu a consciência certamente o eletrocardiograma será de grande ajuda para elucidação diagnóstica Repare como temos supradesnivelamento do segmento ST em V1, V2, V3, V6, D1 e aVL, o que denota um infarto que pegou parede lateral e parede anterior. Note ainda o infra de ST em DII, DIII e aVF trata-se de uma imagem em espelho do supra de parede lateral. De fato, o ECG é compatível com infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Agora, não é um infarto qualquer nosso paciente apresenta critérios de instabilidade hemodinâmica e evolução para uma arritmia potencialmente maligna e fatal. E que arritmia é essa Trata-se de uma clássica taquicardia ventricular monomórfica repare no RR regular, na FC entre 100-300 bpm, QRS alargado e aberrante, com mais de três complexos ventriculares (extrassístoles) sucessivos, sem onda P. Sabemos ainda que infarto agudo do miocárdio é uma causa de taquicardia ventricular aguda, o que faz sentido com o contexto apresentado pela banca. Afirmativa CERTA.

337520.

Comentário: Paciente idoso que perdeu a consciência certamente o eletrocardiograma será de grande ajuda para elucidação diagnóstica Repare como temos supradesnivelamento do segmento ST em V1, V2, V3, V6, D1 e aVL, o que denota um infarto que pegou parede lateral e parede anterior. Note ainda o infra de ST em DII, DIII e aVF trata-se de uma imagem em espelho do supra de parede lateral. De fato, o ECG é compatível com infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Agora, não é um infarto qualquer nosso paciente apresenta critérios de instabilidade hemodinâmica e evolução para uma arritmia potencialmente maligna e fatal. E que arritmia é essa Trata-se de uma clássica taquicardia ventricular monomórfica repare no RR regular, na FC entre 100-300 bpm, QRS alargado e aberrante, com mais de três complexos ventriculares (extrassístoles) sucessivos, sem onda P. Sabemos ainda que infarto agudo do miocárdio é uma causa de taquicardia ventricular aguda, o que faz sentido com o contexto apresentado pela banca. Se o paciente não tiver pulso, então estaremos diante de uma PCR em ritmo de TV sem pulso, correto E nesse sentido, sabemos que o choque desfibrilatório é a única medida confiável capaz de reverter essa PCR. Repare não estamos falando de cardioversão (choque sincronizado com o complexo QRS), mas de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

desfibrilação Para os cardiodesfibriladores tradicionais (monofásicos), o choque aplicado para reverter a FV ou a própria TV sem pulso deve ser de 360 J (lembrando que é sempre dessincronizado). Para os mais modernos (bifásicos) a carga gira em torno de 120 a 200 J, ficando na dependência do tipo de onda bifásica (retilínea 120 J ou exponencial 150 a 200 J). Na prática, se você dispõe de um cardiodesfibrilador bifásico e não sabe o tipo de onda, dê um choque de 200 J. Afirmativa ERRADA.

322164.

Comentário: Vamos recordar o clássico algoritmo das taquiarritmias em primeiro lugar, existe uma taquicardia Sim Repare que em diversos momentos os intervalos R-R apresentam um distância entre si inferior a 1,5 cm (3 quadradões) indicando uma FC 100 bpm. Segunda pergunta existe onda P Não... terceira pergunta existe onda F de flutter atrial Também não.. Quarta pergunta o QRS é estreito ou alargado Reparem que o QRS é alargado (duração 120ms), logo, até que se prove o contrário, estamos diante de uma taquicardia ventricular (TV). Como os complexos QRS são similares entre si trata-se de uma taquicardia ventricular monomórfica. Pois bem... qual deverá ser a nossa conduta Temos uma arritmia com claros critérios de instabilidade hipotensão (PA 70 x 40 mmHg) e dessaturação (SatO2 86%). A conduta imediata obrigatória nesse contexto deve ser a pronta cardioversão elétrica sincronizada Cuidado com a letra A em casos de taquicardia supraventricular conduzida com aberrância (na presença de BRD ou BRE) até podemos ter complexos QRS. Para uma adequada diferenciação, devemos aplicar os critérios de Brugada, mas precisaríamos também do ECG completo, com todas as derivações (o que não foi fornecido pela questão). De toda forma, no ECG apresentado, em alguns momentos podemos evidenciar a presença de alguns sinais de dissociação atrioventricular , como a ocorrência de batimentos de fusão (QRS com morfologia intermediária entre um complexo sinusal e um ventricular). Lembre-se que a dissociação atrioventricular somente se faz presente nos casos de TV, não ocorrendo na taqui supra . E ainda que fosse esse o diagnóstico, a conduta prioritária também seria a cardioversão elétrica, não a manobra vagal. Agora, sobre a letra C a atropina é um agente anticolinérgico que pode ser considerado em casos de bradiarritmias, não tendo aplicação em uma

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

taquiarritmia como a TV. Resposta letra D.

322174.

Comentário: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), afogamento é o processo de disfunção respiratória decorrente de submersão imersão em meio líquido. O termo submersão refere-se ao posicionamento da via aérea abaixo da superfície de uma massa líquida, enquanto o termo imersão refere-se à entrada de líquido na via aérea sem que a mesma tenha ficado abaixo da superfície de uma massa líquida. A causa básica da disfunção respiratória é a lesão da membrana alveolocapilar pelo líquido inalado (levando à lavagem do surfactante e à leso osmótica dos pneumócitos). A quantidade de líquido inalado determina a extensão e o grau da lesão pulmonar. Se a hipoxemia for grave e persistente o paciente acabará evoluindo com parada cardiorrespiratória. O ritmo de parada mais comumente observado no afogamento é a assistolia, em geral precedida por um período de atividade elétrica sem pulso e, anteriormente, bradicardia. Fora da água, a vítima deve sempre ser colocada em decúbito dorsal, com cabeça e tronco no mesmo nível (geralmente em paralelo a margem da praia ou coleção hídrica). Se houver movimentos respiratórios espontâneos, colocamos o paciente em posição de recuperação (decúbito lateral). Se não houver respiração, as manobras de suporte básico de vida devem ser iniciadas de imediato, e uma equipe de suporte avançado deve ser acionada. Aqui há uma importante diferença em relação ao BLS como a causa da PCR é a hipoxemia grave, no BLS do afogamento, a sequência inicial ainda é o ABC (Airway, Breathing, Circulation via aérea, ventilação e circulação). Inclusive, nos casos de afogamento, preconiza-se a administração de até 5 ventilações antes de iniciar a compressão torácica Após essas 5 ventilações pode ter início a sequência 30 compressões torácicas para cada 2 ventilações, até que o paciente se recupere, o socorrista fique exausto ou a equipe de suporte avançado chegue ao local. Problemas da questão em nenhum momento foi falado que o paciente está em parada cardiorrespiratória... apenas que a vítima está desacordada. Outro detalhe é que muitos pacientes que se afogam também apresentam lesão cervical por mergulho e trauma, motivo pelo qual a estabilização da coluna pode ser uma conduta fundamental Sugerimos um pedido de recurso na época da prova considerando que letras A, B e C seriam

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

possíveis respostas. O gabarito inicialmente liberado foi a letra B (partiram do pressuposto de que o paciente estava parado), mas a banca trocou a resposta para a letra C.

305287.

Comentário: A banca quer uma arritmia com QRS estreito e regular. Vamos às opções. FA tem QRS estreito (exceto nos casos associados a bloqueio de ramo), mas é irregular. Excluída torsades de pointes tem QRS largo (é um subtipo de TV polimórfica). Excluída taquicardia atrial tem QRS estreito e RR regular taquicardia de movimento circular antidrômica é um subtipo de taquicardia supraventricular por reentrada em via acessória na qual o estímulo desce pela via acessória e sobe pelo nódulo AV (ao contrário do que ocorre na TSV ortodrômica, que é bem mais comum). Pelo fato de o estímulo descer pela via acessória, o QRS é alargado (embora o RR seja regular). Excluída flutter atrial com BAV variado tem QRS estreito, mas o RR é irregular devido ao BAV variado. Excluída. Entre as taquiarritmias citadas, a FA, o flutter atrial e a taquicardia atrial são aquelas com QRS estreito (as demais têm QRS alargado, já podendo ser excluídas). Dentre essas três, a FA possui intervalo RR irregular, assim como um flutter atrial que se apresente como bloqueio AV variado... Dessa forma, apenas a taqui atrial responde à questão (QRS estreito, RR regular). Resposta letra C.

298858.

Comentário: A síndrome de Wolff-Parkinson-White é decorrente da presença de uma via acessória congênita com capacidade de condução anterógrada (do átrio para o ventrículo), revelando-se no ECG sinusal com o padrão da pré-excitação ventricular (PR curto e onda delta) e manifestando-se clinicamente com taquiarritmias de repetição, geralmente do tipo Taqui supra ou FA - exatamente o que este paciente parece estar apresentando agora. Realmente o diagnóstico de FA associado a WPW é difícil, mas pode ser dado pelas seguintes características eletrocardiográficas, presentes no traçado deste paciente RR irregular, QRS alargado, sem onda P e eventual onda delta. Assertiva ERRADA, portanto. Resposta B.

298859.

Comentário: A síndrome de Wolff-Parkinson-White é decorrente da presença de uma via acessória

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

congênita com capacidade de condução anterógrada (do átrio para o ventrículo), revelando-se no ECG sinusal com o padrão da pré-excitação ventricular (PR curto e onda delta) e manifestando-se clinicamente com taquiarritmias de repetição, geralmente do tipo Taqui supra ou FA - exatamente o que este paciente parece estar apresentando agora. Realmente o diagnóstico de FA associado a WPW é difícil, mas pode ser dado pelas seguintes características eletrocardiográficas RR irregular, QRS alargado, sem onda P e eventual onda delta. A longo prazo , o procedimento de ablação por radiofrequência da via acessória está sempre indicada na síndrome de Wolff-Parkinson-White quando esta se manifesta com taquiarritmias de repetição. Portanto, estes pacientes devem ser encaminhados ao arritmologista. A terapia farmacológica depende da taquiarritmia que o paciente apresentou 1. taqui supra ortodrômica verapamil, diltiazem digoxina, ou propafenona (grupo IC) 2. taqui supra antidrômica, fibrilação atrial WPW ou flutter WPW a droga profilática de escolha nesses casos é um antiarrítmico do grupo IC em nosso meio, utiliza-se a propafenona 450-900 mg dia (três tomadas). Nos EUA, dá-se preferência pela flecainida. Não está indicado sotalol. Assertiva ERRADA, portanto. Resposta B.

305291.

Comentário: O ECG revela complexos QRS alargados com formatos semelhantes. Ora, trata-se de uma taquicardia ventricular monomórfica Na abordagem inicial de qualquer taquiarritmia, é preciso avaliar se há algum critério de instabilidade rebaixamento do nível de consciência, dispneia, hipotensão ou angina. Perceba que o paciente apresenta estes dois. De acordo com o ACLS, a conduta a ser tomada é a cardioversão elétrica, um choque sincronizado para reestabelecer o ritmo cardíaco normal com carga inicial de 100 joules. Resposta letra E.

298860.

Comentário: A síndrome de Wolff-Parkinson-White é decorrente da presença de uma via acessória congênita com capacidade de condução anterógrada (do átrio para o ventrículo), revelando-se no ECG sinusal com o padrão da pré-excitação ventricular (PR curto e onda delta) e manifestando-se clinicamente com taquiarritmias de repetição, geralmente do tipo Taqui supra ou FA - exatamente o que este paciente parece estar apresentando agora. Realmente o diagnóstico de FA associado a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

WPW é difícil, mas pode ser dado pelas seguintes características eletrocardiográficas, presentes no traçado deste paciente RR irregular, QRS alargado, sem onda P e eventual onda delta. Nos pacientes com WPW e FA, é considerado alto o risco de evolução para TV e FV, uma vez que a via acessória não possui a propriedade de filtro típica do nódulo AV portanto, uma taquiarritmia atrial de alta frequência torna-se perigosa se a maioria dos estímulos atriais passarem aos ventrículos pela via acessória, em vez de serem filtrados pelo nódulo AV. Logo, o risco de morte súbita sem dúvida está AUMENTADO em casos como este. Assertiva CERTA, portanto. Resposta A.

298861.

Comentário: A síndrome de Wolff-Parkinson-White é decorrente da presença de uma via acessória congênita com capacidade de condução anterógrada (do átrio para o ventrículo), revelando-se no ECG sinusal com o padrão da pré-excitação ventricular (PR curto e onda delta) e manifestando-se clinicamente com taquiarritmias de repetição, geralmente do tipo Taqui supra ou FA - exatamente o que este paciente parece estar apresentando agora. Realmente o diagnóstico de FA associado a WPW é difícil, mas pode ser dado pelas seguintes características eletrocardiográficas, presentes no traçado deste paciente RR irregular, QRS alargado, sem onda P e eventual onda delta. Todos os casos de FA com instabilidade hemodinâmica devem ser prontamente revertidos com cardioversão elétrica emergencial. Na FA com WPW, a carga deve ser mais alta, começando com 200 J. Assertiva CERTA. Resposta A.

305305.

Comentário: Segundo as recomendações mais recentes do suporte básico de vida (BLS), é fundamental reconhecer a Parada Cardiorrespiratória (PCR) o mais rápido possível Porém, é importante que a avaliação da respiração e a verificação do pulso não atrasem as medidas de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). Para isso, recomenda-se que, em pacientes desacordados, os profissionais de saúde gastem, NO MÁXIMO, dez segundos para checar pulso carotídeo antes de iniciar a RCP. Se o socorrista for leigo, a verificação do pulso não deve ser realizada e a RCP deve ser iniciada assim que houver suspeita de que o paciente esteja em PCR A realização de RCP em um paciente que não responde e que não está em PCR tem poucas consequências

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

adversas, ao passo que não realizar a RCP em um paciente que está em PCR pode contribuir para um desfecho desfavorável. Ou seja, a nossa primeira medida, após verificar responsividade, deve ser checar o pulso carotídeo e a respiração (para confirmar que se trata de uma PCR). Em seguida, devemos começar o BLS, na sequência C (compressão) executar imediatamente 30 compressões torácicas, na frequência de 100 120 por minuto. Letra A incorreta A (via aérea) consiste em abrir e manter a via aérea do paciente pérvia B (respiração) após as compressões iniciais e abertas as vias aéreas, realizar duas ventilações (manter sempre a relação compressão ventilação de 30 2). Leigos podem fazer apenas as compressões sem ventilação (hands-only). Letra B incorreta D (desfibrilação) assim que o desfibrilador automático externo (DEA) ou o cardiodesfibrilador manual estiverem disponíveis, monitorar o ritmo e, em caso de FV ou TV sem pulso, proceder a um choque dessincronizado de 360 J (monofásico) ou 120 200 J (bifásico), voltando imediatamente depois às manobras de RCP. Repare que é só nessa etapa que nos preocupamos com o ritmo do paciente e, ainda assim, o mesmo deve ser checado com o próprio DEA (letra D incorreta). Caso o paciente não tenha se recuperado após o primeiro choque desfibrilatório, devemos começar o ACLS. Em geral, é neste momento que iremos obter uma via aérea avançada e acesso venoso periférico para administração de drogas. Letra C incorreta. Resposta letra E.

274359.

Comentário: Questão que depende unicamente da interpretação eletrocardiográfica. Vamos direto à análise do exame. Trata-se de um ritmo irregular, não sinusal (não são identificadas ondas P), e ao contrário da descrição do enunciado, não há taquicardia no momento O eixo elétrico encontra-se dentro da normalidade. E quanto à avaliação dos intervalos e ondas Chama a atenção não apenas a ausência de ondas P, mas a presença de ondas regulares e rápidas na linha de base, conferindo aspecto serrilhado. São ondas F , representando flutter atrial. Nessa arritmia, o átrio bate em frequência de cerca de 300 bpm, mas os batimentos são conduzidos aos ventrículos com bloqueio atrioventricular variável. Perceba que existem cerca de 4 ondas F para cada complexo QRS, resultando em uma frequência ventricular de apenas cerca de 75 bpm. Em outras palavras, o diagnóstico é de flutter atrial com condução AV variável. Resposta letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255692.

Comentário: Afirmativa errada, pois o paciente apresenta um Bloqueio Atrioventricular Total (BAVT) ou de terceiro grau, não de segundo grau. Isso fica mais fácil de ser percebido no DII longo, onde vemos que a onda P está completamente dissociada do complexo QRS. Dá para encontrar a onda P antes do QRS, em cima do QRS, logo depois do QRS, em cima da onda T... Enfim, uma bagunça, cada hora ela está em um lugar Entenda o estímulo sai do nó sinusal, estimula o átrio, mas não passa do nó atrioventricular (afinal, é um bloqueio total, não é). Então, como o ventrículo contrai Surge um outro estímulo, um escape, que pode ser juncional ou ventricular, promovendo a contração ventricular. Isso mesmo, são dois ritmos separados um lá no átrio (repare nos intervalos P-P que seguem uma frequência sinusal e regular) e outro ventricular (veja os intervalos R-R, também regulares que seguem seu ritmo de escape, só que independente do ritmo atrial). Esse achado tem alguma coisa a ver com o infarto de parede inferior Sim O BAVT pode ocorrer em 10% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio de parede inferior, revelando pior prognóstico quando ocorre após as primeiras seis horas. Resposta letra B.

255740.

Comentário: Em relação a diretriz citada sobre taquicardias supraventriculares, uma das mensagens centrais é a não utilização de sotalol em pacientes com episódios repetidos de taquicardia supraventricular. Tal conduta baseia-se no fato de que esse fármaco possui efeito pró arrítmico, especialmente em pacientes que já apresentam prolongamento do intervalo QT. Afirmativa CERTA.

255741.

Comentário: Sabemos que em pacientes com predisposição à ocorrência de taquicardias supraventriculares apresentam maior chance de episódios durante a gestação, com prevalência de 22-24 100.000 gestações, aumento o risco de morte. Na fase aguda, tanto a manobra vagal, quanto a adenosina (em pacientes instáveis) e a cardioversão elétrica (pacientes instáveis) podem ser empregadas. Considerando a alta eficácia terapêutica definitiva com a realização de ablação por cateter, a mesma pode ser realizada mesmo durante a gestação. Afirmativa CERTA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255742.

Comentário: A taquicardia supraventricular paroxística é aprincipal arritmia de mulheres jovens sem cardiopatia estrutural e quando presente na gestação, parece se associar a maior morbidade materna, cesárea, baixo peso ao nascer, parto pré-termo e anormalidades fetais em geral. Não é claro se a gravidez aumenta a incidência dessa arritmia, mas se sabe que o quadro clínico é o mesmo de uma paciente não gestante, o que inclui palpitação associada ou não a síncope, pré-síncope, dispneia e ou dor torácica. A depender da gravidade, podemos encontrar instabilidade hemodinâmica. Assim, a afirmativa está incorreta, pois essa taquiarritmia pode ser causa de síncope e de queda. Resposta B.

211982.

Comentário: Uma questão difícil e específica demais para o R1, mas que eventualmente poderia ser cobrada na prova de R3. A banca mostra uma imagem de ecocardiografia na janela PARAESTERNAL ESQUERDA no plano LONGITUDINAL. Uma janela típica do ecocardiograma, onde avaliamos válvula aórtica, atrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo e músculo papilar. A estrutura apontada na figura como número 1 é o VENTRÍCULO ESQUERDO. Resposta LETRA B.

211957.

Comentário: Questão interessante Segundo a diretriz da SBC, atletas sintomáticos que apresentam TV polimórfica catecolaminérgica (CPVT) devem ser impedidos de praticar qualquer tipo de esporte de alto rendimento até que se faça uma avaliação completa. O paciente da questão seguiu essa recomendação e foi submetido a um teste ergométrico que comprovou a presença desse distúrbio. Ainda de acordo com essa referência, a prática de esportes competitivos por indivíduos portadores dessa arritmia está contraindicada se Sintomática Assintomática com extrassístoles ventriculares prematuras induzidas pelo exercício, bigeminismo e ou taquicardia ventricular não sustentada. Dessa forma, esse paciente não poderá praticar qualquer esporte de alto rendimento. Resposta (D).

212003.

Comentário: Uma questão de protocolo de PCR ACLS. Após uma parada por FV o paciente evolui

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com RETORNO DA CIRCULAÇÃO ESPONTÂNEA(RCE), o que fazer Protocolo da RCE Neste protocolo, se o paciente estiver comatoso a medida tomada deve ser CONTROLE DIRECIONADO DE TEMPERATURA entre 32-36oC (ACLS AHA 2015). Antigamente chamada HIPOTERMIA TERAPÊUTICA , essa conduta agora também abrange temperatura normal de 36oC, conhecida como terapia não-febre . Mas a banca optou por hipotermia terapêutica nesse caso. Quais as principais complicações descritas nos estudos da HIPOTERMIA TERAPÊUTICA Coagulopatia Risco de infecção Resposta LETRA C.

196706.

Comentário: As características eletrocardiográficas de um hemibloqueio posterior esquerdo (ou bloqueio divisional posteroinferior esquerdo) são (1) eixo elétrico médio de QRS em torno de 120 graus, (2) padrão S1Q3, (3) QRS com duração dentro dos limites normais (entre 60 e 100ms). Logo, não há tal alteração no ECG apresentado. Assertiva ERRADA.

196614.

Comentário: No BAV de primeiro grau, a duração do intervalo PR (início da onda P até o início do complexo QRS) é 5 quadradinhos ou 200ms. Não há tal alteração no ECG apresentado. Assertiva ERRADA. Resposta letra B.

196623.

Comentário: Os critérios de BRE são (1) duração de QRS maior ou igual a 120ms (3 quadradinhos), (2) alargamento das ondas R em V5 e V6 (bem como em D1 e aVL), ou presença de entalhes nestas ondas (3) ausência de Q em V5, V6 e D1. A derivação aVL pode apresentar uma onda Q (4) aumento do tempo de ativação ventricular, que fica acima de 60ms em V5 e V6, sendo normal em V1 e V2 (5) desnível de ST no sentido oposto ao da principal deflexão do QRS e onda T também oposta ao QRS. Tudo isso está presente no traçado mostrado. Assertiva CERTA.

196629.

Comentário: Pela definição clássica, a bradicardia sinusal é um ritmo conduzido pelo nódulo sinoatrial em que a frequência cardíaca encontra-se 60 bpm. Nem toda bradicardia sinusal é patológica... Esta é a informação encontrada em diversas fontes de referência, como o Harrison

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Tratado de Medicina Interna. Porém, existem pequenas variações na literatura, e a referência citada no enunciado de fato coloca que a definição de bradicardia sinusal é uma FC 50 bpm... Questão maldosa, que teve como gabarito Assertiva Errada .

214450.

Comentário: Questão que aborda uma situação bastante comum no dia a dia do médico a liberação de atestado para prática de atividades desportivas. O enunciado cita um menino de oito anos cujo ECG evidencia uma onda T negativa em V1 e V2. Em geral, a onda T acompanha a polaridade do complexo QRS, razão pela qual a onda T em V1 e V2 estando negativa neste caso, não nos preocupa muito. Como a onda T costuma ser negativa em V1, não há critérios para afastar esta criança das atividades esportivas. Afirmativa ERRADA.

214458.

Comentário: Uma questão interessante sobre eletrocardiograma do atleta. A banca mostra um ECG com onda T invertida em V1 e V2 e afirma que esse achado pode ser considerado normal, atribuído ao treinamento físico. Essa afirmação está ERRADA, pois conforme as Diretrizes para emissão de laudo de ECG da SBC são considerados achados normais em atletas as seguintes alterações a) Bradicardia sinusal. b) Arritmia sinusal fásica ou respiratória. c) Aumento do intervalo PR. d) Aumento da voltagem de ondas R ou S entre 30 a 35mm. e) Alteração da repolarização ventricular,tipo repolarização precoce (elevação do ponto J com entalhe inicial). f) Atraso de condução pelo ramo direito. g) BAV de segundo grau tipo Mobitz I. h) Padrão de sobrecarga ventricular somente por critérios de voltagem (Sokolow-Lyon). Onda T invertida não é um deles. Resposta certa LETRA B.

196650.

Comentário: Achados como bradicardia leve (FC 40 bpm) e BAV de primeiro grau são considerados variações na normalidade em atletas e, em indivíduos assintomáticos e sem história familiar de doença coronariana hereditária ou morte súbita por causa cardiovascular, não há necessidade de interrupção de atividade física. Assertiva ERRADA.

196656.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Achados como bradicardia leve (FC 40 bpm) e BAV de primeiro grau são considerados normais e, em indivíduos assintomáticos e sem história familiar de doença coronariana hereditária ou de morte súbita por causa cardiovascular, não há necessidade de seguir investigação. Assertiva ERRADA

196661.

Comentário: Faz parte do tratamento conservador da HAS a prática de exercícios físicos, que idealmente devem conjugar atividades aeróbicas com exercícios de força, isto é, exercícios resistidos (pelo menos 2 sessões por semana). Assertiva ERRADA.

196672.

Comentário: A referida diretriz indica a realização de ECG de repouso para os indivíduos classificados como máster e idosos e não para todos os indivíduos. Nessa idade, já existe uma maior prevalência de doenças cardiovasculares, sendo a principal delas a doença arterial coronária. Essa indicação aplica-se mesmo a indivíduos assintomáticos e ou sem conhecimento de patologia cardiovascular prévia. Afirmativa ERRADA.

177607.

Comentário: Os fatores de risco para ocorrência de eventos tromboembólicos na fibrilação atrial são reunidos através das letras da sigla CHA2DS2VASc, a qual determina um escore de pontos. Vamos rever seus elementos C - insuficiência Cardíaca 1 ponto H - Hipertensão arterial sistêmica 1 ponto A - Age idade 75 anos 2 pontos D - Diabetes mellitus 1 ponto S2 - Stroke AIT AVE prévio 2 pontos V - doença Vascular 1 ponto A - Age idade 65-74 anos 1 ponto Sc - Sexo feminino 1 ponto. O sexo masculino não representa fator de risco. Se a paciente pontuar 0, não recebe terapia antitrombótica nem anticoagulante. Se pontuar 1, recebe terapia antitrombótica. Pontuando 2 ou mais, recebe anticoagulação. Assertiva certa. Resposta A.

134985.

Comentário: Questão conceitual A adrenalina é uma catecolamina endógena que atua estimulando os receptores alfa e beta-adrenérgicos, sendo a droga de eleição a ser utilizada durante as manobras de reanimação na parada cardiorrespiratória (PCR). É um potente vasopressor, que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

promove o aumento da resistência vascular sistêmica, da frequência cardíaca e da contratilidade miocárdica. Desta forma, também ocorre aumento da pressão de perfusão gerada pela compressão torácica externa e do fluxo sanguíneo cerebral e coronariano, aumentando assim a liberação de oxigênio para o coração. Afirmativa CORRETA

105533.

Comentário: A onda (p) é o registro da despolarização atrial. É uma onda pequena e arredondada que precede o complexo QRS. Tem duração normal de até 0,11s e amplitude até 0,25 mV. Sua orientação espacial varia de 0 a 90 graus no plano frontal, motivo pelo qual esta normalmente é positiva em DII e negativa em aVR. Alterações em sua morfologia, amplitude e duração representam, portanto, problemas atriais. Gabarito D.

108161.

Comentário: Esse enunciado foi um pouco mal escrito, o que comprometeu a valdiade da questão... Quando se diagnostica uma parada cardiorrespiratória (ausência de pulso central após sua checagem por, pelo menos, 10 segundos), a PRIMEIRÍSSIMA e MAIS IMPORTANTE conduta a ser implementada é a COMPRESSÃO TORÁCICA (forte, rebaixando em esterno em pelo menos 5 centímetros e rápida, numa frequência de PELO MENOS 100 por minuto). Apesar de a estimulação cardíaca externa PODER ser tentada, a interna não deve ser tentada a todo custo. Como o enunciado não fez menção à medida mais IMPORTANTE (compressão torácica), a questão foi anulada.

82034.

Comentário: Esta afirmativa está errada por alguns motivos. Em primeiro lugar, a definição de obesidade utiliza o Índice de Massa Corpórea (IMC) e não a circunferência abdominal. Em segundo lugar, a circunferência abdominal isoladamente, não define a presença de síndrome metabólica, sendo apenas um dos critérios de acordo com a definição proposta pela NCEP ATP3. De acordo com definição da IDF, a circunferência abdominal seria um critério obrigatório, necessitando de no mínimo outros 2 critérios (TG 150 HDL 40 em homens e 50 em mulheres PAS 130 ou PAD 85 ou tratamento para HAS Glicose de jejum 100 ou DM já diagnosticado) para ser dado o diagnóstico de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

síndrome metabólica. Em terceiro lugar, de acordo com a NCEP ATP3, os valores utilizados como corte para a circunferência abdominal preencher critério para o diagnóstico de síndrome metabólica seriam ou igual 102 em homens e ou igual 88 em mulheres já na definição da IDF, os pontos de corte seriam ou igual a 94 em homens e ou igual a 80 em mulheres. Incorreta.

82042.

Comentário: Esta questão causou muita confusão no ano desse concurso. O grande problema é que não existem dados estatísticos que comprovem essa afirmação Sabemos que a apneia do sono, sem dúvida, é uma condição com elevada associação a todos os componentes da síndrome metabólica (DM, obesidade, HAS e dislipidemia), sendo constatado que a maioria dos PORTADORES DE APNEIA DO SONO possuem síndrome metabólica, mas não podemos dizer que o contrário seja verdadeiro sem que haja algum respaldo reconhecido na literatura médica. Foram enviados diversos pedidos de recurso para mudança de gabarito e anulação da questão, mas a banca preferiu não se pronunciar e manteve o gabarito como CERTO.

79655.

Comentário: Questão conceitual... Sabemos que a miocardiopatia chagásica, além de levar à insuficiência cardíaca propriamente dita, cursa comumente com arritmias cardíacas dos mais variados tipos, incluindo disfunção do nodo sinusal, bloqueio atrioventricular completo intermitente, fibrilação atrial e arritmias ventriculares complexas. Logo, no Brasil, um idoso com tamanha instabilidade elétrica, deve ser avaliado em relação à possibilidade de Doença de Chagas. Alternativa A correta.

82099.

Comentário: Conceito clássico dentro da reanimação cardiorrespiratória a principal causa de morte súbita é a fibrilação ventricular Tanto que o tradicional A-B-C foi alterado para C-A-B, dando ênfase ao fato de que as compressões torácicas e a desfibrilação precoce são mais importantes na abordagem desse ritmo que qualquer outro procedimento. E para ilustrarmos a importância de um atendimento precoce, se após 7 minutos da parada não foram executadas as manobras de RCP, a chance de reverter a FV é de apenas 30 a 50%, sendo esperada uma grave sequela de anóxia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

cerebral. Porém, se a RCP foi executada corretamente desde o início, a chance de reversão aumenta para 70 a 80%, com pouca ou nenhuma sequela cerebral AFIRMATIVA CORRETA.

88690.

Comentário: A Parada Cardiorrespiratória (PCR) pode dar-se em quatro ritmos cardíacos fibrilação ventricular (a mais comum fora do ambiente hospitalar), taquicardia ventricular em pulso, assistolia e atividade elétrica sem pulso. Todas elas deverão contar com epinefrina adrenalina em seu tratamento, além das compressões torácicas (numa frequência entre 100-120 batimentos por minuto e com força suficiente para deprimir o esterno em pelo menos 5 cm, adultos) e ventilações (10 por minuto, 2 ventilações alternadas com 30 compressões, quando a vítima estiver sem via aérea definitiva e sem sincronização com compressões se houver via aérea definitiva). A desfibrilação deverá ser usada nos ritmos chocáveis , isto é, TV sem pulso e FV. Assistolia e AESP não são ritmos chocáveis . Lembramos que na parada cardíaca, deveremos buscar suas causas (5H e 5T). Assertiva CORRETA.

64687.

Comentário: Naturalmente, o paciente deverá fazer uso de drogas que comprovadamente alteram mortalidade em seu estágio IECA, beta-bloqueador e espironolactona. Essa combinação está presente nas alternativas C e E, sendo que esta última fornecida como gabarito acrescenta ainda um diurético de alça. Esse acréscimo é absolutamente discutível, pois tais diuréticos são usados para controle sintomático e, no enunciado, não é citado o estado clínico atual ou pregresso do paciente. Deste modo, fazemos essa ressalva em relação ao gabarito fornecido pela banca (opção E).

64255.

Comentário: Assertiva claramente errada de acordo com as diretrizes do ACLS 2010. Leigos não devem checar o pulso. Se o provedor do BLS for um profissional da área da saúde, ele pode avaliar o pulso, desde que essa avaliação não exceda o prazo máximo de 10 SEGUNDOS.

64272.

Comentário: Sabemos que uma massagem cardíaca bem feita, mantém a perfusão cerebral e do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

miocárdio, aumenta a chance de sucesso da desfibrilação (caso indicada) e amplia a janela de oportunidades para a reversão de qualquer ritmo de PCR. Uma massagem para ser considerada bem feita deve ser composta das seguintes características 1) depressão torácica (terço inferior do esterno) de pelo menos 5 cm (e não mais que 6 cm) 2) frequência de 100-120 compressões por minuto 3) permitir o retorno completo do esterno a cada compressão e 4) reduzir as interrupções das compressões ao mínimo inevitável. Logo, assertiva CORRETA.

29749.

Comentário: A HIPOCALCEMIA (Ca total 8,5md dl ou Ca ionizado 4,5 mg dl) promove um aumento da excitabilidade neuromuscular, determinando sintomas como as contraturas musculares prolongadas (tetania), parestesias, câimbras, espamo carpopedal, estridor laríngeo e até convulsões. Alguns pacientes não fazem tetania espontaneamente, mas apresentam essa alteração após a realização de algumas manobras. O sinal de Trousseau é um espasmo cárpico que ocorre após a insuflação do manguito no antebraço 20 mmHg acima da PA sistólica por 3 minutos. O sinal de Chevstek é a contração do lábio superior e músculos faciais ipsilaterais após percussão do nervo facial abaixo do arco zigomático. O ECG desses pacientes pode apresentar um QT longo. RESPOSTA item ERRADO (letra B).

19249.

Comentário: De acordo com a atual versão das diretrizes do ACLS (2010), após constatação de que um paciente não responde aos chamados e não respira (ou apresenta apenas gasping), podendo o profissional de saúde tentar checar o pulso por não mais que 10 segundos, devemos chamar ajuda e iniciar a massagem cardíaca de qualidade o mais rápido possível Caso o paciente já esteja monitorizado e o ritmo em tela seja de assistolia (linha reta), é válido checar os cabos do monitor, a fim de confirmar se as derivações estão corretamente plugadas e posicionadas... Confirmada a correta posição dos cabos, a massagem cardíaca deve ser iniciada de imediato, com o mínimo de interrupções possíveis, enquanto se providencia acesso venoso e infusão de adrenalina ou vasopressina (esta última apenas 1 vez), além de controle da via aérea de preferência com IOT... Após 2 minutos de RCP o ritmo é novamente checado, dando continuidade

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ao protocolo de reanimação em função do ritmo encontrado neste momento (persistência do ritmo não chocável Surgimento de FV TV). De toda forma, não podemos esquecer de pensar nas possíveis CAUSAS para o quadro, o que implica lembrar dos 5 Hs e 5 Ts... A história clínica deste paciente sugere pneumotórax hipertensivo como causa para a PCR... Logo, podemos tentar a punção torácica empírica (no hemitórax esquerdo) ao nível do segundo espaço intercostal... Resposta certa B.

19337.

Comentário: O traçado é de uma taquicardia sem onda P, com QRS estreito e ritmo regular, que são as características da Taquicardia Supraventricular Paroxística a popular taqui supra . Lembre que ela pode ser de 2 tipos reentrada nodal (maior parte dos casos, com predomínio no sexo feminino) e reentrada em via acessória (principal tipo na infância, até porque a via acessória é uma condição congênita). Logo, o mais provável é que, caso em questão, estejamos diante de uma taqui supra por reentrada em via acessória. Nesta situação, devemos administrar adenosina (1ª dose de 6 mg e, se necessário, uma 2ª dose de 12mg) ou partir para a cardioversão elétrica, mas apenas a primeira opção encontra-se entre as alternativas da questão... Só para enriquecer o comentário, lembre-se de que um outro diagnóstico possível para taquicardia regular sem onda P e com QRS estreito é a taquicardia juncional, mas, nesta situação, a frequência cardíaca não costuma passar de 120 bpm. Resposta certa letra E.

343407.

Comentário: Vamos pontuar a definição de cada uma das arritmias dispostas nas alternativas para determinarmos à qual delas a descrição apontada corresponde Letra A incorreta. O bloqueio atrioventricular representa um grupo de disfunção do ritmo cardíaco estudado no grupo das bradiarritmias. Considerando os componentes da junção atrioventricular, nodo AV e feixe de His , a localização do distúrbio determinará a benignidade ou malignidade do bloqueio. Assim, a onda P estará presente, mas com alentecimento ou bloqueio em sua condução. Letra B incorreta. A bradicardia sinusal caracteriza-se por presença de onda P positiva em D2 e D1, precedendo cada QRS. Apesar do ritmo normal, a frequência cardíaca é menor que 60 bpm. Letra C incorreta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Estamos habituados com o flutter atrial. Porém há uma descrição de taquicardia ventricular extrema com QRS alargado e monomórfico de aspecto sinusoidal denominado por alguns autores de flutter ventricular. Refere-se frequência em torno de 300 bpm e curtíssima duração desta, com progressão para fibrilação ventricular. Letra D correta. A taquicardia supraventricular trata-se de uma entidade arrítmica com mais de um mecanismo possível. Destes, a taquicardia por reentrada nodal corresponde a maioria dos casos. Na sequência temos o mecanismo de reentrada em via acessória, usualmente sucedendo uma extrassístole atrial ou ventricular. Tal como descrito, sua forma mais comum, a ortodrômica, inscreve-se eletrocardiograficamente por QRS estreito, R-R regular, podendo ser detectada onda P retrógrada, Resposta Letra D.

273313.

Comentário: Temos aqui um paciente com quadro clínico de estabilidade hemodinâmica, porém com taquicardia importante, sugestiva de uma taquiarritmia. Para um diagnóstico mais detalhado, dependemos da análise do eletrocardiograma fornecido Embora tenha sido fornecida apenas uma tira pequena do exame, podemos identificar uma taquicardia não-sinusal (não há ondas P visíveis), regular, com complexos QRS estreitos. Com essas informações, podemos encaixar essa arritmia no grpo das taquicardias supraventriculares (TSV). As duas possibilidades mais comuns são as taquicardia por reentrada nodal, e a taquicardia por reentrada atrioventricular (esta última epidemiologicamente mais provável em um paciente tnao jovem). E como é o tratamento Primeiramente, pode ser tentada manobra vagal, na tentativa de reversão para o ritmo sinusal. Em caso de insucesso com essa abordagem, a próxima opção é a adenosina, que é capaz de bloquear a condução pelo nó atrio-ventricular temporriamente, interrompendo o mecanismo de reentrada (seja reentrada nodal ou AV). Melhor resposta, letra C

230558.

Comentário: Apesar dos avanços no tratamento com anticoagulantes orais, a varfarina ainda é o anticoagulante mais utilizado no mundo, o que ocorre em função da sua boa eficácia e baixo custo. No entanto, alguns aspectos dificultam a sua utilização, como a grande interação com outras drogas, alimentos e alterações metabólicas, como em patologias agudas, o que faz com que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

apenas cerca de metade dos pacientes encontrem-se com os alvos de INR adequados durante a maior parte do tratamento. Quanto aos alvos preconizados, tratando-se de trombose venosa ou arterial, ou paciente com fibrilação atrial não valvar e não portador de valva mecânica, os alvos preconizados são entre 2 e 3. Para os paciente com prótese mecânica mitral ou prótese mecânica aórtica em associação com fibrilação atrial, os valores desejados são entre 2,5 e 3,5. Gabarito Alternativa B.

230579.

Comentário: Questão conceitual. Os principais parâmetros do ECG que devem ser avaliados diante de uma criança com alteração do ritmo são a) Análise do ritmo de base e quantificação da frequência cardíaca b) Análise da duração, amplitude e morfologia da onda P e duração do intervalo PR c) Determinação do eixo elétrico de P, QRS e T d) Análise da duração, amplitude e morfologia do QRS e) Análise da repolarização ventricular e descrição das alterações do ST-T, QT e U quando presentes. A avaliação do débito cardíaco não está contemplada nesses parâmetros (letras A, B, e C erradas). Resposta letra D.

203130.

Comentário: A presença de onda delta em ECG basal antes do período da taquiarritmia demonstra o diagnóstico de Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW). A onda delta marca um espessamento inicial do complexo QRS em virtude de uma ativação ventricular inicial a partir de uma via acessória, exatamente como descrito na letra E. No paciente que desenvolve fibrilação atrial nesse cenário, não podemos prescrever qualquer droga que reduça a condução pelo nodo atrioventricular, como beta-bloqueador e verapamil (citados nas letras C e D), uma vez que isso obrigaria que todos os estímulos fibrilatórios atriais percorressem a via acessória, permitindo a indução de uma arritmia ventricular de maior gravidade. Resposta certa LETRA E.

206170.

Comentário: O traçado apresentado é fibrilação ventricular. Seu tratamento é realizado, em adultos, com 200J de choque desfibrilatório (bifásico) ou 360J (monofásico). Resposta D.

212110.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Trata-se de eletrocardiograma com ausência de onda P, intervalo R-R irregular e QRS estreito, caracterizando típica fibrilação atrial. Assertiva correta. Resposta A.

175085.

Comentário: As canalopatias cardíacas são o resultado de mutações genéticas ou de um mau funcionamento adquirido dos canais iônicos, responsáveis por desencadear alterações na despolarização ou repolarização das fases do potencial de ação celular (B e C corretas). Enquanto as formas hereditárias decorrem de mutações nos genes que codificam a subunidade ou genes codificadores das proteínas reguladoras - subunidades dos canais iônicos, as formas adquiridas podem ser decorrentes da ação de drogas, anticorpos, entre outros (A correta). As formas adquiridas são de extrema importância e deve nos lembrar de questionar quanto ao uso de medicações habituais ou recentes em casos suspeitos de alterações eletrocardiográficas. Apesar de haver grande distinção entre suas apresentações clínicas e eletrocardiográficas, existem algumas similaridades que nos devem levantar a hipótese de canalopatias, sendo elas síncopes espontâneas ou desencadeadas pelo exercício e presença de arritmias ventriculares em coração estruturalmente normal (D incorreta). Dentre as canalopatias, a síndrome do QT longo (SQTL), a síndrome de Brugada e a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica são as mais importantes. Por exemplo , na SQTL tipo 1 (SQTL-1), os episódios tendem a ocorrer principalmente durante esforço, em particular natação. Na SQTL-2, estímulos auditivos súbitos ou aborrecimentos emocionais predispõem aos episódios. Na SQTL-3, a morte súbita durante o sono é o padrão. Resposta D.

175106.

Comentário: A síndrome do QT longo tem associação com uso de drogas, dentre elas, a amiodarona, os antipsicóticos, antifúngicos e antibióticos, como a claritromicina. O alargamento do intervalo QT pode resultar em arritmias ventriculares malignas, sendo essencial o conhecimento das possíveis causas e a sua identificação no eletrocardiograma. Para monitorização do intervalo QT deve haver correção pela frequência cardíaca, uma vez que quanto menor a frequência, maior o intervalo entre os complexos QRS e, consequentemente, o intervalo QT. Gabarito Alternativa A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175110.

Comentário: A onda P sinusal é positiva em D1 e D2 e negativa em aVR. Se houver situs inversus atrial (nódulo sinusal localizado no átrio esquerdo), o contrário é observado, isto é, a onda P torna-se negativa em D1 e D2, ficando positiva em aVR. A amplitude normal da onda P é de no máximo 2.5 mm. Enfim, nos ritmos atriais ectópicos a onda P pode ser negativa em D2, principalmente quando o foco ectópico tem localização no miocárdio atrial baixo, o que não é incomum em adolescentes saudáveis. Resposta certa B.

175111.

Comentário: O torsades de pointes é uma forma de taquicardia ventricular polimórfica que ocorre em um contexto de prolongamento do intervalo QT. Nesses casos, surgem variações cíclicas do complexo QRS, como se ele estivesse se torcendo em torno da linha de base do eletrocardiograma. Por estar geralmente associada à instabilidade hemodinâmica e ser causa de morte súbita, é tratada com desfibrilação elétrica. Além disso, o paciente deve receber sulfato de magnésio, mesmo na ausência de hipomagnesemia. Já a síndrome de Wolff-Parkinson-White, é caracterizada pela presença de uma via acessória ligando átrios e ventrículos, capaz de conduzir um potencial de ação sem passar pelo nodo Atrioventricular (AV). Com isso, ocorre o fenômeno da pré-excitação ventricular (o estímulo não é freado pelo nodo AV), responsável pelo encurtamento do intervalo PR e surgimento da onda delta. Sendo assim, a única alternativa correta é a opção (D).

183963.

Comentário: No traçado eletrocardiográfico apresentado, temos um aumento progressivo do intervalo PR, seguido de onda P que não gera intervalo QRS (onda P bloqueada), caracterizando um bloqueio átrio ventricular de segundo grau tipo Mobitz I. Tal alteração decorre de alteração do nó AV na condução do estímulo atrial. Dessa forma, trata-se de uma alteração do dromotropismo e não do cronotropismo. Item ERRADO.

183965.

Comentário: No traçado eletrocardiográfico apresentado, temos um aumento progressivo do intervalo PR, seguido de onda P que não gera intervalo QRS (onda P bloqueada), caracterizando

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

um bloqueio átrio ventricular de segundo grau tipo Mobitz I. Tal alteração decorre de alteração do nó AV na condução do estímulo atrial. Nos casos de extrassístole supraventricular há condução normal do estímulo atrial, gerando complexo QRS (despolarização ventricular). Item ERRADO.

175163.

Comentário: Vamos analisar essa questão segundo as Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial A) Incorreta. Define-se fibrilação atrial paroxística aquela que é revertida espontaneamente ou com intervenção médica em até 7 dias de seu início. B) Correta. Episódios com duração superior a 7 dias têm o nome de fibrilação atrial persistente . C) Incorreta. Alguns estudos utilizam a terminologia de fibrilação atrial persistente de longa duração para designar os casos com duração superior a 1 ano. D) Incorreta. Finalmente, o termo fibrilação atrial permanente é utilizado nos casos em que as tentativas de reversão ao ritmo sinusal não serão mais instituídas. Um último conceito Fibrilação atrial não valvar é definida por FA na ausência de estenose mitral reumática, válvula mecânica ou biológica ou plastia mitral prévia. Dessa forma, percebemos que somente a letra B encontra-se correta e portanto é o nosso gabarito.

175174.

Comentário: Na fibrilação atrial os átrios perdem sua atividade contrátil organizada. Desse modo, gera-se estase sanguínea dentro dessa câmara, a qual se mostra mais pronunciada na região da auriculeta do átrio esquerdo. O próprio processo de fibrilação atrial, ao resultar em remodelamento do tecido cardíaco atrial, culmina na formação de lesão inflamatórias endocárdicas, o que ajuda a compor a tríade de Virchow, isto é, além da estase sobrevém lesão endocárdica e aumento de fatores inflamatórios e pró-coagulantes. Assim, a agregação plaquetária está AUMENTADA no interior do átrio esquerdo, e existem AUMENTO local de fatores pró-coagulantes, criando um estado pró-trombótico e hipercoagulável próprio... Resposta certa D.

168486.

Comentário: A principal arritmia em crianças é a arritmia sinusal , uma alteração benigna e assintomática caracterizada por uma discreta variação da frequência cardíaca de acordo com a fase do ciclo respiratório (aumento da FC durante a inspiração, redução da FC durante a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

expiração). Quando a criança tem uma arritmia SINTOMÁTICA, o tipo mais frequentemente encontrado passa a ser a taquicardia supraventricular por reentrada nodal (TRN). O que caracteriza esta última é a presença de complexos QRS estreitos (origem supraventricular do estímulo), RR regular e ausência de ondas P ou f de flutter. Logo, o quadro descrito permite o diagnóstico desta última condição Como abortar uma TRN Diante de um paciente estável, podemos realizar a manobra vagal e ministrar uma droga que bloqueie o nódulo AV de forma rápida e transitória. A droga de escolha, por conseguinte, é a adenosina, cujo efeito dura poucos segundos, mas que geralmente é suficiente para interromper o circuito de reentrada presente no nódulo AV, permitindo a retomada do ritmo sinusal normal. Vale lembrar que se o paciente estivesse instável (ex. edema pulmonar, hipotensão arterial), a conduta seria a cardioversão elétrica sincronizada imediata Gabarito letra B.

159580.

Comentário: As alterações do ritmo cardíaco fetal são definidas como taquicardia fetal quando a frequência for maior que 160 batimentos por minuto e bradicardia fetal quando for menor que 110 batimentos por minuto. Uma das causas para a bradicardia fetal e neonatal é a presença de bloqueio átrio-ventricular total e pode estar associada a malformações cardíacas maiores, à doença de colágeno materna, como lúpus eritematoso sistêmico, e a cromossopatias. A associação entre bloqueio átrio-ventricular total e doença do tecido conectivo materna está bem determinada, principalmente quando há anticorpos maternos circulantes do tipo anti-Ro e anti-La. Portanto, não se pode excluir lúpus eritematoso sistêmico na gestante. Resposta letra B.

168519.

Comentário: O ECG mostra uma fibrilação atrial com alta resposta ventricular. Logo, temos que controlar a frequência cardíaca do paciente, a fim de evitar o surgimento de taquicardiomiopatia. Isso pode ser feito com relativa facilidade durante a própria internação, ajustando-se a dose do medicamento que o paciente poderá manter posteriormente sem necessidade de ajustes recorrentes na posologia. O ideal seria anticoagulá-lo também, até porque ele possivelmente apresentou episódios de isquemia cerebral aguda (acidente isquêmico transitório). No entanto, não

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dá pra anticoagular alguém que, enquanto lúcido e orientado, afirma que não vai comparecer às consultas médicas e vai continuar morando isolado num sítio distante este tipo de situação constitui na realidade CONTRAINDICAÇÃO CLÁSSICA À ANTICOAGULAÇÃO Logo, só poderíamos ficar em dúvida entre as letras A e C Por que marcar C Ora, muito simples betabloqueadores são os inibidores do nódulo AV de primeira escolha, na ausência de contraindicações Além de menos eficaz, o digital é reservado para associação com outras drogas, especialmente no paciente portador de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, não estando indicado, por conseguinte, em nosso paciente Resposta C.

111304.

Comentário: O bloqueio atrioventricular pode apresentar três graus de gravidade crescente. No primeiro grau ocorre apenas uma lentificação discreta da condução do estímulo, e todos os estímulos gerados acima do nódulo AV conseguem ultrapassá-lo e antigir os ventrículos. Em ritmo sinusal, isso provoca o prolongamento do intervalo PR, sem afetar a relação entre as ondas P e os complexos QRS-T, isto é, na prática, um BAV de 1 não produz batimentos perdidos - logo, não é sobre esse tipo específico de BAV que a questão está se referindo. Ora, os batimentos perdidos só podem ser justificados quando as ondas P não conduzem pelo nodo AV sistema de His-Purkinje, isto é, quando as ondas P não são acompanhadas de um QRS-T correspondente Isso é o que acontece nos BAV de 2 e 3 graus. Ora, quando o batimento é perdido, isto é, quando a onda P não conduz para o sistema His-Purkinje, observam-se ondas P sucessivas no eletrocardiograma, desacompanhadas de complexos QRS-T correspondentes Logo, a melhor resposta aqui seria a letra C, e não a letra D, como quis a banca.

111316.

Comentário: O paciente em questão se apresenta com bradiarritmia associada à instabilidade hemodinâmica. Nestes casos, o ECG é essencial para nos auxiliar na definição da etiologia da instabilidade. Existe onda P, no entanto esta não possui qualquer relação com o QRS. Se analisarmos com calma, podemos observar que a frequência atrial está em torno de 90 bpm e a ventricular, aproximadamente 53 bpm, nos mostrando que há completa dissociação atrioventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Observe que podemos ver a onda P em qualquer posição, inclusive dentro da onda T. Desta forma, estamos diante de um bloqueio atrioventricular total ou de terceiro grau. O escape é provavelmente juncional, por isso o QRS é estreito e a frequência cardíaca está maior que 40 bpm. Este paciente necessita de marca-passo temporário de urgência para resolução da instabilidade clínica.

97864.

Comentário: O ECG revela a presença de taquicardia (FC 100 bpm), com ausência de ondas p e ausência de ondas f de flutter , complexos QRS estreitos (120 ms, revelando a origem supraventricular da taquicardia) e intervalos RR irregulares ... Qual é a única arritmia que pode justificar todos esses achados É claro que é a fibrilação atrial Logo, o principal achado eletrocardiográfico aqui é uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular. É digno de nota, no entanto, que há também critérios para um diagnóstico de sobrecarga (hipertrofia) do ventrículo esquerdo, o que é condizente com a longa história de hipertensão arterial... Um dos critérios mais específicos é o famoso índice de Sokolow , definido pelo somatório de R em V5 ou V6 S em V1 maior que 35... Pois bem, sabemos que a FA é um poderoso fator de risco para AVE cardioembólico com a perda da contração atrial organizada, surge o fenômeno de remora do sangue no interior do átrio esquerdo, particularmente no apêndice atrial (auriculeta), local onde geralmente se formam trombos cujos fragmentos desprendidos originam os êmbolos responsáveis pelo AVE.

97862.

Comentário: Temos aqui um paciente idoso e hipertenso crônico que apresenta um quadro de fibrilação atrial com alta resposta ventricular (FC 110 bpm), sem instabilidade cardiovascular neste momento, acometido há cerca de 9 horas por um acidente vascular cerebral isquêmico . Podemos dizer tudo isso pelos seguintes motivos (1) o ECG revela uma taquicardia com ausência de ondas P e ondas F, QRS estreito e irregularidade dos intervalos RR elementos que permitem o diagnóstico de FA (2) o paciente tem um quadro de déficit neurológico focal agudo persistente, com TC de crânio sem hemorragias ou imagem de hipodensidade elementos que em conjunto garantem o diagnóstico de AVC isquêmico agudo. Pois bem, a questão quer saber que condutas devem ser

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

tomadas especificamente em relação à FA no contexto do AVC. Ora, diante de todo paciente com FA e AVC isquêmico, assume-se que a lesão cerebrovascular é consequência de fenômeno cardioembólico relacionado à formação de trombos no interior do átrio esquerdo. Temos então que documentar a existência do trombo, o que é feito de preferência com o uso do ecocardiograma transesofágico , e temos que manter a anticoagulação do paciente, seja com a warfarina que ele já está utilizando (e de forma adequada, diga-se de passagem, já que seu INR está dentro do alvo preconizado, que é entre 2-3), seja trocando por heparina parenteral (não fracionada ou de baixo peso molecular). A troca por heparina venosa é prudente se julgarmos que o paciente pode precisar de algum procedimento invasivo em curto prazo (a heparina faz a ponte até a realização do procedimento, isto é, ela mantém a anticoagulação enquanto o cumarínico é suspenso e perde seu efeito, o que leva alguns dias). Como a heparina não fracionada é uma droga de meia-vida curta, fica mais fácil retirar a anticoagulação do paciente caso venha a ser necessário (basta suspender a infusão que dentro de 6-12h o PTT normaliza). Enfim, como existe alta resposta ventricular, temos também que reduzir a frequência cardíaca, o que é feito, na FA, com drogas bloqueadoras do nódulo AV (betabloqueadores, digital ou antagonistas dos canais de cálcio). Vale lembrar que a amiodarona também pode reduzir a resposta ventricular, porém, não deve ser usada pelo fato de poder cardioverter quimicamente a arritmia, o que seria extremamente prejudicial em um paciente que acabou de sofrer um AVC cardioembólico (chance de um novo evento cerebrovascular por desprendimento de êmbolos atriais). GABARITO OFICIAL Diagnóstico de uma fibrilação atrial com rápida resposta ventricular. Condutas 1. Solicitar ecocardiograma, preferencialmente transesofágico. 2. Manter warfarina ou trocar para heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular. 3. Controlar a frequência cardíaca (usando bloqueador de canal de cálcio, betabloqueador ou digoxina). O uso de amiodarona pode reverter a FA.

97794.

Comentário: Diante de um paciente que colapsa subitamente a nossa frente, a primeira conduta a ser adotada é testar sua responsividade avaliando o nível de consciência . Assume-se que uma pessoa está em situação de PCR quando ela se encontra inconsciente e irresponsiva, e não

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

apresenta movimentos respiratórios (ou apresenta apenas gasping). Feito isso, o próximo passo consiste em chamar imediatamente por ajuda, pois ninguém, por melhor profissional médico que seja, consegue reverter sozinho uma parada cardiorrespiratória da forma adequada. Reconhecida a PCR, e acionada a equipe de emergência, é hora de iniciar os procedimentos de reanimação cardiopulmonar propriamente dita, visando, essencialmente, a manutenção de um fluxo sanguíneo mínimo para o encéfalo e outros órgãos nobres (como o próprio coração). O atual protocolo de BLS ACLS preconiza que a sequência da reanimação seja CAB (compressões torácicas, via aérea e respiração), e o leigo deve iniciar o CAB imediatamente após chamar ajuda (quanto antes as compressões torácicas começarem, maiores serão as chances de sobrevida). A etapa de verificar pulso central foi abolida do protocolo para leigos não treinados em medicina, pois viu-se que essas pessoas, de um modo geral, apresentam uma significativa dificuldade em realizá-la, o que ocasiona a perda de uma quantidade preciosa de tempo. Para médicos e outros profissionais treinados, no entanto, pode-se checar um pulso central do paciente como parte da confirmação diagnóstica de uma situação de PCR. Vale lembrar que tal verificação não deve demorar mais do que 10 segundos, e não dependemos dela para chamar o serviço de emergência diante de um paciente inconsciente. Resposta certa A.

64449.

Comentário: Diante de uma taquiarritmia (como a FA) acompanhada de sinais e sintomas de INSTABILIDADE (hipotensão arterial, dispneia aguda grave e ou dor torácica anginosa), a conduta imediata deve ser a cardioversão elétrica sincronizada (ou seja, não é certo utilizarmos o termo desfibrilação neste caso - a desfibrilação é uma cardioversão elétrica não sincronizada A sincronização do choque com os complexos QRS impede a ocorrência do fenômeno R sobre T , isto é, o choque não corre o risco de ser ministrado justamente no meio do período refratário do ventrículo, momento no qual algumas áreas já recuperaram a excitabilidade, enquanto outras ainda estão inexcitáveis. Se isso acontecesse, haveria risco de se formarem múltiplos circuitos de reentrada no miocárdio ventricular, o que poderia resultar numa degeneração do ritmo inicial para a temível FIBRILAÇÃO VENTRICULAR). Resposta certa B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

75557.

Comentário: O traçado eletrocardiográfico revela a presença de uma FIBRILAÇÃO ATRIAL, vamos conferir Podemos ver (1) taquicardia, (2) ausência de onda P, (3) ausência de onda F de flutter , (4) complexo QRS estreito, e (5) irregularidade do intervalo RR. O relato de déficit neurológico transitório, com resolução completa e espontânea em menos de 24h, acompanhado por TC de crânio normal, permite o diagnóstico de Acidente Isquêmico Transitório (AIT). Ora, não é preciso mais nenhuma informação clínica para concluir que se trata de paciente com alto risco cardioembólico e indicação de anticoagulação plena definitiva No CHA 2 DS 2 -VASC (o escore de avaliação do risco cardioembólico no portador de FA atualmente recomendado), a história de acidente isquêmico prévio já coloca automaticamente o paciente na categoria alto risco (esse fator soma 2 pontos no escore). Como a paciente é mulher e hipertensa, ela ainda ganha mais dois pontos (CHA 2 DS 2 -VASC 4). Logo, não há dúvida, vamos anticoagulá-la ad eternum com warfarina ou algum dos novos anticoagulantes orais (ex. dabigatran, rivaroxaban, apixaban). Resposta certa A.

137579.

Comentário: RR irregular sem onda P FIBRILAÇÃO ATRIAL. Esse é o diagnóstico da questão. E agora, o que fazer Primeiro determinar se tem ou não instabilidade hemodinâmica. Nessa situação, não. Então vamos avaliar agora a frequencia cardíaca. O alvo preconizado é abaixo de 110bpm. Ele está com 105. Não vamos controlar a frequencia. Depois da avaliação da frequência vamos avaliar a anticoagulação. Como ele está com o quadro a mais de 48 horas, devemos iniciar anticoagulação plena, inclusive tem que se manter de forma indefinida, pois o mesmo é de alto risco para eventos tromboembólicos (diabético e HAS). Portanto, resposta letra D.

138414.

Comentário: O que podemos ver nesse ECG Um ritmo regular, de QRS alargado e FC superior a 150bpm. Esse ritmo provocou uma parada no nosso paciente.... Qual deve ser o diagnóstico Uma taquicardia ventricular (TV) sem pulso uma taquicardia muito rápida com complexos QRS alargados, o que sugere TV ou, mais raramente, taquicardia supraventricular conduzida com

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

aberrância. A morfologia dos complexos QRS é idêntica, mostrando que todos têm origem o mesmo foco (provavelmente uma região doente do miocárdio ventricular). A TV deve ser tratada da mesma forma que a fibrilação ventricular, ou seja desfibrilação imediata Resposta letra E

31041.

Comentário: Temos um paciente em quimioterapia para LLA que apresenta indícios laboratoriais da síndrome de lise tumoral. Lembre-se de que essa síndrome é mais comum durante o tratamento das neoplasias hematológicas, pelo fato dessas doenças cursarem com elevada taxa de proliferação celular. A destruição de um grande número de células, ao mesmo tempo, resulta na liberação maciça de seus componentes intracitoplasmáticos no sangue, o que pode desencadear graves alterações homeostáticas. Os principais elementos liberados são ácido úrico (que pode formar cristais intratubulares renais, levando à IRA oligúrica), ácido lático (acidose metabólica), fósforo (hiperfosfatemia e hipocalcemia, esta última pela precipitação de fosfato de cálcio insolúvel nos tecidos) e potássio (hipercalemia). Perceba que todas as alterações citadas serão exacerbadas na vigência de insuficiência renal grave Logo, a síndrome de lise tumoral sempre deve ser prevenida (agentes hipouricemiantes, como o alopurinol, além de hidratação venosa generosa antes, durante e depois da QT). Mas a despeito de todos os cuidados profiláticos, eventualmente teremos um paciente com uma carga de doença tão grande que o surgimento da síndrome durante a QT torna-se virtualmente inevitável. Para estes casos, é preciso estar atento e monitorizar a função renal e a bioquímica sérica, intervindo tão logo se suspeite do diagnóstico As medidas terapêuticas consistem no tratamento individual de cada distúrbio eletrolítico, além de pronto suporte renal (ex. hemodiálise), se necessário, e medidas específicas para reduzir rapidamente o ácido úrico (ex. urato oxidase ou rasburicase uma enzima recombinante que transforma o ácido úrico tóxico em alantoína atóxica). No paciente em questão observamos uma alteração eletrocardiográfica muito provavelmente secundária a um dos distúrbios eletrolíticos mais comuns da lise tumoral. NÃO temos propriamente um flutter atrial, pois NÃO estamos vendo as ondas f de Flutter (o clássico serrilhado). O que se vê aqui é uma onda T alta e apiculada, sugestiva de hipercalemia Após essa onda T vemos a onda P (não são duas ondas P). Portanto, afirmativa

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ERRADA.

138584.

Comentário: Observando o ECG da questão temos (1) Taquicardia (2) Ritmo IRREGULAR, evidenciado pelos intervalos R-R irregulares (3) QRS estreito 120 mS (4) Ausência de ondas P e (5) Ausência de ondas F. Assim, não dá para errarmos o diagnóstico eletrocardiográfico de Fibrilação Atrial O que fazer para este paciente O primeiro passo do tratamento é baixar a resposta ventricular (controlar a FC), que irá melhorar os sintomas em grande parte dos pacientes. O objetivo atual é manter uma FC de repouso 110 bpm, o que pode ser alcançado com a administração de digitálicos, antagonistas do canal de cálcio ou betabloqueadores. Como não há instabilidade hemodinâmica, não há necessidade de cardioversão elétrica imediata. Como a duração da Fibrilação Atrial (FA) é superior a 48 horas está indicado a anticoagulação antes da cardioversão. A anticoagulação deverá ser feita 3-4 semanas antes e 4 semanas após a cardioversão. Caso esteja disponível, podemos realizar um ECO transesofágico na ausência de trombos podemos heparinizar o paciente por 12 horas e depois proceder a cardioversão. A anticoagulação por 4 semanas após a cardioversão continua sendo necessária.

22169.

Comentário: A qualidade da imagem está um pouco ruim, mas mesmo assim podemos observar alguns detalhes... O ritmo é IRREGULAR (veja os intervalos R-R, como são de tamanhos diferentes) o QRS está ESTREITO NÃO HÁ onda P e nem ondas F (de flutter) e a FC está elevada (FC aproximada de 240 bpm). Diante destes achados eletrocardiográficos temos um quadro de FIBRILAÇÃO ATRIAL Só mais um detalhe, vocês lembram como estabelecer a FC de um ECG com ritmo irregular É só contar o número de complexos QRS em 3 segundos, o equivalente a 15 quadrados grandes, e multiplicar por 20. Resposta item errado (letra B).

19226.

Comentário: Paciente apresentou um quadro de síncope após um episódio de tosse excessiva. O que pensar Nessa faixa etária precisamos descartar doenças cardiovasculares, principalmente bradicardia devido à degeneração do sistema de condução. Perceba que o exame físico é normal,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sem nada que guie nosso raciocínio para alguma patologia cardíaca. Nesse caso, o que ocorre é um reflexo vagal pela tosse excessiva, gerando uma síncope neurocardiogência, conhecida como síncope situacional. Não há correlação com distúrbio metabólico. Portanto, a assertiva encontra-se ERRADA e o nosso gabarito é a letra B.

19227.

Comentário: Paciente apresentou um quadro de síncope após um episódio de tosse excessiva. O que pensar Nessa faixa etária precisamos descartar doenças cardiovasculares, principalmente bradicardia devido à degeneração do sistema de condução. Perceba que o exame físico é normal, sem nada que guie nosso raciocínio para alguma patologia cardíaca. Nesse caso, o que ocorre é um reflexo vagal pela tosse excessiva, gerando uma síncope neurocardiogência, conhecida como síncope situacional. Portanto, a assertiva encontra-se CORRETA e o nosso gabarito é a letra A.

352188.

Comentário: Vejamos cada uma das alternativas sobre fibrilação atrial (FA) Letra A correta. A definição desta alternativa traz exatamente o conceito descrito pea diretriz, que diz que a FA paroxística é aquela que é revertida espontaneamente ou com intervenção médica em até sete dias de seu início. Letra B correta. FA persistente é aquela com episódios com duração superior a sete dias e pode exigir intervenção médica para ser revertida. Letra C correta. O termo FA permanente é utilizado nos casos em que as tentativas de reversão ao ritmo sinusal não serão mais instituídas, caracterizada quando a condição torna-se crônica e as tentativas de restaurar o ritmo sinusal podem não ser mais uma opção preferencial de tratamento. Letra D incorreta. Na verdade, a FA aguda é geralmente referida quando a condição é de início súbito e ocorre dentro de um período mais curto, frequentemente dentro de 48 horas. Portanto, não é necessariamente restrito a menos de sete dias. Resposta letra D.

345697.

Comentário: Os métodos complementares utilizados para os diagnósticos de doenças cardiovasculares em mulheres devem considerar tanto a probabilidade pré-teste de eventos, quanto as singularidades dos resultados dos exames subsidiários. Em relação ao eletrocardiograma, a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

presença das mamas e a menor massa cardíaca implicam em menor amplitude do QRS, especialmente nas derivações precordiais, o que torna a letra A incorreta. Da mesma maneira, a amplitude do ponto J e da onda T também é menor que nos homens, sendo a letra C inadequada. Opostamente, o intervalo QT corrigido é maior no sexo feminino, considerando-se normais valores até 470ms, estando a letra B inadequada e a D adequada. Resposta letra D.

346839.

Comentário: O caso clínico traz um homem idoso, portador de diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS) com sintoma de tontura ao adotar a posição ortostática. Seu exame físico documenta significativa queda da pressão arterial sistólica e diastólica durante a mudança posicional, sendo feito diagnóstico de hipotensão postural. À lembrar, esta entidade é definida por queda igual ou maior que 20 mmHg na pressão arterial sistólica e ou 10 mmHg na diastólica com a ortostase. Na gênese desta afecção são descritos distúrbios barorreflexos, depleção volumétrica e paraefeitos medicamentosos. Sobre as possibilidades de condutas para nosso cenário, vamos determinar a incorreta Letra A incorreta. Note que nosso paciente possui o diagnóstico de DM 2 mal controlado, dado o valor de hemoglobina glicada. Neste contexto, a hipotensão ortostática pode representar uma manifestação disautonômica da doença, devendo a terapia antidiabética ser otimizada. Mas veja que, apesar dos inúmeros benefícios descritos com o uso das glifozinas, esta classe de medicações possui como efeitos adversos depleção de volume e hipotensão. Desta forma, a dapaglifozina poderia potencializar os sintomas e demais consequências da queda da pressão arterial com a ortostase, representando uma má opção medicamentosa para o contexto descrito. Letra B correta. Visto que a contração do volume intravascular é apontada entre os mecanismos da falência da resposta pressórica à ortostase, recomenda-se o aumento da ingestão de água e sal entre as medidas terapêuticas não farmacológicas para evitar seu desenvolvimento. Deseja-se que tal ação provoque indução do reflexo osmopressor, aumentando a atividade simpática. Letra C correta. A recomendação de posicionar a cabeceira entre 30 e 45 graus durante o sono objetiva reduzir a perfusão renal e, consequentemente, a diurese noturna, a qual pode ser exarcebada nestes pacientes. Trata-se de uma instrução com finalidade de manter ajustado o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

volume circulante. Letra D incorreta. Esta alternativa foi considerada adequada pela banca, mas podemos tecer algumas críticas. Os diuréticos devem ser reavaliados nos portadores de hipotensão postural, especialmente os de alça. Comparativamente à estes, os tiazídicos são julgados de baixo risco, principalmente quando em uso crônico. Já os inibidores da enzima conversora de angiotensina podem implicar em vasodilatação, principalmente no momento de sua introdução, sendo passíveis de substituição. A troca do enalapril por captopril poderia ser ponderada como uma estratégia adequada, em função da pequena meia-vida da última, porém, a posologia de uma dose diária é considerada subdose para o tratamento da HAS. Cabe a ressalva de que mesmo nos pacientes com hipotensão ortostática a hipertensão deve ser tratada. A alternativa era sujeita a recurso, o qual não foi apreciado pela banca examinadora. Resposta letra A.

345701.

Comentário: Veja que a questão traz apenas pequenas variações de uma mesma assertiva. O fato é que a interpretação dos exames complementares cardiológicos difere entre homens e mulheres, tanto em função da probabilidade pré-teste, quanto pelas particularidades dos resultados no sexo feminino. Pela presença das mamas e menor massa ventricular esquerda, espera-se menor amplitude do QRS, do ponto J e da onda T. Além disso, a inversão de T anterior é mais comum na população feminina, sendo considerado um padrão benigno em assintomáticas de baixo risco, estando somente a letra C correta. Estudos realizados com ressonância magnética cardíaca sugerem que tal alteração decorra do deslocamento lateral do ventrículo direito, o qual ocorre com menor frequência no sexo masculino. Resposta letra C.

345705.

Comentário: Veja que o eletrocardiógrafo representa um galvanômetro com capacidade de filtrar e registrar a atividade elétrica do coração em um papel milimetrado. Desta forma, a inscrição do traçado decorre da diferença de potencial elétrico alcançada pelos eletrodos de superfície. Como sabemos, esta condução de energia sofre influência de planos cutâneos, subcutâneos, musculares, ósseos e outros, que modificam a impedância entre a monitorização e o coração. Assim, são clássicas as descrições de variações causadas por derrame pericárdico, hipertrofia da musculatura

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

peitoral, obesidade e inúmeras mais. A presença de implante mamário é passível de gerar alterações no ECG por sua composição e pela mudança de posicionamento dos eletrodos. Dado isto, descrevem-se especialmente inversão de ondas T, depressão do segmento ST inferolateral e baixa progressão de R de V1-V4 relacionados à sua presença, o que torna a letra A errada. Em função das alterações da onda T, o intervalo QT pode estar prolongado, sendo ainda possível que o material protético implique em redução de resistência elétrica, com consequente aspecto de aumento de amplitude do QRS e hipertrofia de ventrículo esquerdo, estando a letra B incorreta. Tais manifestações podem levar a interpretações enganosas, com necessidade de avaliação cardiológica por outros métodos, sendo, por isso, a letra C adequada e a letra D inadequada. Resposta letra C.

337624.

Comentário: Nossa paciente apresenta um quadro franco de hipertireoidismo (perda de peso, tremor e aumento do apetite com TSH suprimido e T4L aumentado). Importante lembrar que o estado de hipertireoidismo favorece o surgimento de algumas arritmias, já que os hormônios da tireoide tem um efeito permissivo à ação das catecolaminas (em última análise, isso aumenta o tônus adrenérgico no coração). Pois bem olhe, agora, para o ECG dessa paciente taquicardia com QRS estreito, ritmo irregular e ausência de ondas P isso é uma fibrilação atrial, o que explica a queixa de palpitação. Como deve ser a nossa conduta Já que não sabemos o delta-T dos sintomas, não podemos indicar nenhuma conduta que envolve reversão do ritmo a fibrilação atrial sustentada favorece a formação de trombos intracavitários que podem se desprender com o controle do ritmo e gerar fenômenos tromboembólicos (a cardioversão elétrica emergencial até poderia ser indicada se houvesse instabilidade hemodinâmica, mas também não é esse o caso). Nossa conduta deve envolver início de betabloqueador para controle da frequência e anticoagulação pelo risco de fenômenos tromboembólicos (pode ser feita com warfarina ou mesmo com anticoagulantes orais diretos). Além disso, indicamos também o tratamento do estado de hipertireoidismo, que não dependerá nem de exames sorológicos, nem de ultrassonografia O diagnóstico é clínico e laboratorial. Resposta iniciar atenolol para controle de frequência, warfarina como anticoagulante e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

iniciar metimazol.

345706.

Comentário: Vamos juntos extrair um pouco mais de informações desta questão A taquicardia sinusal é definida por frequência cardíaca (FC) maior que 100 bpm na presença de ritmo sinusal, determinado por onda P positiva em D1 e D2, seguindo-se de complexo QRS. Tem como gênese a resposta fisiológica compensatória a outro evento, podendo ainda ocorrer na síndrome da taquicardia postural ortostática e na taquicardia sinusal inapropriada. A taquicardia supraventricular (TSV) trata-se de arritmia caracterizada por aumento de FC, com QRS estreito, R-R regular e ausência de onda P aparente. Decorre, em dois terços dos casos, de reentrada em via nodal, podendo ainda advir de reentrada em via acessória. Tanto a taquicardia sinusal quanto a TSV por reentrada nodal são mais comuns nas mulheres, especialmente jovens, tendo seu risco aumentado na gestação, o que torna a letra B adequada e as outras alternativas inadequadas. No primeiro caso, tratamos de mecanismo compensatório ao aumento de volume sanguíneo circulante e a anemia dilucional. Já no segundo, representativo da arritmia sintomática mais comum da gravidez, encontramos um cenário usualmente deflagrado por uma extrassístole em um coração estruturalmente normal. Resposta letra B.

346856.

Comentário: Tratamos de um criança com repentina taquicardia sintomática sem sinais de instabilidade hemodinâmica. Dada a apresentação clínica e a descrição eletrocardiográfica, vamos analisar os diagnósticos apontados nas alternativas Letra A incorreta. A taquicardia sinusal tem o mecanismo compensatório como sua principal etiologia, razão pela qual seu desenvolvimento raramente é manifestado como taquicardia súbita. O eletrocardiograma (ECG) é determinado por taquicardia, com complexo QRS estreito, sendo presente a onda P sinusal, isto é, positiva em D1 e D2. Letra B incorreta. O bloqueio atrioventricular (BAV) usualmente cursa com bradicardia, podendo ser expressa em crianças por tonteira, síncope e letargia. O BAV Mobitz I caracteriza-se pelo fenômeno de Wenckebach, no qual há aumento progressivo do intervalo PR, até bloqueio da P. Desta forma, há onda atrial, a qual é bloqueada, de modo que o intervalo PR antecessor é maior

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

que o sucessor ao bloqueio. Letra C incorreta. A taquicardia ventricular (TV) monomórfica é incomum na população pediátrica, podendo estar associada com substrato estrutural por cardiopatias congênitas. O traçado da TV é inscrito com QRS alargado e aberrante, e não estreito, sendo este precisamente repetido em cada derivação na forma monomórfica. Letra D correta. A taquicardia supraventricular representa o distúrbio do ritmo mais comum na faixa pediátrica. Usualmente é marcada por palpitações e fadiga, sendo a designação no ECG exatamente a indicada. Nas crianças a manobra vagal mais frequentemente sugerida consiste na aplicação de gelo sobre a face. Nos casos estáveis refratários orienta-se a administração de adenosina. Resposta letra D.

335100.

Comentário: A fibrilação atrial (FA) persistente é caracterizada pela presença da arritmia com duração superior a sete dias e manutenção indefinida nos casos de não reversão. Nos portadores desta entidade devemos aplicar o escore CHA2DS2-VASc a fim de determinar a necessidade de uso de anticoagulantes para prevenção da ocorrência de eventos cardioembólicos. O escore representa um acrônimo para C ongestão (ICC ou IVE) 1 ponto H ipertensão 1 ponto A ge - Idade ou 75 anos 2 pontos - Idade 65 - 74 anos 1 ponto D iabetes mellitus 1 ponto S troke (AVC ou AIT) 2 pontos V asculopatia (IAM, DAOP, ateromatose aórtica) 1 ponto S exo c ategoria feminino 1 ponto. Na presença de zero ponto em homens ou um ponto em mulheres, não há necessidade de anticoagulação. Diante de um ponto em homens ou dois pontos em mulheres, podemos optar por não prescrever anticoagulantes, prescrever AAS ou anticoagular, com preferência pelo último. Na presença de dois ou mais pontos em homens e três ou mais pontos em mulheres, devemos anticoagular. Nosso paciente pontua em 3 no escore CHA2DS2-VASc insuficiência ventricular esquerda, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Assim, está formalmente indicada a anticoagulação, que poderá ser realizada com varfarina ou anticoagulantes diretos, o que torna a alternativa C incorreta. Uma vez que não há descrição de eventos isquêmicos prévios, não há benefícios na manutenção do uso do AAS, o qual está aplicado com finalidade de prevenção primária, estando a letra A inadequada. Do mesmo modo, o uso de um segundo antiagregante

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

plaquetário, como o clopidogrel, não imputa efeito protetor a ocorrência de eventos cardioembólicos no cenário de uma FA, sendo a assertiva D errada. Resposta letra B.

336303.

Comentário: A questão descreve paciente que, enquanto monitorizado, evolui para o ritmo demonstrado no eletrocardiograma, a fibrilação ventricular (FV) um ritmo de parada cardíaca - parece que alguns complexos QRS estão derretidos , caracterizando uma verdadeira dificuldade de organização elétrica dos miócitos ventriculares em formarem um estímulo sincrônico e capaz de bombear o sangue de forma normal. Como a situação toda se deu durante a observação, não é necessário checar o pulso. O recomendado é, mesmo antes de começar a massagem, aplicar o choque desfibrilatório prontamente disponível, que é capaz de reverter a situação na maioria das vezes. A energia desfibrilatória recomendada é de 360 J caso o aparelho seja monofásico e de 120 a 200 J no bifásico (conforme a recomendação do fabricante). A cardioversão elétrica, ao contrário da desfibrilação é um choque sincronizado com o complexo QRS recomendada para tratamento de taquiarritmias estáveis e com ritmo organizado . Resposta letra C.

304993.

Comentário: Questão acertadamente anulada pela Banca Vamos entender... De forma geral, o flutter atrial dificilmente ocorre em um coração estruturalmente normal. Algumas referências indicam que qualquer condição que possa causar fibrilação atrial (FA) também pode levar ao desenvolvimento do flutter. Portanto, todas as opções listadas são etiologias possíveis, embora a FA seja mais comumumente encontrada. Só para lembrarmos outras etiologias destas arritmias cardiomiopatia hipertrófica, cardiopatias congênitas (ex defeito do septo atrial), entre outras.

304854.

Comentário: Questão que gera muita discussão. Muita mesmo e deveria ter sido anulada. O acesso central pode ser puncionado na veia femoral e isso não iria atrapalhar as compressões torácicas e o acesso. Se pensarmos somente na punção de veias jugulares e subclávias, vamos avalair. Tanto as letras B, C e D, são corretas e devem ser consideradas. Veja, a punção em um cenário de emergência, em que você não consegue delimitar os marcos tal qual um cenário eletivo, o risco de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

complicaçõe como pneumotórax e punção arterial é maior. A dificuldade técnica e este risco existem, mas não impedem a punção. Agora o fato de interromper as compressões, aí é um evento inacenitável. Melhor resposta seria a letra A. Mas a questão deveria te sido anulada.

283892.

Comentário: Taquiarritmia supraventricular, em geral, é sinônimo de taquicardia supraventricular por reentrada nodal, pois esta é a forma mais comum de taquicardia supraventricular depois da taquicardia sinusal. Sabemos que a taqui supra pode ser abolida com manobras vagais ou uso de adenosina. As letras A, B e C representam manobras vagais. Respirar dentro de um saco plástico é uma forma de aumentar o CO2 no sangue, o que não tem qualquer efeito sobre esse tipo de arritmia.

227077.

Comentário: Temos um paciente com exame físico compatível com fibrilação atrial (palpitação e ritmo cardíaco irregular). Neste caso, está exposto o conceito de fibrilação atrial (FA) de etiologia valvar, ou seja, secundária a um quadro de estenose aórtica, além de insuficiência mitral, o que resultou em crescimento também de ventrículo esquerdo, visto que a estenose mitral caracteristicamente poupa o ventrículo esquerdo, ocasionando crescimento atrial importante. Assim, o tratamento consiste em controle da frequência cardíaca ou do ritmo, associado a anticoagulação, uma vez que o paciente possui dois pontos no escore de CHA2DS2VASc apenas pela idade. Quanto às drogas a serem utilizadas para este fim, sabemos que os anticoagulantes de ação direta, como a rivaroxabana e a apixabana, não devem ser utilizadas na FA valvar e que o controle de frequência cardíaca em pacientes com disfunção ventricular esquerda não deve ser realizado com bloqueadores do canal de cálcio. Gabarito Alternativa A.

234408.

Comentário: Recebemos um caso de paciente portadora de insuficiência cardíaca que se apresenta com bradicardia importante ao exame físico, com variação do som da primeira bulha (que corresponde ao fechamento das válvulas atrioventriculares). Apesar disso, encontra-se assintomática. Em seu eletrocardiograma, podemos avaliar frequencia ventricular próxima de 30

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

bpm, porém frequência atrial próxima a 80 bpm, devido a dissociação atrio-ventricular completa (BAVT). Além disso, é possível observar padrão de bloqueio completo do ramo esquerdo (BRE). Primeiramente, antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, devemos responder 2 perguntas 1) Trata-se de uma emergência clínica com risco de vida Visto que a paciente encontra-se hemodinamicamente estável e assintomática, não se trata de uma emergência que requeira tratamento imediato com aminas vasoativas e colocação de marcapasso provisório. (A e B INCORRETAS) 2) Existe causa secundária para esta bradiarritmia Nosso paciente faz uso de duas medicações cronotrópicas negativas que podem estar implicadas no diagnóstico Tanto os betabloqueadores quanto os digitálicos podem prolongar o intervalo PR, reduzindo a condução do estímulo cardíaco pelo nó atrioventricular. No momento, ambas as medicações devem ser interrompidas e a paciente deve ser mantida em observação para avaliar se o BAVT será revertido. Não há indicação de estudo eletrofisiológico nesse caso, que apenas serviria para confirmar a presença de BAVT. (C INCORRETA, D CORRETA) Resposta correta letra D

232140.

Comentário: Questão de interpretação eletrocardiográfica Repare que existe taquicardia e existe também onda P, mas a onda P apresenta grande variação de morfologia. Isso é claramente perceptícel em DII longo, que é a última linha do traçado disponível na imagem. Isso é compatível com taquicardia atrial multifocal que, assim como a fibrilação atrial, produz um ritmo bastante irregular. Resposta certa LETRA D.

232141.

Comentário: Questão pura de eletrocardiograma... O traçado mostra ondas P e QRS com ritmos totalmente dissociados, refletindo átrios e ventrículos contraindo de forma completamente independente trata-se de bloqueio atrioventricular total (BAVT). Veja, na imagem do comentário, as setas roxas representando o ritmo ventricular e as vermelhas, o ritmo atrial... O segundo QRS apresentado parece estar conduzindo a onda P, mas perceba que se trata, na verdade, de mera coincidência a presença daquela onda P próxima ao QRS não modificou em nada o ritmo ventricular. O bloqueio atrioventricular (BAV) avançado se expressa ao eletro quando a maioria das

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ondas P não é sucedida por QRS, na proporção de 3 1 ou 4 1, ou seja, de cada 3-4 ondas P, apenas uma conduz no eletro apresentado, não há sequer uma onda P conduzindo normalmente (A errada). O BAV do segundo grau se caracteriza por ondas P que ora conduzem aos ventrículos, ora não no eletro, esse fenômeno aparece com ondas P ora sucedidas de QRS, ora não (B errada). O BAV do tipo 2 1 é espécie de BAV em que, de cada 2 ondas P, apenas uma conduz (C errada). O BAV de primeiro grau, eletrocardiograficamente, é caracterizado por intervalo PR maior que 200 ms (5 quadradinhos), mas com todas as ondas P sucedidas por QRS (D errada). Resposta E.

227322.

Comentário: Questão puramente eletrocardiográfica... Veja que há ondas P precedendo todos os QRS mas que, em certos momentos, a condução da onda P é bloqueada, traduzindo bloqueio atrioventricular do segundo grau isso quebra a ritmicidade dos batimentos, justificando o ritmo cardíaco irregular. Ademais, o intervalo PR sobre alargamento progressivo, sinalizando BAV de 2º grau Mobitz I. Resposta B.

199493.

Comentário: Questão direta sobre síncope. Obviamente a ausência de pródromos não exclui a hipótese de síncope cardiogênica, muito menos podemos cravar disautonimia ou hipoglicemia como causa. Vale ressaltar que a hipoglicemia é um diagnóstico diferencial de síncope, e não uma causa, sendo ainda geralmente acompanhada de outros sinais e sintomas como sudorese e cefaleia. Por fim, obviamente TEP deve entrar no diagnóstico diferencial, ainda mais considerando a paciente hipoxêmica, taquicárdica, taquipneica e discretamente hipotensa. Resposta opção D.

220298.

Comentário: O enunciado nos trouxe o caso de uma paciente com história de hipertensão e diabetes em acompanhamento e tratamento irregular, com vários estigmas de doença microvascular diabética (gastroparesia, neuropatia periférica, e nefropatia diabética), que evolui com quadro de perda transitória da conciência (síncope) com pródromos, ao mudar da posição sentada para ortostática. A síncope relacionada à mudança postural decorre mais provavelmente de uma incapacidade do sistema autônomo organismo de adaptar-se à mudança postural, e no

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

caso acima, pode ser mais uma das manifestações neurológicas relacionadas ao diabetes, a DISAUTONOMIA. Não há relato de abalos musculares, liberação esfincteriana ou período pós-ictal para considerar o diagnóstico de crise convulsiva, ou relato de palpitações ou ausência de pródromos que sugiram síncope arritmica (o ECG normal também fala contra esse diagnóstico). A síncope vasovagal está relacionada principalmente com períodos prolongados de ortostase, gerando um refleco abrupto de hipotensão. Embora possível, é menos provável nesse caso de uma paciente com história clínica tão sugestiva. O tratamento sugerido é de fato o uso de medicação que mantenha o tônus vascular e a volemia (fludrocortisona), incluindo o auxílio mecânico das meias elásticas, que favorecem o retorno venoso. Resposta correta letra D

199633.

Comentário: Questão de reconhecimento de padrão de ECG. Não é um diagnóstico comum do dia a dia, porém, é importante saber bem que tipo de ritmo é esse para evitar iatrogenias. O ECG apresentado objetivamente possui Complexo QRS normal Onda P antes de todo QRS Intervalo PR normal Onda T de morfologia normal Intervalo QT normal. A única coisa alterada é a IRREGULARIDADE DO INTERVALO R-R. O diagnóstico é de ARRITMIA SINUSAL. Comum em jovens após esforço respiratório e estresse agudo, como um pós-operatório (caso da questão). A única alteração é R-R irregular com alteração 0,12seg em cada ciclo. Resposta LETRA A.

196806.

Comentário: Questão que falou sobre o uso do CHADS 2, que serve para a avaliação do risco de acidente vascular cerebral em pessoas com fibrilação atrial. Vamos, então, relembrar que a avaliação é feita através de pontos sendo BAIXO RISCO quando não houver nenhum ponto MÉDIO RISCO quando houver um ponto e ALTO RISCO quando houver dois ou mais pontos. Utilizando-se a tabela, observa-se que a pontuação ocorre em ICC 1 ponto HAS 1 ponto Idade 75 anos 1 ponto DM 1 ponto AVE AIT 1 ponto Resposta letra D.

172784.

Comentário: Em primeiro lugar, temos que fazer o diagnóstico eletrocardiográfico taquiarritmia e sem ondas P, intervalos RR irregulares e QRS estreito. O diagnóstico é Fibrilação Atrial (FA). Seus

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

fatores de risco são idade avançada, HAS, DM, tireotoxicose, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, doença valvar, DPOC e apneia obstrutiva do sono. Libação alcoólica é gatilho para o desenvolvimento da arritmia. A obesidade também é um fator de risco bem estabelecido. Assim, como tanto a alternativa A quanto a B respondem à questão, em nossa opinião ela deveria ter sido anulada. A banca manteve B como gabarito.

172544.

Comentário: Analisaremos opção por opção Letra A Desde 2015, a vasopresina não é mais recomendada no algoritmo da reanimação cardiopulmonar porque nem o uso isolado de vasopressina, nem o combinado de vasopressina e epinefrina se mostrou superior ao uso somente de adrenalina. INCORRETA Letra B A amiodarona é o antiarrítmico de escolha na FV e na TV sem pulso que não responde à adrenalina. Apesar de o ACLS continuar recomendando seu uso, poucos estudos comprovam seu benefício nessas situações, sendo isso válido para pacientes com cardiopatia isquêmica também. CORRETA Letra C Repetindo o conceito - De falto há pouca evidência do seu benefício na FV e na TV sem pulso. O ACLS sugere que pode ser útil em certas situações mas nem mesmo as especifíca e, dessa forma, continua sendo recomendado seu uso. INCORRETA Letra D A atropina não é indicada para uso rotineiro na assistolia porque nenhum trabalho prospectivo conseguiu mostrar seu benefício (continua, no entanto, sendo útil na bradicardia sintomática). INCORRETA Letra E A obtenção de uma via aérea avançada é a primeira medida após o monitor revelar uma atividade elétrica sem pulso ou uma assistolia (lembre-se que muitas vezes a causa de paradas nesses ritmos é justamente a hipóxia). INCORRETA Concluímos que o gabarito é a letra B

155343.

Comentário: Na cardioversão farmacológica na Fibrilação Atrial FA diversas drogas antiarrítmicas são eficazes As mais empregadas são ibutilida (formulação exclusivamente venosa), amiodarona , dofetilida, propafenona, flacainida e sotalol. Exceto a ibutinida que é de administração exclusivamente venosa, todas as outras podem ser usadas também na profilaxia das recidivas (uso oral crônico), porém na manutenção com antiarrítmico profilático, sempre que possível, a droga de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

escolha será amiodarona , pois apesar de ser menos eficaz na cardioversão, seu efeito preventivo é superior às outras drogas. Resposta certa D

155370.

Comentário: A decisão da reversão da fibrilação atrial deve levar em conta o tempo de instalação da arritmia. Ela pode ser feita eletricamente, através de cardioversão elétrica, ou quimicamente, por meio do uso de antiarrítmicos. São considerados eficazes para a reversão química de uma FA ibutilida, dofetilida, flecainida, propafenona e, em menor grau, amiodarona. No Brasil, temos disponíveis propafenona e amiodarona. Para os pacientes sem cardiopatia estrutural (em que se inclui a doença arterial coronariana) a propafenona é considerada uma escolha segura e eficaz. A estratégia pill-in-the-pocket , que consiste na administração de propafenona, precedida pelo uso de um bloqueador do novo AV, como betabloqueador ou antagonista de canal de cálcio, pode ser inclusive realizada em ambiente domiciliar, quando o próprio paciente reconhece a recidiva da arritmia. Para os portadores de cardiopatia estrutural a amiodarona acaba sendo a melhor opção. Gabarito letra B.

155467.

Comentário: Para lembrarmos das causas reversíveis clássicas de parada cardiorrespiratória (PCR), devemos nos lembrar do mnemônico 6H5T 6H h ipovolemia, h ipóxia, acidose (íons H em excesso), h ipercalemia, h ipocalemia, h ipotermia e h ipoglicemia. 5T t óxicos (medicamentos ou outros agentes químicos), t amponamento cardíaco, pneumo T órax hipertensivo, t rombose coronariana (infarto agudo do miocárdio) e t romboembolismo pulmonar. Com esses dados, só não conseguimos eliminar a opção (E). A intoxicação por organofosforados entra no mnemônico no item tóxicos . Esses agentes podem provocar manifestações eletrocardiográficas graves, como prolongamento do intervalo QT e bloqueios atrioventriculares, que levam à PCR em alguns casos. Dessa forma, a alternativa (E) é a nossa resposta.

155419.

Comentário: Dentre as muitas alterações que ocorrem no idoso, a redução do número de receptores BETA adrenérgicos e a redução da resposta desses receptores aos estímulos, aliados

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ao aumento da produção de catecolaminas, geram quadro de maior vasoconstrição, menor resposta na elevação da frequência cardíaca e consequente aumento da pressão arterial (pois o número e a resposta dos receptores alfa não sofrem redução semelhante). Resposta A.

127150.

Comentário: Diante de uma PCR presenciada em ambiente hospitalar, por mais que o desfibrilador esteja prontamente disponível (na maioria dos casos), enquanto que algum membro da equipe fica responsável por pegar o aparelho, é mandatório que as compressões cardíacas sejam realizadas até o momento da desfibrilação. Alternativa C correta.

127178.

Comentário: Vejamos o traçado eletrocardiográfico do paciente em questão temos uma taquicardia de QRS alargado com aspecto de torção, isto é, torsades de pointes ou TV polimórfica sem pulso. Somente duas medidas, quando bem aplicadas, alteram a mortalidade de pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória massagem cardíaca e desfibrilação precoce. Em pacientes que apresentam PCR por FV ou TV, a desfibrilação deve ser realizada de forma IMEDIATA. Por exemplo se um paciente monitorizado evolui com PCR em ritmo chocável, a desfibrilação deverá ser imediata e seguida de massagem cardíaca (sem checagem de pulso, que só ocorrerá após o término do primeiro ciclo) se um paciente em PCR por ritmo não chocável evolui para ritmo chocável, devemos interromper o procedimento em curso e proceder a desfibrilação. Portanto, na PCR, ocorrendo FV TV flagrada, o choque deve ser imediato. A letra B está perfeita.

126896.

Comentário: No cenário descrito a conduta adequada consiste na aplicação do BLS (Basic Life Suporte), isto é, das recomendações de ressuscitação cardiopulmonar que ocorrem antes da chegada do desfibrilador (e que podem inclusive ser realizadas por leigos). Não podemos nos esquecer que o primeiro passo da assistência a vítimas de PCR é chamar ajuda com cardiodesfibrilador, visto que a desfibrilação é uma das medidas que impactam na sobrevida deste grupo de pacientes quando se identifica ritmo passível de choque (FV TV). A segunda medida consiste em realizar compressões torácicas eficazes a uma frequência de 100-120 por minuto, com

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

relação de 30 compressões para 2 ventilações. As compressões são prioritárias às ventilações, especialmente quando realizadas por socorristas leigos. Letra A é a única correta.

131651.

Comentário: Nos pacientes em parada cardiorrespiratória refratários ao choque e à adrenalina, fica indicado o uso de antiarrítmicos. A medicação de escolha nesses casos é a amiodarona, numa dose de ataque de 300mg, seguida por uma segunda (e última) dose de 150mg. Na ausência de amiodarona, pode-se utilizar lidocaína, sendo sua dose total de 1,5mg por quilograma de peso. Resposta E.

106418.

Comentário: O flutter atrial é uma arritmia cardíaca que ocorre por mecanismo de macroreentrada, isto é, forma-se um grande circuito elétrico no miocárdio do átrio direito. A reversão para ritmo sinusal pode ser feita por meio de medicamentos antiarrítmicos ou pela cardiovers o elétrica. A cardiovers o elétrica sincronizada com dose inicial de 50 J tem elevada taxa de sucesso (90%) e é o método de escolha para a reversão para o ritmo sinusal. Caso opte-se pela cardiovers o química, as melhores drogas seriam a ibutilida ou dofetilida, que possuem taxa de sucesso em torno de 60%. A taxa de sucesso com a amiodarona é bem menor que com as drogas citadas, diferente da fibrilaç o atrial, a qual apresenta boa resposta.

102765.

Comentário: Temos aqui uma paciente do sexo feminino com um diagnóstico altamente provável de cardiopatia reumática crônica (no caso, uma insuficiência mitral como sequela de um episódio prévio de febre reumática aguda complicada com cardite). É razoável supormos isso pelos seguintes motivos (1) história de antibioticoprofilaxia regular com ATB injetável durante a infância (provavelmente penicilina benzatina) - alguém em algum momento fez o diagnóstico (2) exame físico compatível com doença mitral grave (3) fibrilação atrial complicando o quadro. Sabemos que a cardiopatia reumática crônica é um dos maiores fatores de risco para FA que existe No entanto, a despeito da piora aguda do quadro de dispneia (pelo contexto clínico, provavelmente uma insuficiência cardíaca desde o início) simplesmente NÃO TEMOS COMO AFIRMAR COM 100% DE

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CERTEZA QUE SE TRATA DE UMA FA DE INÍCIO NAS ÚLTIMAS 48H Talvez a paciente tenha iniciado a FA há 3 meses, e só agora está descompensando pelo surgimento de taquicardiomiopatia. Outra hipótese plausível seria que ela já teve episódios prévios de FA com duração variável, e agora apresenta novo episódio com FC mais elevada (e por isso evoluiu com franca descompensação). O fato é que além de ser fator de risco para FA, a cardiopatia reumática também é fator de risco para tromboembolismo em portadores de FA Ora, em vista das incertezas com relação ao momento de início da FA, levando em conta também o alto risco de eventos tromboembólicos inerente a esta paciente, antes de tentar restabelecer o ritmo sinusal através das manobras de cardioversão (química e ou elétrica) temos que avaliar a existência de trombo no átrio esquerdo através da realização de um ecocardiograma transesofágico. Se houver trombo, será necessário anticoagular por 3-4 semanas antes de cardioverter. Se não houver trombo, podemos iniciar a anticoagulação (que será mantida ad eternum) e cardioverter logo em seguida. Na indisponibilidade de eco transesofágico a conduta a ser adotada é assumir que existe trombo, anticoagulando por 3-4 semanas antes de cardioverter. Logo, como NÃO EXISTEM SINAIS DE INSTABILIDADE (angina, hipotensão arterial ou edema agudo de pulmão - está paciente está congesta e não em franco EAP), não há motivo para proceder à cardioversão elétrica imediata , uma vez que existe risco de acidente cardioembólico se houver um trombo já formado no interior de seu átrio esquerdo A letra A está claramente errada. Se a cardioversão não for bem sucedida, seguiremos a estratégia do controle de frequência apenas - drogas inibidoras do nódulo AV para manter a FC 110 bpm em repouso anticoagulação plena com warfarina ou algum dos novos anticoagulantes orais (dabigatran, rivaroxaban, apixaban). Resposta certa A.

102756.

Comentário: Os sinais e sintomas descritos são condizentes com o diagnóstico de síndrome hipercolinérgica , isto é, uma exacerbação do sistema nervoso parassimpático. Considerando o contexto clínico (tentativa de suicídio), qual passa a ser o provável agente etiológico Sabemos que, principalmente em nosso meio, as drogas associadas à síndrome hipercolinérgica que costumam ser usadas em tentativas de suicídio são os carbamatos e os organofosforados (por serem baratas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

e de relativo fácil acesso). Tais substâncias inibem a enzima acetilcolinesterase nas fendas sinápticas, fazendo aumentar os níveis de acetilcolina, o que acaba hiperestimulando os receptores muscarínicos pós-sinápticos A abordagem terapêutica consiste inicialmente de medidas ressuscitativas, visando estabilizar vias aéreas, respiração e circulação (o ABC do suporte à vida), seguido da administração de antídotos específicos. Um antídoto de ação imediata - amplamente disponível nos carrinhos de parada Brasil afora - é a ATROPINA, que pode ser feita na dose de 1 mg IV de 10 em 10 minutos até o controle dos sintomas. A atropina é um bloqueador de receptores muscarínicos que compete com a acetilcolina. Vale lembrar que a atropina tem meia-vida muito curta e, passado seu rápido efeito, a acetilcolina volta a hiperestimular os receptores muscarínicos. Por este motivo o ideal é ministrar também um antídoto de ação mais duradoura, e a principal substância empregada é a pralidoxima , cujo efeito é reativar a acetilcolinesterase que havia sido inibida pelos carbamatos ou pelos organofosforados. Como você pode perceber, nenhuma opção de resposta é completa De fato, tal é a nossa realidade na maioria dos hospitais brasileiros a pralidoxima não é uma droga amplamente disponível. A melhor resposta aqui acaba sendo a letra C. Não há indicação de se dosar os níveis séricos de acetilcolinesterase - isso não é útil na abordagem da síndrome hipercolinérgica.

102759.

Comentário: Sabemos que a amiodarona interfere de variados modos nos processo de despolarização elétrica cardíaca, sendo, por conseguinte, um excelente antiarrítmico Seu principal mecanismo é a inibição de canais de potássio, mas ela também inibe canais de CÁLCIO, SÓDIO, e RECEPTORES ALFA e BETA-ADRENÉRGICOS. Um dos efeitos colaterais relacionados a esta multiplicidade de ações é o bloqueio atrioventricular, que pode acontecer devido a uma inibição acentuada dos canais de cálcio presentes no nódulo AV (B correta) A amiodarona também é comumente tóxica para a glândula tireoide, podendo causar tanto hipo quanto hipertireoidismo, dependendo do status tireoidiano prévio do paciente (ex. pacientes com hipo subclínico têm maior chance de desenvolver HIPOtireoidismo induzido pela amiodarona) - A correta. A toxicidade pulmonar é outro paraefeito clássico, sendo, na realidade, o paraefeito que mais mata usuários

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dessa droga. A amiodarona pode levar a um quadro de pneumonite intersticial crônica, que pode evoluir com fibrose pulmonar irreversível e síndrome ventilatória restritiva (D correta). Enfim, uma coisa que a amiodarona NÃO É e uma droga nefrotóxica. Não há associação descrita com necrose tubular aguda Vale lembrar, inclusive, que a amiodarona não necessita de ajuste de dose em pacientes nefropatas, nem mesmo nos que fazem hemodiálise (ela não é dializável) Resposta certa C.

100977.

Comentário: Vamos enfatizar, mais uma vez, este conceito importantíssimo a PRIORIDADE MÁXIMA perante um quadro de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso (ritmos chocáveis) deve ser a desfibrilação elétrica, que constitui a única possibilidade de reversão eficaz da arritmia. Sabemos, inclusive, que quanto mais PRECOCE for a desfibrilação nestes casos, maiores serão as chances de reversão. Ora, se estivermos avaliando o ritmo de um paciente em PCR com as pás do desfibrilador e o traçado revelar FV TV, não há dúvida a conduta é proceder ao choque desfibrilatório imediatamente (A correta). Algumas drogas também fazem parte do protocolo de reanimação, pois demonstraram na literatura aumentar a probabilidade de R etorno da Circulação Espontânea (RCE). A atropina , muito utilizada nos protocolos antigos, atualmente foi proscrita das estratégias de reanimação da PCR, pois não demonstrou aumentar o RCE em estudos clínicos (E correta). Em qualquer ritmo de parada, a primeira droga a ser ministrada é sempre um vasopressor a epinefrina (1 mg IV em bolus). A vasopressina (40 U IV em bolus no lugar da primeira ou segunda dose de adrenalina) recentemente também foi retirada do protocolo. Seja como for, a lógica para o uso de vasopressores neste contexto é eles aumentam a resistência vascular periférica, desviando o sangue que está sendo impulsionado pelas compressões torácicas para os órgãos nobres (o próprio coração e o cérebro). Assim, SE AS COMPRESSÕES TORÁCICAS ESTIVEREM SENDO EFETIVAS, os vasopressores diminuem a chance de danos neurológicos, prolongam a viabilidade do tecido cerebral e aumentam a chance de RCE (B correta). Sempre que possível, devemos instalar um capnógrafo de onda contínua no tubo orotraqueal do paciente que está sendo reanimado de uma PCR e já foi devidamente intubado. O capnógrafo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

avalia a quantidade de CO_2 no ar exalado do sistema respiratório, e sabemos que para o CO_2 ser exalado é preciso que haja fluxo sanguíneo pulmonar, ou seja, se o CO_2 estiver sendo exalado em quantidades razoáveis, isso significa que há fluxo sanguíneo razoável, fluxo esse estatisticamente associado a uma maior chance de RCE (D correta). Enfim, nada do que explicamos até agora terá qualquer eficácia se o paciente não receber compressões torácicas de qualidade As compressões também são uma prioridade máxima no atendimento à PCR, e ajudam a manter a vida do paciente enquanto se providenciam as demais medidas necessárias, como o choque nos ritmos chocáveis, e a correção dos 5 Hs e 5 Ts em todos os ritmos. Se o paciente permanecer mais de 2min sem compressões torácicas, o prognóstico se torna muito sombrio, pois boa parte de seus neurônios certamente já evolui para necrose. Ora, então a letra C estaria se referindo, na realidade, às compressões torácicas eficazes, e não ao uso de vasopressores. Vimos, inclusive, que sem uma massagem cardíaca de qualidade os vasopressores não têm qualquer eficácia no tratamento da PCR. Resposta certa C.

77323.

Comentário: Segundo a última versão do protocolo ACLS (Advanced Cardiac Life Support), a atropina NÃO DEVE mais ser utilizada em nenhum ritmo de parada, pois foi reiteradamente demonstrado na literatura que ela não aumenta a probabilidade de retorno da circulação espontânea e, por conseguinte, representa uma medida fútil nesse sentido. Resposta certa D.

77343.

Comentário: A epinefrina é uma catecolamina endógena com ação em receptores beta-1, beta-2 e alfa, que leva ao aumento do inotropismo e cronotropismo e tem ação vasopressora. Desta forma, aumenta a força de contração, produz aumento da frequência cardíaca e da resistência vascular periférica e sistêmica (e não redução, como exposto em A) levando, consequentemente, ao aumento da pressão de perfusão coronária e do fluxo sanguíneo miocárdico e seu consumo de oxigênio (opção D incorreta, portanto). O uso da epinefrina na fibrilação ventricular permite uma maior responsividade à desfibrilação elétrica, estando indicado nestes quadros (o que mostra ser a opção C incorreta). Diante do exposto, resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88890.

Comentário: Como acontece com toda droga antiarrítmica, a amiodarona pode paradoxalmente provocar efeitos pró-arrítmicos , como o prolongamento do intervalo QT (pela inibição de canais de potássio nos cardiomiócitos). Por possuir iodo em sua composição, a amiodarona também pode interferir na função tireoideana, sendo tanto o hipo quanto o hipertireoidismo efeitos colaterais possíveis. Fibrose pulmonar é outro paraefeito clássico - e grave - dessa droga, principalmente com seu uso prolongado (quanto maior a dose cumulativa, maior o risco). Em relação ao risco de crise convulsiva, a amiodarona não parece ser um fator precipitante ela não reduz o limiar convulsivo como diversas outras drogas fazem, logo, resposta certa D.

88888.

Comentário: O exame básico obrigatório para todo paciente com história de síncope é o eletrocardiograma . A solicitação de exames adicionais deve levar em conta eventuais alterações encontradas no ECG de base, bem como quaisquer fatores de risco identificados pela história clínica (ex. certas características clínicas do evento que indicam alta probabilidade pré-teste de cardiopatia subjacente). No caso em tela, temos um indivíduo jovem com ECG normal, cujos episódios de síncope possuem características condizentes com a hipótese de fenômeno vasovagal os episódios de perda da consciência foram precedidos de lipotimia (pré-síncope), e havia presença de outras alterações neurovegetativas, como sudorese fria e náuseas. Se a síncope for um problema recorrente, como no caso em questão, podemos corroborar o diagnóstico de síncope vasovagal através do tilt-test , um método no qual a indução de modificações no tônus do sistema nervoso autônomo (desencadeada por mudanças no retorno venoso em função da movimentação da mesa de teste) provoca a ocorrência dos sintomas, estabelecendo a correlação etiológica entre ambos, isto é, demonstrando que se trata de um distúrbio mais funcional do que estrutural. Os demais exames citados estariam indicados na suspeita de cardiopatia estrutural, logo, em princípio não deveriam ser solicitados para o paciente em tela. Resposta certa B.

88886.

Comentário: Em um paciente jovem sem coronariopatia ou outra cardiopatia estrutural, que se

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

apresenta com síncope ou outros sinais clínicos de taquiarritmia ventricular (como mal-estar e dispneia) temos que pensar na possibilidade de algum distúrbio intrínseco da eletrofisiologia cardíaca, como as canalopatias (doenças genéticas dos canais elétricos da membrana do cardiomiócito). Uma das doenças mais clássicas e graves dentro deste grupo é a famosa síndrome de Brugada , que pode ser prontamente detectada no ECG de repouso pelo encontro do chamado padrão de Brugada supra de ST em V1 e V2, com padrão de BRD em V1. O diagnóstico deverá ser confirmado pelo estudo eletrofisiológico (no qual uma fibrilação ventricular é facilmente induzida), e o tratamento consistirá na imediata implantação de um cardiodesfibrilador permanente, pois o grande risco a que esses indivíduos estão expostos é o de morte súbita arrítmica por FV espontânea. Resposta certa C.

59336.

Comentário: Questão maldosa, que aborda detalhes a respeito de controvérsias da literatura médica atual Vejamos os novos anticoagulantes orais têm sido extensamente estudados, e já se encontram formalmente liberados para uso em diversas situações clínicas, onde podem substituir a tradicional warfarina com o intuito de prover anticoagulação plena crônica. Dois exemplos importantes são a prevenção de fenômenos cardioembólicos nos portadores de fibrilação atrial crônica, e pacientes vítimas de tromboembolismo venoso (ex. TVP TEP). Dentre este novo grupo de drogas, podemos citar (1) dabigatrana (Pradaxa), um inibidor direto da trombina (2) apixabana e rivaroxabana (Xarelto), inibidores diretos do fator XA. Ambas as classes podem ser usadas na FA e no TEV (A e C erradas, E correta). Vale lembrar que, mesmo que essas drogas realmente sejam eficazes, até o momento NÃO EXISTE antídoto específico para reversão imediata do efeito anticoagulante (ao contrário da warfarina, que pode ter seu efeito revertido pela administração de plasma fresco congelado). Discute-se atualmente a segurança dos novos anticoagulantes em populações de pacientes mais idosos (será que eles aumentam o risco de hemorragias graves e óbito nesses pacientes). Até o momento, no entanto, não há restrições formais contra o seu uso em maiores de 80 anos (B errada). Uma das indicações de anticoagulação crônica para a qual os novos anticoagulantes orais ainda não foram oficialmente liberados é a prevenção de fenômenos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

tromboembólicos em portadores de valvas cardíacas metálicas, já que ainda não foram feitos estudos suficientes para demonstrar sua segurança e eficácia nesses pacientes (D errada). Resposta certa E.

44005.

Comentário: O ECG apresenta, em DII, um ritmo sinusal em todo o seu traçado, de modo que a única variação observada é a duração do intervalo P. Este é o comportamento do que chamamos de arritmia sinusal respiratória, onde os intervalos PP reduzem na inspiração (frequência sinusal taquicardiza) e aumentam na expiração (frequência sinusal bradicardiza), isto é, variam com a fase da respiração. Isso é resultado de mudanças no estímulo vagal (parassimpático) durante o ciclo respiratório a inspiração, de modo reflexo, inibe o estímulo vagal, aumentando a frequência sinusal. Já com a expiração, o tônus vagal aumenta de volta ao estado prévio e, assim, a frequência se reduz. Resposta certa Letra D.

23070.

Comentário: Uma taquicardia de início súbito em uma mulher jovem e aparentemente hígida, com ECG mostrando QRS estreito, muito provavelmente é uma taquicardia supraventricular paroxística (TSVP), principalmente se não existe relato de irregularidade RR ou ausência de onda P no ECG, o que sugeriria uma Fibrilação Atrial. Poderia ser uma taquicardia sinusal Não, pois dificilmente encontraríamos uma taquicardia sinusal com esta frequência, além disso, o início súbito fala a favor de TSVP. A forma mais comum de TSVP é a taquicardia por reentrada nodal (TRN), na qual o paciente apresenta uma dupla via nodal, com propriedades eletrofisiológicas diferentes, sendo uma de condução lenta e período refratário curto (alfa) e outra de condução rápida e período refratário longo (beta). A TRN é deflagrada por uma extrassístole que encontra a via beta em período refratário e desce apenas pela via rápida. Ao chegar aos ventrículos o estímulo elétrico os despolariza normalmente, porém, ao encontrar a via beta já fora do período refratário, o estímulo sobe por esta, estabelecendo um circuito de reentrada (desce pela via alfa e sobe pela via beta, desce pela alfa e sobe pela beta...). Nos pacientes estáveis, se não houver contraindicação, a manobra vagal é a primeira medida a ser tentada e reverte a TRN em 25% dos casos. Caso

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

necessitemos de tratamento farmacológico, a droga de escolha é a adenosina 6 mg IV em injeção rápida. A cardioversão elétrica com 150 J está indicada nos pacientes instáveis hemodinamicamente. Resposta Letra D.

23171.

Comentário: Comentário Quando está indicado o tratamento anticoagulante (com warfarim) para prevenção de tromboembolismo Todos os pacientes de alto risco (ver tabela abaixo) e os pacientes com mais de um fator de moderado risco devem ser anticoagulados com warfarim, objetivando um INR entre 2-3 (2,5 de preferência). Pacientes com 65 anos e com ausência dos fatores acima podem ser tratados apenas com aspirina (81-325mg dia). OS RISCOS FRACO MODERADO ALTO Idade 65-74 anos Idade 75 anos Embolia prévia (AVE, AIT, etc) Sexo feminino Insuficiência Cardíaca Estenose Mitral Doença Arterial Coronariana FE 35% Valva protética mecânica Tireotoxicose Hipertensão Arterial Diabetes Resposta Letra E.

9392.

Comentário: A hipotensão arterial postural é definida como uma queda 20 mmHg na pressão sistólica ou 10 mmHg na pressão diastólica quando o paciente assume a posição ortostática (ou seja, quando ele fica de pé) O grande estudo de Framingham mostrou que quase 10% dos casos de síncope eram devidos ao fenômeno de hipotensão arterial postural, o que foi posteriormente corroborado por outras coortes estatísticas Divesas são as causas da hipotensão postural, a saber Hipovolemia (ex excesso de diuréticos) Paraefeito de medicamentos (principais antidepressivos tricíclicos, anti-hipertensivos alfa e beta-bloqueadores, e, principalmente, os VASODILATADORES, como hidralazina, antagonistas do cálcio e nitratos) Doença primária no sistema nervoso autônomo (como a síndrome de Shy-Drager (disautonomia) na doença de Parkinson avançada) Lesão secundária no sistema nervoso autônomo (diabetes mellitus) Consumo de bebidas alcóolicas (bloqueio do mecanismo de vasoconstrição) Envelhecimento (idiopática) Acredita-se que a hipotensão postural idiopática, comum em idosos, esteja relacionada a uma atenuação do reflexo vestibulo-simpático Quando sintomática, ainda mais num indivíduo idoso, temos um importantíssimo fator de risco para quedas e fraturas, o que demanda intervenção farmacológica

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Os agentes de primeira linha incluem mineralocorticóides (ex fludrocortisona, o famoso Florinefe), agonistas alfa (midodrina) e beta-bloqueadores com atividade simpaticomimética intrínseca (pindolol). Logo, a única resposta viável nessa questão é a letra D

8164.

Comentário: Cansamos de ver no módulo de Cardio que as taquiarritmias acompanhadas de INSTABILIDADE HEMODINÂMICA devem ser imediatamente revertidas com eletroterapia Devemos resolver o problema do doente o quanto antes, até porque se ficássemos esperando uma possível reversão da FA pela infusão de amiodarona correríamos o risco de perder esse paciente instável... Também não há lugar para uma tentativa de controle farmacológico da frequência cardíaca (digital, betabloqueador, antagonistas do cálcio) o paciente está morrendo na nossa frente... Mas não podemos marcar a letra A apesar de se tratar de um tipo de FIBRILAÇÃO, na fibrilação atrial a terapia é a CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA... Desfibrilação é um termo usado exclusivamente para o tratamento da fibrilação VENTRICULAR, onde o choque deve ser NÃO SINCRONIZADO. No tratamento da FA devemos sincronizar a descarga elétrica com os complexos QRS, caso contrário podemos induzir uma fibrilação ventricular lembre-se que na FA os ventrículos estão despolarizando normalmente, e a descarga elétrica não sincronizada com o QRS poderia dar origem a um fenômeno R sobre T, causando instabilidade elétrica no miocárdio do ventrículo... A dose inicial com um cardioversor monofásico é de 200 J, passando-se para 300 J e 360 J, caso sejam necessários um segundo e terceiro choques... Com os cardioversores bifásicos (mais eficazes) a dose inicial é menor, de 120-200 J (alguns autores mais antigos falavam em 100 J apenas)...

363960.

Comentário: Essa questão foi feita com base na Diretriz Brasileira de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis 2023. Vamos às opções Letra A incorreta. Em pacientes com doença do nó sinusal, temos a seguinte indicação classe I doença do nó sinusal (bradicardia sinusal, pausa parada sinusal, bloqueio sinoatrial ou síndrome bradi- taquicardia) espontânea, sem causa passível de tratamento ou induzida por fármacos necessários e insubstituíveis, com documentação de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sintomas (síncope, pré-síncope, tontura ou cansaço fadiga) relacionados à bradicardia. Repare que o uso de amiodarona não se encaixa nessa definição. Letra B incorreta. Dentro das recomendações para implante de marca-passo definitivo no bloqueio atrioventricular, cita-se o BAV adquirido de segundo grau Mobitz I sintomático não atribuível à causa reversível ou fármaco não essencial. Letra C correta. Na síndrome da hipersensibilidade do seio carotídeo (SHSC) e síncope vasovagal, temos a seguinte indicação classe I síncope recorrente, 40 anos de idade e documentação de pausa sintomática espontânea 3s (pausa sinusal e ou BAV) ou pausa 6s assintomática. Quando o autor da questão coloca que a pausa sintomática espontânea teve duração 6 segundos, significa que durou 3 segundos, exatamente como coloca o documento. Letra D incorreta. Em pacientes com obstrução do trato de saída do VE (gradiente maior ou igual a 50mmHg), a estimulação bicameral com intervalo AV curto pode ser considerada em casos refratários ao tratamento clínico, que não tenham indicação de CDI e que tenham contraindicação ou não aceitem ablação septal, miectomia cirúrgica ou transplante cardíaco. Cabe notar que a classe de recomendação é IIb. Resposta letra C.

330059.

Comentário: A letra A cita alguns sopros fisiológicos, sopros que não estão associados a qualquer anormalidade estrutural no coração nem a qualquer distúrbio hemodinâmico o sopro sistólico pulmonar, por exemplo, é um sopro suave e de média intensidade que aparece em 50% das crianças, diminui na puberdade e desaparece com o decorrer da idade (ocorre por dois fatores característicos da infância maior velocidade do fluxo sanguíneo na raiz da artéria pulmonar e pelo predomínio do diâmetro da pulmonar em relação à aorta) o sopro musical de Still, por sua vez, é um sopro mesossistólico audível no foco mitral, de causa desconhecida, mas detectado em 75% a 85% dos escolares (raramente está presente em crianças menores ou adolescentes) o sopro cardioPULMONAR é um sopro mesossistólico audível no foco mitral que aparece em adolescentes magros. Sua gênese é atribuída à aspiração do ar pela lingueta pulmonar durante a retração sistólica, e à sua expulsão durante a dilatação diastólica do coração o sopro venoso é o único sopro fisiológico contínuo ocorre nas crianças entre três e seis anos de idade e é localizado nas fossas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

supraclaviculares. Admite-se que a origem desse ruído seja o turbilhonamento causado pela entrada do sangue da veia jugular externa na veia cava superior - ele pode ser abolido pela compressão delicada da veia jugular externa. Veja que a banca cita sopro cardioVASCULAR (A INCORRETA). O sopro de Flint é um sopro diastólico, de baixa intensidade, audível no ápice, que seria produzido pelo deslocamento da lacínia anterior da valva mitral pelo sangue que reflui da aorta para o ventrículo, condicionando uma estenose relativa da referida valva (B INCORRETA). O sopro da anemia é localizado no foco pulmonar, é de pequena intensidade, suave e nunca é acompanhado de frêmito. Origina-se na artéria pulmonar e é decorrente do aumento da velocidade do sangue, causado pela diminuição de sua viscosidade (C CORRETA). Os sopros orgânicos são sopros decorrentes de lesões anatômicas das estruturas cardiovasculares. Basicamente são decorrentes por uma das seguintes situações quando houver uma barreira ao livre trânsito do fluxo sanguíneo quando houver refluxo de sangue quando existir uma comunicação anormal entre as várias cavidades cardíacas (D CORRETA). Temos duas incorretas Por esse motivo, sugerimos um recurso para anular a questão na época do concurso. Olhem que confusão ao invés de anular, a banca trocou o gabarito inicial da letra B para a letra A. Na opinião do medgrupo, questão que deveria ter sido anulada.

331961.

Comentário: A questão traz paciente com diagnóstico de fibrilação atrial. Seja ela paroxística, persistente ou permanente, a decisão a respeito da profilaxia anticoagulante deve ser baseada em preditores de risco. Segundo a mais recente diretriz de fibrilação atrial da AHA ACC, o escore recomendado para estratificação é o CHA2DS2-Vasc , recebendo 1 a 2 pontos cada item, num total de 9 pontos (VER ESCORE EM ANEXO). Na questão, a pontuação é de 3 mulher (1 ponto), hipertensão (1 ponto) e idade (1 ponto). Escore 2 em homens ou 3 em mulheres anticoagulação recomendada. O melhor gabarito da questão seria a LETRA C, porém o termo mais correto seria terapia anticoagulante e não antitrombótica , que se refere ao uso de drogas como AAS e clopidogrel. O correto é o uso de medicações como os anticoagulantes diretos (ex. rivaroxabana, apixabana) ou warfarina. Na opinião Medgrupo, a questão deveria ter sido anulada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

330063.

Comentário: Vamos analisar as assertivas A) Correta. O complexo QRS é a onda do ECG que traduz a despolarização ventricular, enquanto a onda T traduz a repolarização. B) Incorreta. A voltagem é representada no eixo vertical, onde cada milímetro do papel representa 0,1 mV. O aparelho deve sempre ser calibrado antes de iniciar o registro para que esta proporção (1 mV 10 mm) seja respeitada. O tempo é representado no eixo horizontal , onde cada quadradinho de 1 mm corresponde a 0,04s ou 40ms (velocidade padrão de registro de 25 mm s). C) Incorreta. As derivações periféricas são obtidas no plano frontal, pela colocação de eletrodos nos membros - correspondem a D1, D2, D3, aVR, aVL e aVF. Já as derivações precordiais compõem o plano horizontal e estão dispostas ao longo do gradil costal (V1, V2, V3, V4, V5 e V6). D) Incorreta. Vamos aproveitar para relembrar o posicionamento das seis derivações precordiais V1 - 4 espaço intercostal na linha paraesternal à direita V2 - 4 espaço intercostal na linha paraesternal à esquerda V3 - equidistante de V2 e V4 V4 - 5 espaço intercostal na linha hemiclavicular à esquerda V5 - 5 espaço intercostal na linha axilar anterior à esquerda V6 - 5 espaço intercostal na linha axilar média à esquerda Resposta letra A.

330069.

Comentário: Vamos aproveitar essa questão para revisar os termos semiológicos citados - Ortopneia é a denominação dada ao surgimento ou ao agravamento da sensação de dispneia gerada a partir da adoção da posição horizontal, como por exemplo, quando nos deitamos para dormir. Nesse contexto, observa-se que o sintoma tende a ser aliviado, parcial ou totalmente, com a elevação da porção superior do tórax pelo uso de um número maior de travesseiros ou pela elevação da cabeceira da cama. Classicamente, a ortopneia surge em pacientes com IC. - Trepopneia consiste na sensação de dispneia que surge ou piora ao se adotar uma posição lateral, e desaparece ou melhora quando se institui o decúbito lateral oposto. É uma queixa dotada de inespecificidade, a qual pode surgir em qualquer doença em que haja comprometimento de um pulmão mais intensamente do que de outro (ex derrame pleural unilateral). - Platipneia é o nome dado à sensação de dispneia que surge ou que se agrava com a adoção da posição ortostática.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Classicamente, esse fenômeno ocorre em pacientes com quadros de pericardite ou na presença de shunts direita-esquerda. - Disparapneia não é um termo semiológico descrito nos principais livros. Resposta letra A.

342615.

Comentário: Sobre os mecanismos implicados nas arritmias cardíacas, vamos avaliar as afirmativas Letra A correta. A atividade de marcapasso no coração advém do automatismo intrínseco de alguns dos elementos de seu tecido especializado de condução, tais quais nodo sinusal, nodo atrioventricular e sistema His-Purkinje. Normalmente as células miocárdicas atriais e ventriculares não apresentam atividade de marcapasso, podendo adquirir automatismo anormal expresso por taquiarritmia automática causada por distúrbios como hiperatividade adrenérgica e hipocalemia. Letra B correta. A reentrada representa um dos mais importantes mecanismos das taquiarritmias, sejam elas supraventriculares ou ventriculares. O fenômeno origina-se em uma extrassístole, formando um circuito elétrico de elevada frequência. Pode ser anatômica, em um circuito pré-formado, como na dupla via nodal ou via acessória, ou funcional, sem circuito pré-formado, como na fibrilação atrial ou ventricular. Letra C correta. Na presença de sinais de disfunção hemodinâmica e prejuízo no débito cardíaco as arritmias são classificadas em instáveis. São clássicos sinais de instabilidade clínica hipotensão arterial, dor torácica, rebaixamento do nível de consciência e congestão pulmonar. Letra D incorreta. As cicatrizes (fibroses) miocárdicas secundárias à cardiopatia estrutural produzem alterações eletrofisiológicas que favorecerem o aparecimento de reentrada. A área de tecido miocárdico doente representa uma região de condução lenta, permitindo o trigger da reentrada após a ocorrência de uma extrassístole. Resposta letra D.

330088.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas com relação às taquiarritmias em pediatria Letra A incorreta. Há possibilidade de apresentações de taquicardias ventriculares lentas e rápidas, com pacientes variando desde oligossintomáticos, com início de distúrbio prolongado, à muito sintomáticos, com princípio abrupto, evoluindo para insuficiência cardíaca congestiva ou choque em

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

caso de manutenção do ritmo. Letra B incorreta. A cardioversão elétrica sincronizada ou química com adenosina são indicados em cenários de taquiarritmias, sem benefícios nos bloqueio atrioventriculares, que habitualmente implicam em bradicardia. Além de reestabelecimento de oxigenação, os medicamentos protocolares incluem atropina e adrenalina, mas não adenosina. Letra C incorreta. Em crianças, a taquicardia é definida por frequência cardíaca (FC) alta em relação ao esperado para a faixa etária. No entanto, a identificação de taquicardia sinusal considera a presença de onda P associada a FC menor do que 220 bpm no lactente e menor do que 180 bpm nas crianças maiores. Letra D correta. Em crianças, a bradicardia é definida por FC baixa em relação ao esperado para a faixa etária. Usualmente tal achado decorre de hipóxia e precede paradas cardiorrespiratórias, sendo acompanhado por sinais de choque e baixa perfusão tecidual. Resposta letra D.

300803.

Comentário: A bradicardia sinusal é definida pela presença de onda P positiva em D2 e D1 precedendo cada QRS, além de FC 50-60 bpm. As bradiarritmias sinusais benignas são causadas por uma das seguintes condições (1) vagotonia ou aumento do estímulo vagal, ou (2) uso de drogas cronotrópicas negativas (C CORRETA). Na parada sinusal, temos parada súbita da atividade automática do coração, caracterizado por ritmo sinusial com falhas prolongadas e esporádicas (A INCORRETA). Devemos pensar no bloqueio sinoatrial (BSA) de 2º grau na presença de diversas pausas sinusais no ECG (B INCORRETA). Já o bloqueio de ramo esquerdo é definido pela presença de onda S alargada em V1 e onda R alargada ausência de onda Q em D1 e V6 (D INCORRETA). Resposta letra C.

300914.

Comentário: Questão sem graça pois retira na íntegra um trecho do documento Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2019 e coloca em uma das assertivas. Nas outras assertivas muda uma ou outra palavra tornando-a inválida. Vamos aproveitar para rever sobre o tema Estudo observacional com uso de betabloqueadores via oral ou intravenosa após a PCR por FV TVSP

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

mostrou reduzir mortalidade 72 horas após e em 6 meses. No entanto, podem levar à piora hemodinâmica, exacerbar sinais de Insuficiência Cardíaca (IC) e causar arritmias. Resposta letra C.

313197.

Comentário: Vamos às assertivas sobre FA A incidência da FA de forma geral aumenta com a idade (A incorreta). Sua morbidade decorre principalmente de associação com AVE isquêmico e insuficiência cardíaca, sendo maior nos seguintes grupos idosos, hipertensos, diabéticos, mulheres, portadores de DAC ou DAOP, AVE ou AIT prévio (B incorreta). A necessidade ou não da anticoagulação na FA paroxística depende da presença de outros fatores de risco, como pode ser avaliado por escores específicos (ex. CHA2DS2-Vasc) (D incorreta). A FA persistente é caracterizada como a fibrilação contínua e sustentada por mais de 7 dias, sendo a apresentação mais comum (C correta). Resposta C.

317939.

Comentário: Uma taquicardia ventricular que dura mais de 30 ou causa instabilidade hemodinâmica é definida como TV sustentada. Na presença de instabilidade hemodinâmica, a conduta é a cardioversão imediata, através de cardioversão elétrica (CVE) com 100 J. Resposta C.

295354.

Comentário: Muitos alunos nesta questão marcaram a opção B, alegando que a taquicardia sinusal é a arritmia mais comum. Porém, atentem que é perguntada a arritmia mais comum durante atendimentos de emergência . Taquicardia sinusal realmente é bem mais comum que FA, mas não costuma levar o paciente à emergência (em última análise atendemos vários pacientes taquicárdicos durante um plantão na emergência, mas a taqui sinusal dificlmente é a CAUSA do atendimento em si). A arritmia mais comum que leva a atendimentos de emergência pronto-socorro é a FA - essa informação é trazida em diversos livros-texto Resposta C.

300916.

Comentário: Questão sem graça pois retira na íntegra um trecho do documento Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2019 e coloca em uma das assertivas. Nas outras assertivas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

muda uma ou outra palavra tornando-a inválida. Vamos aproveitar para rever sobre o tema Em um ensaio clínico em adultos com FV TVSP, observou se que a administração de amiodarona 300 mg ou 5 mg kg melhorou a sobrevida à admissão hospitalar, quando comparada com placebo ou administração de lidocaína. No entanto, não houve melhora do prognóstico neurológico. Agora vem o trecho usado na questão A amiodarona pode ser considerada para FV TVSP que não responde à RCP, desfibrilação e terapêutica vasopressora (Classe de Recomendação IIb Nível de Evidência B). A dose inicial deve ser de 300 mg por via intravenosa ou intraóssea e pode ser administrada uma dose adicional de 150 mg, intercalada com vasopressor. Ou seja, exatamente como a letra D, nosso gabarito.

317940.

Comentário: Qual é a conduta frente a uma fibrilação atrial (FA) Depende Se FA o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, a condita é cardioversão elétrica emergencial. Porém, se for FA persistente ou paroxística recorrente temos duas estratégias possíveis 1) Controle da FC feita com inibidores do nódulo AV (diltiazem, verapamil ou betabloqueador), sem que haja reversão para ritmo sinusal. 2) Controle do ritmo ainda que não altere a mortalidade, é feita para alguns pacientes, como aqueles com sintomas refratários, apesar do controle da frequência reverter a FA antiarrítmico profilático oral. A FA pode ser revertida com um antiarrítmico (amiodarona, propafenona, flecainida, dofetilida ou ibutilida) e ou cardioversão elétrica eletiva (mais efetiva). Como antiarrítmicos profiláticos, temos sotalol, propafenona, amiodarona e dronedarona como principais opções. E a terapia anticoagulante Caso a proposta seja reverter o ritmo, a anticoagulação está indicada para pacientes com FA 48h ou início indeterminado ou de alto risco para eventos tromboembólicos (CHA2DS2-Vasc). O ideal, nestes casos, é realizar um ecocardiograma trasesofágico (ECO-TE) para excluir a presença de trombos. Na ausência de trombo, reverter a FA após 6-12h de heparina plena (com bolus e infusão contínua para atingir PTTa 1,5-2 x controle) e fazer, no mínimo, mais quatro semanas de anticoagulação plena após a reversão. Na presença de trombo, a reversão só poderá ser realizada após 3-4 semanas de anticoagulação e repetição do ECO-TE confirmando a resolução (desaparecimento) do trombo. Se

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

não houver ECO-TE disponível, devemos proceder a anticoagulação por, no mínimo, três semanas antes da cardioversão e fazer, no mínimo, mais quatro semanas após. Nos pacientes com FA 48h, sem alto risco, pode-se fazer apenas heparina plena antes da reversão e anticoagulante, no mínimo, quatro semanas depois da reversão. Além disso, independente da terapia escolhida (controle de ritmo ou da FC), a terapia anticoagulante está indicada ad aeternum nos portadores de FA valvar ou pertencentes ao grupo de alto risco (CHA2DS2-Vasc). Portanto, no caso em tela, como paciente apresenta uma FA de início indeterminado, devemos assumir que há a possibilidade de existirem trombos intra-atriais. Desta forma, está contraindicada a reversão imediata do ritmo. A cardioversão só seria permitida neste paciente caso existissem sinais de instabilidade hemodinâmica. Assim, devemos optar pelo controle de frequência cardíaca e a classe medicamentosa de escolha são os betabloqueadores (como o metoprolol). Deve ser iniciada anticoagulação plena, podendo-se optar pela heparina venosa em fase inicial. Caso haja disponibilidade de ECO-TE, este deve ser realizado para avaliar a presença de trombos, e, caso negativo, seria permitida a reversão da arritmia. Se indisponível, a anticoagulação deve ser mantida por 3-4 semanas antes até a reversão do ritmo. Resposta letra C.

300917.

Comentário: Questão sem graça pois retira na íntegra um trecho do documento Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2019 e coloca em uma das assertivas. Nas outras assertivas muda uma ou outra palavra tornando-a inválida. Vamos analisar o trecho utilizado pela banca avaliadora Para pacientes com disfunção ventricular sistólica, a amiodarona e a digoxina são as drogas mais utilizadas. Bloqueadores de canal de cálcio e betabloqueadores intravenosos devem ser evitados quando houver esta suspeita clínica (área cardíaca aumentada, edema de membros inferiores, hepatomegalia, turgência jugular a 45 e história clínica de IC). Ou seja, exatamente como descrito na letra B, nosso gabarito.

317162.

Comentário: Vamos analisar as alternativas Letra A incorreta. A qualidade da imagem dificulta a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

identificação exata da frequência cardíaca, mas ela é, certamente, menor que 60 bpm. Letra B correta. O ritmo sinusal é caracterizado pela presença de ondas p positivas em DI, DII e aVF. É nítido perceber que ela é negativa em DII e aVF nesse ECG, ou seja, os impulsos elétricos não partem do nodo sinusal. Nesse caso, o estímulo elétrico parece surgir em alguma região atrial mais baixa, próxima ao nodo atrioventricular repare que o intervalo PR é curto, justamente por causa dessa proximidade. Letra C incorreta. A polaridade positiva dos QRS de DI e aVF indica que o eixo está situado entre 0 e 90 graus. Letra D incorreta. O enunciado não cita manifestações clínicas e não há desnivelamento do segmento ST no exame para pensarmos em síndrome coronariana aguda. Resposta letra B.

300920.

Comentário: Questão sem graça pois retira na íntegra um trecho do documento Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2019 e coloca em uma das assertivas. Nas outras assertivas muda uma ou outra palavra tornando-a inválida. Vamos analisar o trecho utilizado pela banca avaliadora A atropina antagoniza a ação da acetilcolina, um neurotransmissor parassimpático, nos receptores muscarínicos. Dessa forma, ela bloqueia o efeito do nervo vago tanto no nó sinoatrial como no nó atrioventricular, aumentando a frequência de disparos do nó sinusal e facilitando a condução atrioventricular, o que, teoricamente, podia torná-la útil para uso em casos de assistolia ou AESP. Ou seja, exatamente como a letra D, nosso gabarito.

300922.

Comentário: Questão sem graça pois retira na íntegra um trecho do documento Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2019 e coloca em uma das assertivas. Nas outras assertivas muda uma ou outra palavra tornando-a inválida. Vamos analisar o trecho utilizado pela banca avaliadora Diversos sistemas manifestam sinais e sintomas como os listados a seguir, que são indicativos deste comprometimento hemodinâmico alteração no nível de consciência hipotensão arterial sistêmica (Pressão Arterial Sistólica PAS 90 mmHg) ou choque circulatório com alteração

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

da perfusão periférica congestão pulmonar e dor precordial anginosa. Ou seja, exatamente como descrito na letra B, nosso gabarito.

300926.

Comentário: Questão retirada da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia A adenosina é uma droga que diminui a condução pelo nó atrioventricular e promove vasodilatação coronária. Possui meia-vida de menos de 5 a 10 segundos, tendo efeito fugaz, porém efetivo no término da maioria das taquicardias de QRS estreito. Efeitos colaterais podem ocorrer em até 60% dos casos. Os principais efeitos colaterais da adenosina são - Cardiovasculares flush facial, palpitação, hipotensão e dor torácica. - Bradicardias bloqueio atrioventricular de qualquer grau. - Taquicardias extrassístoles ventriculares, TV não sustentada, TV monomórfica e polimórfica (TdP). - Respiratórios dispneia (12%), hiperventilação e broncoespasmo. - Sistema nervoso central cefaleia (8 a 25%), tonturas e vertigens (20%), parestesias e turvação visual. É importante orientar previamente o paciente que poderá apresentar pressão torácica importante, com sensação de morte iminente , porém tais efeitos são transitórios. As contraindicações absolutas à adenosina são bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro graus, disfunção do nó sinusal e FA pré-excitada. Resposta letra B.

300927.

Comentário: Questão retirada da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia Os principais efeitos colaterais da adenosina são - Cardiovasculares flush facial, palpitação, hipotensão e dor torácica. - Bradicardias bloqueio atrioventricular de qualquer grau. - Taquicardias extrassístoles ventriculares, TV não sustentada, TV monomórfica e polimórfica (TdP). - Respiratórios dispneia (12%), hiperventilação e broncoespasmo. - Sistema nervoso central cefaleia (8 a 25%), tonturas e vertigens (20%), parestesias e turvação visual. É importante orientar previamente o paciente que poderá apresentar pressão torácica importante, com sensação de morte iminente , porém tais efeitos são transitórios. As contraindicações absolutas à adenosina são bloqueio atrioventricular de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

segundo ou terceiro graus, disfunção do nó sinusal e FA pré-excitada. Resposta letra C.

311919.

Comentário: A questão descreve paciente com bradicardia (FC 40 bpm), cujo eletrocardiograma revela o diagnóstico de um bloqueio atrioventricular total (BAV total). Note que há uma completa dissociação entre as ondas P e os complexos QRS Em outras palavras, o átrio está contraindo em um ritmo só dele , tanto que as ondas P eventualmente coincidem com o início da despolarização ventricular, causando um entalhe inicial na onda T. Os ventrículos despolarizam por meio de um ritmo de escape juncional, justificando os complexos QRS de duração normal. Como a paciente encontra-se estável hemodinamicamente, sem hipotensão arterial, rebaixamento de nível de consciência, dispneia ou dor torácica, a melhor conduta é monitorizar o ritmo, preferencialmente por meio de marcapasso transcutâneo, que pode entrar em ação em caso de deterioração clínica. Devem-se avaliar causas reversíveis do BAVT, como isquemia miocárdica, aumento do tônus vagal, hipotireoidismo, hipercalemia e medicamentos depressores cardíaco. Na ausência de causas reversíveis, está indicado tratamento com marcapasso definitivo, que pode ser programado enquanto a paciente é monitorizada em ambiente de unidade de terapia intensiva Não há indicação inicial de atropina ou dopamina, já que não há sinais de instabilidade clínica Resposta Monitorizar e programar passagem de marcapasso definitivo.

300930.

Comentário: De acordo com a Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019 Caso após realização de manobras vagais e adenosina, não houver resolução da arritmia, procede-se à administração de outros bloqueadores do nó atrioventricular, como os bloqueadores de canal de cálcio não diidropiridínicos e betabloqueadores. Verapamil e diltiazem mostraram-se efetivos em reversão para ritmo sinusal em diversos ensaios clínicos e permanecem como tratamento de primeira linha para o tratamento das taquicardias supraventriculares. Betabloqueadores, como nadolol, metoprolol ou esmolol, também, podem ser usados, porém poucos estudos clínicos randomizados embasam o efeito de reversão para ritmo sinusal. Resposta letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

311923.

Comentário: Vamos aproveitar essa questão para rever alguns conceitos sobre o BLS ACLS 1- Sobre a técnica de compressão torácica a técnica correta é feita com o paciente em decúbito dorsal, idealmente sob superfície rígida. Nesta posição, o socorrista deve colocar o calcanhar de uma das mãos sobre o centro do peito da vítima (que é a metade inferior do esterno) e o calcanhar da outra mão no topo da primeira, de modo que as mãos fiquem sobrepostas e paralelas. Estando os braços totalmente esticados, com o movimento do tronco, ele aplicará as compressões, na frequência 100 a 120 por minuto, procurando deprimir ativamente o esterno, no mínimo, com 5 cm de profundidade (1 3 do diâmetro AP do tórax) evitando excesso na profundidade (superiores a 6 cm). 2- Sobre o início do ACLS o ACLS começa, normalmente, pela obtenção de uma via aérea avançada (embora não seja exclusivo deste protocolo), que está indicada quando o paciente não se recupera após o primeiro choque desfibrilatório do BLS, caso tenha sido realizado. A obtenção de acesso venoso periférico para administração de drogas e medidas específicas para algumas causas de parada cardíaca (ex. toracocentese e pneumotórax hipertensivo) também estão incluídas. Logo após a obtenção de uma via aérea avançada, a RCP deve ser retomada por mais 2min, agora sem a relação 30 2, ou seja, um indivíduo fica realizando as compressões 100-120 por minuto e outro fica ventilando o paciente com ambu ligado ao oxigênio 10 L min, numa frequência de 10 por minuto (uma ventilação a cada 6s). 3- Sobre o uso da adrenalina durante a RCP, logo após o segundo choque e a obtenção de acesso venoso periférico, faz-se adrenalina 1 mg (uma ampola) pela veia periférica, infundindo em seguida cerca de 20 ml de soro fisiológico ou água destilada e elevando o braço do paciente. A adrenalina deve ser repetida a cada três a cinco minutos durante todo o ACLS. Trata-se de um vasopressor muito potente, capaz de aumentar o fluxo coronariano e cerebral, reduzindo a hipóxia e acidose teciduais e facilitando a desfibrilação. Resposta letra C.

300933.

Comentário: Questão retirada na íntegra da Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Cardiologia - 2019. Veja só o trecho presente nesta diretriz Na abordagem da FA e do flutter atrial de alta resposta ventricular, alguns pontos devem ser definidos para a programação da terapêutica. Sinais de comprometimento hemodinâmico são indicação formal para CVE sincronizada. Em pacientes estáveis, dados como Fração de Ejeção de Ventrículo Esquerdo (FEVE), tempo de duração da arritmia (menor ou maior que 48 horas) e presença de pré-excitação ventricular (síndrome de Wolf-Parkinson-White) são imprescindíveis para tomada de decisões acerca de indicação de anticoagulação, reversão do ritmo ou controle da resposta ventricular e avaliação da segurança para a reversão do ritmo. Mais adiante, neste mesmo documento, os autores explicam que, em uma FA com início 48h ou duração desconhecida, o risco de trombo em átrio esquerdo e de eventos cardioembólicos é muito maior. Assim, devem-se iniciar anticoagulação e decidir posteriormente sobre a reversão do ritmo. No caso de pacientes com FA flutter e síndrome de Wolf-Parkinson-White, o tratamento de escolha é a CVE. No caso dos pacientes com FEVE reduzida (40%) que foi optado pela reversão do ritmo, a amiodarona e a dofetilida são as drogas mais seguras para serem usadas como antiarrítmico profilático oral. Resposta letra B.

308286.

Comentário: Paciente é encontrado desacordado e SEM PULSO, o que caracteriza uma parada cardiorrespiratória (PCR) Identificada a PCR, a compressão torácica é considerada o principal componente nas manobras de reanimação de uma PCR. O grande valor das compressões se dá pelo fato de que, nos primeiros 5 min de PCR, a concentração de oxigênio do sangue ainda parece ser adequada para a homeostase tecidual e, portanto, o principal determinante da lesão miocárdica e cerebral neste momento não é a hipoxemia, mas sim a parada do fluxo sanguíneo. A compressão, quando feita corretamente, garante 30% do fluxo cerebral e coronariano e pode manter uma PA sistólica em torno de 60 a 80 mmHg e uma Pressão Arterial Média (PAM) em torno de 40 mmHg Ela retarda a lesão isquêmica (por hipóxia e acidose) do miocárdio, aumentando comprovadamente o sucesso da reversão de uma fibrilação ventricular pelo choque desfibrilatório. Caso seja possível, as compressões devem ser alternadas com as ventilações, na relação de 30 2, ou seja, 30 compressões seguidas por duas ventilações (ambu-máscara ou boca a boca).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Define-se, portanto, 1 ciclo de RCP como a execução de 30 compressões e duas ventilações. Geralmente, pelo menos 5 ciclos de RCP (aproximadamente 2 min) devem ser realizados antes de qualquer nova medida de reanimação (ex avaliação do ritmo, choque desfibrilatório, intubação traqueal, uso de drogas antiarritmicas). Cabe lembrar que a cardioversão não é feita no contexto da PCR, e sim a DESFIBRILAÇÃO. Resposta letra B.

273122.

Comentário: Bom, analisando as alternativas, percebemos que a melhor resposta realmente é a letra C. Queixa e duração são elementos fundamentais para formular o raciocínio clínico acerca de determinada queixa do paciente. Reconhecimento e história de doenças FUTURAS não fazem parte da anamnese. Os hábitos religiosos até podem ser importantes, mas, sem dúvida, saber a queixa e sua duração são elementos mais decisivos. Resposta letra C.

285058.

Comentário: Pessoal, o diagnóstico provável dessa paciente é FA, embora a questão não traga o traçado eletrocardiográfico. No caso de FA 48 horas, como é o caso, não deve ser tentada cardioversão imediata, mas sim controle da FC e anticoagulação. Esta paciente, sendo jovem e sem comorbidades, muito provavelmente não apresentará indicação para anticoagulação nem antiagregação. Passando ao controle da FC, as drogas mais indicadas são os betabloqueadores e antagonistas do cálcio não di-hidropiridínicos - Diltiazem, Verapamil. O digital só é indicado nos casos de ICC sistólica sintomática. Resposta A.

258162.

Comentário: Questão sobre paradacardiorrespiratória e as medidas do BLS a serem implementadas. O primeiro passo, que é chamar por ajuda, já foi dado. Com o desfibrilador presente, não há porque mantermos as compressões torácicas se, a depender do ritmo, o desfibrilador automático externo (DEA) pode resolver o quadro (Letra A incorreta). Colocado o DEA, aguardamos 10 segundos para avaliação de ritmo, que se identificado como chocável, nos autoriza a proceder com a desfibrilação. As alternativas C e D colocam um tempo muito curto (cinco segundos), enquanto que a alternativa B, dada como gabarito da questão, cita um tempo muito

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

longo (15 segundos). Portanto, como a questão não apresenta resposta correta, foi devidamente anulada.

257720.

Comentário: Pessoal, vamos lembrar quais fatores pontuam no CHA2DS2-Vasc - Disfunção de VE - HAS - Idade 75 anos ou 65-74 anos - DM - AVE AIT - Doença vascular (IAM, doença arterial periférica) - Sexo feminino. Todos pontuam 1 ponto, com exceção da idade 75 e o AVE AIT, que somam 2 pontos cada. Como vimos, este paciente não soma ponto algum. Quando o escore CHA2DS2-VASc é zero, há consenso de que o risco de fenômenos tromboembólicos é muito baixo e não há necessidade de qualquer terapia antitrombótica. Resposta A.

258171.

Comentário: Os fármacos antiarrítmicos são classificados da seguinte forma. Grupo IA bloqueiam os canais de sódio, responsáveis pela fase 0 do potencial de ação e reduzindo ou bloqueando a condução no sistema de His-Purkinje, bem como no miocárdio atrial ou ventricular. Aumentam em 10 a 20% a duração do complexo QRS. São representantes dessa classe a quinidina, a procainamida e a disopiramida. Grupo IB bloqueiam os mesmos canais de sódio, porém apresentam cinética mais rápida que os do grupo IA. Assim, permanecem menos tempo ligados a esses canais, revertendo o efeito durante a diástole. Essas drogas não agem nos tecidos de condução normais do coração na faixa fisiológica de frequência cardíaca, não influindo na duração do QRS. Fazem parte desse grupo a lidocaína, a fenitoína e a tocainida. Grupo IC bloqueiam os mesmos canais de sódio, mas apresentam uma cinética mais lenta que os do grupo IA. Com isso, tem ação mesmo na faixa de frequência cardíaca fisiológica, bem como nos tecidos de condução normais. São as drogas que mais aumentam a duração do QRS. Podemos citar como exemplos propafenona, flecainida, ecainida, morizicina. Grupo II betabloqueadores como propranolol, metoprolol e atenolol. Bloqueiam os betarreceptores adrenérgicos, podendo ser eficazes nas arritmias supraventriculares ou ventriculares dependentes do sistema adrenérgico (como arritmias do pós-IAM e da tireotoxicose). Grupo III bloqueiam os canais de potássio da repolarização, aumentando a duração do potencial de ação e, consequentemente, o período refratário. São

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

exemplos amiodarona, sotalol e ibutilida. Grupo IV bloqueadores de canal de cálcio cardiosseletivos como verapamil e diltiazem. Ao bloqueiam os canais de cálcio, responsáveis pela fase despolarizante do potencial de ação do nódulo sinusal e AV, bem como pelo período refratário desses elementos. Existem ainda outros compostos que não pertencem a esses grupos, como é o caso da adenosina, dos digitálicos e do magnésio. Resposta D.

265855.

Comentário: Questão baseada, integralmente, na I DIRETRIZ DE RESSUSCITA ÃO CARDIOPULMONAR E CUIDADOS CARDIOVASCULARES DE EMERG NCIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Vamos, então, revisar o trecho do documento que respondia a questão A terapia farmacológica também pode ser recomendada para se restaurar o ritmo sinusal de Fibrilação Atrial e Flutter Atrial de início 48 horas, mas não é a terapia de primeira escolha (reservar para casos em que a cardioversão elétrica e o seu preparo sedação impõe risco alto para o paciente). Vários estudos foram realizados para definir a eficácia de medicações na cardioversão química da FA. Resposta letra D.

265856.

Comentário: Vamos aproveitar para reforçar este conceito - o antiarrítmico de escolha na FV TV sem pulso que não responde ao choque e à adrenalina (refratária) é a amiodarona, facilitando o sucesso na desfibrilação. Pode ser feita duas vezes na primeira, a dose é de 300 mg (duas ampolas) e na segunda, 150 mg (uma ampola). Acontece que a lidocaína demonstrou eficácia semelhante à amiodarona em PCR extra-hospitalar, sendo uma alternativa a esta droga. A dose é de 1,0 a 1,5 mg kg por via intravenosa contínua (5 ml 100 mg). Pode ser repetida (0,5 a 0,75 mg kg) em caso de persistência até a dose cumulativa de 3 mg kg. Resposta D.

274767.

Comentário: O CHA2DS2 VASc, escore utilizado para indicar anticoagulação em pacientes com fibrilação atrial, possui dois pontos para idade maior ou igual a 75 anos, um ponto para hipertensão e um ponto para diabetes, sendo o total de pontos desse paciente quatro. A anticoagulação está formalmente indicada para pacientes com pelo menos dois pontos. Os antiagregantes plaquetários

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

não possuem acurácia na prevenção de fenômenos tromboembólicos. Os anticoagulantes orais de ação direta, quando utilizados na dose adequada, são mais eficazes e seguros como terapia para esses pacientes quando comparados à varfarina.

265858.

Comentário: A taquiarritmia conhecida como torsades de pointes representa uma taquicardia ventricular polimórfica especial, cujo fator predisponente fundamental é o intervalo QT longo. É marcada por complexos QRS de morfologia diferente (polimórfica), oscilando em amplitude e polaridade (aspecto de torção de pontas), e ritmo de base com intervalo QT longo. Seu tratamento de primeira linha consiste na administração de sulfato de magnésio em bolus intravenoso (B incorreta). A taquicardia ventricular (TV) polimórfica não torsades, por definição, não se associa ao QT longo no eletrocardiograma basal. A causa mais comum é a isquemia miocárdica aguda por lesão coronariana. Neste caso, não adianta fazer sulfato de magnésio (C correta A incorreta). A alternativa D poderia gerar dúvidas... Notem que a única diferença entre a letra C é a troca entre a palavra normal e padrão . A questão, sem criatividade, foi baseada no trecho Dois estudos observacionais mostraram que a administração de sulfato de magnésio por via intravenosa pode finalizar TV polimórfica do tipo torsades de pointes (TdP), porém não é efetiva para TV polimórfica em pacientes com intervalo QT normal . Por esse motivo, o gabarito foi a letra C.

265859.

Comentário: O antiarrítmico de escolha na FV TV sem pulso que não responde ao choque e à adrenalina (refratária) é a amiodarona, facilitando o sucesso na desfibrilação. Pode ser feita duas vezes na primeira, a dose é de 300 mg (duas ampolas) e na segunda, 150 mg (uma ampola). A lidocaína demonstrou eficácia semelhante à amiodarona em PCR extra-hospitalar, sendo uma alternativa a esta droga (letras A e B corretas). Em relação ao betabloqueador, um estudo observacional mostrou que a administração desta droga após PCR por FV e TV sem pulso foi associada à maior probabilidade de sobrevivência. Assim, seu uso pode ser considerado imediatamente após o retorno da circulação espontânea causada por uma PCR neste contexto (C correta). Por fim, o soco precordial pode ser considerado na TV instável em pacientes

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

monitorizados, quando um desfibrilador NÃO está imediatamente pronto para uso caso o desfibrilador esteja disponível, a terapia de escolha será o choque (D incorreta). Resposta D.

265861.

Comentário: Essa questão foi inteiramente retirada da Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência , da Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicado em 2019. Veja o trecho abaixo, retirado deste documento, que contempla todas as alternativas O cálcio apresenta papel no mecanismo celular de contração miocárdica e da musculatura lisa vascular. Não há evidências científicas que deem suporte ao uso rotineiro do cálcio na RCP (Classe de Recomendação III Nível de Evidência B). Seu uso pode ser considerado, na dose de 0,5 a 1 g (gluconato de cálcio 10%, de 15 a 30 mL, ou cloreto de cálcio 10%, de 5 a 10 mL), nas seguintes condições de PCR hiperpotassemia, hipocalcemia e intoxicação por agentes bloqueadores dos canais de cálcio. Não utilizar soluções de cálcio e bicarbonato de sódio simultaneamente na mesma via de administração. Resposta letra D.

281992.

Comentário: Vamos analisar as alternativas Letra A Correta. Atualmente, devido a alguns aspectos, como a menor incidência de desfechos desfavoráveis (ex sangramento maior e AVE hemorrágico), não inferioridade e até mesmo maior proteção contra fenômenos tromboembólicos, menor interação com a dieta e por não precisarem de monitorização seriada, os NOACs são considerados as drogas de escolha para anticoagulação nos pacientes com fibrilação atrial. Letra B Incorreta. Toda fibrilação atrial de instalação há mais de 48h ou indeterminada ou em paciente de risco alto para tromboembolismo (pelo CHADSVASC) necessita de um protocolo de anticoagulação antes e depois da reversão Letra C Incorreta. Pelo CHADSVASC, a anticoagulação está recomendada se a pontuação for 2 em homens ou 3 em mulheres nos casos onde o escore é 1 em homens ou 2 em mulheres, a anticoagulação pode ser considerada. Letra D Incorreta. Em pacientes com fibrilação atrial valvar, poucos dados são conhecidos sobre os NOACs (já que estes pacientes foram excluídos dos principais estudos) e, por isso, é preferível a anticoagulação com warfarin Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

265865.

Comentário: A massagem do seio carotídeo é, na prática, a principal forma de se realizar a manobra vagal, método inicial de escolha no tratamento da maioria das taquiarritmias regulares com QRS estreito (taqui supras). Outra opção é a realização da manobra de Valsalva. As manobras vagais induzem a uma diminuição temporária da atividade do nó sinusal e da condução do nó atrioventricular, por estimular barorreceptores da aorta que, por sua vez, deflagram reflexo de aumento de reposta vagal e diminuição de resposta simpática. Na massagem do seio carotídeo, temos esse mesmo reflexo, deflagrado pela pressão externa no bulbo carotídeo, estimulando seus barorreceptores (D correta). A massagem do seio carotídeo é realizada com o paciente em posição supina, com o pescoço hiperestendido. Antes do procedimento, deve-se observar a presença de sopro carotídeo, que é uma contraindicação formal, assim como acidente vascular encefálico ou acidente isquêmico transitório prévios (exceto se exame de imagem de carótidas sem doença aterosclerótica), infarto agudo do miocárdio nos últimos 6 meses e história de arritmia ventricular grave (TV FV). Realiza-se pressão estável em região inferior ao ângulo da mandíbula, na altura da cartilagem tireoidea, perto do pulso arterial, por 5 a 10 segundos. Se não houver resposta positiva, pode-se repetir a manobra do outro lado, após 2 minutos. Resposta D.

281996.

Comentário: Vamos avaliar cada afirmativa a respeito das atualizações da AHA em 2020 A) Verdade, grandes avaliações clínicas incluindo até 12500 paciente serviram como confirmação das recomendações para RCP de qualidade. Foram reafirmados os valores de 5-6cm e 100-120 bpm para as compressões, assim como a sequência dos eleos da cadeia de sobrevivência. (CORRETA) B) N ausência da possibilidade de desfibrilação, a terapia com adrenalina ganha prioridade nos ritmos não chocáveis. A diretriz reafirmou a importância do acesso venoso (anteriormente o acesso intraósseo era equiparado ao venoso como possibilidade). (CORRETA) C) Essas mudanças de dose não ocorreram A dose de atropina de 0,5mg se mantém, assim como a dose mínima de 2 mcg kg min para dopamina (INCORRETA) D) Os ritmos chocáveis tem como absoluta prioridade a desfibrilação. O restante do algoritmo também não sofreu alterações. (CORRETA) Resposta letra C

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274478.

Comentário: Uma taquicardia monomórfica sustentada, até que se prove o contrário, representa uma TAQUICARDIA VENTRICULAR, até que se prove o contrário, o que representa uma emergência médica. Se o paciente encontra-se clinicamente bem durante o episódio, é sinal de que estamos diante de uma TV. monomórfica ESTÁVEL. O tratamento correto é com amiodarona venosa, na dose inicial de 150mg em 10-30 minutos (dose de ataque) seguida de manutenção, visando cardioversão química para ritmo sinusal. O milrinone é uma medicação inotrópico e cronotrópica positiva, que não tem papel no tratamento das TVs. Resposta letra B

265869.

Comentário: Uma questão bastante direta Não há dúvidas quanto ao fato de que a grande preocupação em pacientes que apresentam síncope é em relação ao risco de complicações cardiovasculares, que podem agudamente levar a situações de gravidade ou óbito. Uma das investigações importantes com esse objetivo diz respeito à história familiar do paciente. Quando existem alterações como doenças cardíacas congênitas e aritmias no familiares próximos, podemos estar diante de uma cardiopatia geneticamente determinada, que pode elevar o risco cardiovascular do paciente. (A e B CORRETAS) A dúvida então fica entre as alternativas C e D. A história infecciosa não ajuda muito, pois há pouca relação entre pneumonias e causas de síncope. (D INCORRETA) Por outro lado, há alguma causa metabólica que pode gerar síncope em crianças e adolescentes, que deve ser investigada Sim A hipoglicemia O diabetes tipo 1 é uma das possíveis causas de síncope em crianças e adolescentes, e deve ser pesquisado nessa circunstância, tanto diretamente quanto na história familiar. (C CORRETA) Resposta letra D

265884.

Comentário: Síncope é um sintoma definido como uma perda transitória da consciência e tônus postural que resulta de uma perfusão cerebral inadequada. O sintoma prodrômico mais comumente relatado por crianças e adolescentes com síncope é a tontura. Na maioria das vezes, a perda de consciência ocorre sem aviso. A recuperação é rápida e espontânea, usualmente acompanhada da restauração dos sentidos e orientação. A duração do episódio tipicamente é breve, não mais que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

20 segundos de perda de consciência. A síncope vasovagal é o tipo mais comum de síncope em crianças sadias. Este tipo de síncope faz parte de um contexto muito maior, que são os distúrbios do sistema nervoso autônomo e que podem levar à hipotensão, intolerância ortostática e, por último, à síncope. A história deve ser detalhada, e sempre que possível ser colhida com alguém que presenciou o episódio. Na maioria das vezes é a maior fonte de pistas para a origem da síncope. O exame físico destes pacientes deve ser detalhado, incluindo a aferição dos sinais vitais com o paciente em decúbito dorsal e após permanecer ereto por 5 a 10 min. Logo, a alternativa A está incorreta e é a resposta da questão. Se a pressão sistólica de adolescentes, após a realização dos dois registros dos sinais vitais, for menor do que 80 mmHg ou houver variação de mais de 30mmHg, a etiologia provável é vagal mediada. A alternativa B está correta. A avaliação cardiovascular deve ser cuidadosa, pois a presença de sopros, principalmente do trato de saída do ventrículo esquerdo irradiando-se para o pescoço, segunda bulha anormalmente alta ou a presença de sopro diastólico longo em decrescendo, no ápice, obviamente exige exames de diagnósticos adicionais. A palpação do precórdio na avaliação cardiológica pode sugerir doenças cardíacas estruturais. A alternativa C está correta. Os distúrbios convulsivos devem ser considerados se houver uma história de pródromos com aura, atividade tônico-clônica focal ou generalizada e uma fase pós-ictal prolongada de letargia ou confusão. As convulsões são a causa mais provável de síncope que ocorre em pacientes deitados. O exame neurológico deve incluir fundoscopia, pesquisa do sinal de Romberg, avaliação da marcha, reflexos tendíneos profundos, função cerebelar e propriocepção. Contudo, a maioria dos pacientes com síncope apresenta o exame físico normal. Alternativa D está correta. Gabarito da questão letra A.

274834.

Comentário: Um paciente totalmente hígido faz um exame com diagnóstico de arritmia sinusal. O que é isso Trata-se de um nome que frequentemente causa confusão e medo entre os pacientes, mas na verdade representa um evento na enorme maioria das vezes benigno e fisiológico. A arritmia sinusal é a variação visível da frequência cardíaca com o movimento da respiração, e é principalmente visto em indivíduos jovens. Não há qualquer motivo para preocupação, e o paciente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pode seguir suas atividades normalmente, sem outros exames complementares. Resposta letra C

229491.

Comentário: Segundo a diretriz da FA da SBC, a manutenção da ACO deve ser decidida de acordo com o escore de risco de CHA2 DS2 VASC, mas após 4 semanas. Por essa razão a assertiva A está errada e corresponde ao gabarito. As demais opções são corretas de acordo com a referida diretriz.

229495.

Comentário: Como é típico das provas da FUBOG, as assertivas foram retiradas na íntegra de Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nesse caso, as de Posicionamento sobre Antiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes em Cardiologia 2019 . Em pacientes com fibrilação atrial (FA) que necessitam de cardioversão de emergência (ex. devido à instabilidade hemodinâmica), pode-se utilizar a heparina não-fracionada (HNF) ou heparina de baixo peso molecular (HBPM) em dose plena antes do procedimento (letra C correta), mantendo-as por pelo menos quatro semanas. O erro na alternativa A é que a HNF endovenosa é realizada em bolus e depois continuamente, em bomba infusora. Após o período de quatro semanas, a necessidade de continuação do anticoagulante oral irá depender do risco CHA 2 DS 2 VASc. Quando o paciente é submetido a uma ECOTE para avaliar trombos intracavitários e esse exame dá positivo , deve-se aguardar para realizar a cardioversão por pelo menos três semanas de anticoagulação e nova reavaliação após com novo exame (letra D correta). Se o ECOTE não apontar trombos, a cardioversão pode ser feita, desde que o anticoagulante seja imediatamente prescrito (letra B correta). Resposta A.

249464.

Comentário: Questão baseada na Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019. Vamos, então, revisar um trecho que respondia a questão Pontos essenciais no sucesso do atendimento da parada cardiorrespiratória (PCR) Melhoria nas estruturas e nos sistemas de saúde criação de um sistema integrado com treinamento de pessoas, auxílio de materiais e transportes para um

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

atendimento unificado, além da disponibilidade de DEA em locais públicos com alta movimentação de pessoas . Resposta letra D.

249467.

Comentário: Segundo a diretriz, mencionada no enunciado, são elos de sobrevivência Vigilância e prevenção Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência RCP imediata de alta qualidade Rápida desfibrilação, Suporte Avançado de Vida e cuidados pós-PCR, ou uma PCR extra-hospitalar, Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência RCP imediata de alta qualidade e rápida desfibrilação Serviços médicos básicos e avançados de emergência Suporte Avançado de Vida e cuidados pós-PCR. Resposta letra C.

249468.

Comentário: Questão baseada na Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019. Neste documento é falado sobre os pontos essenciais no sucesso do atendimento da parada cardiorrespiratória (PCR). Como, por exemplo, os cuidados pós-PCR com ênfase na avaliação neurológica, cumprimento das metas hemodinâmicas e controle térmico, com menor variação de temperatura e prevenção de febre. Resposta letra B.

249471.

Comentário: Questão simples, mas que traz conceito valiosíssimo sobre o atendimento à parada cardiorrespiratória (PCR)... O suporte avançado de vida se baseia no tratamento, com medicação, da arritmia responsável pela PCR. Qualquer que seja o ritmo (fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso ou assistolia), assim que iniciado o suporte avançado, devem ser investigadas as causas reversíveis de parada (5H e 5T). Resposta A.

248912.

Comentário: Somente as células especializadas do sistema de condução possuem a propriedade do automatismo, pondendo assumir função de marca-passo (A correta). A reentrada é o principal mecanismo gerador de taquiarritmias em todas as faixas etárias, sejam elas supra ventriculares ou ventriculares, podendo ter base anatômica ou funcional (ex. dispersão da refratariedade em

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

frequências cardíacas muito elevadas) - B correta. As arritmias devem ser clinicamente classificadas em estáveis ou instáveis, e isso modifica o tratamento de emergência - C correta. A presença de cicatrizes miocárdicas é um dos principais substratos anatomopatológicos para o surgimento do fenômeno de reentrada - D errada. Resposta D.

249477.

Comentário: Questão sem muita dificuldade. Os algoritmos de atendimento no cenário de uma PCR são pautados em condutas bem estabelecidas e simplificadas, para otimizar o atendimento emergencial deste cenário extremo, com objetivo de reduzir a mortalidade e reverter o quadro clínico inicial , levando à sobrevivência do paciente. Resposta A.

247411.

Comentário: O ECG mostra uma taquicardia com complexos QRS alargados, com ritmo regular. A principal hipótese diagnóstica nesse caso torna-se a taquicardia ventricular, neste caso monomórfica . Como o paciente apresenta desconforto torácico isquêmico (sinal de instabilidade hemodinâmica), existe indicação imediata de cardioversão elétrica, que neste caso deve ser sincronizada com o QRS, iniciando-se com 100 J. Resposta A.

249870.

Comentário: Vamos relembrar a classificação de afogamento das crianças Grau 1 - Tosse sem espuma na boca ou nariz. Grau 2 - Pouca espuma na boca e ou nariz. Grau 3- Muita espuma na boca e ou nariz com pulso radial palpável. Grau 4 - Muita espuma na boca e ou nariz sem pulso radial palpável. Grau 5 - Parada respiratória, com pulso carotídeo ou sinais de circulação presente. Grau 6 - Parada Cárdio-Respiratória (PCR). O paciente em questão encontra-se em apneia porém com pulso central. Ou seja, trata-se do Grau 5 e o nosso gabarito é a letra C.

229547.

Comentário: Vamos analisar o eletrocardiograma conforme um algoritmo de perguntas e respostas... A partir da segunda pergunta, sempre que a resposta for NÃO, devemos seguir para a próxima... 1 - Há taquicardia Sim, conforme o enunciado, a frequência é de 180 bpm. Na prática, a distância entre duas ondas R consecutivas menor que 3 quadradões define taquicardia. 2 - Tem

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

onda P Sim taquicardia sinusal. Não próxima pergunta. 3 - Tem onda f de flutter Sim flutter atrial. Não próxima pergunta. 4 - O QRS é alargado Sim taquicardia ventricular. Não próxima pergunta. 5 - O intervalo RR é regular Sim taquicardia supraventricular paroxística (taqui supra). Não fibrilação atrial. Em casos de taqui supra com sinais de instabilidade - qualquer um dentre dor torácica, hipotensão, rebaixamenteo de consciência e congestão pulmonar - a conduta admite duas possibilidades ou cardioversão elétrica ou adenosina via intravenosa, na dose de 6mg. Amiodarona seria utilizada para taquicardia ventricular estável (A e B erradas). O metoprolol poderia ser utilizado em taqui supra estável, para lentificar a frequência cardíaca e permitir melhor análise do traçado (C errada). Resposta D.

229888.

Comentário: Nos cuidados à parada cardiorrespiratória (PCR), a principal manobra é a COMPRESSÃO TORÁCICA rápida e forte, numa frequência entre 100 e 120 vezes por minuto e que rebaixa o esterno entre 5 e 6 cm, permitindo seu retorno à posição original Após 30 compressões, deve-se interrompê-las brevemente, abrir as vias aéreas e fazer duas ventilações de resgate, após o que se reiniciam as compressões torácicas. A proporção de 30 compressões para duas ventilações configura um ciclo de RCP. Quando é instalada via aérea artificial, compressões e ventilações passam a ser independentes as compressões são contínuas, na frequência entre 100 e 120 por minuto, e uma ventilação é feita a cada 6 segundos. Resposta C.

229889.

Comentário: Na sequência do algoritmo ACLS, após o choque a RCP é retomada por 5 ciclos (2 minutos), após o que o ritmo é novamente checado. Havendo ritmo que não FV ou assistolia, avalia-se a presença de pulso. Se houver pulso, entraremos no próximo elo da cadeia de sobrevivência os cuidados pós-parada. Neste caso, se o paciente estiver hipotenso com um bloqueio atrioventricular completo (3º grau), a conduta é instalar uma marcapasso transcutâneo até que um marcapasso transvenoso e, eventualmente, definitivo, sejam impantados. No entanto, o paciente pode estar em AESP (atividade elétrica sem pulso), isto é, o ECG pode mostrar um ritmo qualquer que não seja FV, TV ou assistolia, e não haver circulação espontânea. Neste caso, a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

conduta consiste em administrar epinefrina 1 mg IV a cada 3-5 minutos (dose padrão , diferente do conceito de alta dose), mantendo RCP contínua e investigando e tratando possíveis etiologias dentro do mnemônico 5 H s e 5 T s... O problema dessa questão é que ela não deixa claro que o BAV de 3º grau que o paciente apresenta é ou não acompanhado de pulso. Esta informação é essencial, pois muda completamente a conduta (ex. marca-passo não tem benefício se o paciente estiver em AESP)... Questão merecidamente anulada pela banca.

246606.

Comentário: Segundo o livro Medicina ambulatorial Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências , de Duncan, são consideradas atividades físicas de alta intensidade - Movimentar móveis. - Caminhar rapidamente com carga em plano inclinado, correr. - Pedalar rápido bicicleta (16 km h). - Nadar rápido. - Ginástica aeróbica, step. Ou seja, o nosso gabarito é a letra A. Limpar a casa é considerado um exercício de moderada intensidade. Já realizar exercícios de alongamento, executar trabalho de carpintaria e caminhar lentamente (1,6 a 3,2 km h) são considerados exercícios de baixa intensidade.

210541.

Comentário: Um escore bem validado e bastante utilizado na prática é o CHADS2, que utiliza as seguintes variáveis Congestive heart failure (ICC), HAS, Age (idade) 75 anos, Diabetes e Secondary prevention (evento cerebrovascular prévio). O CHADS2-VASC seria a evolução deste escore, também levando em consideração história de outros eventos vasculares prévios (IAM prévio, doença arterial periférica, placa aórtica) e sexo neste caso idade entre 65-74 anos soma 1 ponto, idade 75 anos soma 2 pontos, AVE ou AIT prévio soma 2 pontos e todos os demais somam 1 ponto. Este paciente apresenta apenas 1 fator de risco maior (AIT prévio), se portador de prótese mitral mecânica, é recomendada varfarina e manter INR 3, a dupla antiagregação com AAS clopidogrel ou a dabigatrana não substituem a varfarina. A indicação de terapia antitrombótica independe da forma de apresentação da FA, estando a assertiva A correta.

218214.

Comentário: Vamos analisar as alternativas separadamente (A) Incorreta. A cardioversão elétrica é

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

conceitualmente um choque sincronizado O procedimento não-sincronizado é a desfibrilação, utilizada na abordagem da parada cardiorrespiratória. (B) Incorreta. Há uma certa discordância em relação à taxa de sucesso da amiodarona na fibrilação atrial aguda. Entretanto, é consenso de que a sua eficácia não alcança 99% em 24 horas. (C) Correta. Quanto maior for o átrio esquerdo, mais importante será a distorção do sistema de condução cardíaco. Sendo assim, o risco de recorrência da arritmia é mais elevado nessa situação.(D) Incorreta. O sotalol não deve ser usado em pacientes com IC. Resposta certa LETRA C.

217036.

Comentário: O ECG mostra um ritmo composto por RR s regulares, com complexos QRS alargados e aberrantes e de mesma morfologia. O diagnóstico, portanto, é de uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada. Como a paciente está estável hemodinamicamente (não havendo indicação de cardioversão elétrica), as drogas que podem ser utilizadas são procainamida, amiodarona e sotalol. Resposta certa LETRA A.

202630.

Comentário: O grande objetivo do emprego de adrenalina na parada cardiorrespiratória é propiciar fluxo sanguíneo adequado para as regiões mais nobres do organismo cérebro e miocárdio. Esse objetivo é alcançado fechando-se a periferia, isto é, aumentando-se a resistência vascular sistêmica. Resposta B.

202712.

Comentário: Questão sobre o ciclo cardíaco, aquele que estudamos em fisiologia com o temido Diagrama de Wiggers. O que precisamos saber e entender Primeira bulha - B1 Fecha valva mitral e tricúspide 1o M1 2o T1 Segunda bulha - B2 Fecha valva aórtica e pulmonar 1o A2 2o P2 Isso ocorre devido a força de contração do ventrículo ESQUERDO, por isso os sons oriundos das valvas mitral e aórtica são o primeiros componentes. Resposta LETRA B.

201700.

Comentário: Bem, não há dúvidas sobre a superioridade da anticoagulação sobre a antiagregação na profilaxia de eventos tromboembólicos associados à fibrilação atrial. Dessa forma, ficamos entre

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

as alternativas C e D. Por ter demonstrado superioridade na prevenção de ocorrência de eventos tromboembólicos em pacientes com FA não valvar, além de menor risco de sangramento, comparado ao warfarin a apixabana é uma droga com melhor eficácia para esses pacientes. Gabarito alternativa C.

202643.

Comentário: Sabemos que o grande problema da fibrilação atrial (FA), além de possível taquicardiomiopatia, é o risco de embolização sistêmica por formação de trombo no interior dos átrios. Portanto, é necessário verificar, caso a caso, nos pacientes com FA não valvar, a necessidade de se indicar terapia anticoagulante, objetivo que pode ser alcançado com base no escore CHA2DS2VASc. (C)ongestive Heart Failure 1 ponto (H)ipertensão 1 ponto (A)ge 75 anos 2 pontos (A)ge entre 65-74 anos 2 pontos (D)iabetes tipo II 1 ponto (S) troke - AVE ou AIT ou fenômeno cardioembólico prévio 2 pontos História de doença (Vasc)ular 1 ponto (S) ex (c) ategory (feminino) 1 ponto Escore 2 anticoagulante oral (warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban e edoxaban). Escore 1 anticoagulante oral, AAS com ou sem clopidogrel, ou sem terapia antitrombótica. Escore 0 sem terapia antitrombótica. Resposta B.

205562.

Comentário: Estamos diante de um paciente de 1 ano com quadro de taquicardia supraventricular. Sua manifestação eletrocardiográfica é a de uma taquicardia de frequência bastante alta (maior ou igual a 180 bpm), com QRS estreito, ritmo regular (intervalo R-R regular), compatível com o apresentado. Por se tratar de uma emergência cardiológica, a sua abordagem ocorrerá em ambiente hospitalar, de forma imediata. Se o paciente não apresentar sinais de instabilidade hemodinâmica, a primeira medida é tentar reverter a taquiarritmia com manobra vagal. No entanto, a criança do enunciado apresenta sinais clínicos de choque, como hipotensão, pulso fraco e perfusão lentificada. Logo, nos paciente instáveis, a conduta deverá ser a cardioversão imediata, farmacológica ou elétrica. Como o paciente está com acesso venoso, devemos tentar primeiramente a reversão farmacológica, sendo a ADENOSINA intravenosa a droga de escolha, com dose inicial de 0,1 mg kg em bolus. No entanto, caso esta não estiver disponível no momento,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

deve-se proceder com a cardioversão elétrica sincronizada, com carga inicial de 0,5 Joules kg. Resposta letra B.

215454.

Comentário: A síncope neurocardiogênica é a forma mais comum de síncope autonômica. Após experiência que gere ansiedade, medo ou dor, ou na presença de desidratação, há aumento do tônus simpático do paciente. O mesmo pode ocorrer se houver mudança brusca de decúbito supino para ortostático. A síncope reflexa pode ocorrer com a micção ou evacuação, tosse profunda, hiperextensão do pescoço (espreguiçar) e a deglutição. A perda de fôlego pálida do lactente é uma das apresentações da síncope reflexa ou situacional. Tipicamente, o lactente ou pré-escolar sofre uma contrariedade ou dano menor, seguido por um ou dois choros curtos, palidez e perda da consciência. Resposta letra B.

217056.

Comentário: Se diante de uma parada cardiorrespiratória houver apenas uma pessoa leiga para o atendimento, ela deve reconhecer a PCR, chamar ajuda e iniciar as compressões torácicas até que uma equipe treinada do Sistema Médico de Emergência chegue ao local e assuma a responsabilidade pelo atendimento. Se o atendimento inicial for feito por um profissional de saúde, ele deve avaliar pulso e respiração na criança gravemente enferma para a adequada tomada de decisão. Se a criança não responde e não respira de forma regular, mas apresenta pulso, devemos abrir a via aérea e fazer ventilação de resgate. Se após isso a frequência cardíaca for menor que 60bpm, devemos iniciar as compressões torácicas. Se a FC estiver superior a este valor, podemos apenas realizar ventilações. A proporção de compressões ventilações deverá ser 30 2 se houver apenas 1 socorrista e 15 2, se houver 2 socorristas. Resposta letra B.

174400.

Comentário: Entenda este conceito fundamental de uma vez por todas na CARDIOVERSÃO o choque é sincronizado ao complexo QRS (sendo aplicado no exato momento em que a onda R atinge seu ápice), ao passo que na DESFIBRILAÇÃO não (o choque é aplicado a qualquer momento, basta acionar o desfibrilador)... A razão para essa diferença é a seguinte quando há

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

complexos QRS morfologicamente identificáveis, o choque deve ser sincronizado, pois a liberação inadvertida da corrente elétrica durante a fase de repolarização ventricular (intervalo ST) pode gerar o fenômeno R-sobre-T , isto é, um novo potencial de ação pode aparecer num momento em que existe grande heterogeneidade elétrica no miocárdio, com parte das fibras já tendo recuperado por completo a excitabilidade, mas outra parte apresentando recuperação parcial da excitabilidade e outra ainda se mantendo no período refratário . Assim, um potencial de ação gerado neste momento encontra todas os pré-requisitos básicos para a formação de circuitos de reentrada no miocárdio ventricular, ou seja, o choque - que deveria ser terapêutico - pode transformar o ritmo anterior em franca fibrilação ventricular Os ritmos tratados com desfibrilação são os ritmos de parada cardíaca a própria FV, é claro, mas também a TV sem pulso (nesta última, apesar de poder haver uma morfologia monomórfica no traçado, a frequência cardíaca é tão elevada que o aparelho não consegue sincronizar, isto é, não consegue identificar complexos QRS-T discerníveis). Resposta certa D.

175381.

Comentário: Questão decoreba de anatomia que cobra o epônimo de uma estrutura anatômica. A válvula da veia cava inferior, cujo epônimo é a válvula de Eustáquio, é uma válvula venosa que situa-se na junção da veia cava inferior com o átrio direito. Resposta A

175387.

Comentário: O principal ritmo de parada em ambiente extra-hospitalar é a fibrilação ventricular. Na maioria dos casos, é causada por doença coronariana. Assistolia e atividade elétrica sem pulso são mais frequentes no ambiente intra-hospitalar. Taquicardia supraventicular e fibrilação atrial não são ritmos de parada. Resposta D.

183254.

Comentário: O ritmo sinusal, comando fisiológico do coração (A certa), origina-se do nó sinusal, localizado na junção da veia cava superior com a parede posterior mais alta do átrio direito (B errada). É diagnosticado através da observação de ondas P positivas em D1, D2 e aVF (C certa), sendo seu eixo variável, no plano frontal, entre -30º e 90º (D certa). Resposta B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175405.

Comentário: Epinefrina, ou epinefrina, como é de conhecimento geral, causa vasoconstricção periférica, aumentando a pós-carga cardíaca e a resistência vascular sistêmica (A errada). Ao mesmo tempo, estimula as contrações cardíacas, aumentando o consumo miocárdico de oxigênio (D errada). Tal medicação é utilizada em todos os mecanismos de parada (C errada). A grande vantagem de se aumentar a RVS é fazer com todo sangue bombeado seja direcionado a órgãos nobres, como cérebro e miocárdio. Em outras palavras, a adrenalina aumenta a pressão de enchimento das artérias coronárias. Resposta B.

183321.

Comentário: Todas são conceituais e estão corretas, exceto a letra C desfibrilação é usada para tratar ritmos de parada cardíaca chocáveis , isto é, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Trombolítico pode ser usado no tratamento da trombose coronariana e do tromboembolismo pulmonar. Ora, tanto a trombose coronariana quanto o tromboembolismo pulmonar são causas possíveis de parada cardíaca, no entanto, se o paciente está parado o mais importante são os procedimentos de ressuscitação. Somente se a parada cardíaca for revertida é que poderemos utilizar o trombolítico nessas situações, de outro modo o trombolítico não exerce qualquer impacto Resposta certa C.

178802.

Comentário: O traçado apresenta um ritmo acelerado (taquicárdico), com QRS alargado (0,12s) - isso nos permite diagnosticar, em princípio, uma taquicardia ventricular (TV). Como a morfologia do QRS varia dentro de cada derivação - isto é, dentro de uma mesma derivação, o QRS tem diferentes morfologias - damos o diagnóstico de TV polimórfica. Resposta A.

174502.

Comentário: Dificilmente vemos numa prova de residência uma questão tão sem sentido quanto essa... O que se está perguntando aqui é literalmente um rodapé de bula de remédio, incluindo até o conhecimento de porcentagens de efeitos colaterais raros Ridículo... Resumindo o único erro aqui - pasmem - é a que a propafenona, apesar de poder causar náuseas, não tem a diarreia aquosa

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

como um de seus efeitos colaterais descritos As demais associações estão corretas e de acordo com as bulas. Questão do inferno, que merece voltar para lá. Resposta certa A.

178810.

Comentário: Pacientes com QT prolongado têm maior probabilidade de desenvolvimento de Torsades de Pointes. Isso ocorre pois a estimulação (despolarização) miocárdica durante a repolarização gera instabilidade elétrica cardíaca, que predispõe a arritmia maligna. Na prática, é o evento de R sobre T . Portanto, drogas que induzem aumento do intervalo QT e, consequentemente, aumento do risco de desenvolvimento de Torsades, não devem ser utilizadas no tratamento dessa arritmia. Dentre as principais drogas com este efeito, está a amiodarona. Quanto ao tratamento indicado, a desfibrilação está indicada imediatamente nos casos de instabilidade. A droga adjuvante de escolha é o sulfato de magnésio, por proporcionar estabilidade das membranas, sendo a lidocaína e o isoproterenol opções ao tratamento. O overdrive pacing, ou seja, estimulação cardíaca por marca-passo numa frequência superior a da taquiarritmia, com intenção de inibir o circuito gerador da arritmia, também é uma opção possível. Gabarito Alternativa E.

174405.

Comentário: O procedimento da ablação da FA consiste geralmente no isolamento elétrico dos óstios das veias pulmonares, pois o miocárdio presente no interior dessas veias é um dos focos mais comuns de geração dos episódios de FA em pacientes sem cardiopatia estrutural. No portador de cardiopatia estrutural, por outro lado, o foco gerador de FA costuma ser o próprio miocárdio atrial difusamente doente (ex. átrios muitos dilatados e com fibrose), sendo a ablação menos eficaz nestes casos, apesar de poder ser tentada... Resposta certa D.

173565.

Comentário: No atendimento a uma parada cardiorrespiratória em ritmo chocável (fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso), após realizarmos um primeiro choque, se a vítima permanece em ritmo chocável, diagnosticamos um ritmo refratário. A partir deste momento, percebemos que o suporte básico (compressões, ventilações e CHOQUE sim, o primeiro choque

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

faz parte do suporte básico) NÃO TEM NOVAS MEDIDAS a serem implementadas. Dizemos, então, que acabou o BLS (Basic Life Support) Neste momento, ao passo que MANTEMOS as manobras de compressão e ventilação, iniciamos o suporte avançado de vida (ACLS), que contará com medicações e instituição de via aérea segura. Dentre as medicações, há duas classes VASOPRESSORES (adrenalina, 1 mg a cada 3-5 minutos e vasopressina, 40 U, dose única, substituindo a primeira ou a segunda dose de adrenalina) e ANTIARRÍTMICOS (amiodarona, 300 mg, em dose de ataque e, posteriormente, 150 mg lidocaína, na dose total de 1,5 mg kg). Apesar de não haver RESPALDO BASEADO EM EVIDÊNCIA para se indicar uma SEQUÊNCIA do uso dessas medicações, HABITUALMENTE começaremos com VASOPRESSORES Resposta C.

174468.

Comentário: Questão muito mal-feita, que foi textualmente copiada das Diretrizes Brasileiras de FA de 2016... Como deu pra perceber, em vários momentos, nas opções de resposta, não fica muito claro a que perfil de paciente o autor está se referindo, mas vamos dizer para vocês todas essas alternativas foram extraídas de apenas 2 parágrafos da diretriz, que tratam da estratégia de controle de ritmo com a terapia intervencionista (ablação dos óstios das veias pulmonares)... Então vamos lá Sabemos que a ablação tem seus melhores resultados em pacientes jovens sem cardiopatia estrutural de base (A correta). Idosos, portadores de FA de longa duração e, principalmente, cardiopatas estruturais crônicos, não são bons candidatos a essa estratégia terapêutica, até porque existem poucas evidências a esse respeito, uma vez que tais indivíduos sequer costumam ser incluídos nos estudos de terapia intervencionista (o problema deles costuma ser uma doença difusa do miocárdio atrial, com pouca expectativa de resolução da FA com um procedimento focado como o isolamento elétrico dos óstios das veias pulmonares)... Nos pacientes que respondem à ablação, nota-se melhora importante na qualidade de vida (melhora dos sintomas em função da manutenção eficaz do ritmo sinusal sem necessidade de uso de antiarrítmicos), porém, não foi demonstrado melhoria em desfechos duros como morte, AVC ou IC (até porque o risco do tipo de doente que responde bem à ablação já é naturalmente baixo - jovens sem cardiopatia estrutural de base)... Resposta certa B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174506.

Comentário: Sem maiores delongas, vamos direto ao ponto o autor copiou um trecho da diretriz brasileira de FA e o repartiu entre as alternativas de resposta, incluindo um errinho na letra C... Os procedimentos híbridos para tratamento da FA são definidos exatamente conforme o exposto na letra A. Os objetivos do tratamento com esses procedimentos são justamente aqueles descritos conforme exposto na letra B. Apesar de não haver evidências definitivas sobre o assunto, os estudos iniciais sugerem resultados expressivos em doentes mais complexos , que foram as populações mais estudadas até o momento (D correta)... Ora, se a letra B está correta, automaticamente a letra C tem que estar errada, pois as técnicas utilizadas isoladamente teriam resultados INSATISFATÓRIOS, é claro, pois de outro modo não faria sentido utilizá-las em conjunto formando os procedimentos híbridos ... Resposta certa C.

182497.

Comentário: Vejamos as alternativas A - errada. A ação cronotrópica negativa - redução da frequência cardíaca - faz os betabloqueadores serem úteis na fibrilação atrial de (FA) alta resposta, independente do inotropismo. B - certa. A tireotoxicose pode determinar surgimento de taquiarritmias - a principal é a FA. C - certa. Idade acima de 75 anos pontua duplamente no CHA2DS2VASc, escore utilizado para aferir o risco de tromboembolismo em pacientes com FA. D - certa. Mdicações com ação inibitória sobre o nó atrioventricular reduzem a resposta ventricular na FA. São exemplos betabloqueadores e bloqueadores dos canais de cálcio cardiosseletivos (diltiazem). Resposta A.

182494.

Comentário: Fisiologicamente, apresentamos um aumento da amplitude do pulso arterial na inspiração e uma redução na expiração. Isso se deve ao aumento da pressão negativa na caixa torácica elevando o retorno venoso. Já no pulso paradoxal, ocorre o inverso, uma redução na amplitude do pulso arterial durante a inspiração. Através de um aparelho de pressão, percebe-se como uma redução superior a 10 mmHg da pressão arterial sistólica durante a inspiração. Apesar de classicamente associado ao tamponamento cardíaco, pode ocorrer também em outras situações

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

clínicas. Podemos encontrar esse sinal semiológico nas afecções do pericárdio, essencialmente na pericardite constritiva, pericardite com derrame e no tamponamento pericárdico ou ainda em doenças pulmonares com a DPOC. Resposta B.

183271.

Comentário: A afirmativa A está incorreta afogamentos em piscinas têm baixo (e não alto) potencial de desenvolver infecção pulmonar precoce. Isso porque as piscinas (assim como praias) não apresentam colônias bacterianas em numero suficiente para promover pneumonia logo após o acidente. Antibióticos profiláticos nestes casos têm valor ainda mais duvidoso e tendem apenas a selecionar organismos mais resistentes e agressivos. As demais opções são corretas. Resposta letra A.

185159.

Comentário: A primeira conduta a ser empregada num paciente com fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso é a desfibrilação. Em se tratando desfibriladores bifásicos, o choque deve ter a energia de 200J. Não é necessário fazer RCP antes do choque (B errada) o ritmo só deve ser reavaliado 2 minutos depois (ou 5 ciclos depois) - C errada). A adrenalina deve ser infundida o quanto antes, mas a conduta prioritáia é a desfibrilação. Resposta A.

185123.

Comentário: Vamos analisar esse eletrocardiograma conforme o já conhecido algoritmo. Lembre que, a partir da segunda pergunta, sempre que nós respondamos NÃO, devemos seguir para a próxima pergunta. 1 - Há taquicardia Sim, a distância entre duas ondas R consecutivas é menor que 3 quadradões. 2 - Tem onda P Não conseguimos observar onda P. 3 - Tem onda f de flutter Não há onda f de flutter. 4 - O QRS é alargado Não. 5 - O intervalo RR é regular Sim Trata-se, portanto, de uma Taquicardia supraventricular. O que fazer neste caso Como não há instabildiade, adenosina por via intravenosa é a melhor conduta. Dose inicial 6mg caso ineficaz, faremos 12mg. Resposta B.

174527.

Comentário: O ECG nos mostra a existência de taquicardia (FC 100 bpm, ou 3 quadradões), na

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ausência de onda P ou onda f de flutter, QRS estreito (confirmando origem supraventricular) e intervalo RR regular... Não há outra possibilidade que não a Taquicardia Supraventricular Paroxística (TSVP), a famosa taqui supra , que na maioria das vezes possui como mencanismo a formação de um circuito de reentrada dentro do nódulo atrioventricular (reentrada nodal). Perceba que existe uma onda P (negativa) após o QRS na derivação D2, o que corrobora essa impressão diagnóstica... Pois bem, qual deve ser a conduta Como existe um critérios de INSTABILIDADE (hipotensão arterial sinais de choque circulatório, isto é, má-perfusão tecidual generalizada), devemos proceder à imediata cardioversão elétrica , um choque sincronizado ao complexo QRS Resposta certa A.

178858.

Comentário: Paciente apresentando síncope com instabilidade hemodinâmica (hipotensão) e dispneia. ECG evidenciando aumento progressivo do intervalo PR, seguido de onda P bloqueada (sem condução átrio-ventricular), o que caracteriza o bloqueio átrio-ventricular (BAV) de segundo grau Mobitz I Wenckebach. A conduta a seguir é a administração de atropina na tentativa de reversão do bloqueio e em caso de insucesso, prosseguir para o uso de aminas ou marcapasso transcutâneo, até que seja providenciado acesso venoso para marcapasso transvenoso. Gabarito Alternativa B.

174426.

Comentário: A FA aumenta o risco de AVC tanto isquêmico (evento cardioembólico) quanto hemorrágico (complicação do tratamento anticoagulante) - A errada. No portador de IC, o surgimento de FA é fator de risco para maior morbimortalidade, pois a FA não só agrega um componente de aumento no risco de eventos isquêmicos como também acaba reduzindo o próprio débito cardíaco, já que a contração atrial efetiva responde por cerca de 20-25% do débito. Enfim, outros problemas relacionados à FA são a disfunção cognitiva (demência vascular), que pode ser secundária à ocorrência de microinfartos cerebrais não relacionados a um episódio clinicamente evidente de AVC, bem como as múltiplas implicações socioeconômicas da doença, no que tange aos custos do tratamento e o absenteísmo incapacidade laboral. Resposta certa B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174517.

Comentário: A resposta óbvia aqui é a letra D Atualmente se reconhece a enorme influência da obesidade e da apneia obstrutiva do sono na gênese da FA, tanto de forma direta, como fatores de risco independentes , quanto de forma indireta, pelo fato de tais condições representarem fatores de risco para outras doenças diretamente associadas à FA, como HAS, DM e DAC. Resposta certa D.

157328.

Comentário: A capnografia quantitativa contínua com forma de onda (ETCO 2) possui múltiplas utilidades no período peri-parada cardiorrespiratória permite confirmar o adequado posicionamento da via aérea artificial avalia a qualidade das compressões torácicas e obtém informações quanto ao Retorno da Circulação Espontânea (RCE). Na atualização de 2015 das recomendações do ACLS, a ETCO 2 ganhou mais uma utilidade nos pacientes intubados, a incapacidade de obter uma ETCO 2 igual a 10 mmHg após 20 minutos de ressuscitaç o cardiopulmonar pode ser considerada como um dos componentes da abordagem multimodal para definir o término dos esforços de ressuscitação Cabe ressaltar que o próprio ACLS não recomenda o uso deste parâmetro de forma isolada para esta definição. De qualquer modo, a letra C está incorreta, e é, portanto, a resposta a ser marcada aqui.

150265.

Comentário: Questão de semiologia... Gabarito letra A, o ângulo esternal ou ângulo de Louis (formado pela junção do manúbrio com o corpo esternal) é a referencia semiológica para localizarmos o 2 o EIC. Gabarito A.

157433.

Comentário: Todas as assertivas são corretas e foram retiradas, na íntegra, da I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013). A única exceção (e que portanto é o gabarito da questão) é a letra C nos choques monofásicos, toda a energia elétrica selecionada é aplicada em um único sentido vetorial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157439.

Comentário: Todas corretas, menos a letra D Em relação ao posicionamento das pás manuais e adesivas, o local mais adequado é a posição anterolateral, onde uma das pás é colocada na região infraclavicular direita e a outra pá na região precordial. Posições alternativas como anteroposterior, laterolateral podem ser utilizadas em situações especiais, como presença de marca-passo ou cardioversor-desfibrilador implantável, no qual as pás devem ser obrigatoriamente posicionadas, pelo menos, 8cm de distância do gerador. Resposta D.

157448.

Comentário: A cardioversão elétrica está indicada para reversão das taquiarritmias com instabilidade hemodinâmica. Considera-se como critérios de instabilidade a presença de pelo menos um dos quatro critérios seguintes hipotensão e sinais de choque circulatório, dor torácica anginosa, dispneia associada à congestão pulmonar e rebaixamento do nível de consciência. Resposta A.

157455.

Comentário: Todas as assertivas são corretas pois foram copiadas integralmente da I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013). A exceção (e portanto o nosso gabarito) é a letra B A desvantagem do MPTC é a necessidade de alta energia em razão da necessidade de fazer a energia aplicada vencer a impedância transtorácica e chegar ao miocárdio.

157460.

Comentário: O marcapasso transcutâneo é um dispositivo reservado para casos de urgências relacionadas a bradicardia, em função da rapidez de sua instalação. Os eletrodos são placas adesivas, através das quais se transfere corrente elétrica ao coração. Sua atividade sofre influência da impedância das estruturas da parede torácica, que geram resistência a passagem da corrente. Para vencê-la são necessários altos níveis de energia, o que provoca desconforto e dor, por conta da estimulação de músculos não cardíacos. O aumento das placas de eletrodos para oito ou dez centímetros de diâmetro minimizam a densidade de corrente elétrica por área de parede torácica,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

acarretando ainda melhora da condução. A alternativa D é a única incorreta.

160550.

Comentário: Vamos tentar extrair o máximo dessa questão A começar pelo eletrocardiograma temos uma taquicardia, sem onda p sinusal ou F de flutter, com complexos QRS estreitos e intervalos R-R regulares. Assim, tratamos de uma taquicardia supraventricular paroxística. Diante de uma taquiarritmia devemos nos fazer uma pergunta há sinais de instabilidade hemodinâmica ou há estabilidade clínica Em arritmia são considerados sinais de instabilidade hemodinâmica a presença de congestão pulmonar, hipotensão arterial, dor torácica anginosa e confusão mental. Logo, no caso exposto a presença de desconforto torácico e hipotensão arterial denotam a presença de instabilidade hemodinâmica. A partir deste dado só há uma forma de proceder se há taquiarritmia com instabilidade hemodinâmica a terapia é cardioversão elétrica sincronizada. Mas por que não desfibrilação elétrica O termo cardioversão elétrica fica reservado aos casos em que sincronizamos o aparelho com a atividade elétrica do paciente, a fim de evitar o fenômeno de ondas R sobre T com degeneração para fibrilação ventricular. Já a desfibrilação se reserva ao choque administrado sem sincronização do aparelho, indicado somente nas paradas cardiorrespiratórias em fibrilação ou taquicardia ventricular. Assim, a letra A é a única possível.

157464.

Comentário: Durante o manejo da parada cardiorrespiratória (PCR) as prioridades sempre devem ser massagem cardíaca externa de qualidade e desfibrilação precoce. Isto porque estas são as medidas que impactam na sobrevida destes pacientes. O acesso de escolha para a administração de medicamentos e fluidos deve ser preferencialmente o periférico (veia antecubital), por ser de fácil obtenção, garantir boa concentração plasmática de drogas e não exigir a interrupção das manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). A segunda opção é a via intraóssea, sendo ainda uma possibilidade para drogas selecionadas a via endotraqueal. A via venosa central é a última alternativa, podendo ser utilizada se um acesso central já estiver estabelecido. Quando um cateter está adequadamente inserido na veia cava superior este acesso permite a monitorização da saturação venosa central (SVCO 2), medida que pode proporcionar informações acerca do débito

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

cardíaco. Durante o manejo da PCR, em um paciente com acesso central previamente instalado e já monitorizado, é razoável ter como objetivo uma SVCO 2 acima de 30% como reflexo de um adequado débito cardíaco. No entanto, este dado não espelha a perfusão coronariana. Uma forma de refletir a perfusão coronariana é a observação da curva de pressão arterial nos casos em que cursam com cateter de monitorização de pressão arterial invasiva previamente instalado. Nestas situações é razoável buscar, através da adequada RCP, uma pressão de relaxamento (ou diastólica) superior a 20 mmHg, visto que as coronárias se perfundem na diástole. Alternativa C incorreta.

157454.

Comentário: Durante a RCP, a gasometria arterial não se correlaciona com o estado metabólico tecidual. Assim, não devemos pautar nossa RCP neste parâmetro. Apenas em pacientes com acidose metabólica prévia, hipercalemia e intoxicação por antidepressivos tricíclicos, a administração de bicarbonato parece ser benéfica. O uso de bicarbonato pode ter alguns efeitos deletérios como Aumento na geração de CO2, exacerbando a acidose intracelular Efeito inotrópico negativo no miocárdio isquêmico Aumento da osmolaridade sérica e desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda, entre outros. Face ao exposto, a única assertiva que pode ser considerada correta é a letra C.

149168.

Comentário: Na ressucitação cardiopulmonar (RCP) a ênfase deve, de fato, ser dada às compressões cardíacas, que é o que gera débito cardíaco e perfusão cerebral, seguindo a sequência usada na questão (Compression-Airway-Breathing, isto é, Compressão via aérea ventilação)... No entanto a frequência recomendada das compressões torácicas varia de 100-120 bpm, deve ter profundidade de 5-6 cm, e permitir o completo recolhimento do tórax. Vemos na questão uma frequência de compressão de 145 bpm, o que é ineficaz por impedir uma diástole (tempo de ralaxamento) adequeada, não havendo o recolhimento torácico à posição original, sem tempo de enchimento ventricular e perfusão coronariana Resposta certa B

157458.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A atropina é um agente anti-parassimpático Isto é, favorece o tônus simpático A acetilcolina age em dois principais tipos de receptores (1) nicotínicos, encontrados nos músculos e cujo bloqueio é feito pelos relaxantes musculares e os (2) MUSCARÍNICOS, os viscerais, componente do sistema nervoso parassimpático, e cujo bloqueio é feito pela atropina, que exerce diversas ações com base no tecido de ação, como o aumento da frequência cardíaca por favorecer o tônus simpático no sistema de condução cardíaco Portanto, a atropina é um agente anti-muscarínico, que provoca inibição competitiva dos receptores colinérgicos pós ganglionares autônomos. Vale ressaltar que a dose deve variar de 0,5 a 1 mg, e que doses 0,5 mg podem na verdade reduzir a frequência cardíaca. Como a questão pede a incorreta, gabarito A, Já que a atropina não é um AGONISTA da acetilcolina, mas sim um ANTAGONISTA Resposta certa A

149173.

Comentário: A compressão correta na RCP (ressuscitação cardiopulmonar) garante 30% do fluxo sanguíneo cerebral e coronariano, e pode manter uma pressão arterial de 60-80 mmHg, com uma PAM (pressão arterial média) de 40 mmHg Isso retarda a lesão isquêmica do miocárdio, aumentando o sucesso da reversão dos ritmos chocáveis após a descarga elétrica Antes da obtenção de uma via aérea definitiva, se possível, iremos intercalar 30 compressões com 2 ventilações. Mas depois da obtenção de uma via aérea definitiva iremos ventilar lentamente (FR 8-10 irpm), para não prejudicar as compressões. A frequência recomendada das compressões torácicas varia de 100-125 bpm, deve ter profundidade de 5-6 cm, e permitir o completo recolhimento do tórax, já que uma diástole (tempo de ralaxamento) adequeada mantém satisfatório, dentro do possível, o tempo de enchimento ventricular e a perfusão coronariana. O grande determinante das lesões miocárdica e cerebral nos primeiros 5 minutos de parada é do fluxo sanguíneo cerebral, e não a hipóxia, o que reforça a importância de iniciar logo as compressões, bem como de não interrompê-las Como a questão pede o que não fazer, marcaremos a Letra B, já que um compressão 6 cm pode lesar a parede torácica, como fraturar costelas e provocar um hemopneumotórax Resposta certa B

157379.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A bradicardia é definida como uma frequência cardíaca inferior a 60 bpm. Em geral, os sintomas ocorrem quando a frequência cardíaca é 50 bpm, no entanto estes valores são individuais e alguns pacientes apresentam FC baixas fisiologicamente (por exemplo, os atletas). As causas podem ser cardíacas ou não cardíacas e a conduta depende essencialmente dos sintomas clínicos associados. Aqueles assintomáticos não exigem qualquer tratamento imediato, devendo ser monitorizados, observados e investigados quanto a causa. No entanto, naqueles que apresentam sintomas ou sinais decorrentes de baixo débito cardíaco há necessidade de instituição de terapia para recuperação de adequada perfusão. A atropina deve ser administrada na dose cumulativa de até 3 mg. Para os não respondedores devemos lançar mão de marcapasso transcutâneo ou transvenoso, podendo se considerar o uso de outras drogas cronotrópicas como adrenalina ou dopamina. A alternativa A está incorreta.

149179.

Comentário: Na Ressucitação Cardiopulmonar (RCP) a ênfase deve ser dada às compressões cardíacas, que é o que gera débito cardíaco e perfusão cerebral... A frequência recomendada das compressões torácicas varia de 100-120 bpm, deve ter profundidade de 5-6 cm, e permitir o completo recolhimento do tórax. Esse recolhimento produz uma pressão intra-torácica negativa relativa que permite o retorno venoso, o enchimento ventricular e a perfusão coronariana (Alternativa C correta) A compressão correta na RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) garante 30% do fluxo sanguíneo cerebral e coronariano, e pode manter uma pressão arterial de 60-80 mmHg, com uma PAM (Pressão Arterial Média) de 40 mmHg, o que retarda a lesão isquêmica do miocárdio, aumentando o sucesso da reversão dos ritmos chocáveis após a descarga elétrica O grande determinante das lesões miocárdica e cerebral nos primeiros 5 minutos de parada é do fluxo sanguíneo cerebral, e não a hipóxia, o que reforça a importância de iniciar logo as compressões, bem como de não interrompê-las Resposta certa C

157392.

Comentário: As letras A e D estão erradas por um motivo similar, no bloqueio atrioventricular há uma lentificação da condução do estímulo, o que atrasa e alarga o intervalo PR. No bloqueio átrio

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ventricular de primeiro grau não há nenhum estímulo que é bloqueado, a única alteração é o intervalo PR maior que 0,20s ou 20 milissegundos. A coronária direita (CD) é responsável pela irrigação do nó atrioventricular e também do nó sinoatrial, então infartos da CD tem maior potencial de gerar arritmias que os demais. A maioria dos bloqueios se localiza no nó atrioventricular e não no nó sinusal, como indica a letra B. O bloqueio de segundo gral Mobitz Tipo 1 ocorre geralmente no nó atrioventricular, enquanto o Mobitz Tipo 2 geralmente tem origem infranodal. Dessa forma, a letra C é a resposta da questão.

157416.

Comentário: Todas as assertivas estão corretas e são conceituais, exceto pela informação final da letra B 80 a 95% dos bloqueios atrioventriculares de segundo grau Mobiz I localizam-se no nó AV, e apenas o restante originam-se da região infranodal. Resposta B.

149204.

Comentário: Questão esquisita sobre reanimação cardiopulmonar. A alternativa A não faz muito sentido, mas aparentemente o autor sugere compressões torácicas de mais de 6 cm o preconizado é entre 5 e 6 cm. Manter a frequência entre 100 e 120 por minuto faz com que as compressões sejam eficazes por permitir o retorno do tórax e o enchimento das câmaras cardíacas (B certa). Quanto menos se interrompe as compressões e quanto melhor a qualidade delas, maiores são as chances de sucesso (retorno à circulação espontânea com boa condição neurológica - C certa). Por fim, a hiperventilação aumenta a pressão intratorácica, o que piora a hemodinâmica do paciente. Resposta A.

157426.

Comentário: Vamos verificar uma a uma as assertivas dispostas na questão a)Incorreta O bloqueio atrioventricular (BAV) de segundo grau Mobitz 1 caracteriza-se eletrocardiograficamente pelo fenômeno de Wenckebach, um aumento progressivo do intervalo PR até o bloqueio da onda P. Habitualmente ocorre progressiva redução do intervalo R-R até o bloqueio, sendo o principal critério diagnóstico a presença de PR antes da P bloqueada que o intervalo PR depois da P bloqueada. b)Incorreta O BAV de 2º grau Mobitz 1 pode ocorrer em indivíduos jovens ou atletas em função do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

aumento do tônus vagal. Nestes casos é considerado benigno e tende a desaparecer quando o tônus simpático é aumentado e o vagal é diminuído, como durante o exercício. c)Incorreta Os fármacos que bloqueiam a condução atrioventricular, tais como betabloqueadores, antagonistas de canais de cálcio, amiodarona e digitais podem ocasionar o BAV de 2º grau Mobitz 1. Os antiarrítmicos da classe IC, como a propafenona, atuam por bloqueio longo aos canais de sódio, prolongando a condução e o período refratário em todas as áreas do miocárdio. Assim, seu efeito mais pronunciado é na condução intraventricular. d)Correta O fenômeno de Wenckebach caracteriza o BAV de 2º grau Mobitz 1. Ele pode ocorrer em sequências variadas. Gabarito letra D.

149210.

Comentário: Outra questão de difícil interpretação. Sobre fibrilação atrial, qual das opções apresenta um fator que não deve ser levado em conta no tratamento da arritmia Tanto a apneia obstrutiva do sono, quanto a obesidade e o uso de bebidas alcoólicas são fatores de risco modificáveis para fibrilação atrial, e, portanto, devem ser abordados nesses pacientes. Outros exemplos de fatores de risco são hipertireoidismo, miocardiopatias, tabagismo e diabetes. Não há, entretanto, associação entre o uso de antiinflamatórios e o desenvolvimento de fibrilação atrial. Resposta D.

157442.

Comentário: O fenômeno de Wenckebach (alargamento progressivo do intervalo PR até que ocorra o bloqueio na condução de uma onda P) só pode ser observado se houver mais de um QRS antes do bloqueio (ex. 2 2, 3 2). sua identificação seria importante para definirmos se o BAV é Mobitz tipo 1 (melhor prognóstico) ou Mobitz tipo 1 (pior prognóstico) - A correta... Os BAV avançados em geral são secundários a uma lesão localizada abaixo do NAV, o que se reveste de pior prognóstico (B correta)... Tais quadros podem ser sintomáticos ou não, sendo a doença isquêmica do miocárdio uma etiologia frequente (D correta)... Enfim, a letra C está claramente errada o ritmo de escape oriundo do sistema His-Purkinje possui QRS largo, pois se trata de miocárdio ventricular. Resposta certa C.

149221.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão sobre o custo benefício de anticoagular um paciente com fibrilação atrial crônica. Isso deve sempre ser abordado de forma criteriosa, avaliando os dois lados da moeda o risco de fenômenos embólicos versus o risco de sangramento iatrogênico. Para isso foram criados escores, como o CHA2DS2-Vasc, que leva em conta fatores como idade, diabetes e AVE prévio, e recomenda ou não o uso de terapia anticoagulante. Existe também um escore que avalia o outro lado, o HAS-BLED, que leva em conta função renal e hepática, por exemplo, e avalia o risco de sangramento. O médico deve utilizar esses escores como guia para tomada de decisão. No entanto, pode-se indicar o uso de anticoagulante oral mesmo que o risco de sangramento seja alto, desde que o médico considere que o risco de fenômenos embólicos seja maior. Resposta A.

157446.

Comentário: Todo BAVT significa dissociação atrioventricular, mas nem toda dissociação AV significa BAVT (A correta). Nos casos de BAVT, a frequência atrial é sempre maior que a ventricular (B incorreta). A frequência atrial pode ser qualquer uma, desde o próprio ritmo sinusal, até o flutter, a fibrilação atrial ou qualquer outro ritmo atrial (C incorreta). No ECG, observam-se ondas P bloqueadas, dissociadas do complexo QRS, que pode ser estreito ou alargado, com padrão de bloqueio de ramo (D incorreta). Resposta A.

149232.

Comentário: Vamos de baixo pra cima... Betabloqueadores, na ausência de contraindicações (ex. asma), são eficazes no controle da frequência cardíaca em portadores de FA, podendo, inclusive, ser ministrados por via intravenosa em casos de FA aguda (D correta). Bloqueadores de canais de cálcio não-diidropiridínicos (verapamil e diltiazem, que interferem na condução pelo nódulo AV) também podem ser usados na ausência de contraindicações (ex. insuficiência ventricular esquerda). A digoxina pode ser associada tanto aos BB quanto aos ACC, possuindo efeitos aditivos de bloqueio do nódulo AV. Utiliza-se esta estratégia quando o paciente não responde adequadamente aos BB ou AC, ou então quando ocorrem efeitos colaterais relacionados ao uso de altas doses dessas medicações. A associação com digital permite reduzir a dose das drogas, diminuindo seus paraefeitos ao mesmo tempo em que aumenta a eficácia da terapia (C e B

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

corretas, A errada). Lembre-se que o carvedilol é um dos betabloqueadores que tem a vantagem adicional de melhorar a função ventricular em portadores de IC, aumetando a sobrevida desses doentes... Resposta certa A.

157452.

Comentário: A alternativa D está incorreta pois o limite do QRS para ser considerado estreito é de 120 ms, e não 140. As taquicardias instáveis são as que apresentam sinais clínicos de instabilidade alteração do nível de consciência, hipotensão ou choque, dor precordial, sinais de insuficiência cardíaca aguda ou descompensada. Na vigência de pelo menos um desses sinais a conduta deve ser a cardioversão elétrica sincronizada o mais brevemente possível. Geralmente as taquicardias instáveis apresentam frequências cardíacas maiores que 150 bpm, a menos que haja disfunção cardíaca, quando os sinais de instabilidade podem aparecer com frequências menores. Resposta D.

157466.

Comentário: No bloqueio atrioventricular total (BAVT) há uma completa dissociação entre o átrio e o ventrículo (onda P e complexo QRS). No ECG a onda P aparece em diversas posições em relaçao ao complexo QRS (antes, dentro, depois). Os intervalos P-P e os intervalos R-R são regulares, respeitando a frequência de escape. Resposta D.

157471.

Comentário: No bloqueio atrioventricular total (BAVT) ou de 3º grau há completa dissociação atrioventricular. Os átrios atuam com frequência própria e a frequência ventricular depende de um foco de escape. Quando o bloqueio ocorre proximamente ao nodo sinusal (supra-hissiano) o ritmo de escape gera QRS estreito e frequência ventricular maior. Quando o bloqueio ocorre distalmente ao nodo sinusal (intra ou infra-hissiano) o ritmo de escape tem QRS largo e frequência menor. A alternativa C é a única incorreta.

157474.

Comentário: As palpitações podem representar, entre outras causas, a presença de arritmia subjacente. A decisão de tratar uma taquiarritmia depende de uma série de fatores, tais como tipo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de arritmia, presença de sintomas, frequência cardíaca, cardiopatia estrutural coexistente. Vamos avaliar as assertivas dispostas no que tange a este tema a)Incorreta Uma taquiarritmia pode ser causa ou efeito de disfunção ventricular. Quando se infere que ela é a causa, determinamos a presença de taquicardiomiopatia, e devemos portanto, reverter a arritmia a fim de tentar reestabelecer a função cardíaca, mesmo com frequências próximas a 100 bpm. No entanto, em pacientes sem disfunção os casos precisam ser individualizados. Para a fibrilação atrial, por exemplo, deseja-se como meta uma frequência cardíaca 110 bpm em repouso para prevenir sintomas e disfunção ventricular. b)Correta A assertiva não está bem escrita, mas o conceito está correto. Em um paciente com taquiarritmia sintomática é necessário estabelecer a intensidade dos sintomas. Os pacientes podem apresentar manifestações desconfortáveis, como palpitação, tonteira ou sensação de dispneia, sem qualquer sinal clínico de comprometimento hemodinâmico. Neste grupo há tempo para avaliar a melhor terapia. De forma oposta, nos pacientes em que os sintomas denotam comprometimento hemodinâmico a terapia deve ser rapidamente instituída por meio de cardioversão elétrica sincronizada. c)Incorreta O estabelecimento do início de sintomas para a definição da terapia é especialmente importante para as arritmias que acarretam potencial emboligênico, tais como a fibrilação ou flutter atrial. No entanto, nos pacientes em que se verifica comprometimento hemodinâmico associado a taquiarritmia o estabelecimento de tempo decorrente dos sintomas não possui utilidade, visto que a terapia deverá ser prontamente estabelecida por meio de cardioversão elétrica sincronizada. d)Incorreta Em indivíduos assintomáticos em que se identifica taquiarritmias há necessidade de avaliação clínica previamente ao reestabelecimento de ritmo. As possibilidades incluem desde não intervenção a estudo de causas e efeitos, antes da tomada de decisão. A alternativa B é a única adequada.

149261.

Comentário: A hipotermia é a diminuição da temperatura corporal abaixo de 35 C e se apresenta no eletrocardiograma (ECG) através de uma diminuição da velocidade de conduc a o do esti mulo cardi aco, aumentando os intervalos RR, PR, QRS e QT. A presença da onda Osborne é típica e representa a elevac a o do ponto J apresentando um entalhe no QRS. Quanto maior é o entalhe ou

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

a elevac a o do ponto J, mais acentuada é a hipotermia. É válido lembrar que bradicardia, fibrilação atrial, tremor na linha de base e até parada cardiorrespiratória também estão relacionadas a hipotermia. A hipertensão intracraniana pode se apresentar com a tríade de Cushing , composta pela bradicardia, hipertensão arterial e ritmo respiratório irregular. Além da bradicardia, no eletrocardiograma podemos observar a onda T cerebral, que representam ondas T gigantes, negativas e difusas, em geral acompanhadas de desnivelamento de ST e aumento do intervato QT. As ondas T cerebrais marcam uma injúria cerebral aguda. A obesidade pode interferir no eletrocardiograma ao diminuir a amplitude das ondas no ECG, devido a atenuação causada pelo aumento de tecido entre o coração e o captador do aparelho de ECG. Além disso, a obesidade pode cursar com dilatação ventricular esquerda e até direita, além de sobrecarga atrial esquerda e disfunção ventricular sistólica e diastólica, o que chamamos de miocardiopatia da obesidade. A obesidade também é um fator de risco cardiovascular e apresenta associação com inúmeras patologias cardíacas. Dessa forma, o glaucoma é a única patologia que não altera o ECG e por isso, a letra C é a resposta da questão.

157467.

Comentário: A adenosina é a droga de escolha na abordagem inicial da taquicardia supraventricular. A adenosina atua em receptores específicos. O estímulo do receptor A1 leva ao aumento da condução dos canais de potássio com hiperpolarização das células do nódulo AV e sinoatrial, com consequente redução da automaticidade e da condução elétrica, sem efeito vasoconstrictor coronariano. Os efeitos colaterais são frequentes, porém de curta duração, marcadamente uma sensação de morte iminente . Resposta A.

157470.

Comentário: Os critérios de instabilidade são alteração do nível de consciência, hipotensão ou choque, dor precordial, sinais de insuficiência cardíaca aguda ou descompensada. Se a cardioversão química não for alcançada com dose máxima de um medicamento, pode-se tentar utilizar outra classe com cuidado, pois os efeitos podem ser sinérgicos e acabar levando a bradicardia com ou sem bloqueio de condução. Resposta C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149216.

Comentário: Vejamos as alternativas A- Incorreta. A pneumonia pode ocorrer, mas jamais em 100% dos casos, tanto que não está recomendado o uso de antibiótico profilático rotineiramente para os casos de afogamento. B- Correta. O vômito é complicação frequente, e pode acarretar mais broncoaspiração e obstrução da via aérea. C- Incorreta. A febre e a leucocitose podem ocorrer, em geral com elevação das formas jovens, em decorrência provável do estresse traumático a que foi submetido, e não à infecção. D- Incorreta. O uso de corticoides para lesão pulmonar é duvidoso, e não deve ser indicado rotineiramente. Resposta letra B.

141558.

Comentário: Nunca se esqueça do protocolo da linha reta, pode ser uma falsa assistolia É que eventualmente, as ondas de fibrilação ventricular não aparecem em alguns eixos ou derivações da monitoração cardíaca - não podemos deixar passar nenhum tipo de falha, nem mesmo as mecânicas. Por isso, é sempre indicado conferir a presença dessa falsa assistolia. Isso pode ser feito da seguinte forma (a) Conferir o cabeamento da monitorização eletrocardiográfica, verificando se o monitor está ligado e se a fiação está conectada no paciente e no aparelho (parece bobo , mas pode ser esse o problema) (b) Aumentar o ganho da derivação ao máximo, pois ondulações muito finas podem parecer uma linha reta (c) Mudar as derivações do monitor, pois a ausência de ondas em uma derivação pode não se confirmar em outra. Cabe lembrar que se estivermos utilizando pás do desfibrilador como derivação, devemos modificar a posição das mesmas, passando a pá do ápice para o terço superior do tórax e a pá direita para a borda costal inferior direita (fica em uma região infraclavicular esquerda e a outra abaixo do mamilo), invertendo em 90 o eixo pesquisado Se depois dessas ações o monitor persistir com uma linha reta, então estamos diante mesmo de uma assistolia. É fundamental avaliarmos causas reversíveis como hipovolemia, acidose, intoxicação exógena, tamponamento cardíaco ou hipovolemia atropina não está indicada de rotina porque nenhum trabalho prospectivo controlado conseguiu mostrar benefícios lembre-se que a assistolia e a atividade elétrica sem pulso são ritmos não chocáveis . Resposta B.

127652.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O que podemos ver no traçado eletrocardiográfico apresentado Ausência de onda P e um intervalo RR irregular, além de uma FC aumentada. Logo, estamos diante de uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular. Neste contexto, a nossa primeira pergunta deve ser o paciente está estável Sim, então a cardioversão elétrica imediata está fora de cogitação. Em segundo lugar os sintomas começaram 48 horas Sim, então não devemos reverter o ritmo para sinusal de imediato, devido ao risco de complicações tromboembólicas. Assim, procederemos com o controle da resposta ventricular e anticoagularemos o paciente por 3-4 semanas antes da reversão. Uma outra opção seria realizar um ECO transesofágico caso ele não mostrasse trombos intracavitários, a cardioversão poderia ser feita logo. Vale lembrar que a anticoagulação deve ser mantida em todos os pacientes após a cardioversão, por um mínimo de 4 semanas (após retorno ao ritmo sinusal, o miocárdio atrial encontra-se atordoado por até 4 semanas, e nesse período pode haver remora atrial (estase sanguínea na auriculeta) e consequente formação de trombos. Alternativa C correta.

129828.

Comentário: Nos casos em que há taquiarritmias com ritmo irregular devemos sempre suspeitar de fibrilação atrial, pois trata-se de uma grande possibilidade (embora não seja a única). Sabe-se que a libação alcoólica pode levar a surtos autolimitados de fibrilação atrial paroxística em pacientes com corações estruturalmente normais. Esta entidade é conhecida como Holiday Heart Syndrome . A alternativa B tem o diagnóstico mais provável.

136883.

Comentário: O eletrocardiograma da questão nos traz uma taquicardia de QRS alargado e organizado, que durante uma parada cardiorrespiratória só pode ter um diagnóstico - taquicardia ventricular (TV) sem pulso. Sempre que o ritmo de parada for TV ou fibrilação ventricular (FV) sem pulso, a conduta mais importante é aplicar imediatamente um choque desfibrilatório de 360 J (se aparelho monofásico) ou de 120 a 200J (bifásico). Logo após o choque, deve-se retornar com as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) durante 2 minutos, antes de checar o ritmo e o pulso. O uso de drogas como epinefrina ou amiodarona é indicado posteriormente, caso o paciente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

não responda ao seguimento do protocolo de RCP. Resposta D.

136618.

Comentário: Vamos pontuar algumas determinações acerca do manejo da parada cardiorrespiratória de acordo com a diretriz do ACLS. -A massagem cardíaca externa (MCE) de qualidade e a desfibrilação precoce nos ritmos passíveis são as medidas que impactam na sobrevida das vitimas de PCR. -A MCE adequada deve ocorrer a frequência de 100-120 compressões por minuto, com depressão de 5-6 cm do tórax. -Nos ritmos de FV TV a desfibrilação deve ser realizada da forma mais precoce possível. Após cada choque deve ser administrado um ciclo de RCP (dois minutos de massagem cardíaca e ventilação), sendo pulso e ritmo checados após o término deste. -São consideradas FV TV refratárias aquelas que não respondem a MCE e o primeiro choque. Somente nestes casos podem ser administrados drogas antiarrítmicas, como amiodarona ou lidocaína. Isto posto, a letra C é a única assertiva correta.

136623.

Comentário: Esta questão foi anulada A amiodarona é um importante antiarrítmico do grupo III de Vaughan e Willians que aumenta o período refratário por bloqueio dos canais de potássio da repolarização cardíaca. Além disso, exerce menor efeito bloqueador de canais de sódio e de receptores beta. Por seu mecanismo de ação pode deprimir o miocárdio e levar a bloqueio atrioventricular. Pela presença de iodo em sua composição pode piorar disfunções tireoidianas preexistentes ou mesmo gerá-las. A alternativa A, liberada inicialmente como gabarito, também está correta a dose de ataque de amiodarona deve ser feita em alguns minutos para a reversão química de algumas taquiarritmias, porém é sabidamente segura em bolus nos pacientes em parada cardiorrespiratória elegíveis. Ficamos sem nenhuma assertiva incorreta.

137015.

Comentário: Ora vejamos estamos diante de uma mulher de 82 anos, hipertensa e com fibrilação atrial de delta T INDETERMINADO. Não há no caso qualquer achado que remeta a presença de instabilidade hemodinâmica. Na FA os átrios perdem sua contração rítmica, gerando risco de eventos embólicos pela formação de trombos no interior do átrio esquerdo. É por esta razão que na

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ausência de sinais de instabilidade não devemos cardioverter de forma imediata esta arritmia. Desta forma, nossos objetivos são o alívio de sintomas, por meio de controle da frequência cardíaca, e a redução do risco cardioembólico, por meio de anticoagulação. Somente após 3-4 semanas do uso de anticoagulantes está autorizada a cardiovers o elétrica sincronizada. De modo alternativo pode ser realizado um ecocardiograma transesofágico para a exclusão de trombos intracavitários, autorizando a cardioversão mesmo sem anticoagulação prévia. A letra C está correta.

127365.

Comentário: Como sabemos, o inotropismo faz referência à contratilidade cardíaca. A administração de bicarbonato de sódio aumenta a produção de CO2, podendo gerar desvio da curva de dissociação na hemoglobina para a esquerda com consequente inibição de liberação tecidual de oxigênio e aumento paradoxal de acidose intracelular. Estes mecanismos implicam em redução de inotropismo cardíaco. A adrenalina causa inotropismo positivo e vasoconstricção por efeito adrenérgico. A atropina bloqueia os efeitos parassimpáticos da acetilcolina, gerando efeito cronotrópico positivo e podendo aumentar o débito cardíaco. A vasopressina aumenta o AMP cíclico, gerando vasoconstricção direta, sem efeitos ino cronotrópicos (sejam positivos ou negativos). Vale pontuar que a atropina não faz parte do protocolo de PCR do ACLS desde 2010 e a vasopressina tornou-se dispensável no protocolo de 2015. Gabarito correto, portanto C.

136620.

Comentário: Alguns apectos fundamentais no atendimento a parada cardiorrespiratória são -Nos pacientes sem via aérea avançada devemos realizar 30 compressões torácicas alternadas com 2 ventilações. -Nos pacientes com via aérea avançada instituída devemos realizar 100-120 compressões torácicas assíncronas com 10 ventilações por minuto. A regra básica é evitar a hiperventilação. Sabe-se que as ventilações excessivas aumentam a pressão intratorácica e reduzem o retorno venoso para o coração, prejudicando a perfusão cardíaca, pulmonar e cerebral. Desta forma, a hiperventilação AUMENTA A MORTALIDADE nas vítimas de PCR. O gabarito é a letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127367.

Comentário: Taquiarritmia com complexo QRS estreito e R-R irregular na maioria das vezes denota fibrilação atrial. O paciente apresenta sinais de instabilidade associada a taquiarritmia (edema agudo de pulmão), então independente do diagnóstico a conduta é a cardioversão elétrica sincronizada. Para relembrarmos, em arritmia a instabilidade é definida por hipotensão arterial, dor torácica anginosa e congestão pulmonar. A taquicardia ventricular cursa com QRS alargado e R-R regular. A única alternativa possível é a letra D.

136640.

Comentário: O manejo da parada cardiorrespiratória cai frequentemente nas provas de residência médica. A maneira maneira mais adequada de garantir a sobrevida das vítimas de PCR é garantindo massagem cardíaca externa (MCE) de QUALIDADE. A MCE deve ser feita a uma frequência entre 100-120 compressões torácicas por minuto, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm e permitindo completo retorno do tórax entre as compressões. Na ressuscitação cardiopulmonar realizada por mais de um socorrista estes devem se alternar a cada ciclo, a fim de evitar a perda na qualidade da massagem cardíaca. A alternativa A é a única correta.

127360.

Comentário: Se você enche o tórax do paciente de ar durante as manobras ressuscitatórias (como aquele amigo seu que fica ambuzando o doente de forma destrambelhada e desesperada), é de se esperar que ocorra um aumento da pressão intratorácica. Esse aumento impede que o sangue das grandes veias sistêmicas as cavas retorne ao coração direito, isto é, reduz-se o retorno venoso. Ora, se o coração não se enche de sangue, não tem o que ejetar, sendo a redução do débito cardíaco a próxima e lógica consequência. Resposta C.

127254.

Comentário: Desde 2010 o protocolo ACLS recomenda REASSUMIR A MASSAGEM CARDÍACA IMEDIATAMENTE APÓS O CHOQUE, ou seja, não se deve checar o pulso do doente após o choque como se fazia antigamente O motivo para isso é mesmo que o pulso volte após o choque, o miocárdio do paciente encontra-se atordoado , apresentando uma função mecânica subnormal que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

se beneficia do suporte mecânico externo oferecido pelas compressões torácicas de qualidade... Logo, questão sobre um conceito importantíssimo Resposta certa A.

127255.

Comentário: O supradesnível do segmento ST que aparece nos quadros de pericardite aguda é DIFUSO, e não regional . Todas as derivações (com exceção de V1 e a VR) apresentam o típico supra de concavidade para cima. Um supra de ST regional é compatível com isquemia segmentar, isto é, a provável explicação para a dor torácica nesse contexto passa a ser a síndrome coronariana aguda Um QRS de amplitude variável na mesma derivação é achado clássico do derrame pericárdico volumoso (A correta), e a baixa voltagem generalizada é típica do mixedema, ou hipotireoidismo (C correta). Os digitais promovem alterações características na repolarização ventricular (a clássica colher de pedreiro - D correta). Resposta certa B.

127262.

Comentário: A letra C cita bloqueadores de canais de CÁLCIO. As letras A e D citam betabloqueadores (inibidores dos receptores beta-adrenérgicos). Logo, a única opção aqui é a letra A lidocaína e propafenona são bloqueadores dos canais de sódio, exercendo seu efeito antiarrítmico através da modulação na gênese do potencial de ação nos cardiomiócitos. Resposta certa A.

127264.

Comentário: Num derrame pericárdico volumoso existe uma camada de líquido interposta entre o músculo cardíaco gerador dos sinais elétricos e o eletrodo da derivação eletrocardiográfica na superfície da parede torácica do paciente. Logo, existe um distanciamento fora do normal entre o sinal elétrico e seu receptor Curiosamente, tal fenômeno produz um QRS de amplitude VARIÁVEL, refletindo uma variabilidade na intensidade do sinal captado. A explicação para isso é a seguinte a própria movimentação do coração (quando o mesmo se contrai) mobiliza de forma irregular os bolsões de líquido que se formam dinamicamente dentro do saco pericárdico Assim, às vezes o miocárdio fica mais perto do eletrodo (pouco líquido), para outras vezes ficar mais longe (muito líquido). Resposta certa C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

136547.

Comentário: Quando falamos em drogas que podem ser administradas pelo tubo endotraqueal, temos que lembrar da sigla NELA , que inclui os seguintes medicamentos Naloxone, Epinefrina, Lidocaína e Atropina. Alternativa A CORRETA.

111453.

Comentário: Vamos ao posicionamento dos eletrodos para a realização do eletrocardiograma V1 Quarto espaço intercostal direito V2 Quarto espaço intercostal esquerdo V3 Entre V1 e V4 V4 Quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular anterior esquerda V5 Quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior esquerda V6 Quinto espaço intercostal, na linha axilar média esquerda Quanto às derivações acessórias V3R Na mesma posição de V3 à direita V4R Quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular direita V7 Quinto espaço intercostal, na linha axilar posterior esquerda V8 Quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular posterior esquerda

111455.

Comentário: Na fibrilação atrial (a taquiarritmia mais comum do mundo) os átrios não apresentam despolarização organizada e, consequentemente, no ECG simplesmente não pode haver onda P discernível, haja vista que a onda P reflete a despolarização atrial normal. Em todas as demais opções nós temos ondas P (lembrando que na letra D essa onda apresenta, no mínimo, três morfologias diferentes). Resposta certa C.

112350.

Comentário: Quando optamos pelo controle de frequência cardíaca na FA, o alvo preconizado é 110 bpm. Para obtenção deste alvo podemos lançar mão do uso de medicações com efeito cronotrópico negativo. Entre estas, as principais são os betabloqueadores, antagonistas de canais de cálcio e digitálicos. Os betabloqueadores são o grande grupo de drogas, salvo nas contraindicações, assim, a letra B está correta. Nesta opç o de controle de frequência também é de suma importância a anticoagulação. Os portadores de FA tem elevado risco de ocorrência de eventos tromboembólicos, notadamente o AVE isquêmico. Isto ocorre porque a perda da contração rítmica dos átrios permite estase sanguínea dentro deles, com predisposição a formação de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

trombos. O risco de evento tromboembólico é de 5% ao ano e este se reduz drasticamente com a anticoagulação profilática. Via de regra a grande maioria dos pacientes com FA permanente deve ser cronicamente anticoagulada. A prevenção com anticoagulantes orais mostra-se muito superior a realizada com antiagregantes plaquetários. Apenas os pacientes com 65 anos e sem fatores de risco para tromboembolismo podem receber profilaxia com aspirina, pois seu baixo risco de eventos tornaria desnecessária a anticoagulação crônica. E as estatinas Alguns estudos demonstraram que as estáticas reduziram a recorrência de FA pós cardiovers o. Não há estudos que comprovem relação de uso de estáticas e redução de mortalidade na FA.

109305.

Comentário: O sistema de condução cardíaco é afetado precocemente na Doença de Chagas, sendo o achado mais comum ao ECG o Bloqueio do Ramo Direito (BRD) associado ao Hemibloqueio Anterior Esquerdo (HBAE). Talvez a grande pegadinha da questão tenha sido chamar o hemibloqueio anterior esquerdo de bloqueio divisional anterossuperior esquerdo, uma nomenclatura menos usada na prática, porém não menos correta. Dessa forma, bloqueio de ramo direito associado a bloqueio divisional anterossuperior esquerdo (ou hemibloqueio anterior esquerdo). Gabarito correto.

109317.

Comentário: Nos ritmos de PCR não chocáveis (AESP e assistolia) a única droga a ser ministrada é o vasopressor adrenalina (epinefrina) na dose de 1 mg IV em bolus a cada 3-5min. Nenhuma outra droga mostrou aumentar a chance de retorno da circulação espontânea nas manobras de reanimação desse grupo de ritmos (ex. a atropina, que fazia parte do protocolo, foi retirada). Amiodarona e outros antiarrítmicos podem ter papel nos ritmos chocáveis (FV e TV sem pulso), mas não na AESP e na assistolia. Bicarbonato pode ser usado quando a causa da PCR for acidose, hipercalemia e ou intoxicação por tricíclicos cocaína salicilatos, porém, nas demais situações o bicarbonato não é feito de rotina. Resposta certa C.

103731.

Comentário: Pessoal, temos uma questão de abordagem a uma parada cardiorrespiratória (PCR).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Os primeiros passos a instituir (logo depois de chamar por socorro) fazem parte do BLS, ou suporte básico de vida. Segundo as últimas diretrizes, devem ser realizados na ordem C-A-B, ou seja, circulation (compressões torácicas), airway (abertura de vias aéreas) e breathing (ventilação, mantendo a relação compressões torácicas ventilações em 30 2). O outro passo do BLS seria a desfibrilação (D), caso, obviamente, observe-se ritmo chocável (FV ou TV sem pulso). Vale lembrar que, embora corresponda à letra D da sequência, o desfibrilador deve ser utilizado tão logo esteja disponível (a não ser nas PCRs com delta-t superior a 5 minutos, nas quais parece haver benefício de pelo menos 2 minutos de reanimação - compressões torácicas e ventilação - antes da primeira tentativa de choque). Dessa forma, já percebemos que, segundo o suporte básico de vida, todas as assertivas de B a D são corretas. Por outro lado, a opção A é absurda, já que esta paciente deve ser submetida às manobras do BLS ANTES de ser intubada, o que corresponde a uma manobra do ACLS (suporte avançado de vida). Esta paciente só será intubada caso as primeiras medidas de reanimação cardiopulmonar (BLS) não surtam efeito. Gabarito opção A.

103741.

Comentário: INDEPENDENTE do ritmo cardíaco em que ocorreu a parada e do TEMPO decorrido da perda das funções circulatórias espontâneas (A e D erradas), a reanimação cardiorrespiratória envolve 30 compressões torácicas, NUMA FREQUÊNCIA de, pelo menos, 100 por minuto, alternadas com 2 ventilações. Da forma que foi feita a descrição no enunciado, pareceu que o protocolo envolveria 100 COMPRESSÕES antes das 2 ventilações. Após dois minutos ou cinco ciclos de 30 compressões para duas ventilações, realiza-se a troca do socorrista que faz as compressões (C errada). Resposta B.

103661.

Comentário: A amiodarona é um antiarrítmico da classe III segundo a classificação dos antiarrítmicos de Vaughan-Williams . Isso quer dizer que ela (1) inibe canais de K , prolongando a repolarização miocárdica e desse modo aumentando a duração do período refratário (2) inibe canais de sódio, dificultando a condução do potencial de ação nas fibras cardíacas (3) possui efeito betabloqueador. Logo, a amiodarona é útil em arritmias que dependem do fenômeno de reentrada

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

para acontecer, como é o caso, por exemplo, da FIBRILAÇÃO ATRIAL (a principal taquiarritmia supraventricular) Do modo como ela altera as propriedades eletrofisiológicas do miocárdio, ela consegue literalmente cortar os circuitos de reentrada, abortando tais arritmias... Pois bem, existem vários problemas com relação ao uso de amiodarona. Os principais são (1) quando utilizada pela via oral a amiodarona leva semanas para atingir efeito pleno, pois é necessário um período de impregnação do miocárdio pela droga, o que tem que ser gradual para evitar toxicidade (2) a amiodarona possui grande conteúdo de iodo, o que pode comprometer a função da glândula tireoide em pacientes predispostos (3) quando feita pela via IV, a amiodarona deve ser ministrada lentamente, já que em bolus produz instabilidade hemodinâmica... A única situação em que seu uso IV em bolus se justifica é no caso de pacientes em parada cardíaca por FV TV refratária (isto é, que não saíram do ritmo de parada após a primeira tentativa de choque desfibrilatório)... Resposta certa B.

103685.

Comentário: A checagem do pulso logo após a administração do choque desfibrilatório é uma manobra que foi PROSCRITA dos protocolos ACLS de reanimação cardiopulmonar O motivo é além de comprovadamente não mudar o prognóstico, a checagem do pulso interrompe a RCP (massagem cardíaca), e foi definido que a RCP deve ser interrompida o mínimo possível, a fim de garantir o melhor desfecho possível para o paciente. Depois de chocar temos que retomar a RCP imediatamente, checando o pulso somente após 2 minutos (paciente intubado) ou após cinco ciclos de 30 compressões para 2 ventilações (paciente não intubado). Muitos já argumentaram que o paciente poderia voltar a um ritmo de circulação efetiva após o choque e, neste caso, manter a RCP não faria sentido (e talvez até aumentasse o risco de nova FV TV). Todavia, hoje sabemos duas coisas importantes (1) mesmo que o ritmo de circulação efetiva volte, a realização de mais um pouquinho de RCP é BENÉFICA, pois o miocárdio ventricular que acabou de sair de um processo fibrilatório - por mais breve que este tenha sido - encontra-se sempre com um certo grau de atordoamento , quer dizer, a realização de 5 ciclos de RCP num coração que acabou de sair de uma FV funciona como uma espécie de auxílio mecânico na geração de fluxo sanguíneo (2) foi

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

demonstrado que massagear o peito de alguém dificilmente provoca uma arritmia maligna. Ora, então a letra B está GROSSEIRAMENTE ERRADA, e deve servir como resposta à questão Vejamos, então, as demais opções. Numa FV TV refratária (insucesso do choque), deve-se ministrar amiodarona, inicialmente 300 mg em bolus IV, podendo repetir com 150 mg em bolus IV se persistir a refratariedade (A correta). Quando um disfibrilador bifásico está disponível, a dose da eletroterapia (120-200 J) pode ser menor em comparação à dose empregada no desfibrilador monofásico (360 J) - no desfibrilador bifásico a corrente elétrica passa duas vezes através do miocárdio, logo, uma carga relativamente mais baixa acaba sendo tão efetiva quanto à carga mais alta do monofásico (C correta). Em qualquer ritmo de parada está indicado o uso de adrenalina a cada 3-5 minutos. A lógica para esta recomendação é a adrenalina é um poderoso vasoconstrictor, desviando o fluxo de sangue da periferia para órgãos nobres, aumentando, por exemplo, a pressão de perfusão coronariana e cerebral (lembre-se que todos os leitos vasculares do organismo respondem com vasoconstricção à adrenalina, exceto os leitos coronariano e cerebral) - D correta. Resposta certa B.

86335.

Comentário: Paciente com taquicardia deverá ser manejado de acordo com a presença ou não de instabilidade clínica se estiverem presentes sinais da instabilidade, o tratamento é com cardioversão elétrica e, apesar de cada ritmo observado ser revertido com carga específica, a carga de 100J é comumente adequada a todas as taquiarritmias. Lembremos dos sinais de instabilidade sinais de insuficiência cardíaca (baixo débito), hipotensão, dispneia, estertoração pulmonar e alteração do estado de consciência. O manejo, nesses casos, só poderia ser feito com droga quando o ritmo for uma taquicardia supraventricular instável, em que há a opção de se fazer cardioversão elétrica ou adenosina, 6 mg por via endovenosa e mais 12 mg, pela mesma via, caso o paciente não responda à primeira dose. Resposta certa Letra B.

89995.

Comentário: Questão básica sobre arritmias. A e B são corretas. Existem inúmeras causas de arritmia sem doença cardíaca estrutural, como hipertireoidismo e libação alcoólica (fatores de risco

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

clássicos para fibrilação atrial) e distúrbios hidroeletrolíticos (que podem acarretar arritmias ventriculares graves). A assertiva C é correta, já que as palpitações são sintomas clássicos das taquiarritmias, assim como a precordialgia (pelo aumento do consumo miocárdico de O2 e ou pela hipoperfusão miocárdica) e a dispneia (por congestão pulmonar secundária ao baixo débito ventricular esquerdo). Toda arritmia, em princípio, pode ser diagnosticada através do ECG. Logo, a assertiva D é incorreta e responde à questão. A assertiva E é correta, já que a síndrome de Wolff-Parkinson-White é decorrente da presença de uma via acessória congênita com capacidade de condução anterógrada (do átrio para o ventrículo), revelando-se no ECG sinusal com o padrão da pré-excitação ventricular (PR curto e onda delta) e manifestando-se clinicamente com taquiar ritmias de repetição, geralmente do tipo taqui supra .

78125.

Comentário: Questão conceitual. Os ataques de Stokes-Adams (ou síndrome de Stokes-Adams) consistem em episódios sincopais ou pré-sincopais, em decorrência de baixo débito, provenientes de bloqueios atrioventriculares totais que ocorrem de maneira intermitente, levando a períodos de FC muito baixa, culminando em algumas ocasiões em grandes pausas com assistolia. Alternativa D CORRETA.

83819.

Comentário: A síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) representa uma das síndromes de pré-excitação ventricular, em que, através de uma via acessória de condução atrioventricular, pode se desenvolver taquiarritmias potencialmente graves. As duas alterações de base clássicas são o intervalo PR curto e o aparecimento de onda delta, com consequente alargamento do intervalo QRS. Alterações na repolarização ventricular (onda T) também podem ocorrer. A não progressão de ondas R (achado clássico da sequela de um infarto extenso no miocárdio do ventrículo esquerdo) não é esperada na SWPW. Resposta certa C.

84609.

Comentário: O paciente portador do eletrocardiograma dado na questão apresenta critérios de instabilidade hemodinâmica, que podem ser dispneia, sinais de insuficiência cardíaca aguda, dor

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

torácica, rebaixamento do nível de consciência e choque. Nesses casos, sem pestanejar, a nossa conduta deverá ser a cardioversão elétrica (um choque sincronizado, por definição), com uma carga incial entre 50-100 J. Gabarito Letra D.

85808.

Comentário: Um dos conceitos mais importantes para a abordagem de arritmias na emergência é o de INSTABILIDADE HEMODINÂMICA Sabemos que, nas bradiarritmias, como é o caso do portador do eletrocardiograma em questão, existem critérios que nos levam a TOAMR ATITUDES COM EFEITO IMEDIATO Quais seriam esses sinais Principalmente sinais de baixo débito cardíaco, como rebaixamento de consciência, hipotensão e choque A grande atitude a ser tomada nos pacientes com bradicardia e sinais de instabilidade hemodinâmica é a passagem de marcapasso paralelamente ao início da infusão de atropina, 0,5mg a cada 3-5 minutos, com dose máxima de 3mg. Resposta certa Letra C.

85401.

Comentário: A Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) deve ser baseada, principalmente, nas compressões torácicas FORTES E RÁPIDAS (frequência de pelo menos 100 por minuto, deixando o tórax retornar ao seu diâmetro original entre as compressões). Após 2 minutos de ressuscitação, já que esta parada NÃO FOI presenciada, devemos checar o ritmo cardíaco ao monitor (PERCEBA QUE NÃO ESTAMOS FALANDO DE CHECAR PULSO). Existem quatro ritmos de parada, dentre os quais, dois são chocáveis a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular SEM PULSO Os outros dois ritmos, para os quais não cabe choque, são a Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP) e a assistolia. De todo modo, o paciente em questão tem parada cardíaca por Fibrilação Ventricular (FV). Portanto, deveremos, após 2 minutos de RCP (repetindo a parada não foi presenciada se tivesse sido presenciada, já poderíamos iniciar a ressuscitação por um choque - aqui chamado de DESFIBRILAÇÃO, um choque que, por definição, é DESSINCRONIZADO letra B incorreta), desferir um choque. Este pode ser de 360 Joules (J), num aparelho monofásico e, mais modernamente, entre 120-200 J num aparelho bifásico, de acordo com a indicação do fabricante. Caso você não saiba a indicação do fabricante, o que é comum, utilize a maior carga disponível.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Drogas como a epinefrina (que aumenta as pressões de enchimento coronariano - letra C incorreta) e a amiodarona (antiarrítmico de escolha na FV) farão parte da ressuscitação, mas sem dúvidas, a primeira conduta é DESFIBRILAR o doente. Perceba que não há resposta correta. Enviamos sugestão de recurso para esta questão aos alunos, mas a resposta da banca não foi favorável (Dá pra entender isso). Gabarito da banca Letra C.

61717.

Comentário: Na síndrome de Wolff-Parkinson-White (SWPW) existe uma via acessória anômala que liga o miocárdio atrial ao miocárdio ventricular sem passar pelo filtro do nódulo AV. Um dos maiores riscos a que esses indivíduos estão expostos é a chance aumentada de fibrilação ventricular em face ao surgimento de uma fibrilação atrial (lembrando que esta última, por motivos pouco compreendidos, tem sua incidência bastante aumentada em portadores de SWPW). O risco de FV é extremamente aumentado se o portador de SWPW receber uma droga inibidora do nódulo AV na presença de FA (pois, nesta situação, os estímulos deixam de passar pelo nódulo AV e tendem a passar preferencialmente pela via acessória, a qual é desprovida do freio encontrado no nódulo AV, o que pode resultar em frequências ventriculares elevadíssimas e insustentáveis, que degeneram para uma fibrilação ventricular). Ora, qual é a única droga dentre as apresentadas que possui a propriedade de inibir o nódulo AV É claro que é o digital (ex. digoxina). Resposta certa D.

61719.

Comentário: Por recomendação classe III entende-se o seguinte conduta CONTRAINDICADA, pois as evidências mostram mais risco do que benefício. Que conduta deve ser contraindicada no portador de SWPW que apresenta FA É claro que é o uso de drogas bloqueadoras do nódulo AV (pois na SWPW FA, a inibição do nódulo AV faz os estímulos passarem preferencialmente pela via acessória anômala, que não possui o freio natural do nódulo AV, gerando frequências cardíacas elevadíssimas que têm alta probabilidade de degenerar para uma FV). De todas as drogas citadas, a única que não representa um inibidor do nódulo AV é a procainamida que, inclusive, muito pelo contrário, está indicada na SWPW com FA, por inibir especificamente a via acessória. Resposta certa E.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61722.

Comentário: Por razões ainda pouco compreendidas, portadores da síndrome de WPW possuem forte predisposição à fibrilação atrial paroxística e, em menor grau, ao flutter atrial. Estima-se que cerca de 20-30% desses indivíduos apresentarão uma dessas arritmias em algum momento da vida. O grande problema nesses casos é que a via acessória não possui as mesmas propriedades de filtro dos estímulos elétricos que é característica do nódulo AV. Assim, uma taquiarritmia atrial de alta frequência será extremamente perigosa se a maioria dos estímulos atriais passar aos ventrículos pela via acessória, em vez de ser filtrada pelo nódulo AV. Se o período refratário anterógrado da via acessória for muito curto (inferior a 250 ms), assim, grande parte dos estímulos da fibrilação atrial, e todos os estímulos do flutter atrial, passarão para os ventrículos por meio da via acessória. O resultado será uma taquiarritmia que se manifesta com FC altíssima, em torno de 300 bpm ou mais (no caso das FA), ou um flutter com condução 1 1 (FC de 300 bpm). O caso em tela provavelmente representa uma FA associada à SWPW, pois os intervalos RR dos estímulos que passaram aos ventrículos são completamente irregulares (no flutter o RR é REGULAR). Se houvesse instabilidade hemodinâmica, o tratamento imediato teria que ser a cardioversão elétrica. Mas como não se trata de um caso instável, podemos tentar reverter a arritmia lançando mão de drogas que bloqueiam preferencialmente a via acessória (não se esqueça que as drogas que bloqueiam o nódulo AV, como betabloqueadores, antagonistas de cálcio não diidropiridínicos, digital e adenosina - são CONTRAINDICADAS justamente por favorecer a passagem dos estímulos atriais pela via acessória, pois elas literalmente fecham o caminho pelo nódulo AV). A droga de escolha para reverter ou estabilizar o paciente com fibrilação atrial WPW que se encontra hemodinamicamente estável é a procainamida , que deve ser ministrada pela via intravenosa na dose de 15 mg kg (infundir em 30 min, diluído em 50 ml de soro fisiológico), seguida por 1-4 mg min em infusão contínua. A amiodarona e a ibutilida seriam drogas de segunda escolha. Resposta certa D.

69210.

Comentário: Qual é a conduta prioritária perante um paciente que se apresenta com fibrilação atrial

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

INSTÁVEL (lembrando que o termo instabilidade , em arritmologia, significa hipotensão arterial, dispneia aguda grave, dor torácica anginosa e ou outros sinais e sintomas de baixo débito cardíaco) É claro que é a imediata CARDIOVERSÃO ELÉTRICA SINCRONIZADA. Resposta certa letra B.

63670.

Comentário: Colapso súbito, paciente irresponsiva, e o enunciado afirma que se trata de situação que necessita de suporte básico de vida. O que é isso É claro que só pode ser uma parada cardiorrespiratória (PCR) Lembre-se que o reconhecimento da PCR deve ser imediatamente feito quando um paciente inconsciente não responde e não respira (ou apresenta apenas gasping , que é considerado um ritmo respiratório associado à PCR). O leigo não precisa de mais nada para identificar uma situação de PCR (não precisa, por exemplo checar o pulso do paciente - segundo o protocolo atual do BLS, após detectar a PCR conforme descrito ele já deve chamar ajuda e iniciar em seguida as compressões torácicas, podendo intercalá-las, ou não, com ventilações). O médico capacitado PODE checar um pulso central do paciente inconsciente que não responde e não respira (ou apresenta apenas gasping , como já explicamos), porém, essa verificação não deve durar mais do que 10 SEGUNDOS. Seja como for, uma vez reconhecida a situação de PCR, o próximo passo é CHAMAR AJUDA. Em locais públicos, é importante perguntar se existe um DEA (desfibrilador externo automático) disponível. Independentemente de haver ou não um DEA, é preciso dar início o mais rápido possível às compressões torácicas efetivas (depressão do esterno de pelo menos 5 cm, retorno completo do tórax entre cada depressão, frequência de pelo menos 100 minuto, no hands-off - isto é, só interromper a massagem se estritamente necessário). A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é imprescindível para a manutenção da perfusão e, consequentemente, da viabilidade do cérebro e demais tecidos da vítima de PCR, até que um tratamento definitivo da causa básica possa ser instituído com a chegada da equipe de saúde Como na maioria das PCR extra-hospitalares o ritmo de parada é a FV (fibrilação ventricular), a desfibrilação se torna a medida terapêutica mais importante, uma vez que apenas ela consegue reverter a FV e, para que haja sucesso, é preciso que o intervalo de tempo entre o início da FV e o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

choque seja o mais breve possível. Resposta certa B.

63687.

Comentário: O ECG descrito é compatível com a hipótese de Taquicardia Supraventricular Paroxística (TSVP), a famosa taqui supra . Vamos relembrar O QRS estreito nos informa que a origem do estímulo está acima do miocárdio ventricular a ausência de onda P demonstra que o comando do ritmo não está sendo feito pelo nódulo sinusal e a regularidade dos intervalos RR descartam a possibilidade de Fibrilação Atrial (FA). Considerando o contexto clínico (paciente jovem sem comorbidades), a maior probabilidade diagnóstica, sem dúvida nenhuma, recai sobre a TSVP, que na maioria das vezes associa-se à existência de uma via anômala congênita no interior do nódulo AV, a qual é responsável pelo fenômeno de reentrada nodal. Como o paciente em tela não apresenta qualquer sinal de INSTABILIDADE (hipotensão arterial, dor torácica anginosa e ou dispneia), não há necessidade de proceder à cardioversão elétrica da arritmia (A e B erradas). Vale dizer que, se esse fosse o caso, a cardioversão teria que ser SINCRONIZADA ao QRS, a fim de evitar o fenômeno R sobre T (que pode levar à degeneração do ritmo para uma FV). A conduta terapêutica nesse caso, por conseguinte, se focará na interrupção do circuito de reentrada nodal, inicialmente tentando-se alguma manobra vagal (ex. massagem do bulbo carotídeo), e posteriormente lançando mão de drogas que atuem como bloqueadores do nódulo AV, caso a manobra vagal não dê certo O bloqueio do nódulo AV (por efeito da descarga colinérgica vagal ou ação das drogas) extinguirá o circuito de reentrada nodal. Os principais fármacos dentro deste grupo são (1) adenosina - cuja meia-vida extremamente curta permite administração em bolus intravenoso, (2) betabloqueadores, (3) antagonistas de canal de cálcio não diidropiridínicos, (4) digital. Qualquer um desses pode vir a ser utilizado na reversão da TSVP, dependendo das necessidades clínicas do paciente (D errada). Na prática, particularmente no jovem previamente hígido, a droga de primeira escolha para reverter a TSVP é a ADENOSINA, que deve ser ministrada em bolus pela via IV inicialmente na dose de 6 mg, podendo repetir-se com 12 mg caso a primeira tentativa tenha sido ineficaz. Deve-se lembrar de avisar ao paciente que ele vai sentir certo desconforto , uma vez que a adenosina promove um BAV total transitório (durante alguns

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

segundos), dando a estranha sensação de que o coração de repente parou de bater . Resposta certa C.

61790.

Comentário: Estamos, sem dúvida, diante de um paciente com quadro de taquicardia ventricular. Podemos afirmar isso com base no ECG característico, que evidencia uma arritmia caracterizada pela presença de três ou mais extrassístoles ventriculares seguidas. As extrassístoles são arritmias cardíacas originadas nos ventrículos, que ocorrem quando as células cardíacas destes locais assumem temporariamente o controle do ritmo elétrico do coração. A ativação anômala dos ventrículos modifica os complexos QRS, tornando-os largos e bizarros, com duração superior a 120ms. Para o tratamento, quando a TV ocorrer com pulso, deve-se proceder à pesquisa da estabilidade hemodinâmica. Os sinais de colapso cardiovascular são hipotensão arterial sistêmica, choque, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva, diminuição do nível de consciência, dor torácica persistente, congestão pulmonar, infarto agudo do miocárdio e ritmo não sinusal com resposta ventricular maior do que 150 bpm. Quando esses sinais estão presentes, está indicada a cardioversão elétrica sincronizada. A dose inicial da descarga em crianças deve ser de 0,5 a 1 J kg caso não haja resolução do quadro, as descargas seguintes serão de 2 J kg. Resposta letra D.

63480.

Comentário: Diante de um paciente que se apresenta com taquicardia importante (FC 182 bpm), QRS estreito (origem supraventricular do estímulo) e intervalo RR irregular, o diagnóstico arritmológico mais provável - sem sombra de dúvida - é fibrilação atrial . Qual a conduta preconizada para toda e qualquer taquiarritmia em que o doente se apresenta francamente INSTÁVEL (hipotensão arterial, dor torácica anginosa e ou dispneia) É claro que é a cardioversão elétrica imediata Este paciente deverá ser sedado, posteriormente recebendo um choque SINCRONIZADO aos complexos QRS (a fim de evitar o fenômeno R sobre T e, consequentemente, o risco de degeneração para fibrilação ventricular). A carga eficaz da corrente elétrica nos desfibriladores bifásicos geralmente varia entre 120-200 J. Logo, resposta certa letra D.

61818.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão direta e conceitual A síndrome da apneia-hipopneia do sono tem relação íntima com a síndrome metabólica e suas comorbidades como obesidade, alterações glicêmicas, dislipidemia e hipertensão arterial, não possuindo associação com a doença pulmonar obstrutiva crônica. Resposta letra B.

61801.

Comentário: O método atualmente considerado o mais confiável para confirmar e monitorar o posicionamento adequado do tubo orotraqueal é a capnometria contínua (mensuração digital da quantidade de CO2 no ar exalado) - A ERRADA. As causas mais comuns de AESP Assistolia são os famosos 5 Hs e 5 Ts, porém, perceba o equívoco presente nesta frase hipoglicemia não é um dos Hs clássicos, e sim H , isto é, ACIDOSE - B ERRADA. As vias de acesso ao sistema vascular para administração de drogas na PCR apresentam a seguinte ordem de prioridade endovenosa, intraóssea (particularmente em crianças pequenas) e endotraqueal (lembrando que nesta última as doses dos fármacos tem que ser duplicadas ou triplicadas, e somente algumas drogas podem ser ministradas por esta via) - C ERRADA. A frase da alternativa D estaria perfeita se não fosse um pequeno detalhe o alvo da saturação de oxigênio nos cuidados pós-parada é SpO2 maior ou igual a 94%, e não 90%. - D ERRADA. Enfim, hoje sabemos que as manobras de indução de hipotermia terapêutica podem melhorar o prognóstico neurológico, bem como a chance de sobrevivência do paciente vítima de PCR. A hipotermia terapêutica (redução da temperatura central do corpo para a faixa de 32-36ºC, por pelo menos 24h) está atualmente indicada, sempre que possível, para todo paciente que permanece em coma após a PCR (isto é, pacientes que apresentam indícios de lesão neurológica grave). Resposta certa letra E.

48303.

Comentário: Diante de qualquer indivíduo que apresenta um colapso súbito (possível parada cardíaca), a primeira conduta deve ser a verificação da responsividade. O doente responde Se não responde, ele respira (lembrar que o gasping não é considerado respiração). Caso ambas as respostas sejam negativas, o próximo passo consiste em CHAMAR AJUDA, pois o doente está parado , e para reverter uma parada cardiorrespiratória é preciso aplicar o ACLS (Advanced

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Cardiac Life Support) o que demanda a utilização de insumos médicos como drogas endovenosas, via aérea avançada e - claro - um desfibrilador para a maioria dos casos. Resposta certa D.

47666.

Comentário: A única maneira de reverter uma fibrilação ventricular é através da DESFIBRILAÇÃO ELÉTRICA. Segundo o protocolo do ACLS, mesmo após um choque bem-sucedido é preciso massagear o doente, pois o coração não volta batendo normalmente , isto é, a contração miocárdica após a desfibrilação é mecanicamente ineficaz. Em adultos, a relação compressão-ventilação é universal e deve ser de 30 2. A obtenção IMEDIATA de uma via aérea avançada (ex. intubação orotraqueal) é altamente recomendável durante os procedimentos de reanimação, porém, não é considerada obrigatória, e deve-se evitar ao máximo a interrupção da massagem cardíaca para a sua realização. O emprego de certas drogas (ex. vasopressina, adrenalina, amiodarona) tem o potencial de aumentar a chance de ROSC (retorno da circulação espontânea), porém, não é obrigatoriamente IMEDIATO. A única medida verdadeiramente IMEDIATA é a realização de compressões torácicas de qualidade. Se o ritmo for chocável, recomenda-se ministrar - o mais rápido possível - o choque apropriado. Resposta certa C.

53603.

Comentário: Relembre os tipos clínicos de FA e suas definições. Como não houve resposta à cardioversão, gabarito B.

48486.

Comentário: O tilt table test , comumente chamado apenas de tilt test , é um método pouco sensível, pouco específico e pouco reprodutível utilizado, no entanto, para a pesquisa de síncope neurocardiogênica. Resposta certa E.

48498.

Comentário: Questão tranquila de simples interpretação do traçado, vamos a eles - Traçado I Verificamos, em sequência, vários complexos QRS alargados com uma frequência bastante superior a 100 bpm, o que fecha o diagnóstico de Taquicardia Ventricular (TV). Na realidade, o diagnóstico formal de um TV requer apenas uma sequência de 3 complexos QRS alargados. Neste

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

1º traçado, como a morfologia do QRS não se altera, classificamos como TV monomórfica. - Traçado II Aqui, também há uma grande sequência de complexos QRS alargados com frequência elevada, mas, como existe uma variação morfológica, devemos classificar como TV polimórfica. - Traçado III Esse traçado é absolutamente anárquico, ou seja, não conseguimos distinguir complexos QRS, ondas T... É o aspecto de uma Fibrilação Ventricular. Resposta certa letra B.

48503.

Comentário: Na intoxicação pela cocaína um agonista simpatomimético ocorre uma síndrome hiperadrenérgica. Sinais e sintomas como crise convulsiva, hipertensão, taquiarritmias cardíacas e hipertermia são esperados nesse contexto. Resposta certa letra C.

48868.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas - LETRA A ERRADA O bicarbonato não é preconizado para uso rotineiro nos casos de parada cardiorrespiratória. Seu uso era defendido por alguns em situações de paradas muito prolongadas, nas quais a redução acentuada do fluxo sanguíneo promove acidose. Mas atualmente nem mesmo a administração de bicarbonato é defendida nessa situação por ter sido associada a alguns efeitos adversos, como redução da perfusão coronariana (em decorrência da redução da resistência vascular periférica), hipernatremia, inativação de catecolaminas etc. Assim, hoje em dia, o uso de bicarbonato é restrito a situações de reanimação especiais, como acidose metabólica sabidamente pré-existente, hipercalemia e intoxicação por antidepressivos tricíclicos. - LETRA B ERRADA Nenhum estudo com cálcio mostrou benefício de seu uso em casos de parada cardiorrespiratória. - LETRA C ERRADA A atropina (assim como o marca-passo) saiu do protocolo de assistolia AESP na atualização de 2010 por não existir comprovação de sua eficácia. - LETRA D CERTA No ACLS são infundidas drogas por via venosa (ou intraóssea) e as primeiras sempre são drogas vasopressoras. Estas têm a capacidade de aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e coronariano, reduzindo a hipóxia e acidose teciduais, o que aumenta a possibilidade de sucesso, por exemplo, da desfibrilação. Lembre que, enquando a adrenalina pode ser repetida a cada 3-5 minutos, a vasopressina só pode ser prescrita uma única vez. - LETRA E ERRADA A amiodarona é o principal antiarrítmico a ser usado nos casos de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

fibrilação ventricular, sendo intercalada com a administração dos vasopressores. Entretanto, não se posterga a desfibrilação para a administração de nenhuma droga.

35612.

Comentário: Este doente apresenta queixas sugestivas de toxicidade cardíaca da cocaína, o que inclui uma série de distúrbios agudos potencialmente graves, como IAM, dissecção aórtica e taquiarritmias ventriculares. Logo, é mandatório obter um ECG para esclarecer o diagnóstico diferencial, exame esse que, na verdade, faz parte da avaliação básica de todo suposto evento cardiovascular agudo Lembre-se de que está contraindicado administrar betabloqueadores neste paciente a cocaína tem efeito alfa-adrenérgico direto (vasoconstrição), e o uso de betabloqueadores (que acabam bloqueando o receptor beta-2 vascular, indutor de vasodilatação), promove uma tendência ao vasoespasmo coronariano, o que pode precipitar ou agravar uma isquemia miocárdica subjacente. Tanto o flumazenil (antagonista de benzodiazepínicos) quanto o naloxone (antagonista de opioides) não têm qualquer finalidade neste contexto. Não é preciso confirmar a presença de cocaína no exame de urina, pois o doente já está dizendo que fez uso da droga (e realizar ou não esta confirmação não vai mudar em nada a sua conduta imediata).

Resposta certa D.

35626.

Comentário: Em resumo, temos um IAM que evoluiu com BAVT (Bloqueio Atrioventricular de 3º grau). O BAVT ocorre em 5-15% dos IAM, geralmente no contexto de um IAM inferior (DII, DIII e AVF parede irrigada pela coronária direita, a mesma que irriga a porção alta do nódulo AV). Na maioria das vezes o BAVT é transitório no IAM relacionado à coronária direita, durando entre 5-7 dias, e cursando com QRS estreito (lesão supra-hissiana), FC 40 bpm e ritmo de escape juncional. Como o paciente está hemodinamicamente instável (hipotenso e com sintomas de má perfusão cerebral), é preciso agir com rapidez, sendo a maneira mais célere de aumentar a FC, nesta situação, a instalação de um marca-passo transcutâneo . Obviamente, será preciso passar um marca-passo transvenoso, pois devido à impedância progressiva da pele do tórax (além, é claro, do desconforto imposto pelo aparelho, que fica dando choques no peito do paciente) não se consegue

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

manter o transcutâneo por muito tempo. De toda forma, resposta certa B.

35627.

Comentário: Questão sem dificuldade. O que está faltando para tratar corretamente a FA crônica desta paciente portadora de estenose mitral Ora, como se trata de paciente de alto risco para eventos tromboembólicos, além de controle da FC com uma droga inibidora do nódulo AV (como a digoxina), devemos instituir anticoagulação plena permanente, para o que se indica uma droga oral como o Warfarin (mantendo o INR entre 2-3). Resposta certa A.

35846.

Comentário: Logo de cara, podemos descartar as opções nitidamente erradas. Vamos de baixo pra cima... Só podemos excluir a presença de trombo no átrio esquerdo através do eco transesofágico, e não com o transtorácico (E errada). Os inibidores do nódulo AV (como os antagonistas de cálcio verapamil e diltiazem) estão contraindicados nos portadores da síndrome de Wolff-Parkinson-White que desenvolvem FA, pois o efeito inibitório sobre aquele nódulo pode fazer com que todos os estímulos provenientes do miocárdio atrial fibrilante passem direto (através da via rápida representada pelo feixe anômalo de Kent) para o miocárdio ventricular, gerando um quadro de fibrilação ventricular (morte súbita) D errada. A anticoagulação na FA 48h de duração é feita com cumarínico, isto é, warfarin, e não com um antiplaquetário como a aspirina (ácido acetilsalicílico) C errada. O AFFIRM foi o maior estudo randomizado que comparou a estratégia de manutenção da FA controle da frequência cardíaca e anticoagulação crônica com a estratégia de controle do ritmo cardíaco (isto é, antiarrítmico crônico para manter o ritmo sinusal). Seus resultados foram favoráveis à estratégia de controle da frequência cardíaca, pois se observou uma tendência quase estatisticamente significativa à redução da mortalidade geral neste grupo, além de uma clara redução na taxa de hospitalizações F (lembre-se que as drogas antiarrítmicas possuem diversos efeitos colaterais, inclusive o próprio efeito pró-arrítmico). Assim, sobrou a letra B. Na FA aguda (48h desde o início do episódio) não é preciso manter o paciente anticoagulado por 3-4 semanas antes de tentar cardioverter (se for o caso). Todavia, vale lembrar que é preciso manter a anticoagulação por 4 semanas após a cardioversão, devido ao risco aumentado de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

cardioembolismo sistêmico neste período, secundário ao fenômeno do miocárdio atrial atordoado .

Resposta B.

35852.

Comentário: Não tem nem o que discutir aqui. Taquiarritmia com instabilidade hemodinâmica é igual a CARDIOVERSÃO ELÉTRICA. Como há complexos QRS estreitos (taquicardia supraventricular) a cardioversão deverá ser sincronizada. Lembre-se de que na síndrome de Wolff-Parkinson-White existe uma maior incidência de certas arritmias supraventriculares, como a fibrilação atrial e a taquicardia supraventricular por reentrada pela via acessória (ortodrômica).

Resposta certa C.

26938.

Comentário: Durante avaliação ambulatorial para esclarecimento de um episódio de pré-síncope, foi detectado que Maria apresentava uma taquicardia com ritmo cardíaco irregular... O ECG evidenciou RR irregular e ausência de onda P, que é compatível com o diagnóstico de Fibrilação Atrial (FA). Quais exames fazem parte da avaliação inicial de um paciente com FA Além da História e exame físico, recomenda-se a realização de (1) Ecocardiograma transtorácico, para avaliar o tamanho dos átrios e ventrículos, a função ventricular, a possibilidade de doença valvar ou pericárdica, etc. O ecocardiograma transtorácico (de repouso) também pode identificar um trombo atrial, apesar da sensibilidade do exame ser menor do que a do eco transesofágico (2) Dosagem do TSH e T4L para avaliação de hipertireoidismo e (3) Radiografia de tórax quando a clínica sugere alguma alteração pulmonar. Como o diagnóstico da Fibrilação Atrial já foi documentado pelo ECG, não há necessidade de realização do Holter. O Holter é útil nos casos de arritmia intermitente que não é capturada no ECG convencional. O Teste ergométrico e o ecocardiograma de estresse podem ser úteis para avaliar a possibilidade de doença arterial coronariana associada, entretanto, cabe ressaltar que esta não é uma causa frequente de FA... A hipocalemia e hipomagnesemia são distúrbios eletrolíticos que estão associados ao prolongamento do intervalo QT e, portanto, podem ser causas de Torsade des Pointes. Estas arritmias não estão associadas ao desenvolvimento de FA. Ficamos, portanto, com a alternativa E como resposta. Só para lembrar, as principais causas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de FA são cardiopatia hipertensiva, cardiopatia reumática, cardiomiopatia dilatada e hipertireoidismo.

27200.

Comentário: As principais causas de morte súbita em atletas são Miocardiopatia hipertrófica origem anômala da artéria coronária displasia arritmogênica do VD Commotio Cordis Síndrome de Wolff-Parkinson-White Síndrome de Brugada e Síndrome do QT longo congênito. A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética de transmissão autossômica dominante, que se caracteriza pela hipertrofia do VE (principalmente do septo interventricular). Estes pacientes estão sujeito a arritmias atriais e ventriculares, que podem culminar com morte súbita. Esta doença é a causa mais comum de morte súbita em indivíduos previamente assintomáticos com menos de 35 anos de idade A displasia arritmogênica de VD é uma cardiomiopatia que começa no VD e é definida pela presença de áreas de substituição fibrogordurosa do miocárdio ventricular. A perda progressiva de miócitos predispõe a formação de focos de taquicardia ventricular monomórfica. A Síndrome de Brugada é uma entidade com transmissão autossômica dominante caracterizada por padrão pseudo-BRD supradesnível de ST nas derivações V1, V2 e V3 propensão à fibrilação ventricular espontânea e ausência de cardiopatia estrutural. Esta síndrome é bem mais comum no sexo masculino e nos indivíduos de origem asiática. Estes pacientes possuem um defeito nos canais de sódio de alguns miócitos (principalmente do VD) que predispõe à arritmias. A Síndrome de Wolff-Parkinson-White é uma das causas mais comuns de morte súbita em pacientes jovens. Os pacientes com esta síndrome apresentam uma via acessória com período refratário curto que predispõe a episódios de fibrilação atrial paroxística. Há risco de geração de uma Taquicardia de QRS alargado com posterior degeneração para FV se os impulsos passarem todos pela via acessória rápida. A Síndrome do QT longo congênita apresenta 7 subtipos, sendo três mais importantes. Tipo 1 de transmissão autossômica dominante, onde há um defeito genético no canal de potássio lento que pode ou não associar-se a surdez congênita (que neste caso é chamada de Síndrome de Jervell-Lange-Nielsen) Tipo 2 onde o problema está no canal de potássio rápido e Tipo 3, que possui um defeito de inativação do canal de sódio... Lembre-se que o intervalo QT mede o período

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

refratário dos miócitos ventriculares e quando os miócitos ficam despolarizados por muito tempo, podem surgir pequenos picos transitórios de despolarização (pós-potenciais precoces) que eventualmente podem gerar uma extrassístole ventricular. Vários estímulos surgindo podem dar origem a uma TV não sustentada e se houver uma dispersão importante de períodos refratários no miocárdio ventricular pode surgir um circuito de reentrada funcional gerando uma TV polimórfica. Commotio Cordis é o termo clássico que descreve uma contusão cardíaca acidental, onde a força mecânica do trauma sobre o precórdio é capaz de induzir uma disritmia ou mesmo parada cardíaca. É sabido que o tipo de arritmia que resultante da contusão depende fundamentalmente do momento do ciclo cardíaco em que o trauma acontece. Em geral, se o trauma ocorre durante a repolarização ventricular (onda T), a arritmia que se desenvolve é a fibrilação ventricular (mas uma taquicardia ventricular também é possível). Por outro lado, se o trauma ocorre durante o complexo QRS (ativação ventricular), a arritmia tende a ser a assistolia. Esta condição é uma das causas de morte súbita em atletas que não apresentam lesão cardíaca. Resposta Letra C.

27150.

Comentário: Os BAV proximais ou Supra-Hissianos são bloqueios de bom prognóstico e que respondem bem à atropina. Portanto, sua presença não indica a necessidade de um marcapasso definitivo. Todas as demais condições são indicações classe I ou IIa para implante de marcapasso definitivo. Resposta Letra E.

27151.

Comentário: Questão simples, não pense demais para não errar... A melhor maneira de se diagnosticar uma taquicardia é através da realização de um eletrocardiograma durante a arritmia... O Holter e o Gravador de eventos são úteis nos casos de arritmia intermitente que não é capturada no ECG convencional... O teste de esforço e a cintilografia miocárdica são exames para avaliar a presença de doença arterial coronariana. Resposta Letra D.

11090.

Comentário: Questão basal A relação entre compressões torácias e ventilações, no paciente não intubado, que está sendo recomendada pela última edição do ACLS (2005) é 30 compressões para

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

2 ventilações A frequência da massagem deve ser de 100 compressões por minuto. Resposta certa letra C.

11107.

Comentário: As arritmias cardíacas não são incomuns no período pós-operatório, especialmente se o paciente possuir alguma cardiopatia estrutural de base Todos os tipos de arritmia são perfeitamente possíveis taqui e bradiarritmias, bem como os bloqueios AV As taquiarritmias são o tipo mais comum, e se associam a um aumento no risco de eventos cardiovasculares adversos ICC aguda, angina instável, IAM, AVC Fatores de risco são idade avançada, cardiopatia de base, tipo de cirurgia (por exemplo as cirurgias cardíacas são as que acarretam maior risco até 60% dos doentes no pós-op de uma revascularização miocárdica podem apresentar taquiarritmias). Seja como for, os tipos mais frequetes de taquiarritmia na prática são a TAQUICARDIA SINUSAL e a FIBRILAÇÃO FLUTTER ATRIAL As ectopias ventriculares (extrassistoles) aparecem em até 1 3 dos pacientes após cirurgias não-cardíacas, mas são menos comuns do que as duas taquiarritmias citadas

16029.

Comentário: A última versão do ACLS (2010) já coloca a hipotermia terapêutica como tratamento de primeira linha no período pós-parada, indicado a todo paciente que após a PCR se encontra em estado de coma (maioria dos casos). A hipotermia terapêutica não só reduz a chance de sequelas neurológicas como também reduz a taxa de mortalidade global desses doentes... Estas conclusões foram devidamente embasadas por exteno cabedal de informações da literatura... Resposta certa B.

274007.

Comentário: Questão bem interessante Apesar de muitos acharem que a adrenalina é feita para aumentar a frequência cardíaca, esse não é o objetivo da droga Na verdade, a estratégia se baseia na preservação do fluxo sanguíneo de órgãos nobres, como coração e cérebro, através da vasoconstrição da circulação periférica. Não entendeu Calma Pense da seguinte forma ao reduzir o lúmen dos vasos superficiais da pele, por exemplo, o sangue ejetado do ventrículo esquerdo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(através das compressões torácicas) é desviado dessa região menos nobre e tende a migrar para áreas em que o calibre vascular está maior (cérebro e coração não sofrem vasoconstrição). Perceba, portanto, que o objetivo não é aumentar a automaticidade miocárdica , restabelecer a circulação espontânea e, muito menos, aumentar o consumo de oxigênio pelo miocárdio Resposta letra D.

250228.

Comentário: Considerando um paciente de 65 anos, com história de acidente vascular encefálico, hipertenso, com doença vascular periférica e fibrilação atrial, encontramos 5 pontos pelo escore de CHA2DS2VASc. Portanto, trata-se de um paciente de altíssimo risco para evento tromboembólico. Considerando a fibrilação atrial de etiologia valvar (associada à estenose mitral moderada a importante), a única alternativa de anticoagulante oral autorizada para uso é o warfarin. Caso o paciente não possuísse essa alteração valvar, a rivaroxabana seria uma opção terapêutica. Gabarito alternativa A.

216386.

Comentário: A fibrilação atrial é caracterizada por ativação atrial desorganizada, rápida e irregular, com perda de contração atrial e frequência ventricular irregular determinada pela condução nodal AV. A frequência ventricular também tende a ser acelerada (entre 120 e 160 bpm), mas pode ultrapassar 200 bpm. Segundo o Harrison, as consequências clínicas estão relacionadas com frequências ventriculares altas, perda da contribuição atrial ao enchimento ventricular e predisposição à formação de trombos no apêndice atrial esquerdo com potencial de embolização. As apresentações clínicas variam com a frequência ventricular e com cardiopatia e comorbidade subjacentes. Muitos pacientes são assintomáticos. Frequências rápidas podem causar colapso hemodinâmico ou agravamento de insuficiência cardíaca em pacientes com disfunção cardíaca, miocardiopatia hipertrófica e insuficiência cardíaca com função sistólica preservada. Intolerância aos exercícios e fatigabilidade fácil são comuns. Às vezes, ocorre tontura ou síncope em razão de pausas quando a FA é revertida a ritmo sinusal . Pessoal, não é justamente isso que temos Eletrocardiograficamente, muito típico de FA pela perda da contração atrial, não temos onda P, o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ritmo passa a ser irregularmente irregular e o QRS é estreito (a não ser que haja bloqueio de ramo associado e condução com aberrância). Pode ou não ter sintomas associados como palpitação nesse caso e essa história de febre reumática está aí para nos fazer pensar em uma provável estenose mitral como sequela. Isso pode causar aumento atrial, dando substrato anatômico para a arritmia em questão. Gabarito, portanto, letra B.

176124.

Comentário: Parece que o examinador se confundiu aqui... Assistolia é ausência de atividade elétrica identificável em monitor cardíaco portanto, não poderia ter QRS. Por isso, a questão foi anulada. O correto, imaginamos, seria paciente em parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso com QRS estreito . Vamos partir dessa frase para entender as alternativas A - errada. O supradesnivelamento de ST em paredes contíguas, por exemplo, nos faria pensar em infarto... A taquicardia com QRS estreito, isoladamente, não nos leva a pensar em IAM, embora a própria dor associada aumente a frequência. B - errada. Na hipercalemia, pode ocorrer alargamento do QRS e não estreitamento. C - errada. A intoxicação por antidepressivos tricíclicos, por exemplo, pode determinar desvio terminal do QRS para a direita ou seu prolongamento. Os betabloqueadores podem aparecer levar a BAV, bloqueio de ramo, prolongamento do QRS, bradicardia e assistolia. A intoxicação por cocaína, por sua vez, determina taquicardia, mas com QRS alargado. Ou seja observar QRS estreito não nos induz a pensar especificamente em intoxicação. D - errada. A hipoxemia severa pode determinar bradicardia e assistolia. E - teria sido a melhor resposta.
Sabe-se que hipovolemia causa taquicardia sinusal (QRS estreito) reflexa para compensar o débito cardíaco. Questão anulada.

176131.

Comentário: Questão conceitual sobre arritmias. Vejamos as alternativas. A - Certa. Dentre os cardiomiócitos, existem as células com propriedade de marca-passo, isto é, que se despolarizam espontaneamente, como aquelas do nó sinoatrial e existem as células contráteis, que, em condições normais, são desprovidas de atividade de marca-passo. B - Certa. O mecanismo de reentrada está relacionado às principais taquiarritmias supraventriculares e ventriculares. C - Certa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

A repercussão clínica das arritmias pode ser dividida em estável ou instável. A instabilidade é definida pela presença de alteração do nível de consciência, insuficiência cardíaca aguda, desconforto torácico, hipotensão e sinais de choque. D - Certa. O diagnóstico diferencial entre arritmias supraventriculares e ventriculares é importante na tomada de decisão terapêutica. Exemplo claro é a da urgência se um paciente estável tem QRS estreito, sinalizando arritmia de origem supraventricular, pode-se utilizar adenosina, seja para reverter a alteração elétrica, seja para lentificar a frequência cardíaca e facilitar a avaliação eletrocardiográfica. Esta droga não é utilizada em pacientes com taquicardias de QRS alargado, isto é, ventriculares. E - Errada. A presença de cicatrizes ou áreas manipuladas cirurgicamente serve como substrato anatomopatológico para o mecanismo de reentrada como o que ocorre no flutter atrial. Resposta E.

155255.

Comentário: A fibrilação atrial (FA) é uma arritmia caracterizada por perda de contração atrial, sendo definida eletrocardiograficamente por ausência de onda p e intervalos R-R irregulares. A frequência cardíaca normalmente se encontra entre 90-170 batimentos por minuto, sendo possível a sua ocorrência sem taquicardia. Uma frequência cardíaca normal pode ocorrer espontaneamente ou através do uso de drogas bloqueadoras do nodo atriventricular. A letra A está incorreta. As outras assertivas estão corretas. Vamos comentar Devido a perda da contração rítmica dos átrios ocorre estase sanguínea, com consequente risco cardioembólico. Esta é uma realidade mesmo nos portadores de FA paroxística. O escore CHADS2 ou, preferencialmente, CHA2DS2VASC pode ser utilizados para determinar o risco embólico, indicando-se anticoagulação naqueles que pontuam em 2 fatores de risco, e devendo ser considerada naqueles que pontuam em 1 fator de risco. A FA trata-se da arritmia crônica mais comum, aumentando progressivamente com a idade, especialmente acima dos 65 anos. Um portador de FA de 60 anos e diabético pontua em 1 no escore CHA2DS2VASC, podendo realizar profilaxia de cardioembolismo com antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes. Os novos anticoagulantes orais, entre os quais a rivaroxabana, podem ser utilizados na prevenção de eventos embólicos de portadores de FA de etiologia não valvar. Na etiologia valvar a varfarina é o anticoagulante oral indicado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155261.

Comentário: A questão nos apresenta uma criança de 6 meses com uma taquicardia associada a sinais de instabilidade hemodinâmica. Pela descrição do eletrocardiograma trata-se de uma taquicardia supraventricular. Nas taquiarritmias que se apresentam com instabilidade hemodinâmica há necessidade de desacelerar o mais rapidamente a frequência cardíaca, indicando-se a realização de cardioversão elétrica sincronizada. O grande problema da questão é que o autor nos dá duas alternativas que contêm essa conduta. Então vamos a um conceito para a cardioversão elétrica de uma taquicardia supraventricular na faixa pediátrica a carga do choque deve ser de 0,5 a 2 Joules por quilo. A carga inicial é de 0,5-1 J Kg, podendo ser escalonada até 2J em casos de insucesso. A letra B é o gabarito.

131920.

Comentário: A síncope é definida como a perda súbita e transitória da consciência e do tônus postural, que ocorre por redução do fluxo sanguíneo cerebral As síncopes são benignas na maioria dos casos, sendo principalmente as chamadas Neuromediadas neurocardiogênicas (chegam a 41% de acordo com a referência), que podem ser divididas em vasovagal, situacional ou por hipersensibilidade do seio carotídeo. Nessas síncopes de bom prognóstico (neuromediadas) temos uma exacerbação parassimpática por estimulação direta ou em resposta a um estímulo simpático Como resultado temos um reflexo vagal, levando à vasodilatação, com bradicardia ou pausa sinusal É uma síncope precedida por sintomas prodrômicos (sudorese fria, náusea e mal estar), além de salivação e diaforese. As síncopes vasovagais podem ser deflagradas por medo, dor, ansiedade, emoção intensa, visões, odores desagradáveis , exercício intenso. Já a situacional pode ocorrer por tosse, espirro, micção, defecação, deglutição, hiperventilação e pressão ocular Quando temos um fator específico deflagrador, como os citados acima, temos uma síncope de bom prognóstico, apenas por exacerbação parassimpática Agora compare a Letra B (gabarito) com as demais alternativas Precisamos excluir principalmente as síncopes cardíacas, que ocorrem por arritmias, isquemia miocárdica e insuficiência cardíaca, alterações estruturais (cardiomiopatias e estenose aórtica) e embolia pulmonar. Bem como as causas neurológicas, como a isquemia vertebrobasilar,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

enxaqueca de artéria basilar, doença carotídea bilateral e hemorragia subaracnoidea Gabarito B

131862.

Comentário: Nessa questão observamos a descrição de uma taquicardia com QRS estreito, o que nos faz pensar em flutter, fibrilação atrial ou taquicardia supraventricular. Como o R-R é regular, descartamos a fibrilação atrial. No flutter há a presença de uma P com aspecto de serrote com uma frequência atrial em torno de 300 e que no caso do flutter típico, o mais comum, se apresenta negativa na parede inferior. No enunciado, se afirma que não há visualização de p, logo, pode-se tratar de uma P retrógrada, que ocorre na taquicardia supraventricular. O tratamento da Taquisupra inclui manobra vasovagal, injeção de adenosina ou cardioversão. A cardioversão é restrita aos raros casos de instabilidade hemodinâmica. A manobra vasovagal não deve ser realizada nesse caso, pois a paciente está em pré-operatório para angioplastia carotídea, ou seja, ela apresenta placa ateromatosa em carótida com obstrução maior que 70 %, então a pressão ali realizada poderia precipitar uma embolização. A adenosina é realizada na dose de 6 mg, podendo em caso de segunda administração, ser aumentada para 12 mg. Ela sempre deve ser realizada com um flush de soro após sua administração, além de levantar o membro onde está presente o acesso, devido à meia vida curta da adenosina.

80850.

Comentário: O Bloqueio Atrioventricular (BAV) de terceiro grau é também chamado de BAV Total (BAVT). Neste caso, os estímulos de origem atrial não conseguem chegar aos ventrículos e despolarizá-los. Não existe, assim, correlação entre a atividade elétrica atrial e ventricular, o que se traduz no ECG por ondas P não relacionadas ao QRS. Geralmente, um ritmo de escape independente está presente, mas pode não ser suficiente, levando a sintomas como síncope. Em relação à população pediátrica, o BAVT pode ser congênito e é mais frequentemente causado por lesão autoimune do sistema de condução fetal por anticorpos IgG maternos (anti-SSA Ro e anti-SSB La) de mães com lúpus eritematoso sistêmico ou com síndrome de Sjögren. O BAVT congênito também pode ser visto em crianças com cardiopatia congênita complexa. Além disto, esta patologia pode ser adquirida como uma complicação de um abscesso miocárdico ou após a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

correção de uma cardiopatia congênita, em especial, as correções envolvendo o fechamento de CIV. Letra E correta.

47395.

Comentário: Na verdade, a banca quis se referir às causas de FA reversíveis espontaneamente , já que a FA por qualquer causa é potencialmente revertida com cardioversão elétrica e ou química. No grupo de causas de FA espontaneamente reversível, encontramos principalmente a FA associada à libação alcoólica e às eletrocussões acidentais, bem como a FA que ocorre após grandes cirurgias torácicas (particularmente cardíacas). Resposta certa D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina